

Buku Ajar

KEPERAWATAN GAWAT DARURAT

Sri Haryuni • Sulastri • Vita Maryah Ardiyani • Nurma Afiani
Anshar Rante • Nunung Nurhayati

Editor: Prof. Dr. Hajjul Kamil, S.Kp., M.Kep



BUKU AJAR

KEPERAWATAN GAWAT DARURAT

Penulis:

Dr. Sri Haryuni, S.Kep., Ns., M.Kep.

Sulastri, SKp., M.Kep.

Vita Maryah Ardiyani, S.Kep., Ns., M.Kep.

Dr. Nurma Afiani, S.Kep., Ns., M.Kep.

Anshar Rante, S.Kep., Ns., M.Kes.

Ns. Nunung Nurhayati, S.Kep., M.Kep.

Editor:

Prof. Dr. Hajjul Kamil, S.Kp., M.Kep



Buku Ajar Keperawatan Gawat Darurat

Penulis:

Dr. Sri Haryuni, S.Kep., Ns., M.Kep.

Sulastri, SKp., M.Kep.

Vita Maryah Ardiyani, S.Kep., Ns., M.Kep.

Dr. Nurma Afiani, S.Kep., Ns., M.Kep.

Anshar Rante, S.Kep., Ns., M.Kes.

Ns. Nunung Nurhayati, S.Kep., M.Kep.

Editor:

Prof. Dr. Hajjul Kamil, S.Kp., M.Kep

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7756-69-5

Cetakan Pertama: Juli, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Ajar *Keperawatan Gawat Darurat* ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai salah satu sumber belajar bagi mahasiswa keperawatan dalam memahami konsep dasar dan keterampilan esensial keperawatan gawat darurat yang diperlukan dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, aman, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan menuntut perawat untuk memiliki kompetensi yang memadai dalam menghadapi berbagai kondisi kegawatdaruratan yang dapat terjadi di berbagai tatanan pelayanan kesehatan.

Materi dalam buku ini disusun secara sistematis dimulai dari konsep dasar keperawatan gawat darurat dan *patient safety*, sistem triage serta manajemen alur pasien di Instalasi Gawat Darurat, penilaian awal kegawatdaruratan menggunakan pendekatan ABCDE, manajemen jalan napas (*airway*) dan oksigenasi dasar, bantuan hidup dasar serta penanganan henti jantung pada dewasa, hingga kegawatdaruratan pernapasan. Setiap bab dilengkapi dengan latihan soal, studi kasus, simulasi keterampilan, instrumen penilaian OSCE, DOPS, portofolio, ringkasan materi, glosarium, dan daftar pustaka untuk mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa baik secara teoritis maupun praktis.

Penulis menyadari bahwa buku ajar ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan seiring perkembangan ilmu keperawatan gawat darurat. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan pada edisi berikutnya. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, praktisi keperawatan, serta seluruh pembaca dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme dalam memberikan asuhan keperawatan gawat darurat yang berkualitas dan berfokus pada keselamatan pasien.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
---------------------	------------

DAFTAR ISI.....	iv
------------------------	-----------

BAB 1 KONSEP DASAR KEPERAWATAN GAWAT DARURAT DAN PATIENT

SAFETY.....	1
A. Pendahuluan	3
B. Konsep Keperawatan Gawat Darurat	4
C. Sistem Pelayanan Gawat Darurat.....	7
D. Konsep Dasar Pasien Safety	10
E. Sasaran Keselamatan Pasien (SKP).....	13
F. Etika dalam Keperawatan Gawat Darurat	16
G. Aspek Legal dalam Pelayanan Gawat Darurat	19
H. Prinsip Keselamatan pada Layanan Gawat Darurat	21
I. Latihan Soal	24
J. Rangkuman Materi	29
K. Glosarium	31
L. Daftar Pustaka	33

BAB 2 SISTEM TRIAGE DAN MANAJEMEN ALUR PASIEN DI INSTALASI

GAWAT DARURAT	35
A. Definisi <i>Triage</i>	37
B. Tujuan <i>Triage</i>	37
C. Alur Pasien di IGD	38
D. Konsep Prioritas Kegawatdaruratan Dalam <i>Triage</i>	39
E. Form Penilaian Osce Keperawatan Station: Triage Pada Unit Gawat Darurat	52
F. DOPS (Does).....	54
G. Portofolio.....	57
H. Ringkasan	60
I. Glosarium	61
J. Daftar Pustaka	63

BAB 3 PENILAIAN AWAL GAWAT DARURAT: PENDEKATAN ABCDE.....65

A. Definisi.....	67
B. Tujuan	68
C. Indikasi	69
D. Kontraindikasi	69
E. Alat Dan Bahan.....	69
F. Persiapan Pasien/Perawat/Lingkungan	71
G. Langkah Prosedur.....	72
H. Hal Yang Harus Diperhatikan/ <i>Patient Safety</i>	74
I. Komplikasi.....	75
J. Evaluasi Hasil.....	76
K. Dokumentasi	76
L. Form Penilaian Osce Keperawatan Station: Penilaian Awal Dengan Pendekatan Abcde	86
M. Rubrik Penilaian	87
N. Deskripsi Performa Tiap Skor.....	88
O. Direct Observation Of Prosedural Skills (Dops).....	92
P. Portofolio.....	94
Q. Ringkasan	101
R. Red Flag dan Eskalasi	102
S. Glosarium	105
T. Daftar Pustaka	106

BAB 4 MANAJEMEN AIR WAY DAN OKSIGENASI DASAR.....109

A. Definisi.....	111
B. Tujuan	112
C. Indikasi	112
D. Kontraindikasi	113
E. Alat dan Bahan	114
F. Persiapan Pasien/Perawat/Lingkungan	116
G. Langkah Prosedur.....	118
H. Hal yang harus diperhatikan/Patient safety.....	119
I. Komplikasi.....	120
J. Evaluasi Hasil.....	121
K. Dokumentasi	122

L. Mini-Case Study: Diskusi Kelompok Manajemen Airway dan Oksigenasi.....	123
M. Simulasi: Manajemen Airway dan Oksigenasi Dasar (OSCE)	124
N. Form Penilaian Osce Keperawatan.....	130
O. Rubrik Penilaian	131
P. Direct Observation Of Prosedural Skills (DOPS).....	136
Q. Portofolio.....	139
R. Ringkasan	145
S. Red Flag dan Eskalasi.....	147
T. Daftar Pustaka	149

BAB 5 BANTUAN HIDUP DASAR (BHD) DAN HENTI JANTUNG PADA

DEWASA.....151

A. Pendahuluan	153
B. Konsep Henti Jantung	154
C. Chain of Survival pada Dewasa	157
D. Penilaian Awal Korban.....	157
E. Resusitasi Jantung Paru RJP Dewasa.....	160
F. Penggunaan Automated External Defibrillator (AED)	163
G. Penghentian dan Evaluasi Resusitasi.....	165
H. Langkah Penghentian dan Evaluasi Resusitasi.....	165
I. Algoritma Henti Jantung Dewasa.....	167
J. Aspek Keselamatan dan Etika dalam Bantuan Hidup Dasar.....	168
K. Mini-case tertulis (diskusi kelompok)	169
L. Simulasi/skill lab RJP+AED.....	170
M. Template Soal Osce Keperawatan.....	173
N. Rubrik Penilaian	181
O. DOPS (Does).....	186
P. Portofolio.....	188
Q. Ringkasan	194
R. Red Flag dan Eskalasi.....	196
S. Glosarium	198
T. Daftar Pustaka	200

BAB 6 KEGAWATDARURATAN PERNAPASAN203

A. Definisi Kegawatdaruratan Pernapasan	206
---	-----

B. Etiologi dan Faktor Risiko.....	206
C. Patofisiologi Kegawatdaruratan Pernapasan	206
D. Klasifikasi Kegawatdaruratan Pernapasan	208
E. Manifestasi Klinis	210
F. Pemeriksaan Penunjang.....	211
G. Komplikasi.....	212
H. Penatalaksanaan Kegawatdaruratan Pernapasan	212
I. Pengkajian Keperawatan	212
J. Diagnosis Keperawatan.....	216
K. Luaran Keperawatan.....	216
L. Intervensi Keperawatan.....	217
M. Implementasi dan Evaluasi Keperawatan	218
N. Edukasi Keperawatan	218
O. Dokumentasi Keperawatan.....	218
P. Mini-case tertulis (diskusi kelompok)	219
Q. Simulasi / Skill Lab Penanganan Kegawatdaruratan Pernapasan	220
R. Template Soal Osce Keperawatan.....	223
S. DOPS (Does).....	238
T. Ringkasan	250
U. Red Flags & Eskalasi	251
V. Glosarium	254
W. Daftar Pustaka	258
PROFIL PENULIS	261

BAB 1

KONSEP DASAR KEPERAWATAN GAWAT DARURAT DAN PATIENT SAFETY

Capaian Pembelajaran

Tabel 1. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep keperawatan gawat darurat, patient safety, etika–legal, dan keselamatan kerja sebagai landasan praktik.	CPMK-1; CPMK-7

Tabel 2. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep dasar keperawatan gawat darurat, patient safety, etika–legal, dan prinsip keselamatan layanan.

Tabel 3. Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Konsep Dasar Keperawatan Gawat Darurat dan Patient Safety	1.1 Menjelaskan prinsip patient safety dan manajemen risiko pada pelayanan gawat darurat.	1.2 Mengidentifikasi isu etika–legal dan keselamatan kerja yang relevan pada tindakan emergensi.	CPMK-1	CPMK-7; CPMK-2

Tabel 4. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
-----------	------------------	-------------------------------------	-----------	--------------

CPMK-1	Ujian tulis (CBT/essay terstruktur)	Persentase jawaban benar konsep patient safety–etika–legal dan ketepatan penerapan pada skenario.	10	Nilai ujian; lembar jawaban
--------	-------------------------------------	---	----	-----------------------------

Tabel 5. Rubrik CPMK (skala 1–4)

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep patient safety–etika–legal (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten
1.2 Ketepatan penerapan prinsip keselamatan pada skenario	Keliru/tidak relevan	Relevan sebagian; alasan lemah	Tepat; alasan logis	Tepat; alasan kuat dan komprehensif

A. Pendahuluan

Pelayanan gawat darurat merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan memberikan pertolongan segera kepada pasien dengan kondisi yang mengancam nyawa, fungsi organ, atau yang dapat menyebabkan kecacatan permanen. Kondisi gawat darurat dapat terjadi akibat penyakit akut, trauma, kecelakaan, bencana, maupun komplikasi penyakit kronis yang memburuk secara tiba-tiba. Oleh karena itu, pelayanan gawat darurat harus cepat, tepat, akurat, dan terkoordinasi.

Instalasi Gawat Darurat (IGD) menjadi pintu masuk utama bagi pasien dengan kondisi kritis. Di unit ini, tenaga kesehatan dituntut untuk mampu melakukan pengkajian cepat, menentukan prioritas penanganan melalui triase, serta melakukan intervensi segera untuk mempertahankan kehidupan pasien. Keterlambatan atau kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat berdampak fatal terhadap keselamatan pasien.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan turut meningkatkan kompleksitas pelayanan di IGD. Perawat sebagai tenaga profesional memiliki peran penting dalam memberikan asuhan keperawatan yang sistematis, berbasis bukti, dan responsif terhadap kondisi kegawatdaruratan. Oleh karena itu, pemahaman tentang konsep dasar keperawatan gawat darurat menjadi landasan utama dalam praktik klinik.

Keselamatan pasien (*patient safety*) merupakan prinsip fundamental dalam pelayanan kesehatan yang bertujuan mencegah terjadinya cedera akibat kesalahan tindakan, kelalaian, maupun kegagalan sistem pelayanan. Dalam konteks pelayanan gawat darurat, risiko terjadinya kesalahan medis relatif lebih tinggi karena kondisi pasien yang kritis, tekanan waktu, beban kerja yang tinggi, serta kompleksitas tindakan yang dilakukan.

Insiden keselamatan pasien dapat berupa kesalahan pemberian obat, kesalahan identifikasi pasien, tindakan yang tidak sesuai prosedur, hingga kegagalan komunikasi antartim kesehatan. Apabila tidak dikelola dengan baik, insiden tersebut dapat menyebabkan kerugian fisik, psikologis, bahkan kematian pasien.

Penerapan *patient safety* bukan hanya tanggung jawab individu, melainkan budaya organisasi yang harus diterapkan secara sistematis. Perawat memiliki tanggung jawab profesional untuk memastikan setiap tindakan yang dilakukan aman, sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), serta berorientasi pada

perlindungan pasien. Dengan demikian, keselamatan pasien menjadi indikator utama mutu pelayanan kesehatan.

Perawat merupakan tenaga kesehatan yang berada di garis depan dalam pelayanan gawat darurat. Dalam situasi kritis, perawat berperan melakukan pengkajian cepat (*primary survey* dan *secondary survey*), memantau tanda-tanda vital, memberikan intervensi awal, serta berkolaborasi dengan tim medis untuk menstabilkan pasien.

Selain sebagai pemberi asuhan (*caregiver*), perawat juga berperan sebagai advokat pasien, edukator, koordinator tim, dan pelapor insiden keselamatan. Kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan klinis yang cepat, serta keterampilan komunikasi yang efektif menjadi kompetensi utama yang harus dimiliki perawat di IGD.

Peran strategis ini menuntut perawat tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga memahami aspek etika, hukum, dan keselamatan layanan. Dalam kondisi darurat, perawat sering menghadapi dilema etik dan tekanan emosional, sehingga profesionalisme dan integritas menjadi landasan utama dalam praktik.

B. Konsep Keperawatan Gawat Darurat

1. Pengertian Keperawatan Gawat Darurat

Keperawatan gawat darurat adalah pelayanan keperawatan profesional yang diberikan kepada pasien dengan kondisi akut, kritis, atau mengancam nyawa yang memerlukan tindakan segera, cepat, dan tepat untuk mencegah kematian atau kecacatan permanen (Emergency Nurses Association [ENA], 2022). Pelayanan ini mencakup pengkajian cepat, penentuan prioritas, stabilisasi kondisi pasien, serta kolaborasi dalam tindakan resusitasi dan intervensi medis.

Menurut American College of Emergency Physicians [ACEP], 2021), pelayanan gawat darurat berfokus pada penanganan kondisi yang memerlukan evaluasi dan intervensi segera. Dalam konteks keperawatan, praktik gawat darurat menuntut kemampuan berpikir kritis, respons cepat, serta keterampilan klinis yang kompeten untuk mempertahankan fungsi vital pasien.

Dengan demikian, keperawatan gawat darurat tidak hanya berorientasi pada tindakan penyelamatan jiwa (*lifesaving*), tetapi juga pada upaya mempertahankan stabilitas fisiologis, mencegah komplikasi, dan memastikan keselamatan pasien selama proses perawatan.

2. Karakteristik Pasien Gawat dan Darurat

Pasien gawat darurat memiliki karakteristik kondisi klinis yang tidak stabil dan berpotensi mengalami penurunan fungsi vital secara cepat. Karakteristik tersebut antara lain:

- a. Gangguan jalan napas (*airway*)
- b. Gangguan pernapasan (*breathing*)
- c. Gangguan sirkulasi (*circulation*)
- d. Penurunan kesadaran (*disability*)
- e. Cedera atau trauma berat

Pendekatan sistematis yang digunakan untuk menilai kondisi pasien adalah metode ABCDE (*Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure*) (ENA, 2022). Pasien dalam kondisi "gawat" berarti terdapat ancaman nyata terhadap nyawa dan memerlukan tindakan segera, sedangkan "darurat" mengacu pada kondisi yang memerlukan pertolongan cepat tetapi belum tentu mengancam nyawa secara langsung (ACEP, 2019). Karakteristik lain pasien gawat darurat adalah kondisi yang sering kali tidak terduga, memerlukan keputusan cepat, serta membutuhkan kolaborasi multidisiplin.

3. Prinsip Dasar Penanganan Kasus Gawat Darurat

Penanganan kasus gawat darurat didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu:

- a. Cepat dan Tepat
Kecepatan dalam melakukan pengkajian dan intervensi sangat menentukan prognosis pasien. Keterlambatan dapat meningkatkan risiko mortalitas (World Health Organization [WHO], 2021).
- b. Prioritas (Triase)
Pasien ditangani berdasarkan tingkat kegawatannya melalui sistem triase untuk memastikan pasien dengan kondisi paling kritis mendapat pertolongan terlebih dahulu (ENA, 2022).
- c. Stabilitas Fungsi Vital
Fokus utama adalah mempertahankan jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi (ABC).
- d. Kerja Tim dan Komunikasi Efektif
Kolaborasi antartenanaga kesehatan sangat penting dalam situasi kritis. Komunikasi yang jelas dan terstruktur (misalnya SBAR) membantu mencegah kesalahan (Cherry & Jacob, 2023).
- e. Keselamatan Pasien

Setiap tindakan harus mempertimbangkan aspek keselamatan dan mematuhi standar operasional prosedur (SOP).

4. Tujuan Pelayanan Gawat Darurat

Menurut ACEP (2021), pelayanan gawat darurat bertujuan untuk:

- a. Menyelamatkan nyawa pasien.
- b. Mencegah kecacatan permanen.
- c. Menstabilkan kondisi pasien sebelum perawatan lanjutan.
- d. Mengurangi angka morbiditas dan mortalitas.
- e. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan aman sesuai standar profesi.

Selain itu, pelayanan gawat darurat juga bertujuan untuk memberikan rasa aman dan dukungan psikologis bagi pasien dan keluarga yang mengalami situasi krisis.

5. Lingkup Pelayanan IGD

Ruang lingkup pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) meliputi:

- a. Pelayanan triase: Penentuan prioritas pasien berdasarkan tingkat kegawatan.
- b. Resusitasi dan Stabilisasi: Tindakan penyelamatan jiwa seperti *cardiopulmonary resuscitation* (CPR), pemberian oksigen, pemasangan infus, dan tindakan emergensi lainnya.
- c. Observasi dan Monitoring: Pemantauan kondisi pasien secara kontinu.
- d. Tindakan Diagnostik Awal: Pemeriksaan laboratorium, elektrokardiografi (EKG), radiologi.
- e. Rujukan dan Transfer Pasien: Koordinasi dengan unit lain atau fasilitas kesehatan lanjutan.

Menurut ENA (2022), IGD merupakan lingkungan kerja dengan risiko tinggi sehingga membutuhkan sistem manajemen yang terstruktur, sumber daya yang memadai, serta tenaga kesehatan yang kompeten.

6. Peran dan Fungsi Perawat dalam Situasi Gawat Darurat

Menurut Cherry dan Jacob (2023), perawat memiliki peran strategis dalam pelayanan gawat darurat, yaitu:

- a. Caregiver
Memberikan asuhan keperawatan secara langsung, termasuk pengkajian cepat dan tindakan penyelamatan jiwa.
- b. Decision Maker
Mengambil keputusan klinis yang cepat berdasarkan kondisi pasien.
- c. Advocate

Melindungi hak dan keselamatan pasien.

d. Communicator

Berkomunikasi secara efektif dengan tim kesehatan dan keluarga pasien.

e. Educator

Memberikan edukasi singkat kepada pasien dan keluarga mengenai kondisi dan tindakan yang dilakukan.

f. Documenter

Mencatat seluruh tindakan dan respons pasien secara akurat sebagai bentuk tanggung jawab profesional dan aspek legal

Kemampuan berpikir kritis, ketahanan emosional, kompetensi teknis, dan integritas profesional menjadi kunci utama keberhasilan perawat dalam situasi gawat darurat.

C. Sistem Pelayanan Gawat Darurat

Sistem pelayanan gawat darurat merupakan suatu rangkaian pelayanan kesehatan yang dirancang untuk memberikan penanganan cepat, tepat, dan terkoordinasi kepada pasien dengan kondisi akut atau yang mengancam jiwa. Kondisi kegawatdaruratan dapat terjadi kapan saja dan membutuhkan respon segera untuk mencegah kematian atau kecacatan permanen. Oleh karena itu, pelayanan gawat darurat harus dilaksanakan melalui sistem yang terorganisasi dengan baik mulai dari tempat kejadian hingga penanganan lanjutan di fasilitas kesehatan (Tintinalli et al., 2020).

Sistem pelayanan gawat darurat tidak hanya dilakukan di rumah sakit, tetapi melibatkan berbagai komponen pelayanan kesehatan yang saling terintegrasi. Sistem ini mencakup pelayanan pra-rumah sakit, pelayanan di instalasi gawat darurat, sistem rujukan antar fasilitas kesehatan, serta mekanisme triase untuk menentukan prioritas penanganan pasien. Integrasi berbagai komponen tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pasien memperoleh pelayanan yang cepat, efektif, dan aman (WHO, 2021).

1. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) merupakan suatu sistem pelayanan kesehatan yang mengintegrasikan berbagai komponen pelayanan kegawatdaruratan mulai dari masyarakat, pelayanan pra-rumah sakit, transportasi medis, hingga pelayanan di rumah sakit. Sistem ini dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas penanganan pasien gawat darurat serta memastikan koordinasi yang baik antara berbagai fasilitas pelayanan kesehatan.

SPGDT bertujuan untuk memberikan respons cepat terhadap kejadian gawat darurat serta menjamin kesinambungan pelayanan dari tempat kejadian

hingga pasien mendapatkan penanganan yang memadai di fasilitas kesehatan. Dalam implementasinya, SPGDT juga didukung oleh sistem komunikasi kegawatdaruratan seperti Public Safety Center (PSC) 119 yang berfungsi sebagai pusat koordinasi pelayanan darurat di masyarakat (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019).

Melalui SPGDT, penanganan pasien gawat darurat dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan terkoordinasi sehingga dapat meningkatkan keselamatan pasien serta menurunkan angka kematian akibat kondisi kegawatdaruratan.

2. Sistem Pra-Rumah Sakit (*Prehospital Care*)

Sistem pra-rumah sakit merupakan tahap awal dalam pelayanan gawat darurat yang diberikan kepada pasien sebelum tiba di fasilitas kesehatan. Pelayanan ini meliputi pertolongan pertama di tempat kejadian, stabilisasi kondisi pasien, serta transportasi menuju fasilitas kesehatan yang sesuai.

Pelayanan pra-rumah sakit biasanya melibatkan petugas ambulans, tenaga kesehatan, serta masyarakat yang memiliki kemampuan pertolongan pertama. Intervensi yang dilakukan pada tahap ini sangat penting karena dapat menentukan keberhasilan penanganan pasien selanjutnya. Misalnya, pada kasus henti jantung, tindakan CPR yang dilakukan segera dapat meningkatkan peluang keselamatan pasien secara signifikan.

Selain itu, sistem pra-rumah sakit juga mencakup koordinasi antara petugas lapangan dengan fasilitas kesehatan tujuan agar rumah sakit dapat mempersiapkan diri sebelum pasien tiba.

3. Sistem Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat

IGD merupakan unit pelayanan rumah sakit yang memberikan penanganan awal kepada pasien dengan kondisi akut atau kritis yang memerlukan tindakan segera. Pelayanan di IGD bersifat cepat, tepat, dan komprehensif karena bertujuan untuk menyelamatkan nyawa pasien serta mencegah terjadinya komplikasi yang lebih serius.

Setibanya di IGD, pasien akan dilakukan pengkajian awal oleh tenaga kesehatan untuk menentukan kondisi klinis serta kebutuhan tindakan medis. Penanganan pasien di IGD biasanya mengikuti pendekatan *primary survey* (ABCDE) yang meliputi pemeriksaan jalan napas (*airway*), pernapasan (*breathing*), sirkulasi (*circulation*), status neurologis (*disability*), dan pemeriksaan menyeluruh (*exposure*).

Pelayanan di IGD melibatkan kerja sama tim kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, tenaga laboratorium, radiologi, serta tenaga kesehatan lainnya.

Kolaborasi tim sangat penting untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat sesuai dengan kondisi klinisnya.

4. Sistem Rujukan dan Koordinasi Tim

Sistem rujukan merupakan bagian penting dalam pelayanan gawat darurat yang bertujuan untuk memastikan pasien mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kebutuhan medisnya. Apabila fasilitas kesehatan tertentu tidak memiliki kemampuan atau sumber daya yang memadai untuk menangani kondisi pasien, maka pasien dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan lain yang memiliki fasilitas yang lebih lengkap.

Proses rujukan harus dilakukan dengan cepat dan terkoordinasi agar tidak menimbulkan keterlambatan dalam penanganan pasien. Komunikasi antara fasilitas kesehatan pengirim dan penerima sangat penting untuk memastikan pasien mendapatkan pelayanan yang berkelanjutan.

Selain itu, koordinasi tim kesehatan juga merupakan faktor penting dalam keberhasilan pelayanan gawat darurat. Kerja sama yang baik antara berbagai profesi kesehatan dapat meningkatkan efektivitas penanganan pasien serta mengurangi risiko kesalahan dalam pelayanan kesehatan.

5. Konsep Triase dan Prioritas Penanganan

Triase merupakan proses pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatannya untuk menentukan prioritas penanganan. Sistem triase digunakan terutama pada situasi ketika jumlah pasien yang datang melebihi kapasitas pelayanan yang tersedia.

Dalam sistem triase, pasien biasanya dikelompokkan ke dalam beberapa kategori berdasarkan tingkat keparahan kondisinya, yaitu:

- a. Triase merah (*resuscitation*): pasien dengan kondisi kritis yang memerlukan penanganan segera untuk menyelamatkan nyawa.
- b. Triase kuning (*urgent*): pasien dengan kondisi serius namun tidak langsung mengancam jiwa.
- c. Triase hijau (*non-urgent*): pasien dengan kondisi ringan yang masih dapat menunggu penanganan.
- d. Triase hitam: pasien dengan kondisi meninggal atau tidak memiliki kemungkinan untuk diselamatkan.

Penerapan sistem triase membantu tenaga kesehatan menentukan prioritas pelayanan, sehingga pasien dengan kondisi paling kritis dapat segera mendapatkan penanganan yang dibutuhkan. Sistem ini sangat penting

terutama dalam situasi darurat massal seperti kecelakaan besar atau bencana alam.

Sistem pelayanan gawat darurat merupakan rangkaian pelayanan kesehatan yang terintegrasi untuk memberikan penanganan cepat dan tepat kepada pasien dengan kondisi kegawatdaruratan. Sistem ini meliputi SPGDT, pelayanan pra-rumah sakit, pelayanan di instalasi gawat darurat, sistem rujukan, serta penerapan triase untuk menentukan prioritas penanganan pasien. Dengan adanya sistem pelayanan gawat darurat yang terorganisasi dengan baik, diharapkan keselamatan pasien dapat meningkat serta angka kematian akibat kondisi kegawatdaruratan dapat ditekan. Alur sistem penanggulangan gawat darurat terpadu dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1: Alur Sistem Penanggulangan Gawat Darurat
(Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019)

D. Konsep Dasar Pasien Safety

1. Pengertian Patient Safety

Keselamatan pasien (*patient safety*) merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menjamin bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada

pasien berlangsung secara aman dan meminimalkan risiko terjadinya cedera akibat kesalahan baik tindakan medis maupun sistem pelayanan kesehatan. Konsep keselamatan pasien menekankan pentingnya pencegahan kesalahan (*error prevention*), pelaporan insiden, pembelajaran dari kesalahan, serta penerapan sistem yang mampu mengurangi kemungkinan terjadinya kejadian yang tidak diharapkan dalam pelayanan kesehatan (WHO, 2021).

Dalam praktik pelayanan kesehatan modern, keselamatan pasien menjadi salah satu indikator utama kualitas pelayanan kesehatan. Hal ini karena berbagai penelitian menunjukkan bahwa kesalahan medis dapat menyebabkan cedera serius, bahkan kematian pada pasien. Oleh karena itu, institusi pelayanan kesehatan dituntut untuk membangun budaya keselamatan (*safety culture*) yang melibatkan seluruh tenaga kesehatan, termasuk dokter, perawat, tenaga farmasi, dan tenaga kesehatan lainnya (Vincent & Amalberti, 2016).

Di Indonesia, keselamatan pasien telah menjadi bagian penting dari sistem pelayanan kesehatan dan diatur dalam berbagai regulasi, salah satunya melalui kebijakan Kementerian Kesehatan yang menekankan pentingnya penerapan standar keselamatan pasien di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Penerapan keselamatan pasien bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan serta melindungi pasien dari risiko yang dapat terjadi selama proses pelayanan kesehatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

2. Tujuan Patient Safety

Tujuan utama penerapan keselamatan pasien adalah menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang aman bagi pasien (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022; Alquwez et al., 2021). Secara lebih rinci, tujuan keselamatan pasien meliputi:

- a. Mencegah terjadinya kesalahan dalam proses pelayanan kesehatan.
- b. Mengurangi risiko cedera atau kerugian yang dialami pasien akibat tindakan medis.
- c. Meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan.
- d. Mendorong budaya keselamatan di lingkungan pelayanan kesehatan.
- e. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Dengan adanya sistem keselamatan pasien yang baik, fasilitas kesehatan dapat memberikan pelayanan yang lebih aman, efektif, dan berkualitas bagi pasien.

3. Prinsip-Prinsip *Patient Safety*

Joint Commission International [JCI] (2023) menjelaskan bahwa penerapan keselamatan pasien dalam pelayanan kesehatan didasarkan pada beberapa prinsip penting, yaitu:

a. Identifikasi Risiko

Setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus mampu mengidentifikasi berbagai potensi risiko yang dapat membahayakan keselamatan pasien, baik yang berasal dari prosedur medis, penggunaan obat, maupun faktor lingkungan.

b. Pencegahan Kesalahan (*Error Prevention*)

Upaya pencegahan kesalahan dilakukan melalui penerapan standar prosedur operasional, penggunaan teknologi kesehatan yang aman, serta peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.

c. Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien

Tenaga kesehatan didorong untuk melaporkan setiap kejadian yang berpotensi membahayakan pasien, baik yang telah terjadi maupun yang hampir terjadi (*near miss*). Sistem pelaporan ini bertujuan menjadi sarana pembelajaran untuk meningkatkan keselamatan pasien.

d. Pembelajaran dari Kesalahan

Setiap insiden keselamatan pasien harus dianalisis untuk mengetahui penyebabnya, sehingga perbaikan sistem dapat dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

e. Budaya Keselamatan (*Safety Culture*)

Budaya keselamatan merupakan kondisi ketika seluruh tenaga kesehatan memiliki kesadaran dan komitmen untuk menjaga keselamatan pasien dalam setiap tindakan pelayanan kesehatan.

4. Peran Perawat dalam *Patient Safety*

Perawat memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan keselamatan pasien karena merupakan tenaga kesehatan yang paling sering berinteraksi langsung dengan pasien. Dalam praktiknya, perawat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tindakan keperawatan dilakukan sesuai dengan standar keselamatan yang telah ditetapkan (Potter et al., 2021).

Peran perawat dalam keselamatan pasien meliputi melakukan identifikasi pasien secara benar, memastikan pemberian obat sesuai dengan prinsip benar obat, melakukan komunikasi secara efektif dengan tim kesehatan, serta memantau kondisi pasien secara berkelanjutan. Selain itu, perawat juga

berperan dalam melaporkan insiden keselamatan pasien dan berpartisipasi dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan (Potter et al., 2021).

Dengan demikian, penerapan konsep keselamatan pasien memerlukan komitmen dan kerja sama dari seluruh tenaga kesehatan dalam sistem pelayanan kesehatan. Penerapan sistem keselamatan pasien yang baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, mengurangi risiko kesalahan medis, serta memberikan perlindungan optimal bagi pasien (Carayon et al., 2020).

E. Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)

Sasaran Keselamatan Pasien merupakan standar penting dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan serta mencegah terjadinya cedera pada pasien selama proses perawatan. Sasaran ini dikembangkan berdasarkan standar keselamatan pasien internasional dan diterapkan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan sebagai pedoman untuk memberikan pelayanan yang aman, efektif, dan berkualitas. Di Indonesia, sasaran keselamatan pasien menjadi bagian dari standar akreditasi rumah sakit dan harus diterapkan oleh seluruh tenaga kesehatan dalam praktik pelayanan sehari-hari (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022; JCI, 2023).

Penerapan sasaran keselamatan pasien bertujuan untuk meminimalkan risiko kesalahan pelayanan, meningkatkan koordinasi pelayanan kesehatan, serta memastikan bahwa setiap tindakan yang diberikan kepada pasien dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan keselamatan. Sasaran keselamatan pasien terdiri dari enam komponen utama yang harus diterapkan secara konsisten oleh seluruh tenaga Kesehatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022; JCI, 2023).

1. Ketepatan Identifikasi Pasien

Ketepatan identifikasi pasien merupakan langkah awal yang sangat penting dalam menjaga keselamatan pasien. Kesalahan identifikasi dapat menyebabkan berbagai kesalahan dalam pelayanan kesehatan, seperti pemberian obat yang salah, tindakan medis yang tidak sesuai, atau pengambilan sampel laboratorium yang keliru.

Oleh karena itu, setiap fasilitas pelayanan kesehatan diwajibkan menggunakan minimal dua identitas pasien untuk memastikan bahwa pasien yang menerima pelayanan adalah orang yang tepat. Identitas yang biasanya digunakan antara lain nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medis, atau gelang identitas pasien.

Proses identifikasi pasien harus dilakukan sebelum melakukan tindakan apa pun, seperti pemberian obat, transfusi darah, pengambilan sampel laboratorium, maupun tindakan medis lainnya. Tenaga kesehatan juga harus memastikan bahwa identitas pasien sesuai dengan dokumen rekam medis dan label yang digunakan pada obat atau spesimen.

2. Peningkatan Komunikasi yang Efektif

Komunikasi yang tidak efektif merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kesalahan dalam pelayanan kesehatan. Informasi yang tidak lengkap, tidak jelas, atau salah dipahami dapat menyebabkan kesalahan dalam diagnosis, pengobatan, maupun tindakan medis lainnya.

Untuk meningkatkan komunikasi yang efektif, tenaga kesehatan perlu menggunakan metode komunikasi yang terstruktur, seperti SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*). Metode ini membantu tenaga kesehatan menyampaikan informasi secara sistematis sehingga meminimalkan kesalahpahaman dalam komunikasi klinis.

Selain itu, setiap instruksi verbal atau melalui telepon harus dilakukan verifikasi ulang (*read back*) untuk memastikan bahwa informasi yang diterima sudah benar. Dokumentasi komunikasi juga harus dilakukan secara lengkap dalam rekam medis pasien dan ditandatangani.

3. Peningkatan Keamanan Obat yang Perlu Diwaspadai

Obat yang termasuk dalam kategori *high alert medication* merupakan obat yang memiliki risiko tinggi menyebabkan cedera serius pada pasien jika terjadi kesalahan dalam penggunaannya. Contoh obat yang termasuk dalam kategori ini antara lain insulin, heparin, obat kemoterapi, dan elektrolit konsentrat.

Untuk meningkatkan keamanan penggunaan obat tersebut, fasilitas kesehatan harus menerapkan berbagai strategi keselamatan, seperti:

- a. Penyimpanan obat berisiko tinggi secara terpisah
- b. Pelabelan khusus pada obat berisiko tinggi
- c. Verifikasi ganda oleh tenaga kesehatan sebelum pemberian obat
- d. Standarisasi prosedur pemberian obat

Perhatian terhadap obat LASA (*Look Alike Sound Alike*) atau NORUM (Nama Obat Rupa Ucapan Mirip) sangat penting untuk mencegah kesalahan pemberian obat dan meningkatkan keselamatan pasien dalam pelayanan kesehatan. Selain itu, tenaga kesehatan harus menerapkan prinsip enam benar pemberian obat, yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar cara pemberian, dan benar dokumentasi.

4. Kepastian Tepat Lokasi, Tepat Prosedur, dan Tepat Pasien Operasi

Kesalahan dalam tindakan pembedahan, seperti operasi pada pasien yang salah, lokasi yang salah, atau prosedur yang salah, merupakan kejadian yang sangat serius dalam pelayanan kesehatan. Untuk mencegah terjadinya kesalahan tersebut, fasilitas kesehatan harus menerapkan prosedur keselamatan operasi yang dikenal sebagai *Universal Protocol*.

Prosedur ini meliputi beberapa langkah penting, antara lain:

- a. Verifikasi praoperasi untuk memastikan identitas pasien, prosedur yang akan dilakukan, serta lokasi operasi.
- b. Penandaan lokasi operasi oleh tenaga medis yang akan melakukan tindakan.
- c. Pelaksanaan *time out* sebelum tindakan dimulai untuk memastikan kembali bahwa semua informasi sudah benar.

Langkah-langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa prosedur pembedahan dilakukan pada pasien yang tepat, di lokasi yang tepat, dan dengan prosedur yang benar.

5. Pengurangan Risiko Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan

Infeksi yang terjadi selama proses pelayanan kesehatan dikenal sebagai *Healthcare-Associated Infections* (HAIs). Infeksi ini dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti prosedur invasif, penggunaan alat medis, atau kurangnya penerapan prinsip pencegahan infeksi.

Upaya untuk mengurangi risiko infeksi dilakukan melalui berbagai strategi, antara lain:

- a. Penerapan enam langkah kebersihan tangan
- b. Sterilisasi dan desinfeksi alat medis
- c. Penggunaan alat pelindung diri (APD)
- d. Penerapan prosedur aseptik pada tindakan medis

Kebersihan tangan merupakan langkah paling sederhana namun sangat efektif dalam mencegah penularan infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan.

6. Pengurangan Risiko Cedera Akibat Pasien Jatuh

Pasien jatuh merupakan salah satu insiden keselamatan pasien yang sering terjadi di rumah sakit, terutama pada pasien lansia, pasien dengan gangguan mobilitas, atau pasien yang mengalami penurunan kesadaran.

Untuk mencegah kejadian jatuh, tenaga kesehatan perlu melakukan pengkajian risiko jatuh menggunakan instrumen penilaian tertentu, seperti *Morse Fall Scale* pada pasien dewasa atau *Humpty Dumpty Fall Scale* untuk

pasien anak. Berdasarkan hasil pengkajian tersebut, tenaga kesehatan dapat menentukan intervensi pencegahan yang sesuai.

Upaya pencegahan jatuh dapat meliputi:

- a. Pemasangan tanda risiko jatuh pada pasien
- b. Penggunaan pagar tempat tidur
- c. Pengawasan lebih ketat pada pasien berisiko tinggi
- d. Edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai pencegahan jatuh
- e. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut secara konsisten, risiko cedera akibat pasien jatuh dapat diminimalkan.

F. Etika dalam Keperawatan Gawat Darurat

Etika dalam keperawatan gawat darurat merupakan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi perawat dalam memberikan pelayanan kepada pasien yang mengalami kondisi akut, kritis, atau mengancam jiwa. Situasi kegawatdaruratan sering kali menuntut tindakan yang cepat dan tepat, sehingga perawat harus mampu mengambil keputusan klinis yang tidak hanya berdasarkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga mempertimbangkan aspek etika dan profesionalisme. Oleh karena itu, penerapan etika dalam keperawatan gawat darurat sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan tetap menghormati hak pasien, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta memberikan pelayanan yang aman dan bermutu (Butts & Rich, 2023).

Dalam praktik kegawatdaruratan, perawat sering menghadapi berbagai dilema etika, seperti keterbatasan waktu dalam mengambil keputusan, kondisi pasien yang tidak sadar sehingga tidak dapat memberikan persetujuan tindakan, maupun konflik antara kepentingan pasien dengan keluarga atau tim kesehatan lainnya. Situasi tersebut menuntut perawat untuk memiliki kemampuan berpikir kritis serta pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip etika keperawatan.

1. Prinsip-Prinsip Etika dalam Keperawatan

Penerapan etika dalam praktik keperawatan didasarkan pada beberapa prinsip dasar bioetika yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan klinis (Butts & Rich, 2023).

a. *Autonomy* (Otonomi)

Prinsip otonomi menekankan bahwa setiap pasien memiliki hak untuk menentukan keputusan mengenai pelayanan kesehatan yang akan diterimanya. Perawat harus menghormati keputusan pasien setelah pasien mendapatkan informasi yang cukup mengenai kondisi dan tindakan medis yang akan dilakukan. Dalam situasi gawat darurat, prinsip ini terkadang sulit

diterapkan karena pasien mungkin berada dalam kondisi tidak sadar. Dalam keadaan tersebut, tenaga kesehatan dapat mengambil keputusan terbaik demi keselamatan pasien.

b. *Beneficence* (Berbuat Baik)

Prinsip beneficence mengharuskan tenaga kesehatan untuk selalu bertindak demi kepentingan terbaik pasien. Dalam praktik kegawatdaruratan, prinsip ini tercermin dalam tindakan cepat dan tepat yang bertujuan menyelamatkan nyawa pasien serta mencegah terjadinya komplikasi yang lebih serius.

c. *Nonmaleficence* (Tidak Merugikan)

Prinsip ini menekankan bahwa tenaga kesehatan harus menghindari tindakan yang dapat membahayakan atau menyebabkan cedera pada pasien. Dalam situasi gawat darurat, perawat harus memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan memiliki manfaat yang lebih besar daripada risiko yang mungkin terjadi.

d. *Justice* (Keadilan)

Prinsip keadilan mengharuskan tenaga kesehatan memberikan pelayanan secara adil kepada semua pasien tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, agama, maupun budaya. Dalam kondisi kegawatdaruratan, prinsip ini terlihat dalam sistem triase yang menentukan prioritas penanganan pasien berdasarkan tingkat kegawatannya, bukan berdasarkan status sosial atau faktor lainnya.

2. Persetujuan Tindakan Medis dalam Situasi Gawat Darurat

Dalam pelayanan kesehatan normal, setiap tindakan medis harus didahului dengan *informed consent*, yaitu persetujuan pasien setelah mendapatkan penjelasan mengenai tindakan yang akan dilakukan. Namun, dalam kondisi gawat darurat, pasien sering kali tidak mampu memberikan persetujuan karena mengalami penurunan kesadaran atau kondisi yang mengancam jiwa (Pozgar, 2022).

Dalam situasi tersebut, tenaga kesehatan diperbolehkan melakukan tindakan medis segera tanpa persetujuan terlebih dahulu dengan tujuan menyelamatkan nyawa pasien. Prinsip ini dikenal sebagai persetujuan tersirat (*implied consent*), yaitu persetujuan yang dianggap diberikan dalam keadaan darurat untuk kepentingan keselamatan pasien (Pozgar, 2022).

3. Kerahasiaan dan Privasi Pasien Gawat Darurat

Kerahasiaan informasi pasien merupakan salah satu prinsip penting dalam etika keperawatan. Perawat memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data medis pasien dan tidak menyebarkan informasi tersebut kepada pihak yang tidak berkepentingan (Pozgar, 2022).

Dalam situasi gawat darurat, informasi mengenai kondisi pasien hanya boleh disampaikan kepada tim kesehatan yang terlibat dalam perawatan atau kepada keluarga yang berhak menerima informasi tersebut. Pelanggaran terhadap kerahasiaan pasien dapat menimbulkan masalah etika maupun hukum dalam praktik pelayanan kesehatan.

4. Dilema Etika dalam Keperawatan Gawat Darurat

Perawat di unit gawat darurat sering menghadapi berbagai dilema etika, seperti keterbatasan sumber daya, konflik keputusan antara keluarga dengan tenaga kesehatan, atau situasi ketika tindakan medis yang dilakukan tidak memberikan harapan kesembuhan yang signifikan bagi pasien (Butts & Rich, 2023).

Dalam menghadapi dilema tersebut, perawat perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi klinis pasien, nilai-nilai etika profesi, serta peraturan yang berlaku. Diskusi dengan tim kesehatan dan komite etik rumah sakit sering kali diperlukan untuk membantu menentukan keputusan yang paling tepat.

5. Peran Perawat dalam Menjaga Etika Pelayanan Gawat Darurat

Perawat memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pelayanan kegawatdaruratan tetap dilakukan sesuai dengan prinsip etika dan profesionalisme. Perawat tidak hanya bertugas memberikan tindakan medis, tetapi juga berperan sebagai advokat bagi pasien dengan memastikan hak-hak pasien tetap dihormati (Butts & Rich, 2023).

Selain itu, perawat juga harus menjaga sikap profesional saat berkomunikasi dengan pasien, keluarga, maupun tim kesehatan lainnya. Sikap empati, penghormatan terhadap martabat pasien, serta kemampuan komunikasi yang baik merupakan bagian penting dari praktik etika dalam keperawatan gawat darurat (Butts & Rich, 2023).

Dengan demikian, penerapan etika dalam keperawatan gawat darurat menjadi aspek yang sangat penting untuk menjaga kualitas pelayanan

kesehatan. Prinsip-prinsip etika membantu tenaga kesehatan dalam mengambil keputusan yang tepat dalam situasi kritis serta memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan tetap menghormati nilai kemanusiaan dan keselamatan pasien.

G. Aspek Legal dalam Pelayanan Gawat Darurat

Aspek legal dalam pelayanan gawat darurat merupakan landasan hukum yang mengatur kewenangan, tanggung jawab, serta perlindungan bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien dengan kondisi darurat. Dalam praktik pelayanan kesehatan, khususnya dalam situasi kegawatdaruratan, tenaga kesehatan dituntut untuk melakukan tindakan secara cepat dan tepat untuk menyelamatkan nyawa pasien. Namun demikian, setiap tindakan medis dan keperawatan tetap harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari (Pozgar, 2022).

Pelayanan gawat darurat memiliki karakteristik yang berbeda dengan pelayanan kesehatan pada umumnya karena tindakan harus dilakukan segera untuk mencegah kematian atau kecacatan pada pasien. Oleh karena itu, berbagai regulasi telah ditetapkan untuk memberikan pedoman bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga kesehatan.

1. Dasar Hukum Pelayanan Gawat Darurat

Di Indonesia, pelayanan gawat darurat diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan menjamin keselamatan pasien dan memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan. Salah satu dasar hukum yang penting adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Selain itu, rumah sakit memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan gawat darurat kepada setiap pasien yang membutuhkan tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun kemampuan membayar.

Pelayanan gawat darurat di Indonesia juga didukung oleh sistem Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) yang diatur oleh Kementerian Kesehatan untuk memastikan adanya koordinasi antara pelayanan pra-rumah sakit, pelayanan di rumah sakit, serta sistem rujukan sehingga penanganan pasien dapat dilakukan secara cepat dan efektif (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019).

2. Kewajiban Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Gawat Darurat

Tenaga kesehatan, termasuk perawat, memiliki kewajiban hukum untuk memberikan pertolongan kepada pasien yang mengalami kondisi kegawatdaruratan. Kewajiban ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap tenaga kesehatan harus mengutamakan keselamatan pasien serta memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.

Dalam praktik keperawatan, perawat harus memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Tindakan keperawatan yang dilakukan harus mengikuti standar praktik keperawatan serta mempertimbangkan kondisi klinis pasien. Dokumentasi tindakan yang dilakukan juga menjadi bagian penting dalam aspek legal karena dapat menjadi bukti bahwa pelayanan telah diberikan sesuai dengan prosedur yang berlaku (Butts & Rich, 2023).

Selain itu, tenaga kesehatan harus memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan bertujuan untuk menyelamatkan nyawa pasien dan tidak melanggar hak-hak pasien. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum baik secara administratif, perdata, maupun pidana.

3. Tanggung Jawab Hukum Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Gawat Darurat

Dalam memberikan pelayanan gawat darurat, tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab hukum terhadap tindakan yang dilakukan. Tanggung jawab tersebut meliputi tanggung jawab profesional, etika, serta hukum. Tenaga kesehatan harus memastikan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medis, dan standar prosedur operasional yang berlaku.

Apabila terjadi kesalahan dalam pelayanan kesehatan yang menyebabkan kerugian pada pasien, maka tenaga kesehatan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Oleh karena itu, penting bagi tenaga kesehatan untuk selalu bekerja sesuai dengan kompetensi, mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, serta melakukan dokumentasi yang lengkap dan akurat terhadap setiap tindakan yang dilakukan.

4. Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan Pelayanan Gawat Darurat

Selain memiliki kewajiban hukum, tenaga kesehatan juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya. Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang telah

melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar profesi dan prosedur yang berlaku.

Perlindungan ini penting karena tenaga kesehatan pelayanan gawat sering kali harus mengambil keputusan cepat dalam situasi kritis yang dapat menimbulkan risiko tertentu. Dengan adanya perlindungan hukum, tenaga kesehatan dapat menjalankan tugasnya secara profesional tanpa rasa takut terhadap konsekuensi hukum yang tidak berdasar (WHO, 2021).

5. Pentingnya Dokumentasi dalam Aspek Legal Pelayanan Gawat Darurat

Dokumentasi merupakan bagian yang sangat penting dalam aspek legal pelayanan kesehatan gawat darurat. Catatan medis yang lengkap dan akurat dapat menjadi bukti bahwa tenaga kesehatan telah memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang berlaku.

Dalam pelayanan gawat darurat, dokumentasi harus mencakup identitas pasien, kondisi pasien saat datang, tindakan yang dilakukan, obat yang diberikan, serta respons pasien terhadap tindakan tersebut. Dokumentasi yang baik tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi antar tenaga kesehatan, tetapi juga sebagai bukti hukum apabila terjadi masalah dalam pelayanan kesehatan.

Aspek legal dalam pelayanan gawat darurat merupakan komponen penting yang mengatur pelaksanaan pelayanan kesehatan agar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemahaman mengenai aspek legal sangat penting bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat, agar dapat memberikan pelayanan secara profesional, aman, dan sesuai dengan standar hukum. Dengan memahami aspek legal, tenaga kesehatan dapat melindungi hak pasien sekaligus menjaga profesionalitas dan tanggung jawab dalam praktik pelayanan kesehatan.

H. Prinsip Keselamatan pada Layanan Gawat Darurat

Prinsip keselamatan pada layanan gawat darurat merupakan dasar penting dalam penyelenggaraan pelayanan emergensi yang cepat, tepat, aman, dan berorientasi pada penyelamatan nyawa pasien. Unit gawat darurat memiliki karakteristik pelayanan dengan kondisi pasien yang kritis, keputusan klinis yang harus diambil secara cepat, serta risiko tinggi terjadinya kesalahan medis akibat situasi yang kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, penerapan *patient safety* menjadi komponen utama dalam meningkatkan mutu pelayanan gawat darurat dan mencegah terjadinya cedera maupun kematian pasien akibat kesalahan pelayanan (WHO, 2021).

Keselamatan pasien di instalasi gawat darurat menekankan pentingnya pendekatan sistematis dalam mengurangi risiko kesalahan, meningkatkan ketepatan tindakan, memperkuat komunikasi tim, serta memastikan setiap prosedur dilakukan sesuai standar kegawatdaruratan. Pendekatan ini mencakup manajemen risiko, pencegahan *medical error*, sistem pelaporan insiden, peningkatan mutu berkelanjutan, dan kolaborasi tim multidisiplin dalam situasi emergensi.

1. Manajemen Risiko pada Layanan Gawat Darurat

Manajemen risiko dalam layanan gawat darurat merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan berbagai potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan pasien dalam kondisi emergensi. Risiko di unit gawat darurat dapat berasal dari keterlambatan triase, kesalahan identifikasi pasien, *medication error*, kegagalan alat resusitasi, *overload* pasien, hingga komunikasi yang tidak efektif antar tenaga kesehatan (Vincent & Amalberti, 2016).

Proses manajemen risiko meliputi identifikasi risiko, analisis tingkat keparahan, evaluasi prioritas risiko, dan penerapan strategi pengendalian yang sesuai dengan kondisi kegawatdaruratan. Dalam praktiknya, penerapan standar operasional prosedur (SOP), penggunaan sistem triase yang tepat, pengecekan alat emergensi secara rutin, serta simulasi kegawatdaruratan menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko insiden di instalasi gawat darurat.

Penerapan manajemen risiko yang baik dapat membantu tenaga kesehatan memberikan pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan aman sehingga mampu meningkatkan keselamatan pasien pada kondisi kritis (Vincent & Amalberti, 2016).

2. Pencegahan Kesalahan Medis (*Medical Error Prevention*)

Kesalahan medis di layanan gawat darurat dapat terjadi akibat tekanan waktu, kondisi pasien yang tidak stabil, tingginya beban kerja, maupun komunikasi yang kurang efektif. Kesalahan tersebut dapat berupa kesalahan diagnosis, kesalahan pemberian obat, keterlambatan tindakan resusitasi, maupun kesalahan prosedur tindakan invasif (Agency for Healthcare Research and Quality [AHRQ], 2023).

Upaya pencegahan kesalahan medis di unit gawat darurat dilakukan melalui penerapan prinsip patient safety, penggunaan komunikasi efektif seperti SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*), *double check*

obat emergensi, identifikasi pasien secara tepat, serta penerapan prinsip enam benar pemberian obat.

Perhatian khusus juga diperlukan terhadap obat LASA (*Look Alike Sound Alike*) atau NORUM (Nama Obat Rupa Ucapan Mirip) karena kondisi emergensi dapat meningkatkan risiko tertukarnya obat akibat kemiripan nama maupun kemasan. Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus melakukan verifikasi secara teliti sebelum pemberian obat untuk mencegah medication error dan menjaga keselamatan pasien gawat darurat (AHRQ, 2023).

3. Sistem Pelaporan Insiden pada Unit Gawat Darurat

Sistem pelaporan insiden di unit gawat darurat merupakan mekanisme penting dalam mendeteksi, melaporkan, dan mengevaluasi kejadian yang berkaitan dengan keselamatan pasien. Insiden yang sering terjadi di layanan emergensi meliputi keterlambatan penanganan, kesalahan triase, kesalahan pemberian obat, kegagalan komunikasi, hingga kejadian sentinel seperti henti jantung yang tidak tertangani dengan tepat (WHO, 2021).

Pelaporan insiden bertujuan untuk mengidentifikasi akar masalah (root cause analysis) sehingga dapat dilakukan perbaikan sistem pelayanan secara menyeluruh. Sistem pelaporan yang efektif juga membantu organisasi pelayanan kesehatan mengembangkan strategi pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang Kembali (WHO, 2021).

Agar pelaporan berjalan optimal, budaya keselamatan di unit gawat darurat harus mendukung pendekatan non-punitive reporting system, yaitu pelaporan yang berfokus pada evaluasi sistem dan peningkatan mutu pelayanan, bukan mencari kesalahan individu (WHO, 2021).

4. Continuous Quality Improvement (CQI) pada Pelayanan Gawat Darurat

Continuous Quality Improvement (CQI) pada layanan gawat darurat merupakan upaya peningkatan mutu pelayanan secara terus-menerus melalui evaluasi dan perbaikan sistem pelayanan emergensi. Peningkatan mutu sangat penting karena pelayanan gawat darurat menuntut kecepatan respon, ketepatan tindakan, dan koordinasi yang optimal dalam menyelamatkan pasien (JCI, 2023).

CQI dapat dilakukan melalui audit respon time, evaluasi keberhasilan resusitasi, monitoring kepatuhan penggunaan SOP emergensi, evaluasi insiden

keselamatan pasien, serta pelaksanaan simulasi kode biru dan disaster drill secara berkala (JCI, 2023).

Melalui pendekatan CQI, instalasi gawat darurat dapat mengidentifikasi kelemahan pelayanan, meningkatkan efisiensi penanganan pasien, memperbaiki sistem komunikasi tim, serta meningkatkan kualitas pelayanan kegawatdaruratan secara berkelanjutan (JCI, 2023).

5. Kolaborasi Tim dalam Meningkatkan Keselamatan Pasien Gawat Darurat

Keselamatan pasien di layanan gawat darurat sangat bergantung pada kolaborasi tim multidisiplin karena penanganan pasien kritis membutuhkan kerja sama cepat dan terkoordinasi antara dokter, perawat, tenaga farmasi, laboratorium, radiologi, dan tenaga kesehatan lainnya (Potter et al., 2021).

Kolaborasi tim yang efektif ditandai dengan komunikasi yang jelas, pembagian tugas yang tepat, saling menghargai kompetensi profesi, serta kemampuan mengambil keputusan secara cepat dalam situasi kritis. Dalam kondisi emergensi seperti henti jantung, trauma berat, syok, atau kegagalan napas, kerja sama tim yang baik sangat menentukan keberhasilan penyelamatan pasien (Potter et al., 2021).

Pendekatan kolaboratif juga membantu meminimalkan kesalahan medis karena setiap anggota tim dapat melakukan verifikasi tindakan, memberikan masukan klinis, dan memastikan setiap intervensi dilakukan secara aman sesuai standar pelayanan gawat darurat (WHO, 2021).

Prinsip keselamatan pada layanan gawat darurat merupakan bagian penting dalam menciptakan pelayanan emergensi yang aman, cepat, efektif, dan berkualitas. Penerapan manajemen risiko, pencegahan kesalahan medis, sistem pelaporan insiden, peningkatan mutu berkelanjutan, serta kolaborasi tim multidisiplin menjadi faktor utama dalam meningkatkan keselamatan pasien dan keberhasilan penanganan kondisi kegawatdaruratan (WHO, 2021).

I. Latihan Soal

1. Ujian tulis (essay terstruktur dan CBT)

Soal Essay Terstruktur (4 Soal)

1. Jelaskan konsep dasar keperawatan gawat darurat dengan menguraikan:
 - a. Pengertian keperawatan gawat darurat
 - b. Karakteristik pasien gawat darurat
 - c. Tujuan pelayanan gawat darurat

2. Jelaskan sistem pelayanan gawat darurat dengan menguraikan:
 - a. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
 - b. Pelayanan pra-rumah sakit
 - c. Sistem rujukan dalam pelayanan gawat darurat
3. Jelaskan sasaran keselamatan pasien (SKP) dalam pelayanan kesehatan!
4. Kasus:

Seorang laki-laki, 60 tahun datang ke IGD dengan penurunan kesadaran. Perawat langsung memberikan obat injeksi tanpa melakukan identifikasi pasien secara lengkap dan tanpa berkomunikasi dengan tim medis. Setelah itu diketahui bahwa pasien memiliki riwayat alergi terhadap obat yang telah diberikan. Apa saja prinsip keselamatan pasien yang dilanggar

Soal Multiple Choice (6 Soal)

5. Seorang laki-laki 45 tahun, datang ke IGD dengan keluhan sesak napas berat. Perawat segera memeriksa jalan napas pasien sebagai prioritas pertama. Apakah pendekatan yang harus digunakan perawat?
 - a. SOAP
 - b. ABCDE
 - c. SBAR
 - d. PQRST
 - e. ISBAR
6. Seorang perempuan datang ke IGD setelah kecelakaan lalu lintas dengan perdarahan hebat dan penurunan kesadaran. Apakah kategori pasien tersebut dalam sistem triase?
 - a. Hijau
 - b. Kuning
 - c. Merah
 - d. Hitam
 - e. Biru
7. Perawat akan memberikan obat kepada pasien. Sebelum memberikan obat, perawat memeriksa identitas pasien menggunakan dua identitas. Apakah konsep yang sedang diterapkan perawat?
 - a. Etika keperawatan
 - b. Prinsip legal
 - c. Sasaran keselamatan pasien
 - d. Triase
 - e. Manajemen risiko

8. Seorang laki-laki 40 tahun, tidak sadar datang ke IGD dan membutuhkan tindakan segera untuk menyelamatkan nyawa. Tim medis melakukan tindakan ke pasien tanpa persetujuan pasien dan keluarga. Prinsip etik apakah yang sedang diterapkan?
- Autonomy*
 - Beneficence*
 - Implied consent*
 - Justice*
 - Malpractice*
9. Seorang perawat melaporkan kejadian hampir cedera akibat kesalahan pemberian obat kepada sistem pelaporan insiden rumah sakit. Apakah tindakan yang sedang dilakukan perawat?
- Manajemen risiko
 - Sistem triase
 - Patient safety*
 - Resusitasi
 - Diagnosis medis
10. Dalam pelayanan gawat darurat, koordinasi antara ambulans, PSC 119, dan rumah sakit merupakan bagian dari sistem...
- Triage system*
 - SPGDT
 - CQI
 - Patient centered care*
 - Primary survey*

Kunci Jawaban

Soal 1

- Keperawatan gawat darurat adalah pelayanan keperawatan profesional kepada pasien dengan kondisi akut, kritis, atau mengancam nyawa yang membutuhkan tindakan segera untuk mencegah kematian atau kecacatan permanen.
- Karakteristik pasien gawat darurat:
 - Gangguan jalan napas (airway)
 - Gangguan pernapasan (breathing)
 - Gangguan sirkulasi (circulation)
 - Penurunan kesadaran (disability)
 - Trauma atau cedera berat
- Tujuan pelayanan gawat darurat:

- 1) Menyelamatkan nyawa pasien
- 2) Mencegah kecacatan permanen
- 3) Menstabilkan kondisi pasien
- 4) Mengurangi morbiditas dan mortalitas

Skala Penilaian

Skor	Kriteria
4	Menjelaskan semua poin dengan lengkap dan benar
3	Menjelaskan sebagian besar poin dengan benar
2	Menjelaskan sebagian kecil poin
1	Jawaban sangat terbatas / kurang tepat

Soal 2

- a. SPGDT adalah sistem pelayanan kegawatdaruratan yang terintegrasi mulai dari masyarakat, pra-rumah sakit, transportasi medis, hingga pelayanan di rumah sakit.
- b. Pelayanan pra-rumah sakit meliputi pertolongan pertama di lokasi kejadian, stabilisasi kondisi pasien, serta transportasi menuju fasilitas kesehatan.
- c. Sistem rujukan adalah proses pemindahan pasien ke fasilitas kesehatan yang lebih mampu menangani kondisi pasien.

Skala Penilaian

Skor	Kriteria
4	Semua komponen dijelaskan lengkap
3	Sebagian besar dijelaskan dengan benar
2	Penjelasan terbatas
1	Tidak sesuai

Soal 3

Sasaran keselamatan pasien (SKP) dalam pelayanan kesehatan adalah:

- a. Ketepatan identifikasi pasien
- b. Peningkatan komunikasi efektif
- c. Keamanan obat berisiko tinggi
- d. Tepat pasien, lokasi, dan prosedur operasi
- e. Pengurangan risiko infeksi
- f. Pengurangan risiko pasien jatuh

Skala Penilaian

Skor	Kriteria
------	----------

- 4 Menyebut 5-6 Jawaban benar
- 3 Menyebut 3-4 Jawaban benar
- 2 Menyebutkan 1-2 Jawaban benar
- 1 Tidak bisa menyebutkan Jawaban benar

Soal 4

Prinsip yang dilanggar:

- a. Ketepatan identifikasi pasien
- b. Komunikasi efektif
- c. Keamanan pemberian obat (high alert / 6 benar obat)
- d. Pencegahan kesalahan medis

Skala Penilaian

Skor	Kriteria
4	Menyebutkan 4 prinsip yang dilanggar
3	Menyebutkan 3 prinsip yang dilanggar
2	Menyebutkan 2 prinsip yang dilanggar
1	Menyebutkan 1 prinsip yang dilanggar

No 5 Jawaban: b

Pembahasan:

Pendekatan ABCDE digunakan dalam penanganan pasien gawat darurat untuk menilai airway, breathing, circulation, disability, dan exposure.

No 6 Jawaban: c

Pembahasan:

Triase merah diberikan kepada pasien dengan kondisi kritis yang memerlukan penanganan segera untuk menyelamatkan nyawa.

No 7. Jawaban: c

Pembahasan:

Ketepatan identifikasi pasien merupakan salah satu Sasaran Keselamatan Pasien (SKP).

No 8. Jawaban: c

Pembahasan:

Implied consent adalah persetujuan yang dianggap diberikan dalam kondisi darurat untuk menyelamatkan nyawa pasien.

No 9. Jawaban: c

Pembahasan:

Pelaporan insiden merupakan bagian dari sistem keselamatan pasien untuk mencegah kejadian serupa.

No 10. Jawaban: b

Pembahasan:

SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu) mengintegrasikan pelayanan pra-rumah sakit, transportasi medis, dan rumah sakit.

J. Ringkasan

Pelayanan gawat darurat merupakan bagian penting dalam sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan memberikan pertolongan segera kepada pasien dengan kondisi yang mengancam nyawa, fungsi organ, atau berisiko menimbulkan kecacatan permanen. Pelayanan ini harus dilakukan secara cepat, tepat, akurat, dan terkoordinasi. Instalasi Gawat Darurat (IGD) menjadi pintu masuk utama bagi pasien kritis, sehingga tenaga kesehatan, khususnya perawat, dituntut untuk mampu melakukan pengkajian cepat, menentukan prioritas melalui triase, dan memberikan intervensi segera.

Keselamatan pasien (*patient safety*) merupakan prinsip fundamental dalam pelayanan kesehatan yang bertujuan mencegah cedera akibat kesalahan tindakan, kelalaian, maupun kegagalan sistem. Dalam pelayanan gawat darurat, risiko kesalahan lebih tinggi karena kondisi pasien yang kritis, tekanan waktu, beban kerja yang tinggi, dan kompleksitas tindakan. Oleh sebab itu, penerapan keselamatan pasien harus menjadi budaya kerja yang melekat dalam setiap tindakan pelayanan.

Perawat memiliki peran strategis di IGD sebagai pemberi asuhan, pengambil keputusan klinis, advokat pasien, komunikator, edukator, dan dokumentator. Dalam situasi gawat darurat, perawat tidak hanya dituntut memiliki keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, komunikasi efektif, pemahaman etika, aspek legal, dan prinsip keselamatan layanan.

Keperawatan gawat darurat adalah pelayanan keperawatan profesional bagi pasien dengan kondisi akut, kritis, atau mengancam jiwa yang membutuhkan tindakan segera untuk mencegah kematian atau kecacatan permanen. Penanganan pasien gawat darurat dilakukan dengan pendekatan sistematis, terutama menggunakan metode ABCDE (*Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure*). Prinsip dasar penanganannya meliputi kecepatan dan ketepatan tindakan, penentuan prioritas melalui triase, stabilisasi fungsi vital, kerja sama tim, komunikasi yang efektif, dan keselamatan pasien.

Sistem pelayanan gawat darurat merupakan rangkaian pelayanan yang terintegrasi mulai dari tempat kejadian hingga rumah sakit. Sistem ini meliputi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), pelayanan pra-rumah sakit, pelayanan di IGD, sistem rujukan, dan triase. SPGDT berfungsi untuk mengintegrasikan masyarakat, layanan ambulans, transportasi medis, rumah sakit,

dan pusat komunikasi darurat seperti PSC 119. Tujuannya adalah untuk menjamin respons cepat, kesinambungan pelayanan, dan koordinasi antarfasilitas kesehatan.

Pelayanan pra-rumah sakit mencakup pertolongan pertama, stabilisasi awal, dan transportasi pasien ke fasilitas kesehatan. Pelayanan di IGD berfokus pada pengkajian awal, stabilisasi, resusitasi, observasi, tindakan diagnostik awal, dan koordinasi pelayanan lanjutan. Sistem rujukan diperlukan apabila fasilitas kesehatan tingkat awal tidak mampu menangani kondisi pasien secara optimal. Di sisi lain, triase digunakan untuk menentukan prioritas penanganan pasien berdasarkan tingkat kegawatannya, yaitu kategori merah, kuning, hijau, dan hitam.

Konsep dasar patient safety menekankan bahwa pelayanan kesehatan harus diberikan secara aman dengan meminimalkan risiko terjadinya cedera. Tujuan utamanya adalah mencegah kesalahan, mengurangi risiko cedera, meningkatkan mutu pelayanan, membangun budaya keselamatan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Prinsip-prinsip keselamatan pasien meliputi identifikasi risiko, pencegahan kesalahan, pelaporan insiden, pembelajaran dari kesalahan, dan penguatan budaya keselamatan.

Penerapan keselamatan pasien diwujudkan melalui Sasaran Keselamatan Pasien (SKP), yaitu ketepatan identifikasi pasien, peningkatan komunikasi efektif, keamanan obat yang perlu diwaspadai, kepastian tepat pasien-lokasi-prosedur operasi, pengurangan risiko infeksi, dan pengurangan risiko pasien jatuh. Sasaran ini menjadi standar penting dalam pelayanan kesehatan dan harus diterapkan secara konsisten oleh seluruh tenaga kesehatan.

Dalam konteks etika, keperawatan gawat darurat didasarkan pada prinsip otonomi, beneficence, nonmaleficence, dan justice. Situasi darurat sering menimbulkan dilema etika, misalnya ketika pasien tidak sadar sehingga tidak dapat memberikan persetujuan tindakan. Dalam kondisi seperti itu, tindakan dapat dilakukan berdasarkan prinsip *implied consent* untuk menyelamatkan nyawa pasien. Perawat juga wajib menjaga kerahasiaan, privasi, dan martabat pasien serta bertindak profesional dalam situasi yang penuh tekanan.

Dari aspek legal, pelayanan gawat darurat harus dilaksanakan sesuai dengan hukum, standar profesi, dan SOP yang berlaku. Tenaga kesehatan memiliki kewajiban untuk memberikan pertolongan, tetapi juga memiliki hak atas perlindungan hukum selama bekerja sesuai dengan kompetensi dan prosedur yang berlaku. Dokumentasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu menjadi bagian penting dalam aspek legal karena berfungsi sebagai alat komunikasi sekaligus sebagai bukti hukum.

Prinsip keselamatan layanan kesehatan menekankan pentingnya pendekatan sistem dalam mengurangi risiko dan meningkatkan mutu pelayanan. Prinsip ini

mencakup manajemen risiko, pencegahan kesalahan medis, sistem pelaporan insiden, Continuous Quality Improvement (CQI), dan kolaborasi tim. Manajemen risiko membantu mengenali dan mengendalikan potensi bahaya, sedangkan pelaporan insiden memungkinkan organisasi belajar dari kesalahan tanpa budaya saling menyalahkan. CQI dilakukan untuk memperbaiki mutu pelayanan secara berkelanjutan, dan kolaborasi tim menjadi kunci penting dalam meningkatkan keselamatan pasien, terutama di lingkungan gawat darurat yang kompleks.

Secara keseluruhan, konsep dasar keperawatan gawat darurat dan patient safety menegaskan bahwa pelayanan kepada pasien kritis harus dilakukan secara cepat, tepat, aman, etis, legal, dan terkoordinasi. Perawat memegang peran sentral dalam memastikan bahwa setiap tindakan tidak hanya berorientasi pada penyelamatan jiwa, tetapi juga pada perlindungan pasien dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

K. Glosarium

ABCDE: Pendekatan sistematis dalam pengkajian pasien gawat darurat yang meliputi *Airway*, *Breathing*, *Circulation*, *Disability*, dan *Exposure*.

Advokat Pasien: Peran perawat dalam melindungi hak, kepentingan, dan keselamatan pasien selama proses pelayanan kesehatan.

Aspek Legal: Ketentuan hukum yang mengatur kewenangan, tanggung jawab, hak, dan perlindungan tenaga kesehatan dalam pelayanan.

Beneficence: Prinsip etika yang menekankan bahwa tenaga kesehatan harus bertindak demi kebaikan dan kepentingan terbaik pasien.

Caregiver: Peran perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan secara langsung kepada pasien.

Continuous Quality Improvement (CQI): Pendekatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara terus-menerus melalui evaluasi dan perbaikan sistem.

Disability: Penilaian status neurologis, seperti tingkat kesadaran, respons pupil, dan fungsi saraf.

Emergency: Keadaan darurat yang membutuhkan pertolongan cepat untuk mencegah kondisi memburuk.

Etika Keperawatan: Prinsip moral yang menjadi pedoman perawat dalam bersikap dan bertindak profesional.

Exposure: Pemeriksaan menyeluruh pada tubuh pasien untuk menemukan cedera, luka, perdarahan, atau tanda klinis lain.

High Alert Medication: Obat dengan risiko tinggi menimbulkan cedera serius bila terjadi kesalahan dalam pemberian.

Implied Consent: Persetujuan yang dianggap ada dalam situasi darurat ketika pasien tidak dapat memberikan persetujuan langsung dan tindakan harus segera dilakukan untuk menyelamatkan nyawa.

Informed Consent: Persetujuan pasien setelah menerima penjelasan lengkap tentang tindakan medis atau keperawatan yang akan dilakukan.

Insiden Keselamatan Pasien: Kejadian yang dapat atau telah menyebabkan cedera pada pasien akibat proses pelayanan kesehatan.

Justice: Prinsip etika yang menekankan pemberian pelayanan secara adil tanpa diskriminasi.

Kejadian Nyaris Cedera (KNC): Insiden yang belum sampai mencederai pasien, tetapi berpotensi menimbulkan bahaya.

Kejadian Sentinel: Insiden serius yang menyebabkan kematian, cedera berat, atau risiko besar terhadap keselamatan pasien.

Komunikasi Efektif: Penyampaian informasi secara jelas, tepat, lengkap, dan dapat dipahami untuk mencegah kesalahan pelayanan.

Malpraktik: Tindakan tenaga kesehatan yang tidak sesuai standar profesi atau prosedur sehingga menimbulkan kerugian pada pasien.

Manajemen Risiko: Proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat membahayakan pasien.

Medical Error: Kesalahan dalam proses pelayanan kesehatan yang dapat menyebabkan atau berpotensi menyebabkan cedera pada pasien.

Nonmaleficence: Prinsip etika yang menekankan kewajiban tenaga kesehatan untuk tidak merugikan pasien.

Otonomi: Hak pasien untuk menentukan pilihan dan keputusan terkait pelayanan kesehatannya.

Patient Safety (Keselamatan Pasien): Sistem yang bertujuan mencegah cedera pada pasien akibat kesalahan tindakan, kelalaian, atau kegagalan sistem pelayanan.

Pelayanan Pra-Rumah Sakit (*Prehospital Care*): Pelayanan darurat yang diberikan sebelum pasien tiba di fasilitas kesehatan, seperti pertolongan pertama, stabilisasi, dan transportasi.

Perawat Gawat Darurat: Perawat yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani pasien dengan kondisi akut, kritis, atau mengancam jiwa.

Primary Survey: Pengkajian awal secara cepat untuk menilai dan menangani gangguan yang mengancam nyawa dengan pendekatan ABCDE.

Prioritas Penanganan: Urutan pemberian tindakan berdasarkan tingkat keparahan kondisi pasien.

PSC 119 (*Public Safety Center 119*): Pusat layanan komunikasi dan koordinasi kegawatdaruratan di Indonesia.

RJP (Resusitasi Jantung Paru): Tindakan darurat untuk mempertahankan sirkulasi dan pernapasan pada pasien henti jantung atau henti napas.

Resusitasi: Upaya penyelamatan jiwa untuk mengembalikan fungsi vital pasien.

Rujukan: Pemindahan pasien ke fasilitas kesehatan lain yang lebih mampu menangani kondisi pasien.

Safety Culture (Budaya Keselamatan): Nilai, sikap, dan perilaku dalam organisasi yang mendukung keselamatan pasien sebagai prioritas utama.

SBAR: Metode komunikasi terstruktur yang terdiri dari Situation, Background, Assessment, dan Recommendation.

Secondary Survey: Pengkajian lanjutan yang dilakukan setelah kondisi vital pasien stabil untuk menemukan masalah tambahan.

Sistem Pelaporan Insiden: Mekanisme pelaporan kejadian keselamatan pasien untuk dianalisis dan dijadikan dasar perbaikan sistem.

SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu): Sistem pelayanan kegawatdaruratan yang terintegrasi mulai dari masyarakat, pra-rumah sakit, transportasi medis, rumah sakit, hingga sistem rujukan.

Stabilisasi: Tindakan untuk mempertahankan kondisi fisiologis pasien agar tidak memburuk.

Sasaran Keselamatan Pasien (SKP): Standar utama keselamatan pasien yang meliputi identifikasi pasien, komunikasi efektif, keamanan obat, keselamatan operasi, pencegahan infeksi, dan pencegahan pasien jatuh.

Time Out: Pemeriksaan ulang bersama tim sebelum tindakan operasi untuk memastikan pasien, prosedur, dan lokasi tindakan sudah benar.

Triase: Proses memilah pasien berdasarkan tingkat kegawatan untuk menentukan prioritas pelayanan.

Universal Protocol: Prosedur keselamatan untuk mencegah salah pasien, salah prosedur, dan salah lokasi operasi.

L. Daftar Pustaka

- Agency for Healthcare Research and Quality. (2023). Patient safety primer. AHRQ.
- Alquwez, N., Cruz, J. P., Alotaibi, R. S., Alshammari, F., & Al-Ghabeesh, S. (2021). Nurses' patient safety competence and its relationship to patient safety culture: A cross-sectional study. *Journal of Nursing Care Quality*, 36(3), 262–268. <https://doi.org/10.1097/NCQ.0000000000000520>

- American College of Emergency Physicians. (2021). *Emergency department planning and resource guidelines*. ACEP.
- Butts, J. B., & Rich, K. L. (2023). *Nursing ethics: Across the curriculum and into practice* (5th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Carayon, P., Wooldridge, A., Hose, B. Z., Salwei, M., & Benneyan, J. (2020). Challenges and opportunities for improving patient safety through human factors and systems engineering. *BMJ Quality & Safety*, 29(9), 699–701. <https://doi.org/10.1136/bmjqs-2020-011125>
- Cherry, B., & Jacob, S. R. (2023). *Contemporary nursing: Issues, trends, & management* (9th ed.). Elsevier.
- Emergency Nurses Association. (2022). *Emergency nursing: Scope and standards of practice* (2nd ed.). ENA.
- Joint Commission International. (2023). *Joint Commission International accreditation standards for hospitals* (8th ed.). Joint Commission Resources.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Pedoman sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Standar keselamatan pasien di rumah sakit*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. (2021). *Fundamentals of nursing* (10th ed.). Elsevier.
- Pozgar, G. D. (2022). *Legal and ethical issues for health professionals* (6th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Tintinalli, J. E., Ma, O., Yealy, D., Meckler, G., Stapczynski, J., Cline, D., & Thomas, S. (2020). *Tintinalli's emergency medicine: A comprehensive study guide* (9th ed.). McGraw-Hill.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Vincent, C., & Amalberti, R. (2016). *Safer healthcare: Strategies for the real world*. Springer.
- WHO. (2020). *Emergency care systems for universal health coverage: Ensuring timely care for the acutely ill and injured*. WHO.
- WHO. (2021). *Emergency care systems framework*. WHO.
- WHO. (2021). *Global patient safety action plan 2021–2030: Towards eliminating avoidable harm in health care*. WHO.

BAB 2

SISTEM TRIAGE DAN MANAJEMEN ALUR PASIEN DI INSTALASI GAWAT DARURAT

CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-2	Mampu melakukan triage, manajemen alur pasien, dan prioritas pelayanan berbasis tingkat kegawatan.	CPMK-2; CPMK-3
CPL-6	Mampu melakukan komunikasi tim, handover, dokumentasi, evaluasi luaran, dan refleksi perbaikan mutu layanan gawat darurat.	CPMK-2; CPMK-7; CPMK-6

CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-2	Melakukan triage dan manajemen alur pasien IGD secara sistematis serta mendokumentasikan keputusan dan prioritas layanan.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 2. Sistem Triage dan Manajemen Alur Pasien IGD	2.1 Menentukan kategori triage dan prioritas pelayanan berdasarkan data awal kasus.	2.2 Menyusun keputusan alur layanan dan dokumentasi triage untuk kesinambungan pelayanan.	CPMK-2	CPMK-3; CPMK-7

Tabel Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-2	OSCE triage + checklist	Akurasi kategori triage (persentase kasus tepat) dan kelengkapan dokumentasi keputusan triage.	15	Checklist OSCE; lembar triage

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Akurasi kategori triage (persentase kasus tepat)	≤60% tepat	61–75% tepat	76–90% tepat	>90% tepat
2.2 Kelengkapan dokumentasi keputusan triage	Banyak komponen hilang; tidak dapat ditindaklanjuti	Komponen inti ada; masih ada kekurangan bermakna	Lengkap; kekurangan minor	Sangat lengkap, ringkas, jelas; tanpa kekurangan bermakna

Uraian Materi

A. Definisi *Triage*

Triage berasal dari bahasa Perancis yaitu "trier" yang berarti memilih. *Triage* dan *initial assessment* merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang berfungsi untuk mendeteksi secara dini dan mencegah kondisi yang mengancam kehidupan. Dapat disimpulkan bahwa *triage* merupakan sebuah kegiatan pengelompokan atau penggolongan pasien berdasarkan tingkat kegawatannya. Florence Nightingale menggunakan konsep *triage* selama perang crime dengan cara memilah korban perang yang mungkin atau tidak mungkin bertahan hidup dan memerlukan perawatan lebih lanjut. Pada tahun 1960 *triage* mulai berkembang dan dilakukan di unit gawat darurat. Awalnya *triage* dilakukan oleh dokter atau tim yang terdiri dari dokter dan perawat, saat ini *triage* umumnya dilakukan oleh seorang perawat unit gawat darurat yang telah berpengalaman (1).

Triage didefinisikan sebagai suatu sistem seleksi dan pemilihan pasien untuk menentukan tingkat kegawatan dan prioritas penanganan pasien. *Triage* sebagai suatu konsep pengkajian yang cepat dan terfokus dengan suatu cara yang memungkinkan pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan serta fasilitas yang paling efisien dengan tujuan untuk memilih atau menggolongkan semua pasien yang memerlukan pertolongan dan memprioritaskan penanganannya (2).

B. Tujuan *Triage*

Tujuan dari tindakan *triage* adalah untuk menempatkan pasien pada tempat yang tepat sesuai dengan tingkat kegawatannya.. Menjelaskan tujuan dari *triage* yaitu untuk pengkajian pasien yang lebih awal dan singkat, penentuan dari penanganan pasien yang mendesak, mendokumentasikan temuan, mengontrol alur pasien di unit gawat darurat, menempatkan pasien pada area perawatan yang sesuai, awal dari tindakan diagnostik dan intervensi terapeutik yang terbatas, dapat mengontrol infeksi dan untuk pendidikan kesehatan bagi pasien. Ruang *triage* digunakan untuk menyeleksi pasien sesuai dengan tingkat kegawatan penyakitnya. Lokasi ruang *triage* yang ideal adalah area dekat pintu masuk pasien tetapi memungkinkan pasien dan pemeriksa mendapatkan lokasi yang tenang dan juga berdekatan dengan area perawatan akut dan resusitasi. Ruang *triage* dilengkapi oleh peralatan dasar yaitu meja, thermometer, sphygmomanometer, stetoskop dan peralatan monitoring lain seperti glucometer dan pulse oximetry, menjabarkan kriteria dari ruang *triage* yang terletak berdampingan dengan tempat perawat/dokter jaga, sehingga dapat dengan mudah mengawasi semua kegiatan di pintu

masuk, ruang tunggu, ruang tindakan dan ruang resusitasi. Dalam ruang *triage* juga tersedia kit pemeriksaan sederhana, brankar penerimaan pasien, pembuatan rekam medis khusus dan pemberian label, kapasitas ruangan hendaknya dapat memuat minimal 2 (dua) brankar (1.2).

C. Alur Pasien di IGD

Alur pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD) menggambarkan proses sistematis yang dilalui pasien sejak pertama kali datang hingga mendapatkan penanganan lanjutan atau keluar dari unit pelayanan. Alur ini dirancang untuk menjamin kecepatan, ketepatan, keselamatan, dan kontinuitas pelayanan, terutama pada kondisi kegawatan yang membutuhkan respon segera. Secara umum, alur pasien di IGD dimulai dari tahap kedatangan pasien, baik datang sendiri, diantar keluarga, maupun melalui rujukan atau layanan ambulans. Pada tahap ini dilakukan penerimaan awal dan identifikasi cepat terhadap kondisi pasien. Tahap berikutnya adalah triage, yaitu proses pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan menggunakan prinsip prioritas. Triage bertujuan memastikan pasien dengan kondisi paling kritis mendapatkan penanganan terlebih dahulu. Setelah triage, pasien akan diarahkan ke area penanganan sesuai kategori, seperti zona resusitasi (untuk kondisi mengancam nyawa), area observasi, atau area non-emergensi. Pada tahap ini dilakukan pengkajian lebih mendalam menggunakan pendekatan sistematis seperti primary survey (ABCDE: Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure) dan secondary survey untuk mengidentifikasi masalah secara komprehensif. Selanjutnya, pasien mendapatkan tindakan medis dan keperawatan sesuai dengan kondisi klinisnya, termasuk stabilisasi, pemberian terapi, pemeriksaan penunjang, serta monitoring berkelanjutan. Setelah kondisi pasien stabil atau diagnosis lebih jelas, dilakukan tahap disposition, yaitu penentuan tindak lanjut pasien, apakah pasien dipulangkan, dirawat inap, dirujuk ke fasilitas lain, atau dipindahkan ke unit perawatan intensif. Sepanjang alur ini, dokumentasi, komunikasi antar tim kesehatan, serta prinsip patient safety menjadi bagian penting yang harus dijaga untuk meminimalkan risiko kesalahan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan demikian, alur pasien di IGD merupakan rangkaian proses yang terintegrasi, cepat, dan berbasis prioritas kegawatan, yang menuntut tenaga kesehatan memiliki kemampuan klinis, pengambilan keputusan, serta koordinasi tim yang baik demi menjamin keselamatan dan outcome pasien secara optimal (1, 2,6).

D. Konsep Prioritas Kegawatdaruratan Dalam *Triage*

Keperawatan gawat darurat adalah pelayanan profesional keperawatan yang di berikan pada pasien dengan kebutuhan urgen dan kritis. Namun IGD dan klinik kedaruratan sering di gunakan untuk masalah yang tidak urgen. Pada perkembangannya kegawatdaruratan menjadi luas, kedaruratan yaitu apapun yang di alami pasien atau keluarga harus di pertimbangkan sebagai kegawatdaruratan. Pelayanan gawat darurat tidak hanya memberikan pelayanan untuk mengatasi kondisi kedaruratan yang di alami pasien tetapi juga memberikan masukan keperawatan untuk mengatasi kecemasan pasien dan keluarga. Sistem pelayanan bersifat darurat sehingga perawat dan tenaga medis lainnya harus memiliki kemampuan, keterampilan, tehnik serta ilmu pengetahuan yang tinggi dalam memberikan pertolongan kedaruratan kepada pasien. *Triage* dalam keperawatan gawat darurat di gunakan untuk mengklasifikasikan keparahan penyakit atau cedera dan menetapkan prioritas kebutuhan penggunaan petugas perawatan kesehatan secara efisien. Standart waktu yang di perlukan untuk melakukan triase adalah 2-5 menit untuk orang dewasa dan 7 menit untuk pasien anak-anak (3).

Manchester Triage Group menjelaskan beberapa strategi pengambilan keputusan *triage* antara lain pertimbangan (*reasoning*), pola pengakuan (*pattern recognition*), hipotesis berulang (*repetitive hypothesizing*), representasi mental (*mental representation*), dan intuisi (*intuition*).

1. Pertimbangan (*reasoning*)

Pada dasarnya ada dua jenis penalaran yang terlibat dalam berpikir kritis yaitu induktif dan deduktif. Penalaran induktif adalah kemampuan untuk mempertimbangkan semua kemungkinan dari khusus ke umum dan sangat berguna untuk perawat yang kurang berpengalaman. Sedangkan penalaran deduktif adalah penalaran dari umum ke khusus. Hal ini memungkinkan praktisi untuk secara cepat menyortir informasi relevan dari yang tidak relevan untuk mencapai keputusan.

2. Pola pengakuan (*pattern recognition*)

Merupakan strategi yang paling umum digunakan dokter dan sangat penting ketika membuat keputusan cepat berdasarkan informasi terbatas yang diperlukan selama *triage* berdasarkan pola tanda dan gejala pasien dibandingkan dengan kondisi dari kasus sebelumnya. Kemampuan dalam penggunaan keterampilan pengambilan keputusan ini berkembang dari pengalaman dan intuisi.

3. Hipotesis berulang (*repetitive hypothesizing*)

Hipotesis berulang digunakan oleh dokter untuk menguji penalaran diagnostik. Data dikumpulkan untuk mengkonfirmasi atau menghilangkan hipotesis, sehingga keputusan dapat dibuat. Metode ini tergantung pada tingkat keahlian dapat berupa induktif atau deduktif.

4. Representasi mental (*mental representation*)

Representasi mental adalah metode untuk menyederhanakan situasi untuk memberikan gambaran umum dan memungkinkan fokus pada informasi yang relevan. Strategi ini sering digunakan ketika masalah sangat kompleks atau luar biasa. Keputusan *triage* harus cepat dan metode ini memiliki penggunaan terbatas dalam tahap perawatan pasien.

5. Intuisi (*intuition*)

Intuisi terkait erat dengan keahlian dan umumnya dianggap sebagai kemampuan praktisi untuk memecahkan masalah dengan data yang relatif sedikit. Intuisi jarang melibatkan analisis sadar dan sering dinyatakan sebagai 'firasat'. Praktisi ahli melihat situasi secara holistik dan pengalaman masa lalu. Keputusan yang efektif dibuat dengan menggabungkan pengetahuan dengan teori pengambilan keputusan dan pemikiran intuitif (6).

Prinsip dalam menentukan prioritas keputusan *triage* adalah berdasarkan Hirarki Kebutuhan Maslow dimana dalam kerangkanya menyatakan kebutuhan paling mendasar harus dipenuhi sebelum kebutuhan yang paling tinggi yaitu mulai dari kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta dan mencintai, harga diri, dan aktualisasi diri. Di departemen gawat darurat hal ini dijabarkan dalam ABCD yaitu

memenuhi kebutuhan jalan nafas (*Airway*), kemudian pernafasan (*Breathing*), kemudian sirkulasi (*Circulation*), kemudian cacat (*Disability*) (Zimmermann & Herr, 2006).

Triage dilakukan oleh perawat yang profesional (RN) yang sudah terlatih dalam prinsip triase, pengalaman bekerja minimal 6 bulan di bagian UGD, dan memiliki kualifikasi: - Menunjukkan kompetensi kegawat daruratan, Sertifikasi ATLS, ACLS, PALS, ENPCLulus Trauma Nurse Core Curriculum (TNCC), Pengetahuan tentang kebijakan intradepartemen dan Keterampilan pengkajian yang tepat. Berbagai sistem menggambarkan kategori *triage* dengan menggunakan label *triage* dan definisi dari masing-masing kelompok / tingkatan. Berikut contoh pengkategorian sistem pengelompokan *triage*:

1. Sistem *triage* 2 kelompok : *emergent, non emergent*

2. Sistem *triage* 3 kelompok : *emergent, urgent, non urgent*
3. Sistem *triage* 4 kelompok : *life threatening, emergent, urgent, non urgent*
4. Sistem *triage* 5 kelompok : *resuscitation, emergent, urgent, non urgent, referred*.

ACEP (*American College of Emergency Physician*) dan ENA (*Emergency Nursing Association*) mendukung pengelompokan *triage* dalam 5 kelompok (7). Beberapa contoh sistem *triage* 5 kelompok, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Sistem *Triage* Lima Kelompok

Sistem	Negara	Kategori / kelompok	Target waktu penanganan
Australian <i>Triage</i> Scale	Australia New Zealand	1. Resuscitation 2. Emergency 3. Urgent 4. Semi urgent 5. Non urgent	Segera / 0 menit 10 menit 30 menit 60 menit 120 menit
Manchester	Inggris Scotlandia	1-Immediate (red) 2-Very urgent (orange) 3-Urgent (yellow) 4-Standard (green) 5-Non urgent (blue)	0 menit 10 menit 60 menit 120 menit 240 menit
Canadian <i>Triage</i> and Acuity Scale (CTAS)	Canada	1- Resuscitation 2- Emergent 3- Urgent 4- Less urgent 5- Non urgent	0 menit 15 menit 30 menit 60 menit 120 menit

Setelah melakukan penilaian, korban dikategorikan sesuai dengan kondisinya dan diberi *tag* warna. Berikut ini kategori *triage* yang terdiri dari lima kategori tingkat kegawatan untuk kasus cedera yang dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut ini.

MANCHESTER TRIAGE SYSTEM		
CATEGORY	CLASSIFICATION	TIME TO BE SEEN
1	IMMEDIATE	STRAIGHT AWAY
2	VERY URGENT	WITHIN 10 MIN
3	URGENT	WITHIN 60 MIN
4	STANDARD	WITHIN 120 MIN
5	NON-URGENT	WITHIN 240 MIN

Gambar 2.2: Manchester Group Triage

Sumber : *Modern triage in the emergency department*

Berdasarkan Gambar 4.2 kategori *triage* dibagi atas lima tingkat yaitu *immediate* (merah), *very urgent* (orange), *urgent* (kuning), *standart* (hijau), dan *non urgent* (biru) :

1. *Immediate* / segera (merah)

Setiap korban dengan kondisi yang mengancam jiwa dan dapat mematikan dalam ukuran menit, harus ditangani dengan segera dengan waktu penanganan 0 menit. Kondisi penderita pada kondisi ini antara lain:

- Airway*: tidak paten
- Breathing*: pernafasan inadekuat atau tidak adanya pernapasan yang didefinisikan sebagai tidak ada respirasi atau usaha pernapasan sebagaimana dinilai dengan melihat, mendengar dan merasakan selama 10 detik.
- Circulation*: tidak teraba nadi dalam waktu 5 detik dan tanda-tanda klasik syok yaitu berkeringat, pucat, *takikardia*, hipotensi, dan penurunan tingkat kesadaran. Terdapat perdarahan terus-menerus.
- Disability*: tidak sadar dimana pada pasien dewasa tidak responsive terhadap suara dan nyeri, sedangkan pada pasien anak hanya responsive terhadap suara dan nyeri saja, hiperglikemia, koma dan GCS < 10.

2. *Very urgent* / sangat mendesak (oranye)

Setiap korban dengan kondisi cedera berat namun penanganannya dapat ditunda dengan waktu penanganan 10 menit dengan kondisi penderita:

- a. *Breathing*: SaO₂ sangat rendah, sesak nafas akut/tiba-tiba atau sesak nafas kronis
- b. *Circulation*: nadi abnormal, takikardi, perdarahan mayor yang tidak terkontrol
- c. *Disability*: perubahan tingkat kesadaran, defisit neurologis akut. Hilangnya fungsi neurologis yang datang dalam 24 jam sebelumnya. Termasuk perubahan atau hilangnya sensasi, kelemahan tungkai (baik transien atau permanen) dan perubahan dalam kandung kemih atau fungsi usus.
- d. Nyeri berat
- e. Mekanisme kecelakaan yang signifikan. Luka tembus (tusuk atau tembakan), jatuh dari ketinggian, kecelakaan lalu lintas yang signifikan (kecepatan > 40 m/jam) terutama jika telah ada ejeksi dari kendaraan, kematian korban kecelakaan lainnya atau ditandai perubahan bentuk kendaraan

3. **Urgent / mendesak (kuning)**

Waktu penanganan 60 menit dan kondisi penderita antara lain:

- a. *Circulation*: perdarahan minor yang terkontrol
- b. *Disability*: riwayat tidak sadarkan diri oleh saksi yang menyatakan apakah pasien tidak sadarkan diri (dan untuk berapa lama). Jika seorang pasien yang tidak dapat mengingat insiden itu harus diasumsikan telah menjadi sadar dan defisit neurologis baru terjadi
- c. Nyeri sedang
- d. Riwayat tidak wajar (*inappropriate*) yang diberikan tidak menjelaskan fisik, temuan itu disebut tidak wajar yang merupakan penanda cedera non kecelakaan pada yang mungkin dikarenakan penyalahgunaan pada anak-anak yang rentan dan dewasa.

4. **Standart (hijau)**

Kondisi penderita antara lain terdapat pembengkakan, deformitas, nyeri ringan, dan masalah actual dengan waktu penanganan 120 menit.

5. **Non urgent / tidak mendesak (biru)**

Sama dengan pada kondisi *standart* (hijau) tetapi waktu penanganan hingga 240 menit.

Kategori *triage* pada pasien trauma dalam sistem *triage* tiga tingkat antara lain:

1. **Prioritas 1 (merah)**

Kondisi pasien membutuhkan resusitasi. *The American College of Surgeons (ACS), Committee on Trauma* menyarankan pasien ditangani dipusat trauma. Waktu tunggu untuk penanganan pasien adalah 0 menit.

Kriteria pasien dalam prioritas I antara lain:

- a. *Glasgow Coma Scale* (GCS): <14
- b. Tekanan darah sistolik: <90 mmHg

- c. Frekuensi pernafasan: <10 atau >29 x/menit
- d. *Revised trauma score*: <11
- e. Cedera tusuk pada kepala, leher, *torso*, ekstremitas proksimal sampai siku dan lutut
- f. *Flail chest*
- g. Kombinasi trauma dan luka bakar
- h. Fraktur dua atau lebih tulang panjang
- i. Fraktur pelvis
- j. Fraktur kepala terbuka
- k. *Paralysis*
- l. Amputasi sampai pergelangan tangan dan kaki proksimal
- m. Luka bakar mayor
- n. Ejeksi dari mobil
- o. Kematian pada kompartemen penumpang yang sama
- p. Jatuh dari ketinggian >20 kaki
- q. Kecelakaan mobil kecepatan tinggi (>40 mil per jam), perubahan bentuk kendaraan >20 inci, *intrusi* ke kompartemen penumpang >12"
- r. Kecelakaan motor dengan kecepatan >20 mil per jam atau pengendara terpisah dari motor
- s. Pasien berusia <5 tahun atau >55 tahun, hamil, kondisi medis kronis

2. Prioritas 2 (kuning)

Kondisi pasien yang mendesak (*urgent*) stabil, tetapi memiliki potensi memburuk atau perlu dilihat sesegera mungkin. Kondisi dapat digambarkan akut, tetapi tidak "parah". Contoh kondisi dalam kategori ini adalah fraktur terbuka, luka bakar minor, dan pembedahan abdomen. Waktu tunggu untuk penanganan pasien adalah 30 menit.

3. Prioritas 3 (hijau)

Kondisi pasien tidak mendesak (*non urgent*), biasanya dinamakan "*walking wounded*", contohnya pada kondisi *laserasi minor* (perdarahan terkontrol) atau fraktur ekstremitas yang stabil (10)

Sistem *triage* yang diterapkan di Indonesia adalah kategori triage tiga tingkat yaitu Prioritas 1 atau gawat darurat (merah), Prioritas 2 atau gawat tapi tidak darurat (kuning), dan Prioritas 3 atau tidak gawat dan tidak darurat (hijau). Berdasarkan kategori gawat dan tidak gawat, maka yang masuk dalam kategori gawat adalah Prioritas 1 (merah) dan Prioritas 2 (kuning), sedangkan yang masuk dalam kategori tidak gawat adalah Prioritas 3 (hijau).

Canadian *Triage* and Acuity Scale (CTAS), merupakan *guideline* nasional yang di adopsi oleh beberapa negara yang belum memiliki model *triage* tetap. Deskripsi dari CTAS dalam mengkategorikan pasien adalah sebagai berikut:

1. CTAS Level 1 - *Resuscitation* (Pasien harus dilihat segera)
Kondisi yang mengancam jiwa atau anggota tubuh (resiko tinggi untuk mengalami penurunan kondisi) seperti Cardiac/ Respirasi arrest, *Major* trauma, pasien tidak sadar, distress pernafasan, syok.
2. CTAS Level 2 – *Emergent* (pasien harus dilihat dalam waktu 15 menit) Kondisi yang berpotensi mengancam fungsi hidup, yang memerlukan intervensi medis yang cepat atau dapat di delegasikan, perubahan status mental, cedera kepala, trauma berat, neonatus, overdosis obat-obatan dan *Cardio Vascular Attack* (CVA), Sesak nafas, fraktur yang parah.
3. CTAS Level 3 – *Urgent* (pasien harus dilihat dalam waktu 30 menit)
Kondisi yang berpotensi berkembang menjadi masalah serius yang memerlukan intervensi darurat, dapat berhubungan dengan ketidaknyamanan yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Seperti: Trauma sedang, Perdarahan GI track, perdarahan vagina dan kehamilan, psikosis akut / Suicide, nyeri akut, asma.
4. CTAS Level 4 - *Less Urgent/ semi urgent* (pasien harus dilihat dalam waktu 60 menit). Kondisi yang terkait dengan usia pasien, distress, potensi kerusakan/komplikasi akan dapat di atasi dengan intervensi dalam waktu 1-2 jam. Seperti: sakit kepala, Benda asing dalam kornea, *chronic back pain*.
5. CTAS Level 5 – *Non Urgent* (pasien harus dilihat dalam waktu 120 menit) Kondisi yang mungkin akut tetapi tidak mendesak. Seperti: Sakit tenggorokan, nyeri perut ringan yang berulang atau kronis, dengan tanda vital yang normal, muntah saja atau diareha saja (11).

Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Kasus

Perempuan 24 tahun datang ke IGD dengan keluhan demam sudah 2 hari. Hasil pengkajian : pengkajian frekuensi pernapasan: 20 kali/menit, jalan nafas paten, nadi : 100x/menit, tekanan darah : 110/80 mmHg, suhu : 38.5 C, mual (-), diare (-), batuk (+),

Apa kategori triage untuk pasien tersebut ?

- Merah
- Kuning
- Hijau
- Hitam
- Biru

Diskusi kelompok :

- Identifikasi tanda tanda vital pada pasien
- Tentukan **data abdonrmal pada tanda tanda vital pasien**
- Identifikasi **tingkat kegawatan pada pasien**
- Tentukan kategorit triage pada pasien

Format pengkajian triage :

Tanggal/Waktu kedatangan:

Hasil Pemeriksaan Tanda vital: TD:mmHg, Frek Nadi:X/m, Frek Nafas:x/m, Suhu:°C

PENGKAJIAN TRIAGE				
Nama :	No. RM :			
Tanggal :	Jam:	Jenis Kelamin :	L/P	
PENGKAJIAN	MERAH	KUNING	HIJAU	
Jalan Nafas	☐ Obstruksi /Partial Obstruksi	☐ Paten	☐ Paten	
Pernafasan	☐ Distress Nafas Berat/Henti Nafas	☐ Distress nafas ringan-sedang	☐ Normal	
Sirkulasi	☐ Gangguan hemodinamik berat/perdarahan tidak terkontrol	☐ Gangguan hemodinamik sedang-ringan	☐ Stabil	
GCS	☐ < 9	☐ 9-14	☐ 15	
Nyeri		☐ Sedang-berat	☐ Tidak nyeri – ringan	
		☐ Nyeri dada akut		
		☐ Nyeri dada tidak dipengaruhi aktivitas		
Kondisi Mental		☐ Nyeri dada dijalarkan		
Resiko Penularan Infeksi	☐ Tidak kooperatif		☐ Kooperatif	
	☐ Batuk > 2 minggu dengan demam dan sesak ☐ Rujukan dengan suspek/konfirmasi airborne disease ☐ Tidak berisiko airborne disease			
Berdasarkan Australian Triage Scale (Modifikasi)				
Diteruskan kepada	☐ Merah	☐ Anestesi bersama tim	☐ Isolasi	
	☐ Kuning	☐ Anak	☐ Non Isolasi	
	☐ Hijau	☐ Kebidanan		
	☐ Penyakit dalam	☐ Syaraf		
	☐ Umum	☐ Jantung		
Tanda Tangan Petugas Triage				
Nama:				

Aktivitas 2 — *Shows How*

Asesmen (Piramida Miller)

KASUS OSCE

1.	Nomor station	
2.	Judul station	Triage pada Klien Dewasa di IGD
3.	Waktu yang dibutuhkan	15 menit
4.	Tujuan station	Menilai kemampuan menentukan kategori triage dan melakukan perilaku profesional
5.	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku professional
6.	Kategori	1. Oksigenasi 2. Sirkulasi 3. Cairan dan elektrolit 4. Nutrisi 5. Aman dan nyaman 6. Psikososial 7. Eliminasi 8. Aktivitas dan istirahat 9. Seksual dan reproduksi
7.	Instruksi untuk peserta ujian	<u>SKENARIO KLINIK:</u> Perempuan 24 tahun datang ke IGD dengan keluhan demam sudah 2 hari. Hasil pengkajian : pengkajian frekuensi pernapasan: 20 kali/menit, jalan nafas paten, nadi : 100x/menit, tekanan darah : 110/80 mmHg, suhu : 38.5 C, mual (-), diare (-), batuk (+), <u>TUGAS :</u> 1. Lengkapi form triage sesuai data pada scenario atas 2. Tentukan kategori triage pada pasien tersebut

8.	Instruksi untuk penguji	<u>SKENARIO KLINIK:</u> Perempuan 24 tahun datang ke IGD dengan keluhan demam sudah 2 hari. Hasil pengkajian : pengkajian frekuensi pernapasan: 20 kali/menit, jalan nafas paten, nadi : 100x/menit, tekanan darah : 110/80 mmHg, suhu : 38.5 C, mual (-), diare (-), batuk (+), <u>TUGAS :</u> 1. Melengkapi form triage sesuai data pada scenario atas 2. Menentukan kategori triage pada pasien tersebut <u>INSTRUKSI PENGUJI:</u> 1. Menilai Lengkapi pengisian form triage 2. Menilai ketepatan penentuan kategori triage pasien berwarna hijau
9.	Instruksi untuk klien standar	<i>Tidak ada KS</i>
10.	<i>Setting Station.</i>	1. Poliklinik 2. Unit Gawat Darurat 3. Ruangan Rawat Inap 4. Ruang Keluarga 5. Komunitas
11	Peralatan yang dibutuhkan	Manekin Alat TTV Sarung tangan
12.	Penulis	Vita Maryah A, S.Kep., Ns., M.Kep
13.	Referensi	Yancey, C.C. and O'Rourke, M.C., 2020. Emergency department triage.

SOP TRIAGE PADA UNIT GAWAT DARURAT

No	Kegiatan	Dilakukan	Tidak dilakukan	Kompeten	Tidak kompeten
1. Prosedur	I. Tahap persiapan 1) Verifikasi tindakan 2) menyiapkan alat : Stetoskop, tensimeter, thermometer, kode warna merah, kuning, hijau, hitam II. Tahap kerja 1) Penderita datang diterima petugas / paramedis UGD 2) Inform consent (penandatanganan persetujuan tindakan) oleh keluarga pasien 3) Di ruang triase dilakukan anamnesa 4) Penderita diperiksa dengan singkat 5) Penderita diperiksa dengan cepat (selintas) untuk menentukan derajat kegawatannya oleh dokter/paramedis yang terlatih 6) Penderita dibedakan menurut kegawatannya dengan memberi kode warna: a. Hijau adalah warna untuk penderita darurat tidak gawat (waktu respon : 30 menit) tidak ada				

	ancaman kematian tapi dapat terjadi kecacatan b. Kuning adalah gawat darurat (waktu respon : 0-10 menit) pasien perlu pertolongan segera karena ada ancaman kematian c. Merah adalah gawat darurat (waktu respon : 0-10 menit) pasien perlu pertolongan segera karena ada ancaman kematian d. Hitam adalah pasien meninggal atau kondisi yang sangat parah dan tidak ada harapan hidup (waktu respon 50 menit) 7) Apabila penderita mengalami kondisi : a. Warna merah maka langsung diberikan pengobatan b. Warna kuning maka menunggu giliran setelah pasien dengan kategori triase merah selesai ditangani				
--	--	--	--	--	--

	c. Warna hijau maka dapat dipindahkan ke rawat jalan d. Warna hitam maka urus kepulangan dengan keluarga 8) Selanjutnya untuk triase warna merah, kuning, hijau jika masalah sudah dapat ditangani maka pasien pulang jika tidak maka rujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi III. Terminasi 1) Akhiri dan simpulkan aspek yang dinilai 2) Bereskan alat, lepas sarung tangan dan cuci tangan				
--	--	--	--	--	--

Format pengkajian triage

Tanggal/Waktu kedatangan:

Hasil Pemeriksaan Tanda vital: TD:mmHg, Frek Nadi:X/m, Frek Nafas:x/m, Suhu:°C

PENGKAJIAN TRIAGE			
Nama :	No. RM :		
Tanggal :	Jam :	Jenis Kelamin : L/P	
PENGKAJIAN	MERAH	KUNING	HIJAU
Jalan Nafas	☐ Obstruksi /Partial Obstruksi	☐ Paten	☐ Paten
Pernafasan	☐ Distress Nafas Berat/Henti Nafas	☐ Distress nafas ringan-sedang	☐ Normal
Sirkulasi	☐ Gangguan hemodinamik berat/perdarahan tidak terkontrol	☐ Gangguan hemodinamik sedang-ringan	☐ Stabil
GCS	☐ < 9	☐ 9-14	☐ 15
Nyeri		☐ Sedang-berat	☐ Tidak nyeri – ringan
		☐ Nyeri dada akut	
		☐ Nyeri dada tidak dipengaruhi aktivitas	
Kondisi Mental		☐ Nyeri dada dijalarkan	
Resiko Penularan Infeksi	☐ Batuk > 2 minggu dengan demam dan sesak	☐ Tidak kooperatif	☐ Kooperatif
	☐ Rujukan dengan suspek/konfirmasi airborne disease		
	☐ Tidak berisiko airborne disease		
Berdasarkan Australian Triage Scale (Modifikasi)			
Diteruskan kepada	☐ Merah	☐ Anestesi bersama tim	☐ Isolasi
	☐ Kuning	☐ Anak	☐ Non Isolasi
	☐ Hijau	☐ Kebidanan	
	☐ Penyakit dalam	☐ Bedah	
	☐ Umum	☐ Syaraf	
		☐ Jantung	
Tanda Tangan Petugas Triage			
Nama:			

E. Form Penilaian Osce Keperawatan Station: Triage Pada Unit Gawat Darurat

1. Form Penilaian

No	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	4	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Keperawatan	Mengkaji tanda – tanda vital pada pasien						1	
2	Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Mengkaji data data abnormal						2	
3	Implementasi keperawatan: edukasi dan demonstrasi pemberian oralit	Menetapkan kategori triage						5	
4	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, responsif						2	
	Jumlah							10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, kekurangan minor
- 4 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Akurasi kategori triage	≤60% tepat	61–75% tepat	76–90% tepat	>90% tepat

(persentase kasus tepat)				
2.2 Kelengkapan dokumentasi keputusan triage	Banyak komponen hilang; tidak dapat ditindaklanjuti	Komponen inti ada; masih ada kekurangan bermakna	Lengkap; kekurangan minor	Sangat lengkap, ringkas, jelas; tanpa kekurangan bermakna

2. Global Performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

F. DOPS (Does)

Tabel 2.1: Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada prosedur triage pada instalasi gawat darurat

Komponen	Deskripsi	Prosedur triage pada instalasi gawat darurat
Metode penilaian	Mini-CEX merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa dalam encounter singkat, terfokus, dan nyata di lahan praktik.	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi mahasiswa saat melakukan prosedur triage
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi, edukasi, dan profesionalisme dalam satu pertemuan klinik.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari penentuan kategori warna triage, tetapi juga dari kemampuannya mengkaji tanda vital pasien, dan mengelompokkan data sesuai kategori kegawatan pada pasien
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau tahap profesi.	Perempuan 24 tahun datang ke IGD dengan keluhan demam sudah 2 hari. Hasil pengkajian : pengkajian frekuensi pernapasan: 20 kali/menit, jalan nafas paten, nadi : 100x/menit, tekanan darah : 110/80 mmHg, suhu : 38.5 C, mual (-), diare (-), batuk (+),

Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan encounter klinik secara utuh sejak awal interaksi sampai penjelasan rencana tindakan.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan pengkajian singkat namun terarah, mengkaji tanda vital pasien, dan mengelompokkan data sesuai kategori kegawatan pada pasien dan menentukan kategori warna triage
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi anamnesis atau pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi terapeutik, edukasi keluarga, profesionalisme, dan organisasi tindakan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu mengkaji tanda vital pasien, dan mengelompokkan data sesuai kategori kegawatan pada pasien dan menentukan kategori warna triage
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa klinik mahasiswa secara langsung menggunakan format Mini-CEX yang terstruktur.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menghubungkan data klinik dengan masalah prioritas, mengkaji tanda vital pasien, dan mengelompokkan data sesuai kategori kegawatan pada pasien dan menentukan kategori warna triage
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat singkat, spesifik, dan berorientasi pada perbaikan performa.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan identifikasi mengkaji tanda vital pasien, dan

		mengelompokkan data sesuai kategori kegawatan pada pasien dan menentukan kategori warna triage
Keputusan penilaian	Hasil Mini-CEX digunakan untuk menentukan tingkat performa mahasiswa dalam praktik klinik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan mengkaji tanda vital pasien, dan mengelompokkan data sesuai kategori kegawatan pada pasien dan menentukan kategori warna triage
Makna dalam OBE	Mini-CEX memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does.	Pada kasus penentuan triage, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan tindakan keperawatan secara langsung, aman, tepat, dan profesional di lahan praktik.

G. Portofolio

Tabel 2.2: Portofolio Skill Triage Keperawatan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Triage Pasien di IGD
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan dalam melakukan triage. Dalam OBE, portofolio menilai performa nyata mahasiswa di situasi klinik.	Pada praktik di IGD, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan penilaian cepat (rapid assessment), mengklasifikasikan pasien berdasarkan tingkat kegawatan, serta mengambil keputusan prioritas tindakan.
Tujuan portofolio	Mendokumentasikan kemampuan mahasiswa dalam melakukan triage secara sistematis, akurat, dan aman serta menunjukkan perkembangan kompetensi dari waktu ke waktu.	Mahasiswa tidak hanya melakukan triage sekali, tetapi menunjukkan peningkatan ketepatan dalam menentukan kategori (merah, kuning, hijau, hitam) setelah mendapat umpan balik dari CI/dosen.
OSCE dan DOPS	OSCE memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium, sedangkan DOPS menunjukkan performa langsung mahasiswa di lahan praktik.	OSCE: mahasiswa melakukan simulasi triage pada pasien trauma. DOPS: mahasiswa melakukan triage pasien sesak napas di IGD dan dinilai langsung oleh CI.
Catatan kasus singkat	Berisi ringkasan kasus pasien yang ditangani, termasuk kondisi awal, hasil triage, intervensi awal, dan outcome pasien.	Mahasiswa menuliskan kasus pasien kecelakaan lalu lintas dengan penurunan kesadaran, tekanan darah menurun, dikategorikan sebagai

		triage merah, diberikan tindakan airway dan rujukan cepat.
Refleksi patient safety	Mendokumentasikan kemampuan mahasiswa dalam melakukan triage secara sistematis, akurat, dan aman serta menunjukkan perkembangan kompetensi dari waktu ke waktu.	Mahasiswa tidak hanya melakukan triage sekali, tetapi menunjukkan peningkatan ketepatan dalam menentukan kategori (merah, kuning, hijau, hitam) setelah mendapat umpan balik dari CI/dosen.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari pembimbing klinik terkait performa mahasiswa dalam melakukan triage.	CI menilai mahasiswa sudah cepat dalam pengkajian awal, tetapi perlu meningkatkan akurasi dalam interpretasi tanda vital dan pengambilan keputusan kategori triage.
Karakteristik penilaian	Penilaian dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya satu kali praktik, tetapi berdasarkan konsistensi performa mahasiswa dalam berbagai situasi triage.	Mahasiswa dinilai dari beberapa kasus seperti trauma, kegawatan pernapasan, dan kasus non-emergensi untuk melihat konsistensi kemampuan triage.
Bukti konsistensi kompetensi	Menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan kualitas triage di berbagai situasi klinik	Dari OSCE, DOPS, dan catatan kasus terlihat mahasiswa konsisten mampu melakukan primary survey (ABCDE) dan menentukan prioritas dengan tepat
Makna dalam OBE	Portofolio menjadi bukti autentik bahwa mahasiswa tidak	Mahasiswa menunjukkan kemampuan melakukan

	hanya memahami teori triage tetapi mampu menerapkannya secara nyata dan konsisten	triage secara cepat, tepat, dan aman dalam berbagai kondisi pasien di IGD.
--	---	--

Tabel 2.3: Case Report Skill Triage Keperawatan

Komponen	Deskripsi	Contoh Kasus Triage
Hakikat case report	Laporan singkat tentang satu kasus triage yang ditangani mahasiswa secara sistematis.	Pasien laki-laki datang dengan nyeri dada hebat, sesak, dan keringat dingin.
Tujuan	Menunjukkan kemampuan analisis klinis dan pengambilan keputusan triage.	Mahasiswa mampu menetapkan pasien sebagai triage merah karena indikasi kegawatan jantung.
Isi laporan	Identitas, keluhan utama, data subjektif-objektif, kategori triage, intervensi awal, dan evaluasi.	Data vital tidak stabil, pasien langsung diprioritaskan untuk penanganan emergensi.
Fokus penilaian	Ketepatan klasifikasi triage dan kecepatan pengambilan keputusan.	Pembimbing menilai keakuratan mahasiswa dalam mengenali tanda syok.
Nilai edukatif	Mengembangkan clinical reasoning dan kecepatan berpikir kritis.	Mahasiswa belajar pentingnya respon cepat pada kasus life-threatening.
Makna dalam OBE	Bukti penerapan teori triage dalam kasus nyata.	Mahasiswa mampu mengintegrasikan teori dan praktik.

Tabel 2.4: Refleksi Patient Safety pada Triage Keperawatan

Komponen	Deskripsi	Contoh Refleksi
Hakikat refleksi	Tulisan yang menunjukkan kesadaran mahasiswa terhadap keselamatan pasien dalam triage.	Mahasiswa menyadari bahwa keterlambatan triage dapat memperburuk kondisi pasien.
Tujuan	Meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan pasien dalam	Mahasiswa memahami bahwa triage adalah titik awal keselamatan pasien.

	pengambilan keputusan cepat	
Fokus refleksi	Identifikasi risiko, penyebab, pencegahan, dan pembelajaran.	Risiko salah klasifikasi triage akibat kurang teliti membaca tanda vital.
Risiko yang diidentifikasi	Kesalahan prioritas, keterlambatan penanganan, misinterpretasi kondisi pasien.	Pasien kritis masuk kategori non-emergensi.
Tindakan pencegahan	Pengkajian cepat dan sistematis (ABCDE), validasi data, komunikasi tim.	Mahasiswa melakukan cross-check tanda vital dan konsultasi dengan perawat senior.
Pembelajaran mahasiswa	Menunjukkan perubahan sikap dan peningkatan kompetensi.	Mahasiswa lebih teliti dan sistematis dalam melakukan triage berikutnya.
Makna dalam OBE	Menunjukkan perkembangan sikap profesional dan tanggung jawab klinik.	Mahasiswa mampu meningkatkan kualitas praktik secara berkelanjutan.

H. Ringkasan

Skill triage keperawatan merupakan kumpulan bukti pembelajaran yang menggambarkan perkembangan kompetensi mahasiswa dalam melakukan triage secara bertahap dan berkelanjutan dalam konteks praktik klinik. Melalui pendekatan Outcome-Based Education (OBE), portofolio ini tidak hanya menilai pengetahuan teoritis, tetapi juga performa nyata mahasiswa dalam melakukan pengkajian cepat, menentukan prioritas pasien, serta mengambil keputusan klinis secara tepat dan aman. Tujuan utama portofolio adalah mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, serta refleksi diri mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan triage dari waktu ke waktu berdasarkan umpan balik dari dosen atau Clinical Instructor (CI).

Portofolio mencakup berbagai komponen penting seperti hasil OSCE sebagai bukti keterampilan di laboratorium dan DOPS sebagai bukti performa langsung di lahan praktik, catatan kasus singkat yang merangkum kondisi pasien dan keputusan triage yang diambil, serta refleksi patient safety yang menunjukkan

kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi risiko dan mencegah kesalahan prioritas. Selain itu, umpan balik dari pembimbing menjadi bagian penting untuk mengevaluasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Penilaian dalam portofolio bersifat berkelanjutan dan menekankan konsistensi performa mahasiswa dalam berbagai situasi kegawatan. Melalui portofolio ini, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan konsistensi dalam melakukan triage secara cepat, tepat, dan sistematis, serta memiliki kemampuan clinical reasoning yang baik dalam menentukan tingkat kegawatan pasien. Secara keseluruhan, portofolio menjadi bukti autentik bahwa mahasiswa tidak hanya memahami konsep triage, tetapi juga mampu menerapkannya secara profesional dalam praktik klinik nyata, dengan tetap mengutamakan keselamatan pasien dan peningkatan kualitas pelayanan keperawatan.

I. Glosarium

ABCDE: Pendekatan sistematis dalam penanganan pasien gawat darurat yang meliputi Airway, Breathing, Circulation, Disability, dan Exposure untuk mengidentifikasi masalah yang mengancam nyawa secara cepat.

ACLS (Advanced Cardiac Life Support): Pelatihan kegawatdaruratan lanjutan yang berfokus pada penanganan henti jantung, gangguan irama jantung, dan kondisi kardiovaskular emergensi.

Airway: Penilaian dan penanganan jalan napas untuk memastikan jalan napas pasien tetap terbuka dan adekuat.

ATLS (Advanced Trauma Life Support): Program pelatihan penanganan trauma yang bertujuan meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam menangani pasien trauma secara sistematis.

Breathing: Penilaian fungsi pernapasan pasien untuk memastikan ventilasi dan oksigenasi berjalan adekuat.

Canadian Triage and Acuity Scale (CTAS): Sistem triage lima tingkat yang digunakan untuk menentukan prioritas pelayanan pasien berdasarkan tingkat kegawatan.

Case Report: Laporan tertulis mengenai kasus klinik tertentu yang digunakan sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam melakukan analisis dan pengambilan keputusan klinis.

Circulation: Penilaian sirkulasi darah pasien yang meliputi nadi, tekanan darah, perdarahan, dan tanda syok.

Clinical Reasoning: Kemampuan berpikir kritis dan analisis klinik dalam menentukan masalah pasien dan pengambilan keputusan keperawatan.

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah): Kemampuan yang harus dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan suatu mata kuliah.

CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan): Kompetensi umum yang harus dimiliki lulusan sesuai standar pendidikan program studi.

Disability: Penilaian status neurologis pasien seperti tingkat kesadaran, respon pupil, dan Glasgow Coma Scale (GCS).

DOPS (Direct Observation of Procedural Skills): Metode penilaian keterampilan klinik melalui observasi langsung terhadap tindakan mahasiswa di lahan praktik.

Emergency Nursing Association (ENA): Organisasi profesi keperawatan gawat darurat yang mendukung pengembangan standar pelayanan dan triage.

Exposure: Tahap pemeriksaan menyeluruh pada pasien untuk menemukan cedera atau kondisi lain yang tersembunyi.

GCS (Glasgow Coma Scale): Instrumen penilaian tingkat kesadaran pasien berdasarkan respon mata, verbal, dan motorik.

IGD (Instalasi Gawat Darurat): Unit pelayanan rumah sakit yang memberikan pelayanan awal pada pasien dengan kondisi kegawatdaruratan.

Initial Assessment: Pengkajian awal secara cepat untuk menentukan kondisi umum dan tingkat kegawatan pasien.

Intuisi (Intuition): Kemampuan pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman dan firasat klinis dalam situasi tertentu.

Manchester Triage System: Sistem triage lima tingkat yang menggunakan kategori warna dan target waktu penanganan pasien.

Mini-CEX (Mini Clinical Evaluation Exercise): Metode penilaian klinik berbasis observasi langsung dalam encounter singkat antara mahasiswa dan pasien.

Non Urgent: Kategori triage untuk pasien dengan kondisi tidak mendesak dan dapat menunggu pelayanan lebih lama.

OBE (Outcome-Based Education): Pendekatan pendidikan berbasis capaian pembelajaran yang menekankan kompetensi hasil belajar mahasiswa.

OSCE (Objective Structured Clinical Examination)
Metode ujian keterampilan klinik dengan beberapa station untuk menilai kemampuan praktik mahasiswa secara objektif.

PALS (Pediatric Advanced Life Support): Pelatihan penanganan kegawatdaruratan pada pasien anak.

Patient Safety: Prinsip keselamatan pasien untuk mencegah kesalahan dan cedera selama proses pelayanan kesehatan.

Pattern Recognition: Strategi pengambilan keputusan berdasarkan pengenalan pola tanda dan gejala yang pernah ditemui sebelumnya.

Primary Survey: Pemeriksaan awal yang berfokus pada identifikasi masalah yang mengancam nyawa menggunakan pendekatan ABCDE.

Prioritas Triage: Pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan untuk menentukan urutan pelayanan.

Rapid Assessment: Pengkajian cepat untuk mengidentifikasi kondisi kritis pasien dalam waktu singkat.

Resuscitation: Tindakan penyelamatan hidup untuk mempertahankan fungsi vital pasien.

Secondary Survey: Pemeriksaan lanjutan secara lebih lengkap setelah kondisi pasien stabil.

Shock (Syok): Kondisi kegagalan sirkulasi yang menyebabkan perfusi jaringan tidak adekuat dan dapat mengancam nyawa.

Triage: Proses pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan untuk menentukan prioritas penanganan.

Urgent: Kategori triage untuk pasien yang membutuhkan penanganan segera namun tidak dalam kondisi mengancam nyawa langsung.

Very Urgent: Kategori triage untuk pasien dengan kondisi berat yang memerlukan penanganan cepat dalam waktu singkat.

Vital Signs (Tanda Vital): Parameter fisiologis dasar yang meliputi tekanan darah, nadi, suhu tubuh, dan frekuensi pernapasan untuk menilai kondisi pasien.

J. Daftar Pustaka

- Becker, J. B., Lopes, M. C. B. T., Pinto, M. F., Campanharo, C. R. V., Barbosa, D. A., & Batista, R. E. A. (2015). Triage at the Emergency Department: association between triage levels and patient outcome. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, 49(05), 0783-0789.
- Christ, M., Grossmann, F., Winter, D., Bingisser, R., & Platz, E. (2010). Modern triage in the emergency department. *Deutsches Ärzteblatt International*, 107(50), 892.
- Fernandes, M., Vieira, S. M., Leite, F., Palos, C., Finkelstein, S., & Sousa, J. M. (2020). Clinical decision support systems for triage in the emergency department using intelligent systems: a review. *Artificial intelligence in medicine*, 102, 101762.
- Kim, H. S. (2012). Outcomes-based curriculum development and student evaluation in nursing education. *Journal of Korean academy of nursing*, 42(7), 917-927.
- Lin, H. (2023). Action research on the application of OBE based hybrid teaching mode of Basic Nursing. *Pacific International Journal*, 6(1), 12-19.

- Moll, H. A. (2010). Challenges in the validation of triage systems at emergency departments. *Journal of clinical epidemiology*, 63(4), 384-388.
- Phiri, M., Heyns, T., & Coetzee, I. (2020). Patients' experiences of triage in an emergency department: A phenomenographic study. *Applied nursing research*, 54, 151271.
- Shasha, J., Chang, L., Mei, W., Xin, F., & Xiangshu, C. (2023). OBE Concept in Chinese Nursing Education Current Status of Application. *Nursing and Health Research*, 2(4), 53.
- Tan, K., Chong, M. C., Subramaniam, P., & Wong, L. P. (2018). The effectiveness of outcome based education on the competencies of nursing students: A systematic review. *Nurse education today*, 64, 180-189.
- Wolf, L. A., Delao, A. M., Perhats, C., Moon, M. D., & Zavotsky, K. E. (2018). Triageing the emergency department, not the patient: United States emergency nurses' experience of the triage process. *Journal of emergency nursing*, 44(3), 258-266.
- Yancey, C.C. and O'Rourke, M.C., 2020. Emergency department triage.

BAB 3

PENILAIAN AWAL GAWAT DARURAT: PENDEKATAN ABCDE

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-3	Mampu melakukan penilaian awal dan stabilisasi dasar (ABCDE) serta tindakan emergensi dasar sesuai keselamatan pasien.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-3	Melakukan penilaian awal gawat darurat dengan pendekatan ABCDE, menetapkan prioritas, dan melakukan tindakan awal sesuai kebutuhan.
CPMK-4	Melaksanakan manajemen airway dan oksigenasi dasar serta intervensi awal kegawatdaruratan pernapasan secara aman dan terukur.
CPMK-5	Melaksanakan bantuan hidup dasar (dewasa, anak, bayi) dan penanganan awal henti jantung/kegawatdaruratan kardiovaskular sesuai prosedur keselamatan.

Tabel Pemetaan Bab-Sub-CPMK-CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 3. Penilaian Awal Gawat Darurat: Pendekatan ABCDE	3.1 Melaksanakan urutan ABCDE dan mengidentifikasi kondisi mengancam nyawa.	3.2 Menetapkan prioritas tindakan awal dan melakukan re-	CPMK-3	CPMK-4; CPMK-5

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
		evaluasi terstruktur.		

Tabel Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-3	OSCE ABCDE + checklist	Ketepatan urutan ABCDE (persentase item terpenuhi) dan ketepatan prioritas tindakan awal tanpa kesalahan kritis.	15	Checklist OSCE; catatan tindakan

Rubrik CPMK-3 (skala 1-4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Ketepatan urutan ABCDE (item checklist)	≤60% item terpenuhi; ada kesalahan kritis	61–75% item terpenuhi; ada item penting terlewat	76–90% item terpenuhi; tanpa kesalahan kritis	>90% item terpenuhi; sangat sistematis
3.2 Ketepatan prioritas tindakan awal & re-evaluasi	Prioritas tidak tepat; re-evaluasi tidak dilakukan	Prioritas cukup; re-evaluasi terbatas	Prioritas tepat; re-evaluasi terstruktur	Prioritas sangat tepat; re-evaluasi konsisten dan cepat

A. Definisi

Penilaian awal gawat darurat dengan pendekatan ABCDE merupakan suatu kerangka kerja sistematis untuk melakukan penilaian klinis secara cepat dan berurutan untuk mengidentifikasi serta menangani kondisi yang mengancam nyawa pada pasien dengan memprioritaskan pemeriksaan dan intervensi pada komponen Airway (jalan napas), Breathing (pernapasan), Circulation (sirkulasi), Disability (status neurologis), dan Exposure (pemeriksaan menyeluruh). Pendekatan ABCDE digunakan untuk menilai dan merawat pasien. Penilaian awal dilakukan secara lengkap dan penilaian ulang dilakukan secara berkala (Resuscitation Council UK, 2024). Pengkajian awal dengan pendekatan ABCDE telah digunakan secara luas untuk kondisi gawat darurat baik kasus trauma maupun non-trauma (Bruinink et al., 2024). Pendekatan ABCDE memiliki beberapa prinsip utama sebagaimana tampak pada table 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1: Prinsip-Prinsip Utama Pendekatan ABCDE

Prinsip	Penjelasan
Prioritas berbasis ancaman	Kondisi yang paling mengancam nyawa harus ditangani terlebih dahulu (<i>treat first what kills first</i>).
Sistematis dan berurutan	Penilaian ABCDE harus dilakukan secara berurutan, dimulai dari A (<i>airway</i>) dan berakhir di E (<i>exposure</i>). Tidak boleh ada langkah-langkah yang terlewati.
Intervensi segera	Penanganan terhadap kondisi mengancam nyawa pada setiap tahap ABCDE harus ditangani segera sebelum berlanjut ke komponen selanjutnya. Setiap gangguan yang mengancam nyawa harus segera dikenali dan ditangani sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.
Penilaian ulang secara berkala	Setelah intervensi dilakukan pada setiap komponen, maka penilaian ulang secara berkelanjutan harus terus dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dari intervensi yang telah dilakukan.

Pendekatan tim	Pendekatan ABCDE menekankan pentingnya keterlibatan multidisiplin tim.
Keselamatan penolong	Sebelum melakukan Tindakan ABCDE secara sistematis, pastikan penolong menggunakan APD (Alat Proteksi Diri) yang memadai. Pastikan lokasi aman bagi penolong.

B. Tujuan

Penilaian awal gawat darurat dengan pendekatan ABCDE dilakukan untuk memastikan bahwa pasien dalam kondisi gawat darurat segera teridentifikasi dan mendapat penanganan cepat tepat terhadap masalah yang mengancam nyawa. Peningkatan pengetahuan dan latihan secara terstruktur dapat meningkatkan performa perawat dalam melakukan pengkajian awal dengan pendekatan ABCDE (Rogachevsky et al., 2025). Tujuan penilaian ABCDE antara lain:

- 1. Mengidentifikasi kondisi yang mengancam nyawa secara cepat.** Pendekatan ABCDE yang sistematis membantu tenaga kesehatan untuk lebih cepat dalam mengidentifikasi gangguan mengancam nyawa seperti sumbatan jalan napas, syok, penurunan kesadaran, dan lainnya (Peate & Brent, 2021).
- 2. Menentukan prioritas penanganan.** Pendekatan ABCDE membantu tenaga kesehatan dalam memprioritaskan intervensi berdasarkan tingkat kegawatan, sehingga Tindakan yang paling menyelamatkan nyawa akan dilakukan terlebih dahulu (Peate & Brent, 2021).
- 3. Melakukan intervensi segera (*life-saving interventions*).** Pendekatan ABCDE tidak hanya bersifat diagnostik, namun langsung disertai intervensi segera jika ditemukan masalah yang mengancam nyawa. Penolong tidak diperkenankan melanjutkan ke komponen selanjutnya jika masalah pada komponen sebelumnya belum teratasi (Resuscitation Council UK, 2024). Contohnya: jika penolong menemukan masalah pada A (*airway*) yakni berupa adanya sumbatan pada jalan napas, maka penolong wajib menyelesaikan masalah tersebut sebelum beralih ke komponen B (*breathing*).
- 4. Menstabilkan kondisi pasien.** Penilaian awal dengan pendekatan ABCDE bertujuan untuk memastikan fungsi vital pada pasien tetap stabil sebelum dilakukan pemeriksaan dan intervensi lanjutan (Parchim & Nielsen, 2023).
- 5. Mencegah perburukan kondisi pasien.** Pemeriksaan secara cepat dan intervensi tepat dapat mencegah terjadinya komplikasi yang mengakibatkan kematian (Turcato et al., 2025).
- 6. Menyediakan pendekatan sistematis dan terstandar.** Pemeriksaan awal dengan pendekatan ABCDE memberikan algoritma yang jelas dan konsisten

sehingga meminimalisir terjadinya *human error*, serta dapat mengoptimalkan keselamatan pasien (Peate & Brent, 2021).

7. Mendukung pengambilan keputusan klinis dan kolaborasi tim. Pendekatan ABCDE menyediakan standar yang sama bagi tenaga kesehatan dalam tata laksana pasien dalam kondisi gawat darurat sehingga memudahkan komunikasi dan kolaborasi tim (Zeghier Al-Rwili et al., 2024).

C. Indikasi

Penilaian awal dengan pendekatan ABCDE dilakukan untuk setiap pasien dengan kondisi gawat darurat (*critically ill*) dan deteriorasi klinis, baik disebabkan oleh kondisi trauma maupun non-trauma, serta berlaku untuk berbagai setting pelayanan, mulai dari *pra-hospital* hingga ruang rawat inap. Pendekatan ABCDE digunakan untuk pasien dengan penurunan kesadaran, sesak napas, syok, perdarahan hebat, multiple-trauma, henti jantung maupun kondisi akut lain yang memerlukan intervensi segera (Woolfe Loftus et al., 2024).

D. Kontraindikasi

Penilaian awal dengan pendekatan ABCDE hampir tidak memiliki kontraindikasi mutlak, dikarenakan pendekatan ini dirancang sebagai sebuah metode universal dan fleksible untuk segala kondisi gawat darurat. Pendekatan ini bersifat fleksible karena beberapa kondisi khusus yang memerlukan modifikasi. Pendekatan ABCDE dalam pelaksanaannya bersifat adaptif, fleksibel, dan berbasis kondisi klinis pasien. Namun, pada pasien yang telah terkonfirmasi positif mengalami henti jantung (*cardiac arrest*), maka tim kesehatan tidak perlu menggunakan pendekatan ABCDE. Pada pasien dengan henti jantung (*cardiac arrest*) langsung dilakukan intervensi resusitasi jantung paru atau CPR (*Cardiopulmonary Resuscitation*) dengan prinsip CAB (*Circulation-Airway-Breathing*) (Breeding et al., 2023).

E. Alat Dan Bahan

Berikut ini merupakan daftar kebutuhan alat dan bahan yang digunakan dalam penilaian awal dengan pendekatan ABCDE, dikelompokkan berdasarkan komponen penilaiannya.

1. Alat dan bahan untuk perlengkapan keselamatan

Tabel 3.2: Alat dan Bahan untuk Perlengkapan Keselamatan

Alat/ Bahan	Fungsi
Alat Pelindung Diri (APD): sarung tangan medis, masker, pelindung wajah.	Melindungi penolong dari paparan cairan tubuh atau bahan infeksius lainnya.
Hand sanitizer/ desinfektan	Kebersihan tangan sebelum dan setelah prosedur sebagai standar pencegahan infeksi.
Alat komunikasi	Sebagai sarana komunikasi memanggil bantuan atau layanan darurat, mempermudah koordinasi tim.

2. Alat dan bahan berdasarkan komponen ABCDE

Tabel 3.3: Alat dan Bahan berdasarkan Komponen ABCDE

Komponen	Alat/Bahan
<i>A (Airway)</i>	Cervical collar
	Masker oksigen
	Suction portable dan kateter suction
	Airway adjunct: - Oropharyngeal Airway - Nasopharyngeal Airway
	Laringoskop
	Endotrakheal tube (ETT)
	Lubrikan
	Kassa steril
<i>B (Breathing)</i>	Stetoskop
	Pulse oximetri
	Bag Valve Mask (BVM) dan reservoir
	Nebulizer
	Needle decompression kit
	Set tabung oksigen dan flowmeter
	Masker oksigen, nasal canul, dll
<i>C (Circulation)</i>	Tensimeter
	Monitor ECG
	Intravenous cannula
	Cairan kristaloid (NaCl atau RL)

	Tourniquet
	Kassa steril dan perban
	Infus set dan three-way stopcock
	Sput dan needle
	Plester
D (<i>Disability</i>)	Penlight
	Glucometer set
	Skala GCS/ AVPU
	Jam
E (<i>Exposure</i>)	Gunting
	Selimut hangat
	Alat penghangat
	Termometer

3. Alat dan bahan tambahan untuk perawatan lanjutan di Rumah Sakit

Tabel 3.4: Alat dan Bahan Tambahan untuk Perawatan Lanjutan

Alat/ Bahan	Fungsi
Defibrillator/ AED	Digunakan untuk pasien dengan aritmia mengancam nyawa.
Ultrasound	Digunakan untuk melakukan evaluasi cepat penyebab syok, pneumothorax, atau efusi, dll.
Laboratorium cepat (<i>blood gas analyzer</i>)	Digunakan untuk menganalisis gas darah arteri.

F. Persiapan Pasien/Perawat/Lingkungan

- 1. Persiapan tim kesehatan.** Tim kesehatan yang terlibat dalam prosedur penilaian awal dengan pendekatan ABCDE dipastikan memiliki kompetensi klinis yang memadai, mampu bekerja secara cepat dan mampu berkolaborasi dalam tim (Schoeber et al., 2022). Sebelum memberikan pertolongan, tim kesehatan harus menggunakan alat proteksi diri yang memadai (HOU et al., 2021).
- 2. Persiapan lingkungan.** Pastikan lingkungan sekitar area kejadian aman, pencahayaan cukup, bebas dari bahaya baik bagi pasien maupun penolong. Lingkungan harus aman dari bahaya fisik seperti listrik, bahan kimia, kekerasan, lalu lintas, dll. Pastikan alat-alat medis dalam jangkauan penolong. Minimalkan kebisingan agar tidak mengganggu komunikasi antar anggota tim penolong.

Miss-communication diantara tim kesehatan sering menjadi kendala tersendiri dalam kondisi gawat darurat (Bakhrul et al., 2023).

3. **Persiapan pasien.** Letakkan pasien pada posisi yang aman, sehingga memudahkan akses cepat untuk pemeriksaan. Tabel 5 berikut ini menyajikan kondisi pasien dan posisi yang direkomendasikan. Lakukan komunikasi dan minta *informed consent* jika pasien sadar. Jika pasien tidak sadar, maka segera lakukan penilaian awal ABCDE dengan prinsip *implied consent*. Waspadai beberapa posisi yang tidak dianjurkan untuk pasien dicurigai mengalami cedera pada servikal dan tulang belakang (Weir RAMC, 2023).

Tabel 3.5: Kondisi Pasien dan Posisi yang Direkomendasikan

Kondisi Pasien	Posisi yang Direkomendasikan
Tidak ada trauma pada area cervical	Posisi <i>semi-fowler</i>
Dicurigai ada trauma pada area cervical	Posisi terlentang dengan immobilisasi leher (<i>cervical collar</i>)
Syok/ hipotensi	Posisi Trendelenburg, tinggikan kaki 15-30° untuk meningkatkan aliran balik vena
Kehamilan >20 minggu	Miring kiri atau ganjal pinggul kanan untuk mencegah kompresi pada vena cava inferior

G. Langkah Prosedur

Tabel 3.6: Prosedur Penilaian Awal dengan Pendekatan ABCDE

Komponen	Pemeriksaan	Tujuan
A (<i>Airway</i>)	- Buka jalan nafas - Jika terdengar bunyi <i>gurgling</i>, bersihkan cairan pada jalan nafas dengan suction atau gunakan teknik <i>finger swab</i> - Jika terdengar bunyi <i>snoring</i>, pastikan lidah tidak menutup jalan nafas, pasang oropharyngeal tube	Jalan nafas paten
B (<i>Breathing</i>)	- Gunakan teknik <i>look, listen, feel</i> - <i>Look</i>: lihat gerakan dinding dada - <i>Listen</i>: dengarkan suara hembusan nafas	Ventilasi lancar dan kebutuhan oksigen pasien tercukupi

	- <i>Feel</i>: gunakan punggung tangan, rasakan hembusan napas ekspirasi pasien - Kaji frekuensi napas, irama dan kedalaman napas, kesimetrisan gerakan dinding dada - Identifikasi adanya suara napas tambahan - Waspadaai adanya emfisema subkutan - Waspadaai adanya deviasi trachea - Berikan terapi oksigen sesuai kebutuhan	
C (<i>Circulation</i>)	- Ukur tekanan darah dan frekuensi nadi - Identifikasi adanya distensi pada vena jugularis - Kaji <i>capillary refill time</i> - Kaji adanya perdarahan, hentikan perdarahan dengan tekanan langsung dan pembebatan (<i>massive haemorrhage protocol</i>) - Kaji apakah pasien tampak sianosis - Ambil sampel darah pasien - Pasang akses IV line/ infus - Lakukan transfuse jika diperlukan	Sirkulasi stabil
D (<i>Disability</i>)	- Kaji tingkat kesadaran dengan AVPU/ GCS - Kaji reaksi dan kesimetrisan pupil terhadap rangsangan cahaya - Ukur kadar glukosa darah - Kaji pemeriksaan neurologis standar	Evaluasi status neurologis
E (<i>Exposure</i>)	- Lakukan pemeriksaan <i>head to toe</i> - Kaji riwayat medis pasien - Kaji suhu tubuh pasien - Kaji adanya edema, injury, scare, dll - Kaji adanya perubahan warna kulit	Thermomanagement

	- Jika diperlukan pasang selang kateter urine, NGT (<i>Naso Gastric Tube</i>)	
--	---	--

H. Hal Yang Harus Diperhatikan/ *Patient Safety*

Tabel 3.7: berikut ini menyajikan Do's (lakukan) dan Don't (jangan lakukan) pada penilaian awal dengan Pendekatan ABCDE.

Tabel 3.7: Do's (lakukan) dan Don't (jangan lakukan)
pada penilaian awal dengan Pendekatan ABCDE

Tahapan	Do's (Lakukan)	Don't (Jangan Lakukan)
A (<i>Airway</i>)	Gunakan teknik <i>jaw-thrust</i> jika pasien dicurigai mengalami trauma pada servikal.	Jangan lakukan <i>head-tilt/chin-lift</i> pada pasien yang diduga mengalami trauma pada servikal.
B (<i>Breathing</i>)	Berikan segera oksigen aliran tinggi (10-15 lpm) melalui <i>non-rebreathing mask</i> pada pasien kritis. Amati posisi trachea dan pengembangan dada. Posisi trachea asimetris mengarah kecurigaan pada <i>tension pneumothorax</i> .	Jangan menunda pemberian oksigen, terutama pada pasien yang menunjukkan frekuensi napas sangat cepat (>30x/menit).
C (<i>Circulation</i>)	Pasang IV line 2 jalur dengan ukuran besar. Kontrol perdarahan dengan penekanan langsung (<i>direct pressure</i>) dan pembebatan.	Jangan hanya menggunakan tekanan darah untuk menilai syok, identifikasi nadi dan perfusi perifer. Hindari pemberian cairan berlebih pada trauma tumpul thorax.
D (<i>Disability</i>)	Lakukan penilaian Tingkat kesadaran secara cepat dengan GCS atau AVPU. Lakukan pemeriksaan pada pupil mata.	Jangan mengasumsikan penurunan kesadaran hanya disebabkan karena konsumsi alkohol sebelum menyingkirkan penyebab medis seperti hipoglikemia/hipoksia.

E (<i>Exposure</i>)	Gunting pakaian untuk melakukan pemeriksaan pada seluruh tubuh termasuk bagian punggung/ belakang. Berikan pasien selimut untuk mencegah terjadinya hipotermia setelah dilakukan pemeriksaan.	Jangan biarkan pasien dalam kondisi terbuka (telanjang) terlalu lama karena dapat mengakibatkan hipotermia. Jangan memindahkan pasien trauma tanpa teknik <i>log-roll</i> yang benar.
-----------------------	---	---

I. Komplikasi

Penilaian awal dengan pendekatan ABCDE tidak menimbulkan komplikasi jika dilakukan dengan tepat. Namun, terdapat beberapa risiko yang dapat timbul jika intervensi tidak dilakukan secara cepat dan tepat. Berikut ini risiko komplikasi yang dapat terjadi selama prosedur penilaian awal dengan pendekatan ABCDE.

- 1. Komponen ABCDE ada yang terlewatkan.** Jika ada komponen pemeriksaan ABCDE yang terlewat, maka dapat mengakibatkan kondisi yang mengancam nyawa terlambat teridentifikasi (Peate & Brent, 2021).
- 2. Tidak dilakukan *reassessment* secara berkala.** Pemeriksaan secara berkala yang tidak dilakukan dapat mengakibatkan perburukan kondisi pada pasien, intervensi yang telah dilakukan sebelumnya tidak diketahui efektivitasnya (Woolfe Loftus et al., 2024).
- 3. Prosedur pembebasan jalan napas (*airway*) yang tidak tepat.** Intervensi *head-tilt/ chin-lift* yang dilakukan pada pasien dengan trauma servikal dapat memperberat cedera spinal dan mengakibatkan kerusakan pada medulla spinalis. Ketidaktepatan pemilihan ukuran oropharyngeal tube (OPA) dapat menimbulkan muntah, aspirasi, trauma mukosa pada area mulut (Yang et al., 2025). Prosedur *suction* yang tidak dilakukan dengan tepat dapat mengakibatkan pasien kehabisan oksigen (hipoksia).
- 4. Prosedur pemberian terapi oksigen (*breathing*) yang tidak tepat.** Ventilasi yang berlebihan pada penggunaan BVM (*Bag Valve Mask*) dapat mengakibatkan pneumothorax dan penurunan *venous return*. Pemberian oksigen konsentrasi tinggi pada pasien COPD dapat mengakibatkan retensi karbondioksida, asidosis respiratorik, dan depresi napas (Gandra d'Almeida et al., 2022).
- 5. Prosedur *circulation* yang tidak tepat.** Resusitasi cairan yang tidak tepat dapat mengakibatkan edema paru, gagal jantung akut. Pemasangan akses intra vena dengan ukuran canule besar dapat mengakibatkan hematoma, flebitis, infeksi (Herawati et al., 2025).

6. **Prosedur *disability* yang tidak tepat.** Pemberian dekstrosa pada hipoglikemi tanpa konfirmasi dapat mengakibatkan hiperglikemi reaktif, osmotik diuresis (Verma et al., 2024).
7. **Prosedur *exposure* yang tidak tepat.** Pasien dibiarkan dalam kondisi terbuka (telanjang) dalam waktu lama dapat mengakibatkan hipotermia. Prosedur *log-roll* yang tidak tepat beresiko menimbulkan cedera pada tulang belakang (Markowitz & Woods, 2021).

Untuk mencegah terjadinya komplikasi akibat ketidaktepatan prosedur penilaian awal dengan pendekatan ABCDE maka petugas kesehatan harus memperhatikan beberapa hal, antara lain: tangani masalah yang mengancam nyawa sesegera mungkin setelah teridentifikasi, lakukan *reassessment* secara berkala, jangan ragu meminta bantuan senior atau tim spesialis jika kondisi pasien sangat kompleks, gunakan seluruh tim agar penilaian dan intervensi dapat berjalan secara simultan, hanya lakukan intervensi yang menjadi kompetensi kita, jaga keselamatan pasien dan penolong (Zeghier Al-Rwili et al., 2024).

J. Evaluasi Hasil

Evaluasi hasil penilaian awal dengan pendekatan ABCDE dilakukan untuk menilai efektivitas intervensi yang telah diberikan serta memastikan stabilitas fungsi vital pasien secara berkelanjutan (Stahel & Olson, 2022). Evaluasi mencakup pemantauan parameter vital seperti saturasi oksigen, tekanan darah, frekuensi napas, dan tingkat kesadaran pasien. Evaluasi ini sangat penting dilakukan mengingat bahwa kondisi pasien gawat darurat sangat dinamis, sehingga penilaian ulang wajib dilakukan setiap 5-10 menit pada pasien dengan kondisi tidak stabil atau segera setelah setiap tindakan penting (Mubairk Alotaibi et al., 2024).

K. Dokumentasi

Dokumentasi untuk prosedur penilaian awal dapat dilakukan dengan format SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*) yang dikombinasikan dengan ABCDE (Li et al., 2022). Berikut ini merupakan contoh dokumentasi SBAR dengan pendekatan ABCDE:

Tabel 3.8: contoh dokumentasi SBAR dengan pendekatan ABCDE

<i>S (Situation)</i>	:	Pasien laki-laki, usia sekitar 25 tahun, korban kecelakaan lalu lintas, dibawa ke IGD, terdengar suara gurgling, mulut penuh dengan darah (airway), gerakan dinding dada simetris, cepat, teraba deviasi trachea (breathing), terdapat perdarahan massive pada area
----------------------	---	---

		pergelangan tangan kanan (<i>circulation</i>), pasien mengalami penurunan kesadaran, berespon terhadap rangsangan berupa nyeri (<i>disability</i>), terdapat luka laserasi sepanjang 6 cm pada pergelangan tangan kanan, luka abrasi pada lutut kanan dan kiri (<i>exposure</i>).
B (<i>Background</i>)	:	Riwayat medis tidak terkaji, pasien dibawa ke IGD oleh penolong orang awam, tiba di IGD pukul 15.15 WIB
A (<i>Assessment</i>)	:	A = Jalan napas paten, telah dilakukan suction B = Terpasang NRBM 15 lpm C = Pembebatan pada pergelangan tangan kanan D = AVPU (Pain) E = Tidak terdapat fraktur, suhu dalam batas normal
R (<i>Recommendation</i>)	:	Perlu foto thorax, evaluasi terapi oksigen

AKTIVITAS 1 — KNOWS HOW

Mini-Case Study: Diskusi Kelompok Penilaian Awal dengan Pendekatan ABCDE

Perempuan usia 25 tahun korban kecelakaan lalu lintas, dibawa ke IGD dengan kondisi tidak sadarkan diri, korban tampak lemah. Hasil pemeriksaan menunjukkan GCS 10, terdengar suara *snoring*, napas dangkal dan cepat, gerakan dinding dada simetris, frekuensi napas 26x/menit, frekuensi nadi 62x/menit, tekanan darah 90/60 mmHg, akral teraba dingin, CRT >2 detik, terdapat tanda-tanda fraktur terbuka pada os femur dekstra disertai perdarahan massive. Terdapat luka abrasi pada lutut kanan dan kiri.

Petunjuk Diskusi Kelompok

- Mahasiswa dibagi dalam kelompok kecil, setiap kelompok terdiri atas 5-7 mahasiswa
- Identifikasi komponen ABCDE pada ilustrasi kasus
- Identifikasi kondisi yang mengancam nyawa pada ilustrasi kasus
- Diskusikan dalam kelompok intervensi yang dilakukan berdasarkan ilustrasi kasus
- Diskusikan dalam kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas
- Hasil diskusi dipresentasikan dalam bentuk *power point*

AKTIVITAS 2 — SHOWS HOW

Simulasi: Penilaian Awal dengan Pendekatan ABCDE (OSCE)

Soal OSCE

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	 (Dikosongkan)
2	Judul station	Penilaian Awal dengan Pendekatan ABCDE
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan penilaian awal pada kasus pasien gawat darurat dengan pendekatan ABCDE, menetapkan prioritas, dan melakukan tindakan awal sesuai kebutuhan.
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku profesional
6	Kategori	Oksigenasi
7	Instruksi untuk peserta ujian	<u>SKENARIO KLINIK:</u> Laki-laki usia 19 tahun korban kecelakaan lalu lintas, dibawa ke IGD dengan kondisi tidak sadarkan diri, korban tampak lemah. Hasil pemeriksaan menunjukkan GCS 12, terdengar suara <i>gurgling</i>, napas dangkal dan cepat, gerakan dinding dada simetris, frekuensi napas 26x/menit, frekuensi nadi 72x/menit, tekanan darah 100/60 mmHg, akral teraba dingin. Terdapat Terdapat jejas pada dinding thorax, luka abrasi pada lutut kanan dan kiri. <u>TUGAS:</u> a. Lakukan penilaian awal dengan pendekatan ABCDE berdasarkan skenario tersebut pada manekin. b. Tuliskan prioritas masalah yang mengancam nyawa berdasarkan skenario

		c. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawaban berdasarkan skenario di atas d. Lakukan prioritas tindakan awal dan reassessment
8	Instruksi untuk penguji	<u>SKENARIO KLINIK:</u> Laki-laki usia 19 tahun korban kecelakaan lalu lintas, dibawa ke IGD dengan kondisi tidak sadarkan diri, korban tampak lemah. Hasil pemeriksaan menunjukkan GCS 12, terdengar suara <i>gurgling</i>, napas dangkal dan cepat, gerakan dinding dada simetris, frekuensi napas 26x/menit, frekuensi nadi 72x/menit, tekanan darah 100/60 mmHg, akral teraba dingin. Terdapat jejas pada dinding thorax, luka abrasi pada lutut kanan dan kiri. <u>TUGAS:</u> a. Lakukan penilaian awal dengan pendekatan ABCDE berdasarkan skenario tersebut pada manekin. b. Tuliskan prioritas masalah yang mengancam nyawa berdasarkan skenario c. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawaban berdasarkan skenario di atas d. Lakukan prioritas tindakan awal dan reassessment <u>INSTRUKSI PENGUJI:</u> a. Menilai ketepatan peserta dalam menentukan pengkajian fokus tambahan, yaitu identifikasi pemeriksaan kesimetrisan trakhea. Pada saat peserta melakukan pemeriksaan trachea, penguji menyampaikan bahwa terjadi deviasi trachea. b. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan label diagnosis keperawatan: Pola napas tidak efektif berhubungan dengan

		hambatan upaya napas (trauma pada thorax) ditandai dengan napas dangkal dan cepat, frekuensi napas 26x/menit, terdapat jejas pada dinding thorax, terdapat deviasi trachea (dicurigai terjadi Tension Pneumothorax). c. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan intervensi keperawatan yang sesuai, seperti pemberian terapi oksigen aliran tinggi (10-15 lpm) dengan NRBM, melakukan <i>needle decompression</i>. d. Menilai ketepatan penampilan peserta dalam edukasi dan informasi kepada keluarga, meliputi menjelaskan tujuan dari tindakan <i>needle decompression</i>, serta menjelaskan komplikasi yang mungkin terjadi. e. Monitor perilaku profesional peserta. f. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: a. Identitas pasien sesuai kasus: laki-laki usia 19 tahun, KS berperan sebagai keluarga pasien. b. Riwayat penyakit sekarang: korban tidak sadarkan diri, dibawa ke IGD akibat kecelakaan lalu lintas c. Rawat inap saat ini adalah hari pertama, dan saat ini pasien masih berada di IGD RS d. Riwayat penyakit keluarga: di keluarga ada yang memiliki Riwayat penyakit Diabetes Mellitus (Ibu) e. Riwayat kebiasaan sosial: keluarga menyebutkan bahwa pasien sebelumnya sudah pernah mengalami kecelakaan lalu lintas akibat balap liar

		f. Harapan terhadap penyakit: keluarga berharap agar pasien segera membaik dan dapat sehat seperti sedia kala. g. Bila peserta menanyakan riwayat penyakit sebelumnya, jawaban KS: pasien pernah masuk RS, 5 bulan yang lalu akibat kecelakaan lalu lintas, balap liar, dilakukan operasi pada paha sebelah kanan h. KS berdiri di samping tempat tidur pasien dengan raut wajah cemas. Pasien dapat digambarkan melalui manekin/alat bantu pasien dewasa. Peran harus dilakukan secara jelas agar tidak membingungkan peserta ujian.
10	Setting station	Ruang IGD - Tempat tidur pasien - Manekin dewasa - KS berperan sebagai keluarga pasien - Laboran - Penguji Tata letak ruang: 1. Tempat tidur dan manekin dewasa 2. Kursi KS 3. Meja penguji 4. Kursi penguji 5. Pintu masuk 6. Troli alat 7. Wastafel/handrub 8. Tempat sampah 9. Kursi laboran
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: a. Sarung tangan bersih dan steril b. Handrub/hand sanitizer c. Kassa steril d. Suction set e. Kom

		f. Larutan NaCl g. Bengkok h. Pengalas i. Tabung oksigen dan flowmeter j. Masker oksigen k. <i>Needle decompression set</i> l. Lembar jawaban peserta Peran laboran: merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	Dr. Nurma Afiani, S.Kep., Ns., M.Kep.
13	Referensi	a. Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. b. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. c. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. d. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

**STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PENILAIAN AWAL DENGAN PENDEKATAN ABCDE**

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan		Kompeten	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
A	Tahap Pra Interaksi				
	1. Menyiapkan alat dan perlengkapan				

	a. Airway: servical collar, kassa steril, suction set, airway adjunct (oropharyngeal tube/ nasopharyngeal tube), laringoskop, lubrikan, endo tracheal tube (ETT). b. Breathing: tabung oksigen, flowmeter, masker oksigen, nasal kanul, stetoskop, bag valve mask (BVM), <i>needle decompression set</i>, nebulizer, pulse oksimetri. c. Circulation: tensimeter, monitor ECG, AED, bebat, bidai, canule intra vena (infuse set), cairan kristaloid (NaCl/ RL), tourniquet, spuit, needle, kassa, plester, gunting plester. d. Disability: penlight, glucometer set, skala pengukuran GCS/ AVPU e. Exposure: thermometer, selimut hangat, gunting pakaian.				
	2. Mencuci tangan				
	3. Memakai APD				
B	Tahap Orientasi				
	4. Menyampaikan salam				
	5. Memperkenalkan diri				
	6. Mengecek identitas pasien				
	7. Menyampaikan maksud dan tujuan				
	8. Memberi kesempatan bertanya				
	9. Memulai tindakan dengan baik				
	10. Menjaga privasi				
C	Tahap Kerja				
	11. Pastikan lokasi sekitar aman (aman pasien, aman penolong, aman lingkungan). Bebas dari bahaya fisik, kebisingan, pencahayaan cukup.				

	12. Letakkan pasien pada posisi terlentang atau sesuaikan dengan kondisi pasien.				
	13. Pengkajian pada Airway: Buka jalan napas, lakukan <i>head-tilt chin-lift</i> (untuk pasien dicurigai cedera servical, lakukan <i>modified jaw thrust</i>), kaji apakah terdapat benda asing pada jalan napas, kaji apakah terdapat suara tambahan seperti <i>snoring</i> atau <i>gurgling</i>. Intervensi pada Airway: Pasang <i>cervical collar</i>, jika terdengar <i>gurgling</i> lakukan suction, jika terdengar <i>snoring</i> pasang oropharyngeal tube, jika terdapat cedera pada area mulut maka gunakan nasopharyngeal tube.				
	14. Pengkajian pada Breathing: Look (lihat gerakan dinding dada), Listen (dengarkan suara napas), Feel (rasakan udara hembusan napas), kaji adanya deviasi trachea, kaji frekuensi napas, pasang oksimetri. Intervensi pada Breathing: Lakukan <i>needle decompresi</i> jika terdapat tanda-tanda tension pneumothorax, berikan terapi oksigen sesuai kebutuhan pasien. Jika pasien sesak, berikan inhaler dengan nebulizer. Jika pasien <i>gasping</i> berikan oksigen dengan BVM.				
	15. Pengkajian pada Circulation: Kaji adanya perdarahan, identifikasi sumber perdarahan, kaji CRT (<i>Capillary Refill Time</i>), kaji ada nya distensi vena jugularis, ukur tekanan darah, nadi,				

	Intervensi pada Circulation: Jika terdapat perdarahan massiev maka lakukan penekanan langsung pada sumber perdarahan, lakukan pembebatan, pasang infus dua jalur, berikan cairan kristaloid.				
	16. Pengkajian pada Disability: Kaji Tingkat kesadaran pasien dengan skala GCS/ AVPU, ukur kadar gula darah pasien, kaji kesimetrisan dan reaksi pupil terhadap rangsangan cahaya Intervensi pada Disability: Jika pasien menunjukkan kondisi hipoglikemia maka berikan dextrose 40% sebanyak 25cc dan dilanjutkan infus D10% 6cc/kgBB.				
	17. Pengkajian pada Exposure: Buka pakaian pasien, kaji seluruh tubuh pasien terhadap adanya jejas, luka, dll termasuk area belakang atau punggung pasien. Lakukan <i>log-roll</i> dengan hati-hati. Kaji suhu tubuh pasien. Intervensi pada Exposure: Pasang selimut hangat untuk mencegah hipotermia, pasang kateter jika diperlukan, pasang NGT jika diperlukan.				
D	Tahap Terminasi				
	18. Lakukan <i>reassessment</i> secara teratur setiap 5-10 menit sekali untuk pasien dalam kondisi tidak stabil 19. Lakukan evaluasi terhadap intervensi yang telah dilakukan 20. Siapkan pasien untuk pemeriksaan diagnostic, seperti rontgen, USG, dll.				

E	Tahap Dokumentasi 21. Catat hari, tanggal, jam kegiatan, metode serta respon dan efek yang ditunjukkan oleh pasien 22. Catat hasil <i>reassessment</i> dan evaluasi kondisi pasien				
F	Penampilan Profesional 23. Aman, nyaman, teliti, cermat, cepat, tepat, responsive.				

L. Form Penilaian Osce Keperawatan Station: Penilaian Awal Dengan Pendekatan Abcde

1. Form Penilaian

No	Kompetensi	Indikator Penilaian	0	1	2	3	Bobot (B)	Nilai (S x B)
1	Pengkajian	Melakukan pengkajian dengan ABCDE dan mengidentifikasi kondisi yang mengancam nyawa						
2	Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Menetapkan diagnosis yang tepat dan menyusun rencana keperawatan yang sesuai						
3	Implementasi keperawatan	Melakukan intervensi <i>life-saving</i> sesuai hasil temuan pada pengkajian						
4	Perilaku profesional	Menjaga privasi, aman, sistematis, cepat, tepat, teliti, responsive						

Keterangan skor:

0 = tidak dilakukan

1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap

2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap

3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

M. Rubrik Penilaian

No	Kompetensi	0	1	2	3	Bobot (B)	Nilai (S x B)
1	Pengkajian keperawatan: aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menggali data focus pada pasien dengan kondisi gawat darurat dengan pendekatan ABCDE. Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara sistematis dan membaca hasil temuan secara benar.						
2	Diagnosis dan perencanaan keperawatan: aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menegakkan diagnosis keperawatan sesuai masalah prioritas pada pasien dengan kondisi gawat darurat serta menyusun rencana keperawatan yang relevan. Peserta menuliskan diagnosis dan perencanaan secara jelas berdasarkan data pada scenario dan hasil validasi pengkajian focus. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.						
3	Implementasi keperawatan: aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam mengimplementasikan tindakan yang telah diidentifikasi dalam rencana asuhan keperawatan. Tindakan yang dimaksud adalah prosedur <i>life-saving</i> dengan langkah-langkah kerja yang aman, tepat, cepat, sistematis, teliti serta						

	sesuai dengan kondisi pasien. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.						
4	Perilaku professional: aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan profesionalisme dengan baik sesuai prinsip etik dan legal, diantaranya memperkenalkan diri, meminta persetujuan Tindakan, berkomunikasi terapeutik, menjaga kenyamanan dan keamanan, menjaga privasi, serta melakukan Tindakan dengan cepat, tepat, hati-hati, teliti, dan responsive. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.						

N. Deskripsi Performa Tiap Skor

Kompetensi	Skor 0	Skor 1	Skor 2	Skor 3
1. Pengkajian keperawatan	Tidak melakukan pengkajian fokus, atau pengkajian tidak relevan dengan kasus gawat darurat.	Melakukan pengkajian sangat terbatas, hanya menggali sebagian kecil data, tidak sistematis, dan tidak mampu mengidentifikasi tanda bahaya ABCDE.	Melakukan pengkajian fokus cukup baik dan cukup sistematis, mampu menggali sebagian besar data penting seperti kepatenan jalan napas, fungsi ventilasi, sirkulasi, tingkat kesadaran,	Melakukan pengkajian fokus secara lengkap, sistematis, dan relevan, meliputi kepatenan jalan napas, fungsi ventilasi, system sirkulasi, Tingkat kesadaran, kondisi keseluruhan tubuh (<i>exposure</i>),

			tetapi masih ada data penting yang terlewat atau interpretasi belum lengkap.	kemudian mampu menyampaikan hasil pengkajian dengan tepat.
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Tidak mampu menegakkan diagnosis keperawatan, atau diagnosis tidak sesuai dengan data kasus. Tidak mampu menyusun rencana keperawatan.	Menegakkan diagnosis keperawatan tetapi tidak tepat sebagai prioritas, atau diagnosis masih kurang sesuai dengan data. Rencana keperawatan sangat terbatas dan tidak relevan.	Menegakkan diagnosis keperawatan yang cukup tepat sesuai masalah utama, dan menyusun rencana keperawatan yang cukup sesuai, namun masih kurang lengkap, kurang spesifik, atau belum sepenuhnya sesuai prioritas klinis.	Menegakkan diagnosis keperawatan prioritas secara tepat berdasarkan data kasus, serta menyusun rencana keperawatan yang lengkap, relevan, sistematis, dan sesuai kebutuhan pasien dengan kondisi gawat darurat.
3. Implementasi keperawatan	Tidak melakukan demonstrasi intervensi <i>life-saving</i> pada pasien gawat darurat atau tindakan yang dilakukan	Melakukan demonstrasi secara terbatas, banyak langkah penting yang tidak dilakukan,	Melakukan demonstrasi dengan cukup baik, sebagian besar langkah sudah benar, namun masih	Melakukan demonstrasi intervensi <i>life-saving</i> secara tepat, aman, sistematis, dan lengkap, meliputi penjelasan

	tidak sesuai prosedur dan berisiko bagi pasien.	penjelasan kurang jelas, dan teknik belum tepat.	ada kekurangan dalam urutan, kelengkapan penjelasan, atau teknik demonstrasi.	tujuan, cara melakukan pembebasan jalan napas, memastikan napas pasien adekuat, teknik menghentikan perdarahan dilakukan secara tepat, mengukur Tingkat kesadaran dengan tepat, menjaga agar pasien tidak hipotermia.
4. Perilaku profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional, tidak memperkenalkan diri, tidak meminta persetujuan, tidak menjaga privasi, dan tidak memperhatikan keamanan maupun kenyamanan pasien.	Menunjukkan sebagian kecil perilaku profesional, tetapi masih kurang dalam komunikasi terapeutik, persetujuan tindakan, privasi, atau keselamatan pasien.	Menunjukkan perilaku profesional yang cukup baik, komunikasi terapeutik cukup jelas, memperhatikan privasi, kenyamanan, dan keamanan pasien, namun masih ada kekurangan kecil dalam sikap atau	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten, meliputi komunikasi terapeutik yang baik, memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menjaga privasi, memperhatikan keamanan dan kenyamanan

			sistematika tindakan.	pasien, bersikap teliti, hati-hati, responsif, dan etis selama tindakan.
--	--	--	-----------------------	--

Keterangan skor:

0 = tidak dilakukan/ seluruh tindakan tidak sesuai

1 = dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis

2 = dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, namun masih ada kekurangan

3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

Global Performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR
-------------	------------	-------	----------

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Jumlah total skor}}{30} \times 100$$

Kota,.....

(.....)

O. Direct Observation Of Prosedural Skills (Dops)

Penilaian Awal Dengan Pendekatan Abcde di Ruang IGD

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien di IGD
Metode penilaian	Mini-CEX merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa dalam encounter singkat, terfokus, dan nyata di lahan praktik.	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi mahasiswa saat memberikan asuhan awal pada pasien dengan masalah pola napas tidak efektif di Ruang IGD.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi, edukasi, dan profesionalisme dalam satu pertemuan klinik.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang kasus gawat darurat, tetapi juga dari kemampuannya melakukan pengkajian, menjelaskan kondisi pasien, dan menyampaikan rencana asuhan kepada keluarga pasien.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau tahap profesi.	Seorang laki-laki usia 19 tahun dibawa ke IGD dalam kondisi sesak napas berat, frekuensi napas 26x/menit, pola napas cepat dan dangkal, gerakan dinding dada simetris, pasien tampak sianosis.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan encounter klinik secara utuh sejak awal interaksi sampai penjelasan rencana tindakan.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan pengkajian singkat namun terarah, memeriksa tanda hipoksia, menjelaskan kondisi pasien, lalu menyampaikan rencana pemberian terapi oksigen.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi anamnesis atau pengkajian,	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menggali

	pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi terapeutik, edukasi keluarga, profesionalisme, dan organisasi tindakan.	frekuensi napas, tanda-tanda gangguan ventilasi, dan menjaga komunikasi yang baik dengan pasien dan keluarganya.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa klinik mahasiswa secara langsung menggunakan format Mini-CEX yang terstruktur.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menghubungkan data klinik dengan masalah prioritas, misalnya perubahan pola napas, serta mampu memberikan edukasi yang tepat dan aman kepada pasien dan keluarganya.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat singkat, spesifik, dan berorientasi pada perbaikan performa.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan identifikasi tanda pola napas tidak efektif, tetapi masih perlu memperdalam pengkajian system pernapasan dan memperjelas penjelasan tentang tanda bahaya.
Keputusan penilaian	Hasil Mini-CEX digunakan untuk menentukan tingkat performa mahasiswa dalam praktik klinik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan encounter klinik secara runtut, aman, komunikatif, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila masih membutuhkan arahan pada beberapa bagian. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila performanya belum memenuhi standar minimal.

Makna dalam OBE	Mini-CEX memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does.	Pada kasus pasien dengan pola napas tidak efektif, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan asuhan keperawatan secara langsung, aman, tepat, dan profesional di lahan praktik.
-----------------	--	---

P. Portofolio

Portofolio Pada Asuhan Keperawatan

Pasien Dengan Jalan Napas Tidak Paten Dan Perdarahan Massive

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien di IGD
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada asuhan keperawatan pasien gawat darurat, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian awal, menetapkan masalah keperawatan, melakukan intervensi <i>life-saving</i> , menjaga keselamatan pasien, melakukan <i>reassessment</i> , serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah merawat pasien dengan kondisi gawat darurat, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.

OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan pembebasan jalan napas, sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan intervensi untuk prosedur menghentikan perdarahan secara langsung.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah keperawatan, intervensi utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus pasien kecelakaan lalu lintas yang dibawa ke IGD dengan kondisi perdarahan massive dan jalan napas tidak paten, diagnosis keperawatan prioritas, intervensi pembebasan jalan napas dan menghentikan perdarahan secara langsung, dan <i>reassessment</i> pada pasien.
Refleksi <i>patient safety</i>	Refleksi <i>patient safety</i> menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan keperawatan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya memantau tanda-tanda jalan napas tidak paten, tanda-tanda syok hipovolemia, memastikan teknik pembebasan jalan napas dilakukan dengan cara yang benar, dan mengenali tanda bahaya perburukan kondisi pasien yang membutuhkan tindakan segera.
<i>Feedback</i> CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam membuka jalan napas dan menghentikan perdarahan secara langsung, tetapi masih

	kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	perlu meningkatkan ketelitian dalam melakukan <i>head-tilt chin-lift</i> terutama pada pasien yang dicurigai mengalami cedera pada cervical.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus gawat darurat, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu melakukan asuhan keperawatan gawat darurat secara aman, tepat, dan profesional.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan pengkajian awal dengan pendekatan ABCDE, menentukan masalah keperawatan prioritas, melakukan intervensi <i>life-saving</i> , melakukan <i>re-assessment</i> dan dokumentasi keperawatan dengan tepat.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada asuhan keperawatan pasien gawat darurat, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep ABCDE, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik klinik nyata.

CASE REPORT

Case Report Pada Asuhan Keperawatan

Pasien Dengan Jalan Napas Tidak Paten Dan Perdarahan Massive

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien di IGD
Hakikat <i>case report</i>	<i>Case report</i> merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, <i>case report</i> berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang korban kecelakaan lalu lintas, laki-laki usia 19 tahun, dibawa ke IGD dalam kondisi tidak sadarkan diri, terdengar <i>gurgling</i> , mulut penuh dengan darah, terdapat luka laserasi pada kaki kanan sepanjang 10cm disertai perdarahan massive.
Tujuan	<i>Case report</i> bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah keperawatan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data pasien, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan yang diberikan, dan perkembangan kondisi pasien setelah intervensi.
Isi laporan	Isi <i>case report</i> biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus pasien gawat darurat dengan jalan napas tidak paten dan perdarahan massive, mahasiswa menuliskan kepatenan jalan napas, suara napas tambahan, adanya luka terbuka, kondisi luka terbuka, tanda-tanda fraktur, diagnosis jalan napas tidak paten dan syok hipovolemik, intervensi pembebasan jalan napas, penghentian perdarahan secara langsung, pemasangan

		infus, <i>re-assessment</i> tiap 5-10 menit sekali.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan intervensi, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan data jalan napas tidak paten dan perdarahan massive dengan masalah utama, memilih intervensi yang tepat, dan menilai respons pasien setelah dilakukan intervensi.
Nilai edukatif	<i>Case report</i> membantu mahasiswa mengembangkan <i>clinical reasoning</i> , keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus jalan napas tidak paten dan perdarahan massive, mahasiswa belajar bahwa pengkajian kepatenan jalan napas, adanya suara napas tambahan, pengkajian tanda-tanda syok hipovolemik dan upaya menghentikan perdarahan secara langsung merupakan bagian yang sangat penting dalam asuhan keperawatan pada pasien dengan kondisi gawat darurat pada komponen A dan C.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, <i>case report</i> menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep ABCDE sebagai sebuah pendekatan dalam pengkajian awal, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan keperawatan secara utuh pada kondisi gawat darurat.

PATIENT SAFETY

Refleksi *Patient Safety* Pada Asuhan Keperawatan Pasien Dengan Perdarahan Massive

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien di IGD
Hakikat refleksi <i>patient safety</i>	Refleksi <i>patient safety</i> merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus pasien dengan perdarahan massive, mahasiswa merefleksikan bahwa kehilangan cairan yang cepat dapat menyebabkan perburukan kondisi bila tidak dikenali dan ditangani dengan tepat.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan keperawatan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti kurang teliti memantau <i>intake-output</i> atau terlambat mengenali tanda syok hipovolemik, dapat berdampak besar pada keselamatan pasien.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada pasien ini adalah syok hipovolemik jika perdarahan tidak segera dihentikan, serta tidak dilakukan pemasangan infus untuk mengganti cairan tubuh yang hilang maupun transfusi darah.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain penurunan tekanan darah,

	situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	akral dingin, CRT>2", penurunan kesadaran.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya intervensi untuk menghentikan perdarahan secara langsung, memasang infus dua jalur.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada pasien dengan perdarahan massive, pengkajian yang teliti, komunikasi antar tim yang jelas, intervensi cepat tepat, dan pemantauan berulang merupakan bagian penting untuk menjaga keselamatan pasien.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi <i>patient safety</i> menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik keperawatan gawat darurat secara berkelanjutan.

Q. Ringkasan

Asuhan Keperawatan

Pasien dengan Perdarahan Massive

Bab ini menjelaskan tentang salah satu kondisi gawat darurat yang umum terjadi di IGD untuk kasus trauma, khususnya pada komponen C (*Circulation*) yakni perdarahan massive. Kondisi ini sering mengalami perburukan yang cepat jika tidak segera mendapatkan pertolongan tepat. Fokus utama asuhan keperawatan pada pasien dengan kondisi gawat darurat perdarahan massive adalah menghentikan perdarahan segera dan penggantian cairan tubuh yang hilang.

Mahasiswa harus memahami bahwa penilaian awal pada kasus gawat darurat dilakukan dengan pendekatan ABCDE. Pengkajian awal dengan pendekatan ABCDE harus dilakukan secara berurutan, jika ditemukan satu komponen mengalami permasalahan, maka harus dilakukan intervensi segera pada komponen tersebut sebelum beralih kepada komponen pengkajian selanjutnya. Pengkajian diawali dari komponen A (*Airway*) yakni mengidentifikasi kepatenan jalan napas; B (*Breathing*) yakni mengkaji fungsi ventilasi; C (*Circulation*) dilakukan dengan mengkaji fungsi sistem peredaran darah pasien; D (*Disability*) dilakukan untuk mengkaji fungsi neurologis pasien; dan E (*Exposure*) untuk mengidentifikasi adanya cedera secara keseluruhan pada tubuh pasien.

Pada tahap implementasi, mahasiswa harus mampu menunjukkan intervensi keperawatan yang cepat, tepat, sistematis, dan aman. *Informed consent* harus dilakukan sebelum tindakan keperawatan, namun jika pasien sedang mengalami penurunan kesadaran maka dijalankan prinsip *implied consent*. Tindakan keperawatan yang penting dilakukan pada pasien dengan perdarahan massive antara lain prosedur penghentian perdarahan secara langsung, pasang infus dua jalur dengan jarum ukuran besar, berikan cairan Ringer Laktat, ambil sampel darah untuk persiapan transfusi darah. Pantau tekanan darah, frekuensi nadi, CRT (*Capillary Refill Time*), suhu akral, dan kenali segera tanda-tanda syok hipovolemik. Lakukan *reassessment* tiap 5-10 menit.

Evaluasi asuhan keperawatan dilakukan dengan *re-assessment* secara berkala pada pasien untuk menilai efektivitas intervensi yang telah dilakukan dan menilai apakah pasien mengalami perbaikan atau perburukan, serta menilai perlunya intervensi alternatif lainnya. Pada pasien korban kecelakaan lalu lintas dengan perdarahan massive, maka perawat melakukan *re-assessment* untuk menilai apakah perdarahan massive masih terjadi, apakah upaya penghentian perdarahan yang telah dilakukan efektif menghentikan perdarahan, atau bahkan sebaliknya perdarahan tak kunjung berhenti. Jika perdarahan tak kunjung berhenti, maka perawat perlu berkomunikasi dengan tim untuk mempertimbangkan adanya

prosedur di ruang operasi untuk menjahit pembuluh darah yang robek. Pada kasus perdarahan massive, evaluasi juga dilakukan untuk menilai status hidrasi pasien, apakah cairan resusitasi yang diberikan telah memperbaiki kondisi pasien, atau pasien harus segera disiapkan untuk mendapatkan transfusi darah.

Pada pasien gawat darurat, waktu sangat berharga, maka intervensi diprioritaskan untuk *life-saving* pasien. Penilaian awal dengan pendekatan ABCDE diimplementasikan sebagai sebuah prosedur standar yang menjadi pedoman dalam tata laksana pasien dengan kondisi gawat darurat baik pada *setting pre-hospital* maupun *in-hospital*. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk cepat, tepat, teliti dan hati-hati namun juga tetap tenang dalam kondisi gawat darurat.

R. Red Flag dan Eskalasi

Pasien dengan Kondisi Gawat Darurat Pada Komponen Abcde

Red Flags	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
Terdengar suara <i>gurgling</i>	Menunjukkan bahwa jalan napas pasien tidak paten, disebabkan adanya sumbatan berupa cairan atau darah.	Lakukan <i>head-tilt chin-lift</i> (untuk pasien tanpa cedera servical) dan <i>modified jaw thrust</i> (untuk pasien yang dicurigai mengalami cedera servical), buka jalan napas, lakukan <i>finger-swab</i> dengan kassa atau suction cairan/ darah pada area mulut. Lakukan <i>re-assessment</i> dan pastikan tidak ada suara napas tambahan.
Terdengar suara <i>snoring</i>	Menunjukkan bahwa jalan napas pasien tidak paten, disebabkan adanya sumbatan akibat lidah yang menutup jalan napas.	Lakukan <i>head-tilt chin-lift</i> (untuk pasien tanpa cedera servical) dan <i>modified jaw thrust</i> (untuk pasien yang dicurigai mengalami cedera servical), buka jalan napas, pasang oropharyngeal tube atau nasopharyngeal tube. Lakukan <i>re-assessment</i> dan pastikan tidak ada suara napas tambahan.

Pasien tampak <i>gasping</i>	Menunjukkan bahwa pasien mengalami tanda-tanda henti napas.	Setelah jalan napas paten. Pasang BVM (<i>Bag Valve Mask</i>), sambungkan dengan sumber oksigen, alirkan oksigen 10-15 lpm, berikan oksigen 10-12x/ menit, pastikan dinding dada mengembang dan mengempis dengan sempurna selama prosedur.
Pasien tidak sadarkan diri, nadi tidak teraba.	Menunjukkan bahwa pasien mengalami henti jantung.	Segera lakukan prosedur CPR (<i>Cardio Pulmonary Resuscitation</i>) dengan prinsip C-A-B.
Nadi teraba lemah, tekanan darah menurun, CRT>2", akral dingin, sianosis	Pasien menunjukkan tanda-tanda syok hipovolemik.	Kaji adanya perdarahan massive, hentikan perdarahan secara cepat, pasang akses infus dua jalur, berikan cairan resusitasi secara cepat, siapkan prosedur transfusi darah.
Tulang tampak deformitas, pasien nyeri hebat, kehilangan fungsi gerak	Pasien dicurigai mengalami fraktur pada area deformitas.	Lakukan pembidaian melewati dua sendi, immobilisasi area yang dicurigai mengalami fraktur.

FORM CHECKLIST 'Saya sudah bisa'
ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN DENGAN PERDARAHAN MASSIVE

Nama Mahasiswa :
 NIM :
 Tanggal :
 Tempat Praktik/ Skill Lab :

Petunjuk: Beri tanda (√) pada kolom yang sesuai

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan konsep pengkajian awal dengan pendekatan ABCDE			
2	Saya sudah bisa melakukan pengkajian awal dengan pendekatan ABCDE			
3	Saya sudah bisa melakukan pengkajian kepatenan jalan napas (<i>Airway</i>)			
4	Saya sudah bisa melakukan pengkajian fungsi ventilasi (<i>Breathing</i>)			
5	Saya sudah bisa melakukan pengkajian pada fungsi sirkulasi (<i>Circulation</i>)			
6	Saya sudah bisa melakukan pengkajian pada fungsi neurologis (<i>Disability</i>)			
7	Saya sudah bisa melakukan pengkajian secara menyeluruh pada pasien (<i>Exposure</i>)			
8	Saya sudah bisa mengidentifikasi masalah keperawatan prioritas pada pasien gawat darurat			
9	Saya sudah bisa menyusun rencana asuhan keperawatan pada pasien gawat darurat			
10	Saya sudah bisa melakukan intervensi pembebasan jalan napas pada pasien gawat darurat			
11	Saya sudah bisa melakukan intervensi terapi oksigen pada pasien gawat darurat			
12	Saya sudah bisa melakukan intervensi menghentikan perdarahan massive			

13	Saya sudah bisa melakukan intervensi resusitasi cairan			
14	Saya sudah bisa melakukan intervensi pada pasien dengan henti napas			
15	Saya sudah bisa melakukan intervensi pada pasien dengan henti jantung			
16	Saya sudah bisa melakukan pertolongan pertama pada pasien hiperglikemia			
17	Saya sudah bisa melakukan pertolongan pertama pada pasien hipoglikemia			
18	Saya sudah bisa melakukan pemasangan kateter urine pada pasien gawat darurat			
19	Saya sudah bisa melakukan pemasangan NGT pada pasien gawat darurat			
20	Saya sudah bisa melakukan pertolongan pertama pada pasien hipotermia			
21	Saya sudah bisa menentukan kapan harus melakukan eskalasi atau melapor			
22	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi singkat asuhan keperawatan gawat darurat			
23	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional, cepat, tepat, dan responsif			

Refleksi singkat mahasiswa:

S. Glosarium

Abrasi (luka)	:	Cedera pada permukaan kulit akibat gesekan atau goresan dengan benda kasar sehingga menyebabkan lapisan epidermis (lapisan kulit paling luar) terkelupas.
<i>Capillary Refill Time (CRT)</i>	:	Metode pemeriksaan sederhana untuk menilai sirkulasi darah perifer atau aliran darah ke jaringan tubuh. Pemeriksaan dilakukan dengan menekan ujung kuku atau kulit hingga pucat, kemudian menghitung waktu yang dibutuhkan warna normal kembali setelah tekanan dilepas.

<i>Cardiac arrest</i>	:	Keadaan henti jantung mendadak ketika jantung berhenti memompa darah secara efektif ke seluruh tubuh.
<i>Defibrillator</i>	:	Alat medis yang digunakan untuk memberikan kejutan listrik (defibrilasi) pada jantung guna mengembalikan irama jantung yang abnormal menjadi normal, terutama pada kondisi henti jantung akibat aritmia berbahaya seperti fibrilasi ventrikel atau takikardia ventrikel tanpa nadi.
Deteriorasi	:	Keadaan memburuknya kondisi seseorang atau sesuatu dari keadaan sebelumnya, baik secara fisik maupun fisiologis.
Distensi	:	Keadaan pembesaran atau peregangan suatu bagian tubuh akibat peningkatan tekanan, penumpukan cairan, gas, atau isi lainnya di dalam organ atau jaringan.
<i>Gurgling</i>	:	Suara seperti berkumur, gemericik, atau 'ngorok basah' yang muncul akibat adanya cairan, lender, darah, atau secret di saluran napas atau saluran cerna.
Jejas	:	Cedera, kerusakan jaringan, atau trauma pada tubuh akibat pengaruh fisik, kimia, maupun biologis.
<i>Massive</i>	:	Sangat besar, berat, luas, atau dalam jumlah yang sangat banyak. Menunjukkan kondisi yang serius dan membutuhkan penanganan segera.

T. Daftar Pustaka

- Bakhrul, R. N., Propert, K. J., Kawut, S. M., & Schweickert, W. D. (2023). A Survey of Implementation of ABCDE Protocols. *Journal of Intensive Care Medicine*, 38(1), 86–94. <https://doi.org/10.1177/08850666221109157>
- Breeding, T., Martinez, B., Katz, J., Kim, J., Havron, W., Hoops, H., & Elkbulli, A. (2023). CAB versus ABC approach for resuscitation of patients following traumatic injury: Toward improving patient safety and survival. *The American Journal of Emergency Medicine*, 68(68), 28–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ajem.2023.02.034>
- Bruinink, L. J., Linders, M., de Boode, W. P., Fluit, C. R. M. G., & Hogeveen, M. (2024). The ABCDE approach in critically ill patients: A scoping review of assessment tools, adherence and reported outcomes. *Resuscitation Plus*, 20, 100763. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resplu.2024.100763>

- Gandra d'Almeida, A. J., Guedes, R., & Moreno, R. (2022). Mechanical Ventilation in the Trauma Patient. In J. Hidalgo, R. C. Hyzy, A. Mohamed Reda Taha, & Y. Y. A. Tolba (Eds.), *Personalized Mechanical Ventilation: Improving Quality of Care* (pp. 97–113). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-14138-6_8
- Herawati, C., Andreani, N., Kristanti, I., Sirait, S., Indragiri, S., Wahyuni, N. T., & Yulistiyana, L. N. (2025). USE OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE) AND EVENTS PHLEBITIS. *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada*, 16(1), 8–14.
- HOU, Y., Khokhar, M., Khan, M., Islam, T., & Haider, I. (2021). Put Safety First: Exploring the Role of Health and Safety Practices in Improving the Performance of SMEs. *SAGE Open*, 11(3), 1–8. <https://doi.org/10.1177/21582440211032173>
- Li, X., Zhao, J., & Fu, S. (2022). SBAR Standard and Mind Map Combined Communication Mode Used in Emergency Department to Reduce the Value of Handover Defects and Adverse Events. *Journal of Healthcare Engineering*, 2022(1), 8475322. <https://doi.org/https://doi.org/10.1155/2022/8475322>
- Markowitz, M., & Woods, B. (2021). On-Field Management of Suspected Spinal Cord Injury. *Clinics in Sports Medicine*, 40(3), 445–462. <https://doi.org/10.1016/j.csm.2021.03.002>
- Mubairk Alotaibi, T. M., Alqahtani, F. wazi, Majrashi, E. B., Alqahtani, F. A. F., Alshammari, A. O. H., Al-Mutairi, N. M. A., Alanazi, N. H., Alrukhaimi, A. R., Almutairi, S. S., Almushtah, F. S. A., Alqhtani, E. S. A., Khalid, B. A. S., Almutairi, A. M., Alenazi, B. G., & Almotiri, S. M. M. (2024). Nursing Practice in Emergency Care Settings: Evidence-Based Approaches. *The Review of Diabetic Studies*, 20(S20), 253–268.
- Parchim, N. F., & Nielsen, N. D. (2023). Identification and Initial Stabilization of Acutely Deteriorated Patients. In M. and C. M. Duška František and Al-Haddad (Ed.), *Intensive Care Fundamentals: Practically Oriented Essential Knowledge for Newcomers to ICUs* (pp. 3–11). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-21991-7_1
- Peate, I., & Brent, D. (2021). Using the ABCDE approach for all critically unwell patients. *British Journal of Healthcare Assistants*, 15(2), 84–89.
- Resuscitation Council UK. (2024). The ABCDE Approach.
- Rogachevskyi, O. P., Pervak, M. P., Yehorenko, O. S., Khrapova, Y. S., Cheremnykh, H. I., & Onyshchenko, V. I. (2025). Emergencies In Nursing: Current Views On The Role Of The Nurse In Providing Emergency Care And Assessment Of Effectiveness. *Медсестринство*, (1), 30–35. <https://doi.org/10.11603/2411-1597.2025.1.15205>
- Schoeber, N. H. C., Linders, M., Binkhorst, M., De Boode, W. P., Draaisma, J. M. T., Morsink, M., Nusmeier, A., Pas, M., van Riessen, C., Turner, N. M., Verhage, R.,

- Fluit, C. R. M. G., & Hogeveen, M. (2022). Healthcare professionals' knowledge of the systematic ABCDE approach: a cross-sectional study. *BMC Emergency Medicine*, 22(1). <https://doi.org/10.1186/s12873-022-00753-y>
- Stahel, P. F., & Olson, A. W. (2022). Initial Assessment and Diagnostics. In H.-C. Pape, J. Borrelli Jr., E. E. Moore, R. Pfeifer, & P. F. Stahel (Eds.), *Textbook of Polytrauma Management : A Multidisciplinary Approach* (pp. 59–69). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-95906-7_6
- Turcato, G., Zaboli, A., Filippi, L., Cipriano, A., Ferretto, P., Milazzo, D., Sabbà, G. E., Maggi, M., Marchetti, M., & Wiedermann, C. J. (2025). Improving acute care outcome in internal medicine: the role of early stabilization and intermediate care unit. *Internal and Emergency Medicine*, 20(2), 453–461. <https://doi.org/10.1007/s11739-024-03820-3>
- Verma, A., Jaiswal, S., Reid, C., Borah, P., Lal, M., Gupta, S., & Khanna, P. (2024). Efficacy of 10%, 25% and 50% dextrose in the treatment of hypoglycemia in the emergency department – A randomized controlled study. *The American Journal of Emergency Medicine*, 82, 101–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ajem.2024.05.029>
- Weir RAMC, L. C. A. G. A. (2023). Major trauma and multiple injuries. In *RCEM Lecture Notes* (pp. 19–33). <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/9781394323289.ch2>
- Woolfe Loftus, N., Navales, V., & Bowden, T. (2024). Using the NEWS2 and ABCDE assessment to identify early signs of clinical deterioration. *Nursing Standard (Royal College of Nursing (Great Britain): 1987)*, 39(4), 40–45. <https://doi.org/10.7748/ns.2024.e12188>
- Yang, M., Wei, H., & Cheng, Q. (2025). Single-Lumen Endotracheal Intubation Combined with Dynamic Positioning for Bronchoscopy- Associated Acute Massive Airway Hemorrhage: A Case Series Based on ABCDE protocol. *Research Square*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-6598199/v1>
- Zeghier Al-Rwili, M. A., Alradee Al-Ruwaili, R. S., Muharib Nazal Alruwailli, H., Suwailem Harathan Alwaldaee, R., & Abkla Al-Ruwaili, D. (2024). Collaboration Between Nursing Teams And Emergency Departments: An Integrated Approach To Improving The Quality Of Emergency Care. *Gland Surg*, (2), 493–499.

BAB 4

MANAJEMEN AIR WAY DAN OKSIGENASI DASAR

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-4	Mampu melaksanakan resusitasi dan tata laksana awal kegawatdaruratan (respirasi, kardiovaskular, syok) secara aman dan terukur.	CPMK-4; CPMK-5

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-4	Melaksanakan manajemen airway dan oksigenasi dasar serta intervensi awal kegawatdaruratan pernapasan secara aman dan terukur.
CPMK-5	Melaksanakan bantuan hidup dasar (dewasa, anak, bayi) dan penanganan awal henti jantung/kegawatdaruratan kardiovaskular sesuai prosedur keselamatan.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 4. Manajemen Airway dan Oksigenasi Dasar	4.1 Memilih dan menerapkan teknik airway dasar sesuai kondisi klinis.	4.2 Menentukan strategi oksigenasi/ventilasi dasar dan monitoring respons.	CPMK-4	CPMK-3; CPMK-7

Tabel Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-4	Skill station airway/oksigenasi + checklist	Ketepatan pemilihan teknik/alat (persentase item benar) dan efektivitas ventilasi/oksigenasi dasar berdasarkan parameter respons.	15	Checklist keterampilan; catatan respons

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4)

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Ketepatan pemilihan & penerapan airway/oksigenasi dasar	Banyak langkah salah; risiko tinggi	Langkah dasar benar; ada kekurangan bermakna	Tepat; kesalahan minor	Sangat tepat; aman tanpa kesalahan bermakna
4.2 Efektivitas ventilasi/oksigenasi & monitoring respons	Tidak efektif; respons tidak dipantau	Cukup efektif; monitoring belum konsisten	Efektif; monitoring konsisten	Sangat efektif; monitoring lengkap dan respons cepat

A. Definisi

Manajemen airway adalah serangkaian upaya untuk memastikan jalan napas tetap paten (terbuka) sehingga udara dapat masuk dan keluar paru secara adekuat, yang dilakukan untuk upaya perawatan akut untuk keselamatan pasien (Myatra et al., 2023).

Oksigenasi adalah proses pemenuhan kebutuhan oksigen dalam tubuh melalui ventilasi, difusi, dan perfusi, sehingga jaringan mendapatkan suplai oksigen yang cukup (Barbosa & Mosier, 2024).

Manajemen airway dan oksigenasi dasar merupakan tindakan untuk mempertahankan jalan napas, memastikan pertukaran gas berjalan optimal, mencegah hipoksia

Manajemen airway dan oksigenasi dasar memiliki beberapa prinsip utama sebagaimana tampak pada tabel 4.1 berikut ini

Tabel 4.1: Prinsip-prinsip Utama Manajemen Airway dan Oksigenasi Dasar

Prinsip	Penjelasan
Prioritas <i>Airway First</i>	Airway merupakan prioritas utama dalam penanganan pasien, terutama pada kondisi akut dan gawat darurat. Jalan napas harus selalu dipastikan paten terlebih dahulu
Patensi jalan nafas	Mencegah dan mengatasi sumbatan agar udara dapat masuk dengan lancar
Kecukupan Oksigenasi	Menjamin suplai oksigen ke jaringan tetap adekuat dengan memantau saturasi oksigen, mengobservasi tanda hipoksia, memberikan oksigen sesuai indikasi
Pengkajian cepat dan berkelanjutan	Pengkajian dilakukan secara cepat, sistematis dan continue meliputi pola nafas, frekuensi nafas, bunyi nafas dan status kesadaran
Intervensi bertahap	Mengutamakan tindakan non-invasif dan aman terlebih dahulu.
<i>Patient Safety</i>	Semua tindakan harus meminimalkan risiko dan sesuai kewenangan perawat.
Pendekatan tim	Menekankan pentingnya kolaborasi multidisplin tim
Keselamatan Penolong	Sebelum melakukan Tindakan manajemen airway dan oksigenasi dasar pastikan penolong menggunakan APD (alat pelindung diri) yang memadai

B. Tujuan

Tujuan manajemen airway dan oksigenasi dasar adalah untuk mempertahankan dan memastikan patensi jalan napas sehingga proses ventilasi dapat berlangsung secara efektif, serta menjamin kecukupan oksigenasi jaringan melalui mekanisme pertukaran gas yang optimal antara alveoli dan kapiler paru (Choi et al., 2022). Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya hipoksia yang dapat menyebabkan gangguan fungsi seluler hingga kerusakan organ vital, khususnya pada kondisi akut dan kegawatdaruratan. Selain itu, manajemen airway dan oksigenasi bertujuan untuk mengidentifikasi secara dini adanya gangguan pada sistem pernapasan melalui pengkajian yang sistematis dan berkelanjutan, sehingga intervensi dapat diberikan secara cepat, tepat, dan sesuai dengan kondisi klinis pasien. Intervensi ini juga berperan dalam mengurangi risiko komplikasi seperti aspirasi, gagal napas, serta penurunan kesadaran akibat kekurangan oksigen (Kataria et al., 2026).

Tujuan lain dari manajemen airway dan oksigenasi dasar adalah untuk meningkatkan kenyamanan pasien dalam bernapas, mempertahankan stabilitas hemodinamik, serta mendukung proses pemulihan secara menyeluruh (Grensemann et al., 2018). Dalam praktik keperawatan, tindakan ini dilakukan dengan mengedepankan prinsip keselamatan pasien, pendekatan non-invasif yang bertahap, serta kolaborasi dan komunikasi dengan tim kesehatan, sehingga tercapai asuhan keperawatan yang aman, efektif, dan berbasis bukti (Mohammed et al., 2020).

C. Indikasi

Manajemen airway dan oksigenasi dasar dilakukan pada pasien yang mengalami atau berisiko mengalami gangguan jalan napas dan oksigenasi. Kondisi ini dapat ditandai dengan adanya sumbatan jalan napas akibat sekret, muntah, atau benda asing, pasien dengan gagal napas dengan hipoksia maupun hiperkapnia serta pada pasien dengan penurunan tingkat kesadaran yang berpotensi kehilangan refleks proteksi jalan napas (Avva et al., 2025). Selain itu, intervensi ini juga diindikasikan pada pasien dengan gangguan pernapasan seperti sesak napas, perubahan frekuensi dan pola napas, serta penggunaan otot bantu pernapasan (Chowdhury et al., 2025).

Oksigenasi juga diperlukan pada pasien dengan tanda-tanda gangguan oksigenasi, seperti penurunan saturasi oksigen, hipoksemia, atau perubahan warna kulit menjadi sianosis (Council, 2021; Weekley et al., 2025). Pada kondisi klinis tertentu, seperti pasien pasca operasi, penyakit jantung dan paru, trauma, serta

keadaan kegawatdaruratan, tindakan ini menjadi sangat penting untuk mencegah perburukan kondisi dan mempertahankan fungsi vital.

Dengan demikian, indikasi manajemen airway dan oksigenasi dasar mencakup berbagai kondisi klinis yang memerlukan pemeliharaan jalan napas dan pemenuhan kebutuhan oksigen secara adekuat guna menjamin keselamatan dan stabilitas pasien.

D. Kontraindikasi

Pada prinsipnya, manajemen airway dan oksigenasi dasar tidak memiliki kontraindikasi absolut karena merupakan tindakan esensial untuk mempertahankan kehidupan. Namun demikian, terdapat beberapa kondisi yang memerlukan kehati-hatian dalam pelaksanaannya. Pada pasien dengan trauma wajah atau leher, intervensi airway perlu dilakukan secara hati-hati dan sering kali membutuhkan kolaborasi dengan tim medis untuk mencegah cedera lebih lanjut (Athanassoglou et al., 2024). Demikian pula pada pasien dengan dugaan cedera tulang belakang servikal, manipulasi jalan napas harus diminimalkan guna menghindari perburukan kondisi neurologis (Lin et al., 2026). Pada intubasi endotrakeal memiliki kontraindikasi pada trauma airway berat atau obstruksi yang mencegah pemasangan ETT secara aman (Avva et al., 2025).

Selain itu, pada pemberian terapi oksigen, perlu diperhatikan kondisi tertentu seperti pasien dengan penyakit paru kronis (PPOK) yang berisiko mengalami retensi karbon dioksida, sehingga pemberian oksigen harus dilakukan secara terkontrol dan dengan pemantauan ketat (Weekley et al., 2025). Pemberian oksigen dengan konsentrasi tinggi dalam waktu lama juga dapat menimbulkan efek samping seperti iritasi mukosa saluran napas dan kekeringan, sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Oksigen tambahan dikontraindikasikan pada pasien normoksik dengan infark miokard, karena hiperoksia dapat menghasilkan radikal oksigen bebas, menyebabkan vasokonstriksi, dan menyebabkan cedera reperfusi, sehingga secara signifikan mengurangi pemberian oksigen pada pasien jantung dengan SaO₂ normal, dan dapat menghasilkan aliran darah koroner oksigen bebas (Weekley et al., 2025).

Dengan demikian, meskipun manajemen airway dan oksigenasi dasar merupakan intervensi yang sangat penting, pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan kondisi klinis pasien, prinsip keselamatan, serta kewenangan perawat agar tindakan yang diberikan tetap aman dan efektif.

E. Alat dan Bahan

Dalam pelaksanaan manajemen airway dan oksigenasi dasar, perawat memerlukan berbagai alat dan bahan yang mendukung untuk mempertahankan patensi jalan napas serta memastikan kecukupan oksigenasi pasien. Alat yang digunakan meliputi perangkat sederhana hingga penunjang oksigenasi, sesuai dengan kondisi klinis pasien dan kewenangan perawat.

1. Alat dan Bahan untuk perlengkapan keselamatan penolong

Tabel 4.1: Alat dan bahan untuk perlengkapan keselamatan penolong

Alat/	Fungsi
Alat Pelindung Diri (APD): sarung tangan medis, masker, pelindung wajah.	Melindungi penolong dari paparan cairan tubuh atau bahan infeksius lainnya.
Hand sanitizer/ desinfektan	Kebersihan tangan sebelum dan setelah prosedur sebagai standar pencegahan infeksi.

2. Alat dan bahan untuk manajemen airway dan oksigenasi dasar

Tabel 4.2: Alat dan bahan untuk manajemen airway dan oksigenasi dasar

Alat/	Fungsi
Bantal/ penopang kepala	Membantu posisi kepala untuk mempertahankan patensi jalan napas
Suction (alat penghisap sekret)	Membersihkan jalan napas dari sekret, muntah, atau sumbatan
Kateter suction	Menghisap sekret dari jalan napas
Airway adjunct: Oropharyngeal tube, Nasopharyngeal tube, Endotracheal tube (ETT) - Nasopharyngeal Airway	Membantu menjaga jalan napas tetap terbuka pada pasien semi sadar, tidak sadar
Laringoskop	Untuk membantu proses intubasi
Tabung oksigen/sumber oksigen	Menyediakan oksigen untuk pasien
Flowmeter	Mengatur jumlah aliran oksigen yang diberikan

Humidifier	Melembapkan oksigen agar tidak mengiritasi saluran napas
Kanul Nasal	Memberikan oksigen dengan konsentrasi rendah
Masker sederhana	Memberikan oksigen dengan konsentrasi sedang
Masker non-rebreathing	Memberikan oksigen dengan konsentrasi tinggi
Pulse oximeter	Mengukur saturasi oksigen dalam darah
Kasa/ tisu bersih	Membersihkan area sekitar jalan napas
Stetoskop	Mendengarkan suara napas untuk memastikan udara masuk ke paru-paru dengan efektif
Bag Valve Mask (BVM) dan reservoir	Memberikan ventilasi tekanan positif manual (bantuan napas) pada pasien henti napas atau napas tidak adekuat.
Nebulizer	Mengatasi obstruksi saluran napas serta meningkatkan saturasi oksigen (SpO ₂) dengan memperbaiki pertukaran gas.
Tongue spatula	Membantu membuka mulut saat pemeriksaan airway
Tensimeter	Memantau kondisi hemodinamik yang berkaitan dengan oksigenasi
Jam tangan/ timer	Menghitung frekuensi nafas
Penlight	Menilai respon pupil dan kondisi umum pasien
Plester/fiksasi	Menjaga alat oksigen tetap pada posisi
Tempat sampah medis	Pembuangan limbah sesuai prinsip keselamatan

3. Alat dan bahan tambahan untuk perawatan lanjutan

Tabel 4.3: Alat dan bahan tambahan untuk perawatan lanjutan

Alat/ Bahan	Fungsi
Ventilator Mekanik	Membantu atau menggantikan fungsi pernapasan
Monitor pasien (multi-parameter)	Memantau tanda vital secara kontinu
Capnografi	Mengukur kadar CO ₂ untuk evaluasi ventilasi
Defibrilator	Penanganan henti jantung akibat hipoksia
SpO ₂ continuous monitor	Monitoring saturasi secara kontinu

F. Persiapan Pasien/Perawat/Lingkungan

Sebelum melakukan manajemen airway dan oksigenasi dasar, diperlukan persiapan yang optimal meliputi pasien, perawat, dan lingkungan guna menjamin keamanan, efektivitas tindakan, serta keselamatan pasien.

1. Persiapan Pasien

Diawali dengan melakukan pengkajian menyeluruh terhadap kondisi umum dan status pernapasan. Perawat perlu menilai frekuensi, pola, dan kedalaman napas, serta mengidentifikasi adanya tanda-tanda gangguan airway seperti suara napas tambahan, sumbatan sekret, atau penggunaan otot bantu pernapasan. Selain itu, tingkat kesadaran pasien juga harus dievaluasi karena berhubungan erat dengan kemampuan mempertahankan refleks proteksi jalan napas. Posisi pasien yang akan dilakukan intubasi dalam manajemen airway perlu dilakukan untuk mencegah dan mengurangi komplikasi yang terjadi (Nah et al., 2024).

Pemeriksaan saturasi oksigen menggunakan alat pulse oximeter menjadi bagian penting untuk mengetahui kecukupan oksigenasi secara objektif. Setelah pengkajian, pasien perlu diposisikan secara tepat, seperti posisi semi-Fowler atau modifikasi lainnya sesuai kondisi klinis, guna memfasilitasi ventilasi dan mempertahankan patensi jalan napas. Pada pasien yang sadar, perawat juga perlu memberikan penjelasan mengenai tindakan yang akan dilakukan agar pasien lebih kooperatif serta mengurangi kecemasan yang dapat memengaruhi pola pernapasan (Ramkumar, 2016).

Lakukan komunikasi dan minta *informed consent* jika pasien sadar. Jika pasien tidak sadar, maka segera lakukan penanganan dalam manajemen airway dan oksigenasi dengan prinsip *implied consent* (Mcguire et al., 2025).

2. Persiapan Perawat

Persiapan perawat mencakup kesiapan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam melaksanakan tindakan (Jang, 2022). Perawat harus memahami prinsip dan prosedur manajemen airway dan oksigenasi dasar, termasuk indikasi, kontraindikasi, serta langkah-langkah tindakan yang benar. Selain itu, penggunaan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan masker merupakan bagian dari penerapan kewaspadaan standar untuk mencegah infeksi silang (Hor et al., 2024). Perawat juga harus memastikan bahwa seluruh alat dan bahan yang dibutuhkan telah tersedia, dalam kondisi baik, dan siap digunakan. Kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) serta pelaksanaan tindakan sesuai dengan kewenangan menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga keselamatan pasien. Sikap profesional, komunikasi terapeutik, dan kemampuan bekerja secara sistematis juga menjadi bagian integral dalam persiapan perawat.

3. Persiapan Lingkungan

Persiapan lingkungan meliputi penataan ruang yang aman, nyaman, dan mendukung pelaksanaan tindakan secara efektif. Lingkungan harus dalam kondisi bersih untuk mencegah risiko infeksi, serta memiliki pencahayaan yang cukup agar perawat dapat melakukan tindakan dengan jelas dan tepat. Ketersediaan sumber oksigen dan akses terhadap peralatan harus dipastikan mudah dijangkau untuk mengantisipasi kondisi yang membutuhkan tindakan segera.

Selain itu, pengaturan alat yang rapi dan sistematis akan meningkatkan efisiensi kerja serta mengurangi risiko kesalahan selama tindakan. Aspek privasi pasien juga perlu diperhatikan dengan baik untuk menjaga kenyamanan dan martabat pasien selama proses perawatan.

Salah satu tantangan terbesar dalam kondisi gawat darurat adalah stresor yang tinggi sehingga membutuhkan komunikasi antar tim yang baik dan efektif sehingga tidak ada *miss communication* di antara tim (Australasian College for Emergency Medicine, 2024).

Dengan demikian, persiapan yang meliputi pasien, perawat, dan lingkungan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam manajemen airway dan oksigenasi dasar. Persiapan yang dilakukan secara optimal akan mendukung pelaksanaan tindakan yang aman, efektif, dan berkualitas, serta berkontribusi terhadap keberhasilan asuhan keperawatan secara keseluruhan.

G. Langkah Prosedur

Tabel 4.4: Prosedur Manajemen Airway dan Oksigenasi Dasar

Tahap	Langkah Tindakan
Persiapan	Melakukan cuci tangan Menggunakan APD (sarung tangan, masker) Menyiapkan alat dan bahan Menjelaskan prosedur kepada pasien
Pengkajian	Menilai Tingkat kesadaran Mengkaji frekuensi, pola dan kedalaman nafas Mengidentifikasi obstruksi jalan nafas Mengukur saturasi oksigen (SpO ₂)
Tindakan Airway	1. Membuka jalan nafas dengan teknik head tilt–chin lift pada pasien tanpa cedera servikal atau jaw thrust bila dicurigai cedera servikal 2. Mengatur posisi semi-Fowler (30–45°) atau posisi sniffing untuk memudahkan ventilasi sesuai kondisi pasien 3. Membersihkan jalan nafas menggunakan suction dengan teknik aseptik, durasi maksimal 10–15 detik 4. Mengeluarkan benda asing dengan pembersihan manual atau manuver sesuai indikasi 5. Memasang alat bantu airway (OPA/NPA) sesuai indikasi
Tindakan Oksigenasi	1. Pemberian oksigen menggunakan nasal kanul dengan aliran 1-6 l/menit, masker sederhana 5-20l/menit, masker non rebreathing 10-15 l/menit 2. Lakukan nebulisasi jika diperlukan 3. Memberikan ventilasi dengan BVM
Monitoring Evaluasi	1. Observasi pernafasan dengan mengkaji frekuensi, kedalaman dan pola nafas 2. Monitoring saturasi oksigen secara continue 3. Auskultasi paru untuk menilai suara nafas 4. Menilai adanya tanda hipoksia : gelisah, sianosis, penurunan kesadaran
Dokumentasi	Mencatat hasil pengkajian Mencatat Tindakan yang telah dilakukan Mencatat respon pasien

H. Hal yang harus diperhatikan/Patient safety

Dalam pelaksanaan manajemen airway dan oksigenasi dasar, aspek keselamatan pasien (patient safety) merupakan prioritas utama yang harus diperhatikan oleh perawat. Setiap tindakan yang dilakukan harus berlandaskan pada prinsip kehati-hatian, ketepatan prosedur, serta pencegahan risiko yang dapat membahayakan pasien.

Berikut adalah tabel 4.5: menyajikan Do's (lakukan) dan Don't (jangan lakukan) pada manajemen airway dan oksigenasi dasar.

Tabel 4.5: Do's (lakukan) dan Don't (jangan lakukan) pada manajemen airway dan oksigenasi dasar.

Tahapan	Do's (Lakukan)	Don't (Jangan Lakukan)
Manajemen Airway	Gunakan teknik <i>jaw-thrust</i> jika pasien dicurigai mengalami trauma pada servikal.	Jangan lakukan <i>head-tilt/chin-lift</i> pada pasien yang diduga mengalami trauma pada servikal.
	Memastikan jalan napas paten sebelum tindakan lain	Mengabaikan airway dan langsung ke tindakan lain
	Memposisikan pasien dengan benar (semi-Fowler/head tilt)	Memposisikan pasien sembarangan yang menghambat napas
	Melakukan suction sesuai prosedur	Suction terlalu lama (>15 detik)
	Menggunakan OPA/NPA sesuai indikasi	Memasang airway tanpa indikasi/ukuran tepat
Oksigenasi dasar	Berikan segera oksigen aliran tinggi (10-15 lpm) melalui <i>non-rebreathing mask</i> pada pasien kritis. Amati posisi trachea dan pengembangan dada. Posisi trachea asimetris mengarah kecurigaan pada <i>tension</i>	Jangan menunda pemberian oksigen, terutama pada pasien yang menunjukkan frekuensi napas sangat cepat (>30x/menit).

	Memilih alat sesuai kondisi (kanul nasal, masker sederhana, NRM)	Menggunakan alat yang tidak sesuai kebutuhan pasien
	Mengecek sumber oksigen (tabung/sentral)	Tidak mengecek ketersediaan oksigen
	Memberikan oksigen sesuai resep/indikasi	Over-oksigenasi tanpa kontrol
	Menjauhkan dari sumber api (oksigen mudah terbakar)	Merokok/dekat api saat terapi oksigen

I. Komplikasi

Manajemen airway dan oksigenasi dasar merupakan tindakan penting dalam asuhan keperawatan yang bertujuan untuk mempertahankan patensi jalan napas serta memenuhi kebutuhan oksigenasi pasien. Namun demikian, pelaksanaan tindakan ini tidak terlepas dari berbagai potensi komplikasi yang dapat terjadi apabila prosedur tidak dilakukan secara tepat, tidak sesuai indikasi, atau kurangnya monitoring selama intervensi.

Salah satu komplikasi yang paling sering terjadi adalah hipoksia (Hagberg & Krier, 2005), yang dapat disebabkan oleh jalan napas yang tidak paten, tindakan suction yang terlalu lama, atau pemberian oksigen yang tidak adekuat. Sebaliknya, pemberian oksigen yang berlebihan juga dapat menimbulkan hiperoksia, yang berisiko menyebabkan gangguan fisiologis tertentu, termasuk retensi karbon dioksida, terutama pada pasien dengan penyakit paru obstruktif kronis. Oleh karena itu, pengaturan aliran oksigen harus dilakukan secara hati-hati dan disesuaikan dengan kondisi klinis pasien.

Komplikasi lain yang perlu diwaspadai adalah aspirasi, terutama pada pasien dengan penurunan kesadaran, yang dapat terjadi akibat posisi pasien yang tidak tepat atau kegagalan dalam mempertahankan refleks proteksi jalan napas. Selain itu, tindakan pemasangan alat bantu airway seperti orofaringeal airway atau nasofaringeal airway yang tidak sesuai teknik dan ukuran dapat menyebabkan trauma jalan napas, termasuk luka pada mukosa.

Risiko infeksi nosokomial juga dapat terjadi apabila prinsip aseptik tidak diterapkan secara optimal, seperti tidak menggunakan alat pelindung diri atau penggunaan alat yang tidak steril. Penggunaan oksigen dalam jangka waktu tertentu tanpa humidifikasi juga dapat menyebabkan iritasi dan kekeringan mukosa saluran napas, yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan pada pasien.

Selain itu, penggunaan alat oksigen seperti kanul nasal atau masker yang tidak tepat dapat menyebabkan iritasi kulit atau lecet, serta dalam beberapa kasus dapat menimbulkan epistaksis akibat iritasi pada mukosa hidung. Komplikasi lain yang tidak kalah penting adalah keterlambatan dalam mendeteksi perburukan kondisi pasien akibat kurangnya monitoring, yang dapat berdampak pada keterlambatan penanganan.

Dengan demikian, berbagai komplikasi dalam manajemen airway dan oksigenasi dasar pada umumnya berkaitan dengan kesalahan teknik, ketidaktepatan penggunaan alat, serta kurangnya evaluasi berkelanjutan. Oleh karena itu, perawat dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai, menerapkan prinsip keselamatan pasien, serta melakukan monitoring secara terus-menerus guna meminimalkan risiko dan meningkatkan kualitas asuhan keperawatan.

J. Evaluasi Hasil

Evaluasi hasil merupakan tahap penting dalam manajemen airway dan oksigenasi dasar yang bertujuan untuk menilai efektivitas intervensi yang telah dilakukan serta menentukan langkah tindak lanjut yang diperlukan. Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan dengan mengacu pada perubahan kondisi klinis pasien, baik secara objektif maupun subjektif.

Secara objektif, keberhasilan manajemen airway dan oksigenasi dapat dinilai melalui adanya perbaikan status respirasi, seperti frekuensi napas yang kembali dalam rentang normal, pola napas yang teratur, serta tidak adanya penggunaan otot bantu pernapasan. Peningkatan nilai saturasi oksigen (SpO_2) sesuai target terapi juga menjadi indikator utama keberhasilan oksigenasi. Selain itu, hasil auskultasi paru yang menunjukkan berkurangnya bunyi napas tambahan seperti ronki atau wheezing menandakan adanya perbaikan kondisi jalan napas.

Secara subjektif, pasien dapat menunjukkan penurunan keluhan sesak napas, peningkatan kenyamanan dalam bernapas, serta penurunan kecemasan yang berkaitan dengan gangguan pernapasan. Pada pasien dengan kesadaran yang sebelumnya menurun akibat hipoksia, peningkatan tingkat kesadaran juga menjadi indikator penting keberhasilan intervensi.

Evaluasi juga mencakup pemantauan terhadap kemungkinan komplikasi yang timbul, seperti iritasi jalan napas, ketidaknyamanan akibat alat oksigen, atau tanda-tanda retensi karbon dioksida. Perawat harus mampu mengidentifikasi secara dini adanya tanda perburukan, seperti penurunan saturasi oksigen, peningkatan sesak napas, sianosis, atau perubahan tingkat kesadaran, yang memerlukan intervensi segera atau kolaborasi dengan tim kesehatan.

Dengan demikian, evaluasi hasil tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan terapi, tetapi juga pada kemampuan perawat dalam melakukan pemantauan berkelanjutan dan pengambilan keputusan klinis yang tepat. Evaluasi yang komprehensif akan mendukung keberhasilan asuhan keperawatan serta meningkatkan keselamatan dan kualitas hidup pasien.

K. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bagian integral dalam manajemen airway dan oksigenasi dasar yang berfungsi sebagai bukti tertulis pelaksanaan asuhan keperawatan serta sebagai sarana komunikasi antar tenaga Kesehatan. Dokumentasi yang lengkap, akurat, dan sistematis sangat penting untuk menjamin kesinambungan perawatan, evaluasi tindakan, serta aspek legal dalam praktik keperawatan (Carolina et al., 2025).

Dalam pelaksanaan manajemen airway dan oksigenasi dasar, dokumentasi diawali dengan pencatatan hasil pengkajian awal pasien. Hal ini meliputi tingkat kesadaran, frekuensi dan pola napas, adanya tanda obstruksi jalan napas, penggunaan otot bantu pernapasan, serta nilai saturasi oksigen (SpO₂). Data ini menjadi dasar dalam menentukan intervensi yang akan dilakukan.

Selanjutnya, perawat harus mendokumentasikan secara rinci tindakan yang telah diberikan, termasuk jenis intervensi airway (misalnya reposisi, suction, pemasangan OPA/NPA) serta terapi oksigen yang diberikan, seperti jenis alat (kanul nasal, masker), aliran oksigen, dan durasi pemberian. Selain itu, penting juga untuk mencatat respon pasien terhadap tindakan, baik secara objektif maupun subjektif, seperti perubahan saturasi oksigen, perbaikan pola napas, atau penurunan keluhan sesak.

Dokumentasi juga harus mencakup hasil monitoring dan evaluasi secara berkala, termasuk setiap perubahan kondisi pasien, adanya komplikasi, serta tindakan lanjutan yang dilakukan. Apabila terdapat kolaborasi dengan tim kesehatan lain, seperti dokter, maka instruksi dan pelaksanaan tindakan kolaboratif juga perlu dicatat dengan jelas.

Pencatatan harus dilakukan segera setelah tindakan, menggunakan bahasa yang jelas, singkat, dan sesuai dengan standar yang berlaku, seperti format SOAP (Subjective, Objective, Assessment, Plan) (Mowery et al., 2013; Sudarsan et al., 2021). Dokumentasi yang baik tidak hanya mencerminkan kualitas asuhan keperawatan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan keselamatan pasien serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan klinis selanjutnya.

Dengan demikian, dokumentasi dalam manajemen airway dan oksigenasi dasar merupakan komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dari proses

asuhan keperawatan, yang berkontribusi terhadap mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Contoh dokumentasi SOAP

Kasus: Pasien laki-laki, 60 tahun, datang dengan keluhan sesak napas sejak 1 hari, riwayat hipertensi dan merokok.

Subjektif (S): Pasien mengeluh sesak napas sejak 1 hari yang lalu, semakin memberat saat aktivitas. Pasien mengatakan napas terasa pendek dan tidak lega. Tidak ada nyeri dada, namun pasien merasa lemas dan gelisah.

Objektif (O):

- Keadaan umum: tampak sesak
- Kesadaran: compos mentis
- Frekuensi napas: 28x/menit
- Pola napas: cepat dan dangkal
- SpO₂: 90% (tanpa oksigen)
- Nadi: 102x/menit
- Tekanan darah: 150/90 mmHg
- Suhu: 36,8°C
- Penggunaan otot bantu napas (+)
- Bunyi napas: ronki halus bilateral
- Posisi pasien: duduk condong ke depan

Assessment (A):

Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakefektifan ventilasi ditandai dengan sesak napas, peningkatan frekuensi napas, penggunaan otot bantu napas, dan penurunan saturasi oksigen.

Plan (P):

- Memposisikan pasien semi-Fowler
- Memberikan oksigen melalui kanul nasal 3 L/menit
- Melakukan monitoring SpO₂ dan tanda vital secara berkala
- Mengobservasi pola dan frekuensi napas
- Kolaborasi dengan dokter untuk terapi lanjutan
- Edukasi pasien untuk teknik napas dalam

L. Mini-Case Study: Diskusi Kelompok Manajemen Airway dan Oksigenasi

Seorang laki-laki usia 35 tahun dibawa ke IGD setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Pasien tidak menggunakan helm saat kejadian. Saat tiba di IGD, pasien tampak lemah dan mengalami penurunan kesadaran. Frekuensi nafas 32x/mnt, tekanan darah 100/70 mmHg, SpO₂ 85% (tanpa oksigen), terdapat darah dan secret dimulut, gurgling (+).

Petunjuk Diskusi Kelompok

- Mahasiswa dibagi dalam kelompok kecil, setiap kelompok terdiri atas 5-7 mahasiswa
- Identifikasi masalah yang muncul pada ilustrasi kasus
- Identifikasi kondisi yang mengancam nyawa pada ilustrasi kasus
- Diskusikan dalam kelompok masalah keperawatan prioritas utama dan intervensi yang dilakukan berdasarkan ilustrasi kasus
- Diskusikan dalam kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas
- - Hasil diskusi dipresentasikan dalam bentuk *power point*

M. Simulasi: Manajemen Airway dan Oksigenasi Dasar (OSCE)

Soal OSCE

1.	Nomor station	09
2.	Judul station	Kebutuhan oksigenasi pada klien dewasa di ruang Instalasi gawat darurat, Pemberian obat inhalasi (nebulisasi)
3.	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4.	Tujuan station	Menilai kemampuan dalam mengkaji kebutuhan oksigenasi, menegakkan diagnosis keperawatan, melakukan Tindakan Pemberian obat inhalasi (nebulisasi) di ruang Instalasi gawat darurat dan mengevaluasi hasil dari tindakan.
5.	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku profesional
6.	Kategori	1. Oksigenasi 2. Sirkulasi 3. Cairan dan elektrolit 4. Nutrisi

		5. Aman dan nyaman 6. Psikososial 7. Eliminasi 8. Aktivitas dan istirahat 9. Seksual dan reproduksi
7.	Instruksi untuk peserta ujian	<u>SKENARIO KLINIK:</u> Seorang laki laki berusia 40 tahun dirawat di IGD. Hasil pengkajian: pasien Tampak batuk dan sesak, pasien mempunyai riwayat asma. <u>TUGAS :</u> 1. Lakukan pengkajian tambahan untuk menegaskan diagnosis prioritas dan sampaikan kepada penguji 2. Tuliskan diagnosis keperawatan prioritas pada pasien 3. Lakukan tindakan Pemberian obat inhalasi (nebulisasi) pada manekin 4. Lakukan evaluasi atas tindakan yang telah dilakukan
8.	Instruksi untuk penguji	<u>SKENARIO KLINIK:</u> Seorang laki laki berusia 40 tahun dirawat di IGD. Hasil pengkajian: pasien Tampak batuk dan sesak, pasien mempunyai riwayat asma. <u>TUGAS PESERTA :</u> 1. Lakukan pengkajian tambahan untuk menegaskan diagnosis prioritas dan sampaikan kepada penguji 2. Tuliskan diagnosis keperawatan prioritas pada pasien 3. Lakukan tindakan Pemberian obat inhalasi (nebulisasi) pada manekin 4. Lakukan evaluasi atas tindakan yang telah dilakukan

		<u>INSTRUKSI PENGUJI:</u> 1. Penguji mengamati dan menilai penampilan peserta dalam melakukan pemeriksaan fisik berdasarkan rubrik. 2. Saat peserta melakukan pemeriksaan pernafasan, sampaikan "f". Jika peserta melakukan auskultasi di dada sampaikan "terdengar wheezing". Saat peserta menanyakan banyak pertanyaan kepada pasien sampaikan "pasien sulit berbicara". 3. Nilai Diagnosis keperawatan yang diserahkan peserta dengan rumusan diagnosis yang lengkap dan tepat 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi berupa pertanyaan, maupun respon non verbal/gerakan kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Penguji menilai kemampuan peserta uji dalam melakukan Pemberian obat inhalasi (nebulisasi) dan mengevaluasi tindakan secara benar dan sistematis
9.	Instruksi untuk klien standar	<i>Tidak menggunakan KS, menggunakan manekin dewasa setengah badan atas</i>
10	<i>Setting Station:</i>	1. Unit Gawat Darurat Keterangan 1. Bed Pasien 2. Meja Penguji 3. Kursi Penguji 4. Trolley tindakan 5. Wastafel 6. Tempat Sampah 7. Pintu

11	Peralatan yang dibutuhkan	1. Mesin Nebulizer 1 buah 2. Masker dan selang nebulizer sesuai ukuran manekin 1 set 3. Obat inhalasi sesuai program 4. Cairan NaCL sebagai pengencer 1 kolf 5. Sarung tangan 1 pasang 6. Tisu 1 pak/rol
12	Penulis	Dr. Sri Haryuni,S.Kep.,Ns.M.Kep
13	Referensi	<i>Tim Pokja SDKI DPP PPNI. 2021. Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Jakarta Selatan : Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia</i> <i>Tim Pokja SLKI DPP PPNI. 2021. Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Jakarta Selatan : Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia</i> <i>Tim Pokja Pedoman SPO DPP PPNI. 2021. Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. Jakarta Selatan : Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia</i>

Standar Operasional Prosedur (Sop) Nebulisasi

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan		Kompeten	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
A	Tahap Pra Interaksi				
	1. Menyiapkan alat dan perlengkapan 1.Mesin nebulizer 2.Masker dan selang nebulizer sesuai ukuran 3.Obat inhalasi sesuai program 4.Cairan NaCl sebagai pengencer, jika perlu 5.Sumber oksigen, jika tidak menggunakan mesin nebulizer 6.Sarung tangan 7.Tisu 8.Bengkok				
	2. Mencuci tangan				
	3. Memakai APD				
B	Tahap Orientasi				
	4. Menyampaikan salam				
	5. Memperkenalkan diri				
	6. Mengecek identitas pasien				
	7. Menyampaikan maksud dan tujuan				
	8. Memberi kesempatan bertanya				
	9. Memulai tindakan dengan baik				
	10. Menjaga privasi				
C	Tahap Kerja				
	11. Mengatur posisi pasien sesuai dengan keadaan pasien				
	A. Masukkan obat ke dalam chamber nebulizer				

	B. Hubungkan selang ke mesin nebulizer atau sumber oksigen				
	C. Anjurkan untuk melakukan napas dalam saat inhalasi dilakukan				
	D. Mulai lakukan inhalasi dengan menyalakan mesin nebulizer atau mengalirkan oksigen 6-8 l/menit				
	E. Monitor respons pasien hingga obat habis				
	F. Bersihkan area mulut dan hidung dengan tisu				
	G. Rapiakan pasien dan bereskan alat-alat yang digunakan				
	H. Lepaskan sarung tangan				
D	Tahap Terminasi				
	20. Lakukan <i>reassessment</i> secara teratur setiap 5-10 menit sekali untuk pasien dalam kondisi tidak stabil 21. Lakukan evaluasi terhadap intervensi yang telah dilakuka				
E	Tahap Dokumentasi 22. Catat hari, tanggal, jam kegiatan, metode serta respon dan efek yang ditunjukkan oleh pasien 23. Catat hasil <i>reassessment</i> dan evaluasi kondisi pasien				
F	Penampilan Profesional 24. Aman, nyaman, teliti, cermat, cepat, tepat, responsive.				

N. Form Penilaian Osce Keperawatan

STATION: Manajemen Airway dan Oksigenasi Dasar (OSCE)

1. Form Penilaian

No	Kompetensi	Indikator Penilaian	0	1	2	3	Bobot (B)	Nilai (S x B)
1	Pengkajian	Melakukan pengkajian dengan mengidentifika						
2	Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Menetapkan diagnosis yang tepat dan menyusun						
3	Implementasi keperawatan	Melakukan intervensi <i>life-saving</i>						
4	Evaluasi Keperawatan	Melakukan evaluasi terhadap implementasi yang						
5	Perilaku profesional	Menjaga privasi, aman, sistematis,						

Keterangan skor:

0 = tidak dilakukan

1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap

2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap

3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

O. Rubrik Penilaian

No	Kompetensi	0	1	2	3	Bobot (B)	Nilai (S x B)
1	Pengkajian keperawatan: aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menggali data focus pada pasien dengan kondisi gawat darurat. Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara sistematis dan membaca hasil temuan secara benar.						
2	Diagnosis dan perencanaan keperawatan: aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menegakkan diagnosis keperawatan sesuai masalah prioritas pada pasien dengan kondisi gawat darurat serta menyusun rencana keperawatan yang relevan. Peserta menuliskan diagnosis dan perencanaan secara jelas berdasarkan data pada scenario dan hasil validasi pengkajian focus. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.						

3.	Implementasi keperawatan: aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam mengimplementasikan tindakan yang telah diidentifikasi dalam rencana asuhan keperawatan. Tindakan yang dimaksud adalah prosedur <i>life-saving</i> dengan langkah-langkah kerja yang aman, tepat, cepat, sistematis, teliti serta sesuai dengan kondisi pasien. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					
4.	Evaluasi keperawatan : aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menilai melakukan evaluasi keperawatan terhadap implementasi yang telah dilakukan					
5.	Perilaku professional: aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan profesionalisme dengan baik sesuai prinsip etik dan legal, diantaranya memperkenalkan diri, meminta persetujuan Tindakan, berkomunikasi terapeutik, menjaga kenyamanan dan keamanan, menjaga privasi, serta melakukan Tindakan dengan cepat, tepat, hati-hati, teliti, dan responsive. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					

Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR (S)			
	0	1	2	3
1. Komunikasi, edukasi dan konseling	-	-	-	-
2. Pengkajian Keperawatan	Peserta tidak bisa menyebutkan tanda gejala	Peserta menyebutkan 1 point pengkajian : 1. Pasien sulit berbicara 2. Frekuensi nafas berubah/meningkat 3. Terdapat wheezing	Peserta menyebutkan 2 point pengkajian : 1. Pasien sulit berbicara 2. Frekuensi nafas berubah/meningkat 3. Terdapat wheezing	Peserta menyebutkan semua point pengkajian : 1. Pasien sulit berbicara 2. Frekuensi nafas berubah/meningkat 3. Terdapat wheezing
2. Diagnosa keperawatan	Peserta tidak dapat menyampaikan diagnosis keperawatan	Peserta menyebutkan 1 point rumusan diagnosis keperawatan : Terdapat Problem, Etiologi dan Sign Symtom	Peserta menyebutkan 2 point rumusan diagnosis keperawatan : Terdapat Problem, Etiologi dan Sign Symtom	Peserta menyebutkan rumusan diagnosis keperawatan dengan lengkap dan tepat : Terdapat Problem, Etiologi dan Sign Symtom
3. Implementasi: Keperawatan	Peserta tidak melakukan implementasi sesuai prosedur Pemberian obat inhalasi (nebulisasi).	Peserta hanya melakukan 50-70% teknik tepat di bawah ini: 1. Identifikasi identitas pasien	Peserta melakukan semua poin dibawah ini dengan sistematis , tetapi hanya 75-85% teknik tepat:	Peserta melakukan semua poin dibawah ini dengan tepat dan sistematis :

KOMPETENSI	SKOR (S)			
	0	1	2	3
		2. Menjelaskan tujuan dan prosedur 3. Melakukan prinsip 6 benar 4. Melakukan cuci tangan 5. Memposisikan pasien nyaman mungkin 6. Memasukkan obat ke chamber nebulizer atau sumber oksigen 7. Pasang masker menutupi hidung dan mulut 8. Anjurkan pasien melakukan nafas dalam saat inhalasi dilakukan 9. Mulai menyalakan mesin nebulizer atau mengalirkan oksigen 6-8 liter	1. Identifikasi identitas pasien 2. Menjelaskan tujuan dan prosedur 3. Melakukan prinsip 6 benar 4. Melakukan cuci tangan 5. Memposisikan pasien nyaman mungkin 6. Memasukkan obat ke chamber nebulizer atau sumber oksigen 7. Pasang masker menutupi hidung dan mulut 8. Anjurkan pasien melakukan nafas dalam saat inhalasi dilakukan 9. Mulai menyalakan mesin nebulizer atau mengalirkan oksigen 6-8 liter	1. Identifikasi identitas pasien 2. Menjelaskan tujuan dan prosedur 3. Melakukan prinsip 6 benar 4. Melakukan cuci tangan 5. Memakai handscoon 6. Memposisikan pasien nyaman mungkin 7. Memasukkan obat ke chamber nebulizer atau sumber oksigen 8. Pasang masker menutupi hidung dan mulut 9. Anjurkan pasien melakukan nafas dalam saat inhalasi dilakukan

KOMPETENSI	SKOR (S)			
	0	1	2	3
		10. Monitor respon pasien hingga obat habis 11. Bersihkan mulut dan hidung pasien dengan tisu 12. Dokumentasikan prosedur dan respon pasien	10. Monitor respon pasien hingga obat habis 11. Bersihkan mulut dan hidung pasien dengan tisu 12. Rapikan alat dan lepas sarung tangan 13. Dokumentasikan prosedur dan respon pasien	10. Mulai menyalakan mesin nebulizer atau mengalirkan oksigen 6-8 liter 11. Monitor respon pasien hingga obat habis 12. Bersihkan mulut dan hidung pasien dengan tisu 13. Rapikan alat dan lepas sarung tangan 14. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 15. Dokumentasikan prosedur dan respon pasien
4. Evaluasi Keperawatan	Peserta tidak melakukan evaluasi	Peserta melakukan hanya 1 point yang benar 1. Identifikasi kenyamanan pasien	Peserta melakukan hanya 2 poin 1. Identifikasi kenyamanan pasien	Peserta melakukan semua poin dibawah ini dengan tepat dan sistematis : 4. Identifikasi kenyamanan pasien

KOMPETENSI	SKOR (S)			
	0	1	2	3
		2. Pemasangan masker menutup hidung dan mulut 3. Memonitor respon pasien sampai obat habis	2. Pemasangan masker menutup hidung dan mulut 3. Memonitor respon pasien sampai obat habis	5. Pemasangan masker menutup hidung dan mulut 6. Memonitor respon pasien sampai obat habis
5. Perilaku Profesional	Peserta ujian tidak meminta izin secara lisan dan sama sekali tidak melakukan poin berikut: 1. Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan klien dan diri sendiri 2. Memperhatikan kenyamanan klien 3. Menunjukkan sikap empati, menghargai, 4. Menjaga privasi klien	Meminta izin secara lisan dan 1-2 poin berikut : 1. Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan klien dan diri sendiri 2. Memperhatikan kenyamanan klien 3. Melakukan tindakan sesuai prioritas 4. Menunjukkan sikap empati, menghargai 5. Menjaga privasi klien	Meminta izin secara lisan dan 3 poin berikut: 1. Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan klien dan diri sendiri 2. Memperhatikan kenyamanan klien 3. Melakukan tindakan sesuai prioritas 4. Menunjukkan sikap empati, menghargai 5. Menjaga privasi klien	Meminta izin secara lisan dan melakukan di bawah ini secara lengkap : 1. Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan klien dan diri sendiri 2. Memperhatikan kenyamanan klien 3. Melakukan tindakan sesuai prioritas 4. Menunjukkan sikap empati, menghargai 5. Menjaga privasi klien

KOMPETENSI	SKOR (S)			
	0	1	2	3

Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = ----- x 100 =

30

(Kota),

.....

Penguji :

P. Direct Observation Of Prosedural Skills (DOPS)

Asuhan Keperawatan Gawat Darurat Manajemen Airway dan Oksigenasi di Ruang IGD

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien di IGD
Metode penilaian	Mini-CEX merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi mahasiswa saat memberikan asuhan awal pada pasien dengan masalah bersihan jalan nafas tidak efektif di Ruang IGD.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang kasus gawat darurat, tetapi juga dari kemampuannya melakukan pengkajian, menjelaskan kondisi pasien, dan menyampaikan rencana asuhan kepada keluarga pasien.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau tahap profesi.	Seorang pria berusia 30 tahun dibawa ke IGD setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Pasien mengalami trauma kepala (benturan di dahi) dan tidak sadarkan diri. Hasil pengkajian: pasien tampak sesak, terdengar suara napas gurgling (suara ngorok/cairan), frekuensi napas 28x/menit, terdapat sekret/darah di mulut, kesadaran somnolen (GCS E3M4V3), dan TD 130/80 mmHg. , terdapat sekret/darah di mulut, kesadaran somnolen (GCS E3M4V3), dan TD

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien di IGD
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan encounter klinik secara utuh sejak awal interaksi sampai penjelasan rencana tindakan.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan pengkajian singkat namun terarah, memeriksa kepatenan jalan nafas, menjelaskan kondisi pasien, lalu menyampaikan rencana melakukan suction.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi anamnesis atau pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi terapeutik, edukasi keluarga, profesionalisme, dan organisasi tindakan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menggali kepatenan jalan nafas, dan menjaga komunikasi yang baik dengan pasien dan keluarganya.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa klinik mahasiswa secara langsung menggunakan format Mini-CEX yang terstruktur.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menghubungkan data klinik dengan masalah prioritas, misalnya perubahan patensi jalan napas, serta mampu memberikan edukasi yang tepat dan aman kepada pasien dan keluarganya.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat singkat, spesifik, dan	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan identifikasi tanda jalan napas tidak efektif, tetapi masih perlu memperdalam pengkajian jalan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien di IGD
Keputusan penilaian	Hasil Mini-CEX digunakan untuk menentukan tingkat performa mahasiswa dalam praktik klinik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan encounter klinik secara runtut, aman, komunikatif, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila masih membutuhkan arahan pada beberapa bagian. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila performanya belum memenuhi standar minimal.
Makna dalam OBE	Mini-CEX memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does	Pada kasus pasien dengan jalan napas efektif, mahasiswa dinilai tidak hanya Memahami teori tetapi juga mampu Menerapkan asuhan keperawatan secara Langsung, aman, tepat dan profesional

Q. Portofolio

Portofolio Pada Asuhan Keperawatan Pasien Dengan Jalan Napas Tidak Paten dengan Trauma

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien di IGD
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada asuhan keperawatan pasien gawat darurat, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian awal, menetapkan masalah keperawatan, melakukan intervensi <i>life-saving</i> , menjaga keselamatan pasien, melakukan <i>reassessment</i> , serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah merawat pasien dengan kondisi gawat darurat, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan pembebasan jalan napas, sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan intervensi untuk prosedur membuka jalan napas.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus pasien kecelakaan lalu

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien di IGD
	yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah keperawatan, intervensi utama, dan hasil yang dicapai.	lintas yang dibawa ke IGD dengan kasus trauma dan jalan napas tidak paten, diagnosis keperawatan prioritas, intervensi pembebasan jalan napas dan reassessment pada pasien.
Refleksi <i>patient safety</i>	Refleksi <i>patient safety</i> menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan keperawatan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya memantau tanda-tanda jalan napas tidak paten, tanda-tanda syok hipovolemia, memastikan teknik pembebasan jalan napas dilakukan dengan cara yang benar, dan mengenali tanda bahaya perburukan kondisi pasien yang membutuhkan tindakan segera.
<i>Feedback</i> CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam membuka jalan napas, tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian dalam membuka jalan nafas dengan <i>chin lift</i> atau <i>jaw thrust</i> pada pasien dengan trauma
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus gawat darurat, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu melakukan asuhan keperawatan gawat darurat secara aman, tepat, dan profesional.
Bukti kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik,

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien di IGD
	mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan pengkajian awal, menentukan masalah keperawatan prioritas, melakukan intervensi <i>life-saving</i> , melakukan <i>re-assessment</i> dan dokumentasi keperawatan dengan tepat.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang dan terdokumentasi	Pada asuhan keperawatan pasien gawat darurat, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep manajemen airway, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik klinik nyata.

**Case Report Pada Asuhan Keperawatan
Pasien Dengan Jalan Napas Tidak Paten Dengan Trauma**

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien di IGD
Hakikat <i>case report</i>	<i>Case report</i> merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, <i>case report</i> berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang Seorang pria berusia 30 tahun dibawa ke IGD setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Pasien mengalami trauma kepala (benturan di dahi) dan tidak sadarkan diri. Hasil pengkajian: pasien tampak sesak, terdengar suara napas gurgling (suara ngorok/cairan), frekuensi napas 28x/menit, terdapat sekret/darah di mulut, kesadaran somnolen (GCS E3M4V3), dan TD 130/80 mmHg.
Tujuan	<i>Case report</i> bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah keperawatan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data pasien, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan yang diberikan, dan perkembangan kondisi pasien setelah intervensi.
Isi laporan	Isi <i>case report</i> biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis keperawatan, intervensi,	Pada kasus pasien gawat darurat dengan jalan napas tidak paten, mahasiswa menuliskan kepatenan jalan napas, suara napas tambahan, adanya luka terbuka, kondisi luka terbuka, tanda-tanda fraktur, diagnosis jalan napas tidak paten dan syok hipovolemik, intervensi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien di IGD
	implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	pembebasan jalan napas, penghentian perdarahan secara langsung, pemasangan infus, <i>re-assessment</i> tiap 5-10 menit sekali.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan intervensi, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan data jalan napas tidak paten dengan masalah utama, memilih intervensi yang tepat, dan menilai respons pasien setelah dilakukan intervensi.
Nilai edukatif	<i>Case report</i> membantu mahasiswa mengembangkan <i>clinical reasoning</i> , keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus jalan napas tidak paten, mahasiswa belajar bahwa pengkajian kepatenan jalan napas, adanya suara napas tambahan, pengkajian tanda-tanda syok hipovolemik merupakan bagian yang sangat penting dalam asuhan keperawatan pada pasien dengan kondisi gawat darurat.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, <i>case report</i> menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep ABCDE sebagai sebuah pendekatan dalam pengkajian awal, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan keperawatan secara utuh pada kondisi gawat darurat.

Refleksi *Patient Safety* Pada Asuhan Keperawatan Pasien dengan Jalan Napas Tidak Paten Dengan Trauma

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien di IGD
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi <i>patient safety</i> merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus pasien dengan jalan nafas tidak efektif pada pasien trauma, mahasiswa merefleksikan bahwa membuka jalan nafas dengan tepat sangat diperlukan.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan keperawatan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti membuka jalan nafas dengan <i>chin lift</i> dapat berdampak besar pada keselamatan pasien.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada pasien ini adalah jalan nafas tidak efektif sehingga jika tidak segera ditangani maka mengakibatkan ketidakseimbangan ventilasi dan perubahan membrane alveolar.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain adanya sura nafas ronchi/wheezing, perubahan frekuensi nafas serta adanya tanda hipoksia.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan Langkah	Mahasiswa menuliskan pentingnya intervensi untuk membuka jalan nafas

	konkrit yang dapat dilakukan untuk mengurangi Risiko keselamatan pasien.	dengan head tilt/ jaw thrust serta melakukan suction.
Pembelajaran Mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi praktik.	Mahasiswa menyadari bahwa pada pasien dengan jalan nafas tidak efektif, pengkajian yang teliti, komunikasi antar tim yang jelas, intervensi cepat tepat, dan pemantauan berulang merupakan bagian penting untuk menjaga keselamatan pasien.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi <i>patient safety</i> menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik keperawatan gawat darurat secara berkelanjutan.

R. Ringkasan

Asuhan Keperawatan

Pasien Dengan Gangguan Jalan Nafas

Bab ini menjelaskan tentang salah satu kondisi gawat darurat yang umum terjadi di IGD untuk kasus trauma, khususnya pada komponen (Airway) yakni jalan nafas tidak efektif. Kondisi ini sering mengalami perburukan yang cepat jika tidak segera mendapatkan pertolongan tepat. Fokus utama asuhan keperawatan pada pasien dengan kondisi gawat darurat jalan nafas tidak efektif adalah dengan segera melakukan pembukaan jalan nafas.

Mahasiswa harus memahami dalam memberikan manajemen airway yang tepat dimulai dengan pengkajian awal (primary survey), salah satunya yang pertama dilakukan dengan mengkaji airway (jalan nafas) harus dilakukan dengan tepat. Pada tahap implementasi, mahasiswa harus mampu menunjukkan intervensi keperawatan yang cepat, tepat, sistematis, dan aman. *Informed consent* harus dilakukan sebelum tindakan keperawatan, namun jika pasien sedang mengalami penurunan kesadaran maka dijalankan prinsip *implied consent*.

Tindakan keperawatan yang penting dilakukan pada pasien dengan jalan nafas tidak efektif antara lain prosedur utama pembukaan jalan napas pada pasien trauma adalah Jaw Thrust, bukan *head tilt-chin lift*, untuk menghindari cedera servikal lebih lanjut. Langkah-langkahnya meliputi stabilisasi leher manual, membersihkan sumbatan (suction/manual), manuver jaw thrust, dan pemasangan alat bantu napas jika perlu

Evaluasi asuhan keperawatan dilakukan dengan *re-assessment* secara berkala pada pasien untuk menilai efektivitas intervensi yang telah dilakukan dan menilai apakah pasien mengalami perbaikan atau perburukan, serta menilai perlunya intervensi alternatif lainnya. Pada pasien korban kecelakaan lalu lintas dengan trauma, maka perawat melakukan *re-assessment* untuk menilai apakah perdarahan massive masih terjadi, apakah upaya pembukaan jalan nafas yang telah dilakukan efektif, atau tetap belum ada perkembangan. Upaya evaluasi keberhasilan pembukaan jalan napas (airway) pada pasien trauma dinilai dari hilangnya suara napas tambahan (seperti snoring/gurgling), kemampuan pasien berbicara, peningkatan saturasi oksigen, dan pergerakan dada yang simetris. Jika jalan nafas telah efektif, maka perawat perlu berkomunikasi dengan tim untuk melakukan intervensi selanjutnya terkait breathing, circulation dan seterusnya. Pada pasien gawat darurat, waktu sangat berharga, maka intervensi diprioritaskan untuk *life-saving* pasien. Airway (A) merupakan salah satu masalah primer yang harus dikelola terlebih dahulu untuk life saving pada pasien dengan kondisi gawat darurat baik pada *setting pre-hospital* maupun *in-hospital*. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk cepat, tepat, teliti dan hati-hati namun juga tetap tenang dalam kondisi gawat darurat.

S. Red Flag dan Eskalasi

Pasien Dengan Kondisi Gawat Darurat Pada Komponen Airway dan Breathing

Red Flags	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
Terdengar suara <i>gurgling</i>	Menunjukkan bahwa jalan napas pasien tidak paten, disebabkan adanya sumbatan berupa cairan atau darah.	Lakukan <i>head-tilt chin-lift</i> (untuk pasien tanpa cedera servikal) dan <i>modified jaw thrust</i> (untuk pasien yang dicurigai mengalami cedera servikal), buka jalan napas, lakukan <i>finger-swab</i> dengan kassa atau suction cairan/ darah pada area mulut. Lakukan <i>re-</i>
Terdengar suara <i>snoring</i>	Menunjukkan bahwa jalan napas pasien tidak paten, disebabkan adanya sumbatan akibat lidah yang menutup jalan napas.	Lakukan <i>head-tilt chin-lift</i> (untuk pasien tanpa cedera servikal) dan <i>modified jaw thrust</i> (untuk pasien yang dicurigai mengalami cedera servikal), buka jalan napas, pasang oropharyngeal tube atau nasopharyngeal tube
Pasien tampak <i>gaspng</i>	Menunjukkan bahwa pasien mengalami tanda-tanda henti napas.	Setelah jalan napas paten. Pasang BVM (<i>Bag Valve Mask</i>), sambungkan dengan sumber oksigen, alirkan oksigen 10-15 lpm, berikan oksigen 10-12x/ menit, pastikan dinding dada mengembang dan mengempis dengan

FORM CHECKLIST ‘Saya sudah bisa’
ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN DENGAN GANGGUAN AIRWAY DAN
BREATHING

Nama Mahasiswa :

NIM :

Tanggal :

Tempat Praktik/ Skill Lab :

Petunjuk: Beri tanda (·) pada kolom yang sesuai

No	Pernyata	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa melakukan pengkajian kepatenan jalan napas (<i>Airway</i>)			
2	Saya sudah bisa mengidentifikasi masalah keperawatan prioritas pada pasien gawat darurat			
3	Saya sudah bisa menyusun rencana asuhan keperawatan pada pasien gawat darurat			
4	Saya sudah bisa melakukan intervensi pembebasan jalan napas pada pasien gawat darurat			
5	Saya sudah bisa melakukan intervensi terapi oksigen pada pasien gawat darurat			
6	Saya sudah bisa menentukan kapan harus melakukan eskalasi atau melapor			
7	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi singkat asuhan keperawatan gawat darurat			
8	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional, cepat, tepat, dan responsif			

Refleksi singkat mahasiswa:

.....

T. Daftar Pustaka

- Athanassoglou, V., Rogers, A., & Hofmeyr, R. (2024). In-hospital management of the airway in trauma. *BJA Education*, 24(7), 238–244. <https://doi.org/10.1016/j.bjae.2024.03.004>
- Australasian College for Emergency Medicine. (2024). *Environmental sustainability practices in emergency* (Issue June).
- Avva, U., Lata, J. M., Hendrix, J. M., & Kiel, J. (2025). *Airway Management*.
- Barbosa, A., & Mosier, J. M. (2024). *Preoxygenation and apneic oxygenation in emergency airway management*. 11(2), 136–144.
- Carolina, E., Tapia, H., Yosa, J. L., Humbelina, M., García, O., Janeth, N., Morocho, C., Alexandra, Y., & Calle, S. (2025). *Effectiveness of Nursing Documentation Frameworks (SBAR , SOAP , and PIE) in Enhancing Clinical Handoffs and Patient Safety*. 17(8). <https://doi.org/10.7759/cureus.89957>
- Choi, Y., Kim, T. H., Hong, K. J., & Song, K. J. (2022). *Association between prehospital airway management methods and neurologic outcome in out-of-hospital cardiac arrest with respiratory cause: a nationwide retrospective observational study*. <https://doi.org/10.22514/sv.2021.249>
- Chowdhury, R., Orishchak, O., Mascarella, M. A., Aldriweesh, B., Alnoury, M. K., Bousquet-dion, G., Yeung, J., & Nguyen, L. H. P. (2025). *Emergency Airway Management: A Systematic Review on the Effectiveness of Cognitive Aids in Improving Outcomes and Provider Performance*. 1–15.
- Council, A. R. (2021). *Guideline 9 . 2 . 10 – The Use of Oxygen in Emergencies*. 1–5.
- Grensemann, J., Fuhrmann, V., & Kluge, S. (2018). *Oxygen Treatment in Intensive Care and Emergency Medicine*. Table 1. <https://doi.org/10.3238/arztebl.2018.0455>
- Hagberg, C., & Krier, C. (2005). *Complications of managing the airway*. 19(4), 641–659. <https://doi.org/10.1016/j.bpa.2005.08.002>
- Hor, S., Wyer, M., Barratt, R., Turnbull, M., Rogers, K., Murphy, M., Urwin, R., Jorm, C., & Gilbert, G. L. (2024). Risk assessment and the use of personal protective equipment in an emergency department_ Differing perspectives of emergency and infection control clinicians. A video-vignette survey. *AJIC: American Journal of Infection Control*, 52(10), 1114–1121. <https://doi.org/10.1016/j.ajic.2024.06.012>
- Jang, H.-R. (2022). *Emergency nurses ' attitudes , perceptions about personal protective equipment and willingness to care for COVID-19 patients: A descriptive , cross-sectional study*. June, 1–9. <https://doi.org/10.1111/jonm.13720>
- Kataria, S., Juneja, D., Jain, R., & Veenith, T. (2026). *Airway Management in the ICU and Emergency Department in Resource-Limited Settings*. 1–22.

- Lin, L. C., April, M. D., Dphil, Douin, D. J., Winkle, J. M., Jenson, W. R., Rizzo, J. A., & Schauer, S. G. (2026). *Airway management in trauma patients: A seven-year review of emergency department intubations* Author links open overlay panel Lucia C. Lin MD. 99, 306–312.
- Mcguire, B., Crawley, S., Dill, N., Greig, P., Iqbal, R., Patteril, M., Rivett, K., Sud, A., & Slowther, A. (2025). Ethical decision making in airway management: a Difficult Airway Society position statement on good practice. *BJA Open*, 15(April), 100416. <https://doi.org/10.1016/j.bjao.2025.100416>
- Mohammed, S., Enazi, A., & Zamzami, B. A. (2020). *Interprofessional collaboration in emergency departments: The importance of teamwork among nurses , pharmacists , medical records , and physicians*. 87–104.
- Mowery, D., Wiebe, J., Visweswaran, S., Harkema, H., & Chapman, W. W. (2013). *Building an Automated SOAP Classifier for Emergency Department Reports*. 45(1), 71–81. <https://doi.org/10.1016/j.jbi.2011.08.020> Building
- Myatra, S. N., Dhawan, I., & Souza, S. A. D. (2023). *Recent advances in airway management*. 58. <https://doi.org/10.4103/ija.ija>
- Nah, S., Lee, Y., Choi, S. J., Lee, J., Hwang, S., Lim, S., Lee, I., & Cho, Y. S. (2024). *Current trends in emergency airway management: a clinical review*. 11(3), 243–258.
- Ramkumar, V. (2016). *Preparation of the patient and the airway for awake intubation*. 55(5). <https://doi.org/10.4103/0019-5049.89863>
- Sudarsan, P., Gowda, A., Balakrishna, M., Anusha, J., Asir, R., Balu, D., & Gopal, S. (2021). *Development and validation of A-SOAP notes: Assessment of efficiency in documenting patient therapeutic records*. 11(10), 1–6. <https://doi.org/10.7324/JAPS.2021.1101001>
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. 2021. *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia*. Jakarta Selatan : Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. 2021. *Standar Luaran Keperawatan Indonesia*. Jakarta Selatan : Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia
- Tim Pokja Pedoman SPO DPP PPNI. 2021. *Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan*. Jakarta Selatan : Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia
- Weekley, M. S., Lobo, C. M., & Bland, L. E. (2025). *Oxygen Administration*.

BAB 5

BANTUAN HIDUP DASAR (BHD) DAN HENTI JANTUNG PADA DEWASA

Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-4	Mampu melaksanakan resusitasi dan tata laksana awal kegawatdaruratan (respirasi, kardiovaskular, syok) secara aman dan terukur	CPMK-4; CPMK-5

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-5	Melaksanakan bantuan hidup dasar (dewasa, anak, bayi) dan penanganan awal henti jantung/kegawatdaruratan kardiovaskular sesuai prosedur keselamatan

Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 5. Bantuan Hidup Dasar (BLS) dan Henti Jantung pada Dewasa	5.1 Melaksanakan rangkaian BLS dewasa sesuai prosedur dan keselamatan resusitasi	5.2.Mengoperasikan penggunaan AED/defibrilasi dasar sesuai indikasi dan protokol keselamatan	CPMK-5	CPMK-7; CPMK-3

Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-5	Simulasi resusitasi (megacode) + checklist	Kualitas rangkaian BLS (persentase langkah terpenuhi) dan ketepatan penggunaan AED/defibrilasi dasar sesuai prosedur..	20	Checklist megacode; catatan waktu

Rubrik CPMK (skala 1–4)

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Kualitas rangkaian BLS (item checklist)	≤60% langkah terpenuhi; ada kesalahan kritis	61–75% terpenuhi; langkah penting terlewat	76–90% terpenuhi; tanpa kesalahan kritis	>90% terpenuhi; ritme kerja sangat baik
5.2. Ketepatan penggunaan AED/defibrilasi dasar & keselamatan	Indikasi/prosedur keliru; keselamatan diabaikan	Prosedur cukup; keselamatan kurang konsisten	Prosedur tepat; keselamatan terpenuhi	Prosedur sangat tepat; keselamatan sangat konsisten

A. Pendahuluan

Henti jantung merupakan kondisi kegawatdaruratan yang menyebabkan berhentinya sirkulasi darah secara mendadak dan mengancam nyawa dalam hitungan menit. Organ vital seperti otak mulai mengalami kerusakan permanen setelah 4 hingga 6 menit tanpa oksigen. Intervensi cepat dan tepat menjadi faktor penentu keberhasilan penyelamatan pasien (Olasveengen et al., 2021). Oleh karena itu, Bantuan Hidup Dasar atau Basic Life Support (BLS) menjadi kompetensi inti yang wajib dikuasai oleh perawat

Data global menunjukkan bahwa angka kejadian henti jantung di luar rumah sakit masih tinggi dengan tingkat kelangsungan hidup kurang dari 10 persen di banyak negara berkembang (Tsao et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan keterampilan penolong pertama, termasuk tenaga kesehatan pemula. Pendidikan keperawatan memiliki peran strategis dalam menyiapkan lulusan yang kompeten dalam respons kegawatdaruratan berbasis bukti ilmiah.

Dalam situasi darurat ini, sangat penting bagi tenaga medis untuk memberikan perawatan yang cepat dan tepat, terutama di Ruang Gawat Darurat (RGD), yang memiliki peran krusial dalam meningkatkan peluang keberhasilan resusitasi. RGD berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan, bertanggung jawab atas penanganan berbagai kondisi darurat, termasuk henti jantung. Oleh karena itu, tenaga medis yang bertugas di RGD perlu dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk melakukan resusitasi secara efektif. Data yang dipublikasikan oleh American Heart Association (AHA) menunjukkan bahwa setiap menit keterlambatan dalam pemberian pengobatan untuk henti jantung dapat mengurangi peluang bertahan hidup hingga 10 persen. (Rante et al., 2025)

Pendekatan Outcome-Based Education menekankan pencapaian kompetensi yang terukur. Pada konteks BLS, mahasiswa tidak hanya dituntut memahami teori, tetapi juga mampu melakukan tindakan CPR secara benar, cepat, dan aman. Integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional menjadi kunci pembelajaran yang efektif. Bab ini dirancang untuk membangun fondasi klinik mahasiswa dalam menangani henti jantung dewasa secara sistematis dan berbasis standar internasional.

B. Konsep Henti Jantung

1. Defenisi Henti Jantung

Henti jantung merupakan kondisi darurat medis yang ditandai oleh penghentian mendadak aktivitas mekanik jantung, yang mengakibatkan sirkulasi darah yang tidak memadai ke otak dan organ vital. Keadaan ini menyebabkan pasien menjadi tidak responsif, tidak bernapas secara normal, dan tidak menunjukkan tanda-tanda sirkulasi yang efektif. Tanpa intervensi yang cepat, henti jantung dapat berujung pada kematian dalam beberapa menit akibat hipoksia jaringan dan kegagalan organ. Secara klinis, henti jantung didefinisikan sebagai penghentian aktivitas jantung yang menyebabkan kolaps hemodinamik dan hilangnya perfusi sistemik, yang memerlukan tindakan resusitasi segera, seperti resusitasi jantung paru dan defibrilasi (Yow et al., 2026)

Henti jantung pada orang dewasa umumnya disebabkan oleh gangguan pada sistem kelistrikan jantung, yang dapat mengakibatkan aritmia fatal seperti fibrilasi ventrikel, takikardia ventrikel tanpa nadi, aktivitas listrik tanpa nadi, atau asistol. Kondisi ini mengakibatkan ketidakmampuan jantung untuk memompa darah secara efektif, sehingga suplai oksigen ke otak terputus dan pasien mengalami kehilangan kesadaran dengan cepat. Berdasarkan literatur terbaru, henti jantung dikategorikan sebagai suatu keadaan darurat medis dengan tingkat mortalitas yang tinggi, yang memerlukan deteksi dini dan penerapan tindakan Bantuan Hidup Dasar untuk meningkatkan peluang kelangsungan hidup. Tanpa intervensi yang cepat, penghentian aktivitas jantung dapat menyebabkan kegagalan sirkulasi total dan berujung pada kematian mendadak (John Wink, 2025)

2. Epidemiologi Henti Jantung

Henti jantung tetap menjadi penyebab utama kematian global, dengan mortalitas tinggi baik di dalam maupun di luar rumah sakit. Insiden di luar rumah sakit mencapai 40 hingga 100 kasus per 100.000 penduduk per tahun, dengan tingkat kelangsungan hidup di bawah 10%. Di rumah sakit, tingkat kelangsungan hidup berkisar antara 15 hingga 25%, dipengaruhi oleh kecepatan resusitasi dan kualitas intervensi. Faktor penting dalam keberhasilan resusitasi meliputi deteksi dini, resusitasi yang cepat, defibrilasi, dan perawatan pasca henti jantung. Insidensi henti jantung lebih tinggi pada lansia dan pasien dengan penyakit kardiovaskular, serta lebih umum terjadi pada pria. Peningkatan kejadian terkait penyakit jantung koroner, gagal jantung, diabetes, dan hipertensi. Keterlambatan dalam memberikan bantuan hidup dasar dan rendahnya penggunaan Automated External Defibrillators (AED)

oleh masyarakat juga berdampak negatif pada angka kelangsungan hidup pasien henti jantung.(Winterburn et al., 2026)

3. Etiologi Henti Jantung Pada Dewasa

Penyebab henti jantung pada orang dewasa umumnya terkait dengan gangguan kardiovaskular, terutama penyakit jantung koroner dan infark miokard akut, yang dapat memicu fibrilasi atau takikardia ventrikel. Selain itu, gagal jantung dan penyakit katup juga berkontribusi. Data menunjukkan lebih dari 70% kasus henti jantung disebabkan oleh faktor kardiak, seringkali terjadi mendadak tanpa gejala awal. Selain faktor kardiak, henti jantung juga dapat dipicu oleh faktor non-kardiak seperti hipoksia, syok, emboli paru, trauma, overdosis obat, dan hipotermia. Penyebab ini, dikenal sebagai "reversible causes" atau "Hs and Ts," harus cepat diidentifikasi saat resusitasi, terutama hipoksia dan hipovolemia yang umum di ruang gawat darurat. Identifikasi penyebab sangat penting untuk keberhasilan resusitasi.(Virani et al., 2023)

4. Patofisiologi Henti Jantung

Patofisiologi henti jantung mendadak melibatkan gangguan pada sistem kelistrikan jantung, yang menyebabkan denyut jantung menjadi tidak teratur (aritmia). Ventricular tachycardia (VT) dan ventricular fibrillation (VF) diidentifikasi sebagai penyebab utama henti jantung mendadak. Namun, studi terbaru menunjukkan bahwa pulseless electrical activity (PEA) dan asistol lebih umum terjadi sebagai penyebab henti jantung mendadak. Fibrilasi ventrikular (VF) adalah kondisi di mana aktivitas listrik jantung berlangsung dengan sangat cepat dan tidak teratur, sehingga jantung kehilangan kemampuannya untuk berkontraksi dan hanya bergetar tanpa fungsi efektif. Fibrilasi ventrikular ditandai oleh pola gelombang elektrokardiografi yang bervariasi, dengan frekuensi ventrikel yang melebihi 300 detak per menit dan durasi setiap siklus kurang dari 200 milisekon. Menurut penelitian, terdapat tiga fase utama dalam perkembangan VF, yaitu fase inisiasi, transisi, dan rumatan. Patofisiologi dari VF masih belum sepenuhnya dipahami. Beberapa faktor yang dianggap berkontribusi pada VT dan VF meliputi faktor organ (ketidakseimbangan tonus otonom), jaringan (reentry, wave break, dan alternans durasi potensi aksi), seluler (aktivitas yang terpicu dan otomatisitas), serta subseluler (aktivasi atau deaktivasi saluran ion yang abnormal).

Ventricular tachycardia (VT) terjadi akibat gangguan pada konduksi impuls dalam jantung. Aktivasi miokardium di ventrikel menyebabkan depolarisasi yang lambat, yang terlihat sebagai QRS yang melebar pada EKG. Salah satu penyebab paling umum dari VT adalah oklusi arteri koroner. Frekuensi nadi yang tinggi menyebabkan fase pengisian ventrikel kiri menjadi

lebih singkat, mengurangi jumlah darah yang masuk ke ventrikel dan menurunkan curah jantung. Dalam kasus VT dengan kondisi hemodinamik stabil, terapi medikamentosa menjadi prioritas. Namun, pada situasi VT yang disertai gangguan hemodinamik yang menyebabkan henti jantung (VT tanpa nadi), defibrilasi dengan DC shock dan resusitasi jantung paru (RJP) menjadi pilihan utama. *Pulseless electrical activity* (PEA) atau aktivitas elektrik tanpa nadi adalah kondisi di mana sinyal listrik jantung tidak menghasilkan kontraksi yang cukup, sehingga tekanan darah tidak dapat terukur dan denyut nadi tidak terdeteksi. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan PEA termasuk hipoksia berat, asidosis, hipovolemia parah, pneumotoraks tegang, ketidakseimbangan elektrolit, overdosis obat, sepsis, infark miokard, emboli paru besar, tamponade jantung, hipoglikemia, hipotermia, dan cedera. Asistol ditandai dengan tidak adanya aktivitas listrik di ventrikel dan/atau atrium. Pada monitor EKG, irama yang terlihat seperti garis lurus. (dr. Nurul Falah, 2026)

5. Irama Jantung yang menyebabkan Henti Jantung

Henti jantung dapat terjadi akibat irama jantung yang tidak menghasilkan curah jantung yang efektif. Irama yang paling umum menyebabkan henti jantung adalah fibrilasi ventrikel dan takikardia ventrikel tanpa nadi. Kedua irama ini termasuk dalam kategori shockable rhythm karena dapat diatasi dengan defibrilasi. Fibrilasi ventrikel ditandai dengan aktivitas listrik ventrikel yang tidak teratur, sehingga kontraksi yang efektif tidak terjadi. Sementara itu, takikardia ventrikel tanpa nadi ditandai oleh kontraksi ventrikel yang cepat namun tidak mampu menghasilkan perfusi sistemik yang memadai. Selain irama yang dapat di-defibrilasi, terdapat juga irama non-shockable seperti asistol dan aktivitas listrik tanpa nadi. Asistol adalah kondisi di mana tidak ada aktivitas listrik jantung, sedangkan aktivitas listrik tanpa nadi menunjukkan adanya aktivitas listrik tanpa kontraksi mekanik yang efektif. Kedua jenis irama ini memiliki prognosis yang lebih buruk dibandingkan dengan fibrilasi ventrikel. Penanganan utama untuk irama non-shockable adalah melakukan resusitasi jantung paru yang berkualitas tinggi serta pemberian epinefrin sesuai dengan algoritma resusitasi yang berlaku (Soar et al., 2021)

6. Dampak Hipoksia terhadap organ vital

Hipoksia yang disebabkan oleh henti jantung mengakibatkan gangguan metabolisme seluler pada organ-organ penting, terutama otak. Otak adalah organ yang paling rentan terhadap kekurangan oksigen karena memiliki kebutuhan metabolik yang sangat tinggi. Dalam waktu kurang dari 5 menit tanpa pasokan oksigen, neuron mulai mengalami kerusakan yang bersifat permanen. Hipoksia serebral dapat menyebabkan edema otak, gangguan pada

neurotransmitter, serta kematian sel neuron. Situasi ini berkontribusi terhadap terjadinya defisit neurologis dan penurunan kesadaran setelah resusitasi yang berhasil. Selain otak, hipoksia juga berpengaruh pada jantung, ginjal, dan hati. Hipoksia pada miokardium dapat menyebabkan disfungsi kontraktilitas jantung setelah return of spontaneous circulation (ROSC). Ginjal dapat mengalami cedera ginjal akut akibat penurunan perfusi yang berkepanjangan. Hati juga mengalami gangguan metabolisme serta peningkatan kadar enzim hati. Hipoksia sistemik dapat memicu respons inflamasi dan disfungsi multiorgan yang dikenal sebagai sindrom pasca henti jantung. Keadaan ini meningkatkan angka kematian dan memperburuk hasil bagi pasien yang mengalami henti jantung (Sekhon, 2021)

C. Chain of Survival pada Dewasa

Rangkaian Survival pada orang dewasa adalah serangkaian tindakan yang saling terintegrasi dengan tujuan untuk meningkatkan peluang hidup pasien yang mengalami henti jantung. Konsep ini menekankan bahwa keberhasilan dalam proses resusitasi tidak hanya bergantung pada satu tindakan tunggal, melainkan pada keterkaitan setiap langkah yang dilaksanakan secara cepat dan terencana. (Soar et al., 2021)



Gambar 5.1: Rantai Bertahan Hidup AHA untuk IHCA dan OHCA dewasa (American Heart Association, 2024)

D. Penilaian Awal Korban

Penilaian awal terhadap korban adalah langkah pertama dalam Bantuan Hidup Dasar untuk dengan cepat mengidentifikasi henti jantung dan menentukan tindakan yang diperlukan. Pedoman terbaru menekankan pentingnya pendekatan sistematis yang dimulai dengan memastikan keselamatan, menilai respons,

mengevaluasi kondisi pernapasan dan nadi, serta mengaktifkan sistem bantuan medis. Penilaian ini harus dilakukan dengan cepat, dalam waktu kurang dari 10 detik, untuk menghindari keterlambatan dalam proses resusitasi. Penolong harus segera memulai resusitasi jantung paru jika pasien tidak memberikan respons, tidak bernapas dengan normal, dan nadi tidak terdeteksi.(Virani et al., 2023)

1. Prinsip Keselamatan Penolong

Keselamatan penolong adalah prioritas utama sebelum melakukan evaluasi terhadap korban. Penolong harus memastikan bahwa lingkungan bebas dari bahaya seperti arus listrik, kebakaran, bahan kimia, lalu lintas, atau potensi kekerasan. Pedoman AHA menekankan pentingnya tidak membahayakan diri sendiri, karena cedera pada penolong dapat mengganggu proses resusitasi. Penggunaan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan masker sangat dianjurkan, terutama di lingkungan klinis

Selain keselamatan lingkungan, penolong juga perlu mempertimbangkan risiko penularan infeksi. Pedoman terbaru merekomendasikan penggunaan alat penghalang saat memberikan ventilasi. Namun, jika alat tersebut tidak tersedia, kompresi dada harus tetap dilakukan tanpa penundaan. Prinsip ini menekankan bahwa kompresi dada yang dilakukan lebih awal jauh lebih penting dibandingkan menunda tindakan akibat keterbatasan alat (American Heart Association, 2024)

2. Pemeriksaan Respon Pasien

Pemeriksaan respons pasien dilakukan dengan cara menepuk bahu dan memberikan rangsangan verbal, seperti memanggil dengan suara yang cukup keras. Apabila pasien tidak memberikan respons, maka dianggap tidak sadar dan perlu segera dilakukan evaluasi terhadap pernapasan dan nadi. Proses pemeriksaan respons ini harus dilakukan dengan cepat tanpa menimbulkan cedera tambahan. Pedoman AHA menekankan bahwa ketidakresponsifan merupakan tanda awal potensi terjadinya henti jantung

Penilaian terhadap respons juga berfungsi untuk membedakan antara pasien yang tidak sadar dan mereka yang masih memiliki tingkat kesadaran yang parsial. Jika pasien menunjukkan respons yang minimal, penolong tetap harus melakukan evaluasi pernapasan dengan cepat. Ketidakresponsifan yang disertai dengan pernapasan yang abnormal harus dianggap sebagai indikasi henti jantung. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari keterlambatan dalam memulai tindakan resusitasi (American Heart Association, 2024)

3. Penilaian Pernapasan dan Nadi

Penilaian pernapasan dilakukan dengan mengamati gerakan dada dan menilai apakah pernapasan tersebut normal atau tidak. Gasping atau

pernapasan agonal harus dianggap sebagai indikasi adanya henti jantung. Pemeriksaan nadi dilakukan pada arteri karotis dan tidak boleh melebihi 10 detik. Jika nadi tidak terdeteksi atau penolong merasa ragu, maka resusitasi jantung paru harus segera dilakukan. Pedoman terbaru menekankan bahwa kompresi dada tidak boleh ditunda karena kesulitan dalam memeriksa nadi (Soar et al., 2021)

Rekomendasi untuk melakukan penilaian simultan antara pernapasan dan nadi bertujuan untuk mempercepat pengambilan keputusan klinis. Pendekatan ini membantu meminimalkan waktu tanpa kompresi. Penolong harus segera memulai kompresi dada jika pasien tidak bernapas dengan normal dan tidak memiliki nadi. Penilaian yang cepat dan tepat dapat meningkatkan peluang keberhasilan resusitasi serta mencegah kerusakan otak akibat hipoksia (Olasveengen et al., 2021)

4. Aktivasi Bantuan Medis

Setelah henti jantung terdeteksi, penolong harus segera mengaktifkan sistem bantuan medis. Di rumah sakit, aktivasi dilakukan melalui sistem Code Blue, sedangkan di masyarakat melalui layanan darurat. Aktivasi yang cepat memungkinkan tim resusitasi untuk membawa AED dan peralatan canggih. Pedoman AHA menekankan bahwa bantuan harus diaktifkan segera setelah pasien tidak responsif dan tidak bernapas dengan normal.

Apabila terdapat dua penolong, satu penolong akan mengaktifkan sistem bantuan sementara penolong lainnya memulai resusitasi. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan waktu tanpa kompresi dada. Aktivasi bantuan medis yang cepat meningkatkan peluang untuk melakukan defibrilasi dengan cepat dan meningkatkan tingkat kelainan pasien yang mengalami henti jantung

5. Posisi Pasien

Posisi pasien saat penilaian awal harus dalam keadaan terlentang di atas permukaan yang datar dan keras agar kompresi dada dapat dilakukan secara efektif. Apabila pasien berada di tempat tidur, mereka perlu dipindahkan ke permukaan yang keras atau menggunakan papan resusitasi. Penempatan ini sangat penting untuk memastikan kedalaman kompresi yang memadai dan meningkatkan perfusi selama proses resusitasi. Petugas juga harus memastikan bahwa posisi kepala pasien memungkinkan jalan napas terbuka. Teknik head tilt chin lift diterapkan pada pasien yang tidak memiliki indikasi trauma. Untuk pasien dengan trauma, digunakan teknik jaw thrust untuk menjaga agar tulang belakang servikal tetap stabil. Penempatan yang tepat sangat berpengaruh pada efektivitas ventilasi dan meningkatkan peluang keberhasilan dalam resusitasi

E. Resusitasi Jantung Paru RJP Dewasa

1. Prinsip RJP Berkualitas Tinggi

Prinsip RJP yang berkualitas tinggi menekankan pentingnya kompresi yang kuat dan cepat, recoil dada yang penuh, interupsi yang minimal, ventilasi yang memadai, serta pergantian penolong secara teratur. Pedoman terbaru merekomendasikan agar fraksi kompresi dada melebihi 80% untuk menjaga perfusi organ-organ vital. Interupsi dalam kompresi harus diminimalkan karena setiap jeda dapat menyebabkan penurunan perfusi koroner yang signifikan. Kompresi harus segera dimulai dan dilanjutkan hingga defibrilasi dilakukan atau ROSC tercapai.

Selain itu, ventilasi harus diberikan dengan cukup untuk mencegah hiperventilasi. Ventilasi yang berlebihan dapat meningkatkan tekanan intratorakal dan mengurangi aliran balik vena ke jantung. Pedoman terbaru juga menekankan pentingnya penggunaan perangkat umpan balik untuk mempertahankan kualitas kompresi selama proses resusitasi. Pendekatan ini terbukti dapat meningkatkan hasil bagi pasien yang mengalami henti jantung (American Heart Association., 2025)

2. Kompresi Dada

Kompresi dada adalah elemen krusial dalam resusitasi jantung paru (RJP) karena berfungsi untuk memompa darah ke otak dan jantung. Proses kompresi dilakukan dengan menekan sternum secara berirama menggunakan kedua tangan. Penolong harus memastikan posisi bahu berada tepat di atas tangan dan menjaga siku tetap lurus untuk menghasilkan tekanan yang optimal. Kompresi dada yang berkualitas tinggi dapat meningkatkan aliran darah koroner dan memperbesar kemungkinan keberhasilan proses resusitasi.

Pedoman terkini menekankan pentingnya melakukan kompresi dada dengan interupsi yang minimal serta menjaga konsistensi dalam kedalaman dan frekuensinya. Kompresi sebaiknya dilakukan di atas permukaan yang keras untuk meningkatkan efektivitas tekanan. Penolong harus menghindari tekanan yang tidak stabil yang dapat mengakibatkan kedalaman kompresi yang tidak memadai (American Heart Association., 2025)

3. Lokasi Kompresi

Kompresi dada adalah elemen krusial dalam resusitasi jantung paru (RJP) karena berfungsi untuk memompa darah ke otak dan jantung. Proses kompresi dilakukan dengan menekan sternum secara berirama menggunakan kedua tangan. Penolong harus memastikan posisi bahu berada tepat di atas tangan dan menjaga siku tetap lurus untuk menghasilkan tekanan yang optimal.

Kompresi dada yang berkualitas tinggi dapat meningkatkan aliran darah koroner dan memperbesar kemungkinan keberhasilan proses resusitasi.

Pedoman terkini menekankan pentingnya melakukan kompresi dada dengan interupsi yang minimal serta menjaga konsistensi dalam kedalaman dan frekuensinya. Kompresi sebaiknya dilakukan di atas permukaan yang keras untuk meningkatkan efektivitas tekanan. Penolong harus menghindari tekanan yang tidak stabil yang dapat mengakibatkan kedalaman kompresi yang tidak memadai

4. Kedalaman Kompresi

Kedalaman kompresi dada yang disarankan untuk orang dewasa adalah minimal 5 cm dan maksimal 6 cm. Kedalaman ini terbukti memberikan perfusi koroner yang optimal selama proses resusitasi. Kompresi yang terlalu dangkal tidak dapat menghasilkan aliran darah yang memadai, sementara kompresi yang terlalu dalam dapat meningkatkan risiko cedera. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kedalaman kompresi secara konsisten selama tindakan RJP.

Panduan terbaru juga menekankan pentingnya mempertahankan kedalaman kompresi meskipun penolong mengalami kelelahan. Penurunan kedalaman kompresi sering kali terjadi setelah 1-2 menit resusitasi. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan pergantian penolong guna memastikan kualitas kompresi tetap terjaga dengan baik

5. Frekuensi Kompresi

Frekuensi kompresi yang disarankan adalah antara 100 hingga 120 kali per menit. Rentang ini menciptakan keseimbangan yang baik antara perfusi dan pengisian jantung. Frekuensi yang terlalu rendah dapat mengurangi aliran darah, sedangkan frekuensi yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan kedalaman kompresi yang tidak memadai. Oleh karena itu, penolong perlu menjaga ritme kompresi yang konsisten selama proses resusitasi.

Pedoman terbaru menekankan pentingnya konsistensi frekuensi dibandingkan dengan kecepatan kompresi yang tidak disertai kedalaman yang cukup. Penggunaan metronom atau perangkat umpan balik dapat membantu dalam mempertahankan frekuensi kompresi. Pendekatan ini dapat meningkatkan kualitas RJP dan hasil bagi pasien yang mengalami henti jantung

6. Recoil Dada

Recoil dada yang optimal adalah elemen krusial dalam resusitasi jantung paru (RJP) yang efektif. Setelah setiap sesi kompresi, penolong diwajibkan untuk sepenuhnya menghilangkan tekanan agar dada dapat kembali ke keadaan semula. Proses recoil ini memungkinkan jantung untuk terisi kembali dan

meningkatkan aliran balik vena. Tanpa adanya recoil yang sempurna, perfusi ke jantung dan otak akan mengalami penurunan yang signifikan.

Pedoman terbaru menekankan pentingnya bagi penolong untuk tidak bertumpu pada dada selama melakukan kompresi. Menekan dada secara berkelanjutan dapat menyebabkan peningkatan tekanan intratorakal dan mengurangi aliran darah. Oleh karena itu, sangat penting bagi penolong untuk sepenuhnya mengangkat tekanan setelah setiap kompresi

7. Ventilasi Buatan

Ventilasi bantuan diperlukan untuk menjaga oksigenasi selama terjadinya henti jantung. Proses ventilasi dilakukan setelah 30 kali kompresi dengan cara membuka saluran napas menggunakan metode head tilt chin lift. Setiap sesi ventilasi berlangsung selama 1 detik hingga terlihat adanya pengembangan pada dada. Penting untuk menghindari ventilasi yang berlebihan, karena hal ini dapat mengakibatkan penurunan perfusi jantung. Apabila jalan napas lanjutan telah terpasang, ventilasi dilakukan sekitar 10 kali per menit tanpa menghentikan kompresi dada. Metode ini memungkinkan kompresi yang terus menerus dan meningkatkan perfusi pada organ-organ vital. Ventilasi harus cukup untuk memicu pengembangan dada tanpa memberikan tekanan yang berlebihan

8. Rasio Kompresi dan Ventilasi

Rasio kompresi dan ventilasi untuk orang dewasa adalah 30 kompresi diikuti dengan 2 ventilasi. Rasio ini disarankan karena menciptakan keseimbangan yang ideal antara perfusi dan oksigenasi. Pedoman terbaru masih mempertahankan rasio 30:2 untuk penolong yang terlatih dalam resusitasi jantung paru (RJP) pada dewasa. Pelaksanaan rasio 30:2 dilakukan dalam siklus sekitar 2 menit sebelum dilakukan evaluasi ulang. Penolong diharapkan untuk meminimalkan jeda antara kompresi dan ventilasi. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan chest compression fraction dan memperbesar kemungkinan keberhasilan dalam proses resusitasi

9. Pergantian Penolong

Penggantian penolong disarankan setiap 2 menit atau setiap 5 siklus RJP untuk menghindari kelelahan. Kelelahan pada penolong dapat mengakibatkan penurunan kedalaman kompresi serta kualitas resusitasi. Pergantian harus dilakukan dengan jeda yang minimal agar kompresi tidak terhenti terlalu lama.

Pedoman terbaru menekankan pentingnya koordinasi tim saat melakukan pergantian penolong. Penolong yang akan menggantikan harus sudah siap sebelum pergantian dilakukan. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga kualitas kompresi tetap konsisten sepanjang proses resusitasi

10. Kesalahan Umum Saat RJP

interupsi yang terlalu lama, dan ventilasi yang berlebihan. Kesalahan-kesalahan ini dapat mengurangi perfusi koroner dan menurunkan kemungkinan terjadinya ROSC. Pedoman terbaru menekankan pentingnya pelatihan serta penggunaan perangkat umpan balik untuk meminimalkan kesalahan-kesalahan tersebut. Kesalahan lainnya meliputi posisi tangan yang tidak tepat, kompresi yang tidak stabil, dan keterlambatan dalam pergantian penolong. Kelelahan pada penolong juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas RJP. Oleh karena itu, pelatihan berbasis simulasi dan evaluasi kualitas kompresi sangat dianjurkan dalam praktik klinis

F. Penggunaan Automated External Defibrillator (AED)

1. Konsep Defibrilasi

Defibrilasi adalah prosedur yang melibatkan pemberian energi listrik yang terkontrol kepada miokardium untuk menghentikan aktivitas listrik jantung yang tidak teratur, seperti fibrilasi ventrikel dan takikardia ventrikel tanpa nadi. Tujuan dari defibrilasi adalah untuk menghentikan aritmia yang dapat mengancam jiwa sehingga nodus sinus dapat kembali mengatur irama jantung yang normal. Pedoman terbaru dari AHA dan ERC menegaskan bahwa defibrilasi yang dilakukan lebih awal merupakan intervensi paling efektif pada kasus henti jantung dengan irama yang dapat di-shock. Kemungkinan keberhasilan defibrilasi cenderung menurun secara signifikan setiap menit tanpa adanya tindakan, sehingga penggunaan AED harus dilakukan segera setelah alat tersebut tersedia (Kleinman et al., 2025)

Defibrilasi yang menggunakan AED dirancang agar dapat dilakukan baik oleh tenaga medis maupun oleh masyarakat umum. AED memiliki kemampuan untuk menganalisis irama jantung secara otomatis dan hanya akan memberikan kejutan listrik jika diperlukan. Pedoman terbaru menekankan pentingnya integrasi AED dalam algoritma BLS dan penggunaannya secepat mungkin setelah dimulainya RJP untuk meningkatkan peluang bertahan hidup pasien yang mengalami henti jantung (Del Rios et al., 2025)

2. Indikasi Penggunaan AED

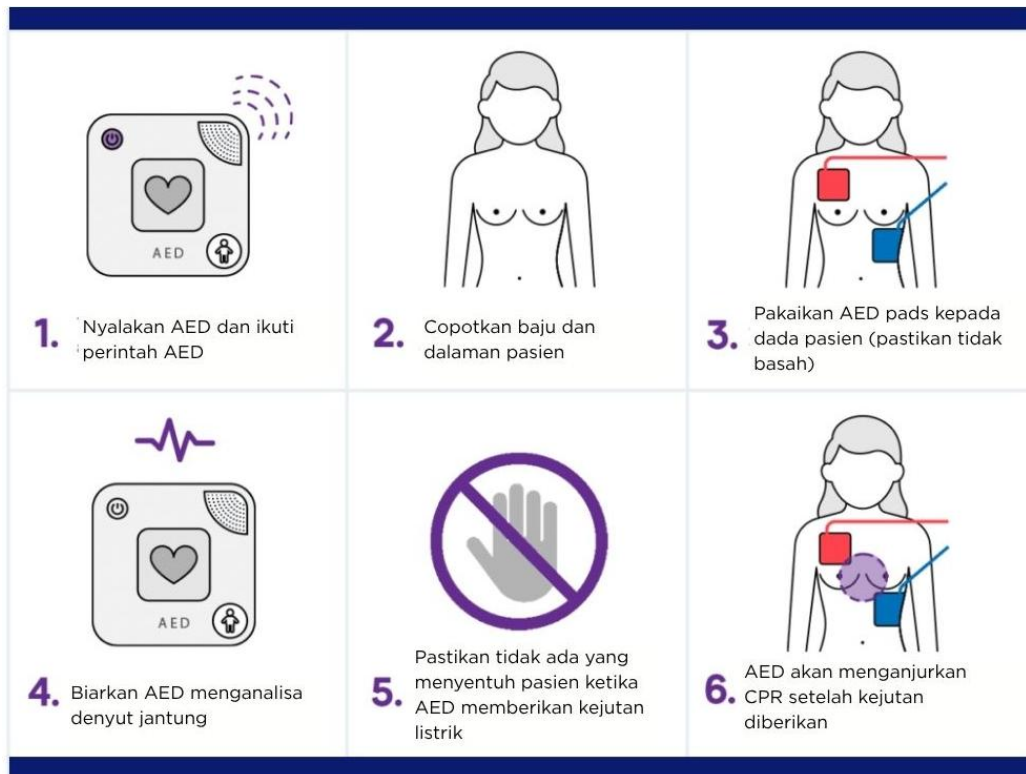
AED digunakan pada pasien yang diduga mengalami henti jantung, yaitu yang tidak responsif, tidak bernapas secara normal, dan tidak memiliki denyut nadi. Pedoman AHA 2025 merekomendasikan agar AED segera digunakan setelah alat tersedia tanpa menunda tindakan kompresi dada. Indikasi utama penggunaan AED adalah adanya irama jantung yang dapat di-shock, seperti fibrilasi ventrikel dan takikardia ventrikel tanpa nadi. AED akan menganalisis

irama jantung dan menentukan apakah defibrilasi diperlukan (Kleinman et al., 2025)

Selain itu, AED juga dapat digunakan pada pasien dewasa baik di luar rumah sakit maupun di dalam rumah sakit ketika terjadi henti jantung. Pedoman terbaru menegaskan bahwa AED harus tersedia dalam sistem defibrilasi akses publik untuk mempercepat proses defibrilasi. Penggunaan AED secara dini bersama dengan RJP yang berkualitas tinggi dapat meningkatkan tingkat kelangsungan hidup dua hingga tiga kali lipat dibandingkan tanpa adanya defibrilasi awal (Tsao et al., 2022)

3. Langkah Penggunaan AED

- a. Pastikan bahwa korban tidak responsif dan tidak bernapas dengan normal.
- b. Aktifkan sistem pertolongan medis atau hubungi tim Code Blue.
- c. Mulailah resusitasi jantung paru sambil meminta AED.
- d. Nyalakan AED segera setelah tersedia.
- e. Lepaskan pakaian korban dan pastikan area dada dalam keadaan kering.
- f. Tempelkan pad AED pada dada korban sesuai dengan petunjuk pada elektroda.
- g. Hentikan kompresi dada saat AED melakukan analisis irama.
- h. Pastikan tidak ada yang menyentuh korban selama proses analisis.
- i. Jika AED memberikan perintah untuk melakukan shock, pastikan semua orang menjauh.
- j. Tekan tombol shock sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh AED.
- k. Segera lanjutkan RJP selama dua menit setelah shock diberikan.
- k. Ikuti petunjuk AED untuk analisis ulang sampai bantuan medis tambahan tiba atau ROSC tercapai.



Gambar 5.2: Cara menggunakan AED (Yvette Tam, 2024)

G. Penghentian dan Evaluasi Resusitasi

Penghentian dan penilaian resusitasi dilakukan secara terstruktur untuk menilai keberhasilan tindakan RJP serta untuk mengambil keputusan mengenai kelanjutan atau penghentian resusitasi. Pedoman AHA 2025 menekankan pentingnya evaluasi setiap 2 menit dengan memperhatikan irama jantung, keberadaan nadi, dan tanda-tanda Return of Spontaneous Circulation (ROSC). Resusitasi akan diteruskan jika belum ada indikasi sirkulasi spontan. Keputusan untuk menghentikan resusitasi dipertimbangkan berdasarkan kondisi klinis pasien, penyebab henti jantung, serta keputusan tim resusitasi yang sesuai dengan standar etika dan klinis (Soar et al., 2021)

H. Langkah Penghentian dan Evaluasi Resusitasi

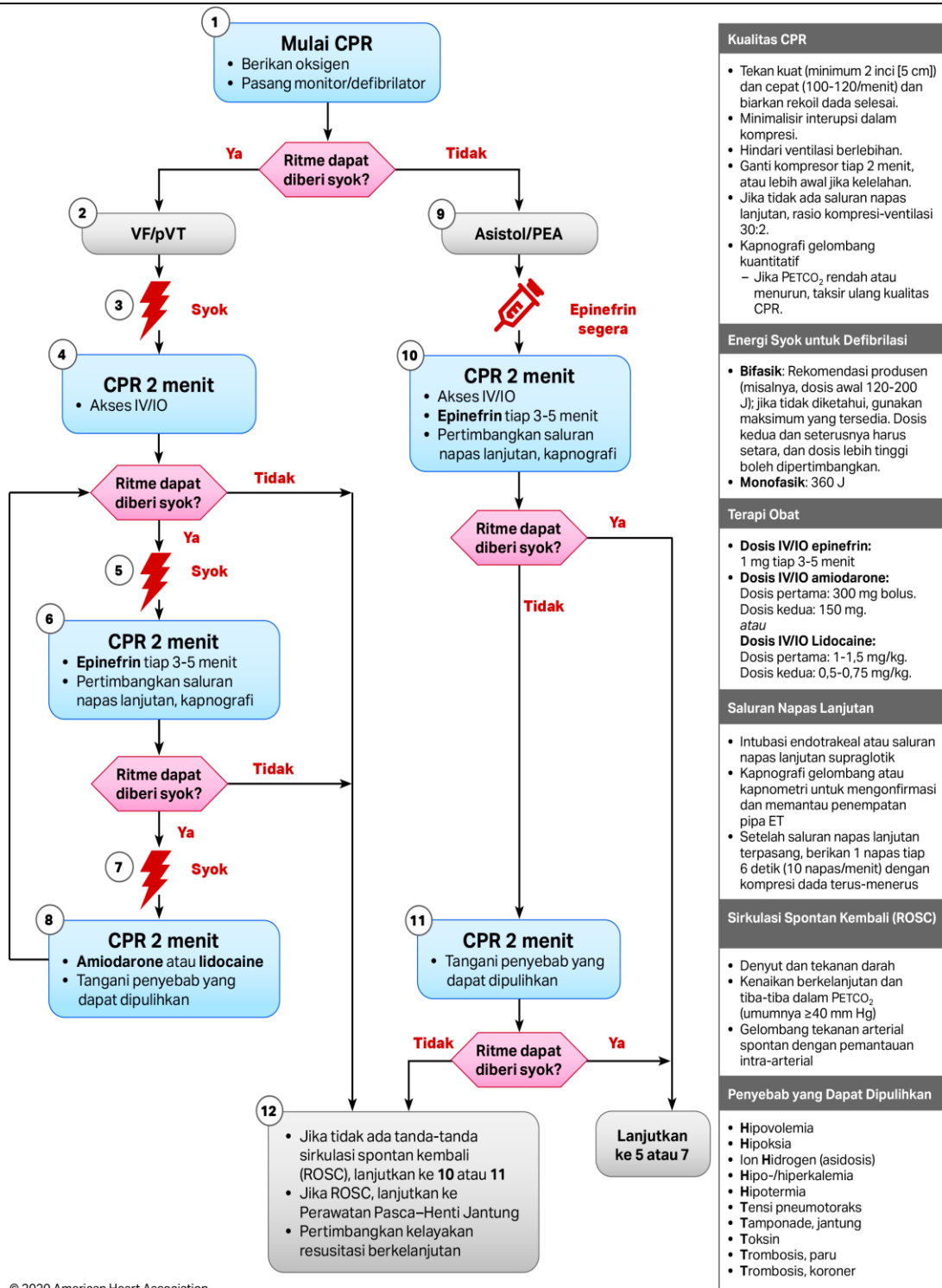
1. Lakukan evaluasi setiap 2 menit atau setelah 5 siklus RJP
2. Hentikan kompresi secara singkat untuk analisis irama jantung
3. Periksa nadi karotis maksimal 10 detik bila irama terorganisir muncul
4. Identifikasi tanda Return of Spontaneous Circulation (ROSC)
5. Jika ROSC tercapai, hentikan RJP dan lanjutkan perawatan pasca henti jantung
6. Jika irama shockable, lakukan defibrilasi dan lanjutkan RJP
7. Jika irama non-shockable, lanjutkan RJP dan identifikasi penyebab reversible

8. Pertimbangkan penghentian resusitasi bila tidak ada ROSC setelah upaya adekuat
9. Pertimbangkan faktor seperti waktu henti jantung, komorbid, dan penyebab
10. Penghentian resusitasi dilakukan berdasarkan keputusan tim resusitasi
11. Dokumentasikan waktu mulai, intervensi, dan hasil resusitasi
12. Lanjutkan monitoring bila terdapat tanda sirkulasi minimal (American Heart Association., 2025)

Kriteria ROSC

1. Teraba nadi spontan
2. Tekanan darah terukur
3. Peningkatan EtCO₂ mendadak
4. Gerakan spontan pasien
5. Pernapasan spontan kembali
6. Irama jantung terorganisir pada monitor

I. Algoritma Henti Jantung Dewasa



Gambar 5.3: Algoritma Henti Jantung Dewasa (Cpr & Ecc, 2020)

J. Aspek Keselamatan dan Etika dalam Bantuan Hidup Dasar

1. Keselamatan Penolong

Keselamatan penolong adalah hal yang paling penting sebelum melakukan Bantuan Hidup Dasar. Penolong harus memastikan bahwa lingkungan sekitar bebas dari risiko seperti listrik, kebakaran, bahan kimia, lalu lintas, atau potensi kekerasan. Pedoman resusitasi terbaru menegaskan bahwa tindakan RJP tidak boleh dilakukan jika dapat membahayakan penolong. Disarankan agar penolong menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan masker jika tersedia, terutama dalam lingkungan klinis. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah cedera dan paparan infeksi selama proses resusitasi.

Selain memperhatikan keselamatan lingkungan, penolong juga harus waspada terhadap risiko penularan penyakit saat memberikan ventilasi bantuan. Pedoman terbaru menyarankan penggunaan alat penghalang seperti pocket mask atau bag valve mask untuk meminimalkan risiko infeksi. Namun, jika alat tersebut tidak ada, kompresi dada harus segera dilakukan tanpa menunda tindakan. Prinsip ini menekankan bahwa kompresi dada yang dilakukan lebih awal tetap menjadi prioritas utama dalam upaya menyelamatkan pasien yang mengalami henti jantung.

2. Prinsip Etik Resusitasi

Prinsip etika dalam resusitasi berlandaskan pada beneficence, nonmaleficence, otonomi, dan keadilan. Beneficence menekankan tanggung jawab tenaga medis untuk melakukan tindakan yang dapat menyelamatkan nyawa. Nonmaleficence menggarisbawahi pentingnya mengurangi risiko cedera tambahan selama proses resusitasi. Otonomi berkaitan dengan penghormatan terhadap pilihan pasien, seperti keputusan untuk tidak melakukan resusitasi (DNR). Keadilan menekankan perlunya memberikan tindakan resusitasi secara merata tanpa adanya diskriminasi.

Panduan terbaru juga menegaskan bahwa resusitasi sebaiknya dihentikan jika tidak memberikan manfaat klinis atau bertentangan dengan keputusan pasien yang sah. Tim resusitasi perlu mempertimbangkan kondisi klinis, komorbiditas, dan kemungkinan keberhasilan sebelum melanjutkan proses resusitasi. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara upaya penyelamatan dan etika klinis dalam konteks praktik kegawatdaruratan.

3. Legal Aspek Tindakan BLS

Tindakan Bantuan Hidup Dasar (BLS) merupakan intervensi kegawatdaruratan yang dapat dilakukan tanpa persetujuan tertulis berdasarkan prinsip implied consent, di mana pasien tidak sadar dianggap setuju untuk

diselamatkan. Pedoman terkini menegaskan bahwa tenaga kesehatan memiliki kewajiban hukum dan profesional untuk melakukan resusitasi pada pasien henti jantung, kecuali ada perintah DNR atau tanda kematian yang jelas.

BLS harus dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur operasional dan pedoman yang berlaku. Ketidakpatuhan terhadap standar dapat berakibat hukum. Oleh karena itu, tenaga kesehatan wajib bertindak sesuai kompetensi, menggunakan algoritma yang tepat, dan mendokumentasikan semua tindakan dengan lengkap. Dokumentasi yang baik berfungsi sebagai bukti hukum bahwa tindakan telah dilakukan sesuai dengan standar praktik profesional

4. Dokumentasi Keperawatan Gawat Darurat

Dokumentasi resusitasi sangat penting dalam pelayanan keperawatan gawat darurat. Catatan harus mencakup waktu kejadian, penilaian awal, tindakan RJP, penggunaan AED, pemberian obat, dan hasil resusitasi. Pedoman terbaru menekankan pentingnya pencatatan waktu yang akurat untuk evaluasi kualitas resusitasi. Dokumentasi juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar tim dan untuk evaluasi mutu pelayanan.

Selain itu, dokumentasi harus mencatat respons pasien, perubahan irama jantung, tanda ROSC, dan keputusan untuk menghentikan resusitasi. Catatan harus ditulis secara objektif, kronologis, dan lengkap. Dokumentasi yang baik mendukung aspek klinis, etik, dan legal dalam praktik keperawatan gawat darurat, serta digunakan untuk audit klinis dan peningkatan kualitas resusitasi di fasilitas kesehatan.

K. Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Seorang pria berusia 58 tahun dibawa ke IGD oleh keluarganya karena tiba-tiba pingsan di rumah. Sebelumnya, pasien mengeluhkan nyeri dada 30 menit sebelum insiden. Setibanya di IGD, pasien tampak tidak responsif. Perawat melakukan penilaian awal dan menemukan bahwa pasien tidak merespons, tidak bernapas normal, dan nadi karotis tidak teraba. Monitor menunjukkan fibrilasi ventrikel, dan AED tersedia di ruang resusitasi. Tim resusitasi belum tiba, sementara perawat berada di lokasi dengan satu perawat lainnya.

Perawat segera memulai resusitasi jantung paru dan mengaktifkan sistem Code Blue. Kompresi dada dilakukan dan AED dipersiapkan. Setelah analisis pertama, AED merekomendasikan pemberian shock. Setelah defibrilasi pertama, RJP dilanjutkan selama dua menit. Pada evaluasi berikutnya, pasien masih tidak sadar dan nadi belum teraba. Tim resusitasi kemudian tiba untuk melanjutkan penanganan.

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut

Pertanyaan Diskusi

1. Apa masalah utama yang terjadi pada pasien dalam kasus tersebut
2. Apa tanda yang menunjukkan pasien mengalami henti jantung
3. Langkah penilaian awal apa yang harus dilakukan perawat pada kasus tersebut
4. Mengapa RJP harus segera dimulai pada pasien ini
5. Apa jenis irama jantung yang muncul pada monitor dan apa artinya
6. Mengapa AED harus digunakan pada kasus tersebut
7. Bagaimana urutan tindakan BLS yang tepat pada kasus di atas
8. Apa rasio kompresi dan ventilasi yang digunakan pada pasien dewasa
9. Kapan evaluasi dilakukan selama resusitasi
10. Mengapa RJP harus dilanjutkan setelah defibrilasi
11. Apa indikator keberhasilan resusitasi pada kasus tersebut
12. Apa peran perawat ketika tim Code Blue belum tiba
13. Bagaimana pembagian tugas jika terdapat dua penolong
14. Apa risiko jika terjadi keterlambatan defibrilasi
15. Apa dokumentasi yang harus dibuat setelah tindakan resusitasi

Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas.

L. Simulasi/skill lab RJP+AED

Fokus: urutan tindakan, komunikasi tim, keselamatan penolong

Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa mampu:

1. Melakukan penilaian awal korban secara sistematis
2. Melakukan RJP dewasa berkualitas tinggi
3. Menggunakan AED dengan benar
4. Menerapkan komunikasi tim resusitasi
5. Menjaga keselamatan selama tindakan BLS

Setting Simulasi

Tempat: Laboratorium keterampilan keperawatan / skill lab Media: Manikin dewasa, AED trainer, bag valve mask, sarung tangan, stopwatch Jumlah mahasiswa: 4–5 orang per kelompok Durasi: 10–15 menit per kelompok

Peran mahasiswa:

1. Penolong 1: kompresi dada
2. Penolong 2: airway dan ventilasi
3. Penolong 3: operator AED

4. Team leader
5. Observer (opsional)

Skenario Simulasi

Seorang laki-laki usia 55 tahun tiba-tiba kolaps di ruang rawat. Pasien tidak responsif dan tidak bernapas normal. Monitor belum terpasang. AED tersedia di ruangan. Mahasiswa diminta melakukan tindakan BLS dewasa sampai evaluasi setelah penggunaan AED.

Langkah Simulasi yang Diharapkan

1. Memastikan keamanan lingkungan
2. Menggunakan alat pelindung diri
3. Memeriksa respons pasien
4. Memanggil bantuan dan aktivasi Code Blue
5. Menilai pernapasan dan nadi maksimal 10 detik
6. Memposisikan pasien pada permukaan keras
7. Memulai kompresi dada segera
8. Melakukan kompresi 100–120 kali per menit
9. Kedalaman kompresi 5–6 cm
10. Memberikan ventilasi 30:2
11. Meminta AED dan menyiapkan alat
12. Menyalakan AED
13. Memasang pad AED dengan benar
14. Menghentikan kompresi saat analisis
15. Memberi instruksi “semua menjauh”
16. Memberikan shock bila dianjurkan
17. Melanjutkan RJP segera setelah shock
18. Melakukan pergantian penolong tiap 2 menit
19. Komunikasi tim menggunakan closed loop
20. Evaluasi setelah 2 menit RJP

Fokus Penilaian Observasi

1. Urutan Tindakan

- Penilaian awal benar
- RJP dimulai segera
- Kompresi berkualitas
- AED digunakan benar
- Evaluasi sesuai algoritma

2. Komunikasi Tim

- Team leader jelas
- Instruksi verbal tegas

- Closed loop communication
- Pembagian tugas efektif
- Koordinasi saat pergantian

3. Keselamatan

- Cek keamanan lokasi
- Penggunaan APD
- Tidak menyentuh saat analisis AED
- Instruksi clear sebelum shock
- Posisi kompresi aman

Checklist Penilaian (Shows How)

No	Komponen	Ya	Tidak
1	Memastikan keselamatan		
2	Cek respons pasien		
3	Aktivasi bantuan		
4	Cek napas dan nadi		
5	Mulai kompresi segera		
6	Kedalaman kompresi tepat		
7	Frekuensi kompresi tepat		
8	Recoil dada penuh		
9	Ventilasi adekuat		
10	Rasio 30:2 benar		
11	AED dinyalakan cepat		
12	Pad dipasang benar		
13	Clear sebelum shock		
14	RJP lanjut setelah shock		
15	Komunikasi tim efektif		

Debriefing Setelah Simulasi

Pertanyaan refleksi:

1. Apakah urutan tindakan sudah sesuai algoritma BLS
2. Apakah kompresi sudah berkualitas tinggi
3. Apakah komunikasi tim berjalan efektif
4. Apakah penggunaan AED sudah benar
5. Apa kesalahan yang terjadi selama simulasi
6. Apa yang harus diperbaiki pada praktik berikutnya

Output Pembelajaran OBE (Shows How)

Mahasiswa mampu:

1. Mendemonstrasikan RJP dewasa
2. Menggunakan AED dengan benar
3. Bekerja dalam tim resusitasi
4. Melakukan komunikasi efektif
5. Menjaga keselamatan tindakan

Cuplikan Rubrik

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan pasien	Aman & konsisten	Minor	Risiko kecil	Tidak aman
Asesmen & keputusan	Tepat & jelas	Cukup	Ragu	Keliru
Komunikasi	Empatik & jelas	Baik	Kurang	Buruk

M. Template Soal Osce Keperawatan

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	
2	Judul station	Sirkulasi: Melakukan Tindakan resusitasi jantung paru pada pasien henti jantung di ruang IGD
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian pasien henti jantung, implementasi resusitasi jantung paru, dan evaluasi
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku professional
6	Kategori	1. Oksigenasi 2. Sirkulasi 3. Cairan dan elektrolit

No.	Komponen	Isi
		4. Nutrisi 5. Aman dan nyaman 6. Psikososial 7. Eliminasi 8. Aktivitas dan istirahat 9. Seksual dan reproduksi
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang laki-laki usia 58 tahun dirawat di ruang rawat penyakit dalam dengan diagnosis infark miokard akut. Pasien terpasang infus NaCl 0,9% 20 tetes per menit dan monitor belum terpasang. Menurut perawat jaga, sebelumnya pasien mengeluh nyeri dada, sesak napas, dan tampak gelisah. Beberapa menit kemudian pasien tiba-tiba tampak tidak bergerak di tempat tidur. Saat Anda mendekati pasien, pasien tidak merespons saat dipanggil dan tidak ada respons terhadap rangsangan nyeri. Pasien tampak tidak bernapas normal dengan pernapasan gasping. Warna kulit tampak pucat dan ekstremitas terasa dingin. Anda tidak meraba nadi karotis. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian ABC pasien henti jantung dan sampaikan ke penguji 2. Lakukan tindakan resusitasi jantung paru 1 siklus 3. Lakukan Evaluasi ABC keadaan pasien setelah Tindakan dan sampaikan ke penguji
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang laki-laki usia 58 tahun dirawat di ruang rawat penyakit dalam dengan diagnosis infark miokard akut. Pasien terpasang infus NaCl 0,9% 20 tetes per menit dan monitor belum terpasang. Menurut perawat jaga, sebelumnya pasien mengeluh nyeri dada, sesak napas, dan tampak gelisah. Beberapa menit kemudian pasien tiba-tiba tampak tidak bergerak di tempat tidur. Saat Anda mendekati pasien, pasien tidak merespons saat dipanggil dan tidak ada respons terhadap rangsangan nyeri. Pasien tampak tidak bernapas normal dengan pernapasan

No.	Komponen	Isi
		gaspings. Warna kulit tampak pucat dan ekstremitas terasa dingin. Anda tidak meraba nadi karotis. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian ABC pasien henti jantung dan sampaikan ke penguji 2. Lakukan tindakan resusitasi jantung paru 1 siklus 3. Lakukan Evaluasi ABC keadaan pasien setelah Tindakan dan sampaikan ke penguji INSTRUKSI PENGUJI: 1. Sampaikan ke peserta pasien tidak ada respon, nadi carotis tidak teraba, dan tidak ada nafas 2. Mengamati dan Menilai Tindakan resusitasi jantung paru 3. Setelah dilakukan RJP 1 siklus (30 kompresi, 2 ventilasi), sampaikan ke peserta pasien teraba nadi carotis dan ada nafas
9	Instruksi untuk klien standar	Menggunakan manekin khusus RJP
10	Setting station	Ruang Unit Gawat Darurat - Tempat tidur pasien - Manekin Khusus RJP - Laboran - Penguji Tata letak ruang: 1. Tempat tidur dan manekin Khusus RJP 2. Kursi KS 3. Meja penguji 4. Kursi penguji 5. Pintu masuk 6. Troli alat 7. Wastafel/handrub 8. Tempat sampah 9. Kursi laboran

No.	Komponen	Isi
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Manekin dewasa khusus RJP 2. Bed pasien 3. Handscoon disposable 4. Kasa steril 5. Bengkok 6. BVM Peran laboran: merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

SOP RJP PADA DEWASA

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra interaksi				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan: 1. Manekin dewasa khusus RJP 2. Bed pasien 3. Handscoon disposable 4. Kasa steril 5. Bengkok 6. BVM				
3	Mencuci tangan				
B	Tahap Orientasi				
4	Aman Diri				
5	Aman Lingkungan				
6	Aman Pasien				
C	Tahap Kerja				
7	Periksa respons klien dengan memanggil, menepuk bahu dan/atau memberikan rangsangan nyeri				
8	Aktifkan Emergency Medical System atau berteriak meminta tolong				
9	Gunakan sarung tangan bersih, jika memungkinkan				
10	Posisikan klien di empat datar dan keras				

11	Atur posisi penolong berlutut di samping dada klien jika klien dilantai atau berdiri disamping dada klien (jika klien di tempat tidur)				
11	Periksa nadi karotis dan napas secara bersamaan dalam waktu 10 detik				
12	Lakukan kompresi dada jika nadi karotis tidak teraba:				
13	Posisikan telapak tangan menumpuk di atas telapak tangan yang lain tegak lurus pada pertengahan dada atau seperdua bawah sternum				
14	Lakukan kompresi dada dengan kecepatan 100-120 kali/menit dan kedalaman 5-6 cm				
15	Buka dan bersihkan jalan napas dengan Teknik head tilt-chin lift atau jaw thrust (jika curiga cedera servikal)				
16	Berikan bantuan napas (ventilasi) 2 kali dengan menggunakan BVM				
17	Lakukan kompresi dan ventilasi dengan kombinasi 30:2 sebanyak 5 siklus sekitar 2 menit				
18	Periksa nadi karotis dan napas tiap 2 menit atau 5 siklus				
19	Lakukan RJP kembali jika nadi karotis belum teraba				

20	Lakukan rescue breathing 10-12 kali/menit jika nadi karotis teraba dan napas tidak ada. Adapun jeda tiupan pertama dan kedua selama 5-6 detik. Cara hitungan nafas: 1 dan seribu, 2 dan seribu, 3 dan seribu, 4 dan seribu, 5 dan seribu kemudian berikan nafas				
21	Berikan posisi pemulihan (recovery position) jika nadi karotis teraba dan napas ada tetapi belum sadar (jika klien di lantai) atau berikan posisi semi fowler (jika klien di tempat tidur)				
22	Lepaskan sarung tangan				
D	Tahap Terminasi				
23	Lakukan cuci tangan				
24	Lakukan evaluasi terhadap klien tentang kegiatan yang telah dilakukan				
E	Tahap Dokumentasi				
25	Catat hasil tindakan yang telah dilakukan				
26	Catat respon klien				
27	Sampaikan hasil pemeriksaan pada keluarga klien				
F	Penampilan Profesional				
28	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

Form Penilaian Osce Keperawatan

STATION: Sirkulasi: Melakukan Tindakan resusitasi jantung paru pada pasien henti jantung di ruang IGD

1. Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Keperawatan	kemampuan peserta Ujian dalam melakukan pengkajian ABC: mengkaji respon pasien, Look listen and feel pernafasan dan Cek nadi karotis					1	
2	Implementasi Keperawatan	kemampuan peserta ujian dalam mengimplementasikan tindakan yang telah diidentifikasi dalam rencana asuhan keperawatan. tindakan yang dimaksud adalah melakukan Tindakan resusitasi jantung paru. Perhatikan deskripsiperforma untuk masing-masing skor.					2	
3	Evaluasi keperawatan:	kemampuan peserta ujian dalam evaluasi melakukan evaluasi ABC setelah dilakukan RJP					5	
4	Perilaku profesional	kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan profesionalisme dengan baik sesuai dengan prinsip etik dan legal, melakukan setiap tindakan dengan hati-hati dan memperhatikan kenyamanan dan keamanan klien.					2	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

N. Rubrik Penilaian

STATION: Sirkulasi: Melakukan Tindakan resusitasi jantung paru pada pasien henti jantung di ruang IGD

1. Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Pengkajian Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta Ujian dalam melakukan pengkajian ABC: mengkaji respon pasien, Look listen and feel pernafasan dan Cek nadi karotis					1	
2. Implementasi keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam mengimplementasikan tindakan yang telah diidentifikasi dalam rencana asuhan keperawatan. tindakan yang dimaksud adalah melakukan Tindakan resusitasi jantung paru. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					2	
3. Evaluasi Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam evaluasi melakukan evaluasi ABC setelah dilakukan RJP					5	
4. Perilaku Profesional Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan profesionalisme dengan baik sesuai dengan prinsip etik dan legal, melakukan setiap tindakan dengan hati-hati dan memperhatikan kenyamanan dan keamanan klien.					2	

2. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
Pengkajian Keperawatan Melakukan pengkajian ABC	Tidak melakukan pengkajian fokus, atau pengkajian tidak relevan dengan kasus Henti Jantung .	Peserta melakukan pengkajian: 1. Kaji respon pasien 2. Look listen and feel pernafasan,	Peserta melakukan pengkajian: 1. Kaji respon pasien 2. Look listen and feel pernafasan	Peserta melakukan pengkajian: 1. Kaji respon pasien 2. Look listen and feel pernafasan

		3. Cek nadi karotis Namun tidak lengkap atau tidak tepat	3. Cek nadi karotis Namun tidak sistematis	3. Cek nadi karotis Secara sistematis
Implementasi keperawatan Melakukan Tindakan resusitasi jantung paru	Peserta tidak melakukan tindakan resusitasi jantung paru.	Peserta melakukan 1-2 Poin tindakan resusitasi jantung paru sebagai berikut: 1. Pasang handscoon 2. Melakukan RJP 1 siklus (30 kompresi, 2 ventilasi) 3. Kedalaman 5-6 cm 4. Posisi yang baik dan benar (posisi penolong sejajar dengan dada korban letakkan 1 telapak tangan yang paling. kuat di bagian tulang dada sedikit dibawah	Peserta melakukan 3-4 Poin tindakan resusitasi jantung paru sebagai berikut: 1. Pasang handscoon 2. Melakukan RJP 1 siklus (30 kompresi, 2 ventilasi) 3. Kedalaman 5-6 cm 4. Posisi yang baik dan benar (posisi penolong sejajar dengan dada korban letakkan 1 telapak tangan yang paling. kuat di bagian	Peserta melakukan semua Poin tindakan resusitasi jantung paru sebagai berikut: 1. Pasang handscoon 2. Melakukan RJP 1 siklus (30 kompresi, 2 ventilasi) 3. Kedalaman 5-6 cm 4. Posisi yang baik dan benar (posisi penolong sejajar dengan dada korban letakkan 1 telapak tangan yang paling. kuat

		putting/ 1/3 dibawah sternum 5. Kecepatan 100120X/me nit)	tulang dada sedikit dibawah putting/ 1/3 dibawah sternum 5. Kecepatan 100120X/m enit)	di bagian tulang dada sedikit dibawah putting/ 1/3 dibawah sternum 5. Kecepatan 100120X/m enit)
Evaluasi : Keperawata n Melakukan evaluasi ABC setelah dilakukan RJP	Peserta tidak melakukan evaluasi ABC	Peserta melakukan evaluasi ABC secara menyeluruh: 1. Kaji respon pasien 2. Look listen and feel pernafasan, 3. Cek nadi karotis Namun tidak lengkap atau tidak tepat	Peserta melakukan evaluasi ABC secara menyeluruh: 1. Kaji respon pasien 2. Look listen and feel pernafasan, 3. Cek nadi karotis Namun tidak sistimatis	Peserta melakukan evaluasi ABC secara menyeluruh: 1. Kaji respon pasien 2. Look listen and feel pernafasan, 3. Cek nadi karotis Secara Sistimatis
Perilaku Profesional	Peserta Ujian tidak meminta ijin secara lisan dan sama sekali tidak melakukan poin berikut: 1. Melakuk an teliti	Peserta Meminta ijin secara lisan dan melakukan 1-2 poin berikut: 1. Melakukan teliti setiap tindakan	Peserta Meminta ijin secara lisan dan melakukan 3 poin berikut: 1. Melakukan teliti setiap	Peserta Meminta ijin secara lisan dan melakukan semua poin berikut: 1. Melakukan teliti setiap

	setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan klien dan diri sendiri 2. Memperhatikan kenyamanan pasien 3. Melakukan tindakan sesuai prioritas 4. Menunjukkan rasa hormat pada klien	dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan klien dan diri sendiri 2. Memperhatikan kenyamanan pasien 3. Melakukan tindakan sesuai prioritas 4. Menunjukkan rasa hormat pada klien	tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan klien dan diri sendiri 2. Memperhatikan kenyamanan pasien 3. Melakukan tindakan sesuai prioritas 4. Menunjukkan rasa hormat pada klien	tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan klien dan diri sendiri 2. Memperhatikan kenyamanan pasien 3. Melakukan tindakan sesuai prioritas 4. Menunjukkan rasa hormat pada klien
--	---	---	--	--

3. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

4. Global Performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = ----- x 100 =

30

(Kota),

.....

Penguji :

O. DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

- Observasi langsung pada Asuhan Keperawatan Anak dengan Diare
- Checklist + umpan balik singkat
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Catatan untuk penulis:

- Dari simulasi → praktik nyata
- Bukti performa sesungguhnya

Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada RJP orang Dewasa

Komponen	Deskripsi	Kasus Henti Jantung
Metode penilaian	Mini-CEX merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa dalam encounter singkat, terfokus, dan nyata di lahan praktik.	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi mahasiswa saat memberikan asuhan awal pada pasien yang mengalami henti Jantung
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi, edukasi, dan profesionalisme dalam satu pertemuan klinik.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang Konsep henti , tetapi juga dari kemampuannya melakukan pengkajian, menjelaskan kondisi pasien, dan menyampaikan rencana asuhan keperawatan.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau tahap profesi.	Seorang laki-laki usia 58 tahun dirawat di ruang rawat penyakit dalam dengan diagnosis infark miokard akut. Pasien terpasang infus NaCl 0,9% 20 tetes per menit dan monitor belum terpasang. Menurut perawat jaga, sebelumnya pasien mengeluh nyeri dada, sesak napas, dan tampak gelisah. Beberapa menit kemudian pasien

		tiba-tiba tampak tidak bergerak di tempat tidur. Saat Anda mendekati pasien, pasien tidak merespons saat dipanggil dan tidak ada respons terhadap rangsangan nyeri. Pasien tampak tidak bernapas normal dengan pernapasan gasping. Warna kulit tampak pucat dan ekstremitas terasa dingin. Anda tidak meraba nadi karotis
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan encounter klinik secara utuh sejak awal interaksi sampai penjelasan rencana tindakan.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan pengkajian singkat namun terarah, memeriksa tanda henti jantung, menjelaskan kondisi ABC Pasien, lalu menyampaikan rencana tindakan, RJP,
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi anamnesis atau pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi terapeutik, edukasi keluarga, profesionalisme, dan organisasi tindakan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menggali tanda tanda henti jantung, pengkajian ABC, kompresi Jantung Luar dan pemberian ventilasi napas buatan dengan bahasa sederhana, dan menjaga komunikasi yang baik dengan keluarga pasien.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa klinik mahasiswa secara langsung menggunakan format Mini-CEX yang terstruktur.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menghubungkan data klinik dengan masalah prioritas, misalnya henti jantung dan adanya obstruksi jalan napas.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat singkat, spesifik, dan berorientasi pada perbaikan performa.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan identifikasi tanda henti jantung, tetapi masih perlu memperdalam pengkajian

		lanjutan tentang gangguan kardiovaskuler dan memperjelas penjelasan tentang tanda bahaya.
Keputusan penilaian	Hasil Mini-CEX digunakan untuk menentukan tingkat performa mahasiswa dalam praktik klinik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan encounter klinik secara runtut, aman, komunikatif, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila masih membutuhkan arahan pada beberapa bagian. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila performanya belum memenuhi standar minimal.
Makna dalam OBE	Mini-CEX memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does.	Pada kasus Henti Jantung, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan asuhan keperawatan secara langsung, aman, tepat, dan profesional di lahan praktik.

P. Portofolio

Tabel Portofolio pada Kasus Henti Jantung Dewasa

Komponen	Deskripsi	Kasus Henti Jantung Dewasa
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada Kasus Henti Jantung, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian, menetapkan masalah keperawatan, memberikan edukasi, menjaga keselamatan pasien, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah

	belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	merawat Kasus Henti Jantung, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan Resusitasi Jantung Paru, sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan asuhan pada kasus Henti Jantung.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah keperawatan, intervensi utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus lelaki dewasa usia 58 tahun dengan Henti Jantung nyeri dada, sesak napas cair, tidak bernapas normal dengan pernapasan gasping. Warna kulit tampak pucat dan ekstremitas terasa dingin. tidak meraba nadi karotis muntah, tanda dehidrasi, pengkajian keperawatan prioritas, intervensi RJP, dan evaluasi respons Pasien.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan keperawatan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya memantau tanda henti napas dan jantung, mencatat intake-output dengan teliti, memastikan tindakan yang diberikan dengan cara yang benar, dan mengenali tanda bahaya yang membutuhkan pelaporan segera.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dengan keluarga pasien, tetapi masih perlu meningkatkan

	dan area yang masih perlu ditingkatkan.	ketelitian dalam pengkajian ABC dan dokumentasi setelah RJP.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus Henti jantung, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu melakukan asuhan keperawatan Gawat darurat secara aman, tepat, dan profesional.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan pengkajian ABC, RJP, dan komunikasi terapeutik dengan keluarga pasien
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada asuhan keperawatan Gawat Darurat dengan Henti Jantung, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep RJP, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik klinik nyata.

Tabel Case Report pada Asuhan Keperawatan Gawat Darurat dengan Henti Jantung

Komponen	Deskripsi	Kasus Henti Jantung Dewasa
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami,	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang Seorang laki-laki usia 58 tahun dirawat di ruang rawat penyakit dalam dengan diagnosis infark miokard akut pasien mengeluh nyeri dada, sesak napas, dan tampak gelisah.

	menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	tampak tidak bergerak di tempat tidur. pasien tidak merespons saat dipanggil dan tidak ada respons terhadap rangsangan nyeri. Pasien tampak tidak bernapas normal dengan pernapasan gasping. Warna kulit tampak pucat dan ekstremitas terasa dingin. tidak teraba nadi karotis
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah keperawatan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data pasien, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan yang diberikan, dan perkembangan kondisi pasien setelah intervensi.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus henti jantung, mahasiswa menuliskan diagnosa infark miokard akut pasien mengeluh nyeri dada, sesak napas, dan tampak gelisah tampak tidak bergerak di tempat tidur. pasien tidak merespons saat dipanggil dan tidak ada respons terhadap rangsangan nyeri. Pasien tampak tidak bernapas normal dengan pernapasan gasping. Warna kulit tampak pucat dan ekstremitas terasa dingin. tidak teraba nadi karotis, intervensi tindakan RJP, dan evaluasi perbaikan jalan napas, teraba nadikarotis
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan data kehilangan

	penalaran klinik, ketepatan intervensi, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	napas dan nadi karotis dengan masalah utama, memilih intervensi yang tepat, dan menilai respons pasien setelah pemberian tindakan.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus henti jantung, mahasiswa belajar bahwa pengkajian Airway Breathing dan sirkulasi tanda henti napas, dan edukasi keluarga merupakan bagian yang sangat penting dalam asuhan keperawatan Gawat Darurat.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep Henti jantung pada Dewasa, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan keperawatan secara utuh.

Tabel Refleksi Patient Safety pada Asuhan Keperawatan Gawat Darurat dengan Henti Jantung

Komponen	Deskripsi	Kasus Henti Jantung Dewasa
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus Gawat Darurat dengan Henti Jantung, mahasiswa merefleksikan bahwa kehilangan napas dan nadi yang cepat dapat menyebabkan perburukan kondisi bila tidak dikenali dan ditangani dengan tepat.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti kurang teliti memantau sirkulasi dan pernapasan

	keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan keperawatan.	atau terlambat mengenali tanda henti napas dan nadi, dapat berdampak besar pada keselamatan pasien.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada pasien ini adalah kematian, ketidakseimbangan sirkulasi dan pernapasan, dan keterlambatan penanganan bila keluarga tidak memahami tanda bahaya.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain penurunan status kesadaran, kesalahan pemberian tindakan, dan keterlambatan pelaporan tanda bahaya.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya memantau tanda henti napas dan jantung secara berkala, mencatat tanda vital khususnya pernapasan, Nadi Tekanan Darah dengan teliti, menjelaskan cara pemberian RJP yang benar, serta mengedukasi Keluarga tentang tanda bahaya.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada dewasa dengan Henti Jantung, pengkajian yang teliti, komunikasi yang jelas kepada keluarga, dan pemantauan berulang merupakan bagian penting untuk menjaga keselamatan pasien.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas

	jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	praktik keperawatan Gawat darurat secara berkelanjutan.
--	--	---

Q. Ringkasan

1. Bantuan Hidup Dasar (Bhd) Dan Henti Jantung Pada Dewasa

Henti jantung merupakan kondisi kegawatdaruratan yang ditandai dengan berhentinya aktivitas mekanik jantung secara mendadak sehingga sirkulasi darah ke otak dan organ vital terhenti. Kerusakan otak dapat terjadi dalam 4 hingga 6 menit tanpa oksigen sehingga tindakan cepat sangat menentukan keselamatan pasien. Bantuan Hidup Dasar menjadi kompetensi inti tenaga kesehatan, khususnya perawat, dalam meningkatkan peluang hidup pasien henti jantung. Secara epidemiologi, henti jantung masih menjadi penyebab kematian utama dengan insiden tinggi baik di luar maupun di dalam rumah sakit. Tingkat kelangsungan hidup di luar rumah sakit kurang dari 10 persen, sedangkan di rumah sakit berkisar 15 hingga 25 persen. Keberhasilan resusitasi dipengaruhi oleh deteksi dini, RJP cepat, defibrilasi dini, serta perawatan pasca henti jantung. Faktor risiko meliputi usia lanjut, penyakit jantung koroner, gagal jantung, diabetes, dan hipertensi.

Etiologi henti jantung pada dewasa terutama berasal dari penyebab kardiak seperti infark miokard, penyakit jantung koroner, dan aritmia fatal. Selain itu terdapat penyebab non kardiak seperti hipoksia, hipovolemia, emboli paru, hipotermia, trauma, dan overdosis obat. Penyebab ini dikenal sebagai reversible causes atau Hs and Ts yang harus segera diidentifikasi selama resusitasi. Gangguan kelistrikan jantung menyebabkan irama fatal seperti ventricular fibrillation, ventricular tachycardia tanpa nadi, pulseless electrical activity, dan asistol. Irama VF dan VT tanpa nadi termasuk shockable rhythm, sedangkan PEA dan asistol termasuk non shockable dengan prognosis lebih buruk. Hipoksia akibat henti jantung berdampak pada organ vital terutama otak. Kerusakan neuron terjadi dalam beberapa menit dan dapat menyebabkan defisit neurologis permanen. Selain itu terjadi disfungsi miokard, cedera ginjal akut, gangguan fungsi hati, dan sindrom pasca henti jantung akibat respons inflamasi sistemik.

Penilaian awal korban pada BLS dilakukan secara sistematis dengan memastikan keselamatan penolong, menilai respons pasien, menilai pernapasan dan nadi maksimal 10 detik, mengaktifkan bantuan medis, dan

memposisikan pasien pada permukaan keras. Jika pasien tidak responsif, tidak bernapas normal, dan tidak ada nadi, maka resusitasi jantung paru harus segera dimulai. Resusitasi jantung paru berkualitas tinggi menekankan kompresi kuat dan cepat, interupsi minimal, recoil penuh, ventilasi adekuat, serta pergantian penolong setiap dua menit. Kompresi dada dilakukan pada pertengahan sternum dengan kedalaman 5 sampai 6 cm dan frekuensi 100 sampai 120 kali per menit. Rasio kompresi dan ventilasi pada dewasa adalah 30 banding 2. Ventilasi diberikan selama 1 detik hingga dada mengembang. Kesalahan umum meliputi kompresi dangkal, interupsi lama, ventilasi berlebihan, dan posisi tangan tidak tepat.

Penggunaan Automated External Defibrillator dilakukan segera setelah tersedia pada pasien tidak responsif tanpa napas normal dan tanpa nadi. AED menganalisis irama jantung dan memberikan shock pada irama yang dapat di defibrilasi seperti VF dan VT tanpa nadi. Langkah penggunaan meliputi menyalakan alat, memasang pad, menghentikan kompresi saat analisis, memberikan shock jika dianjurkan, dan melanjutkan RJP selama dua menit sebelum evaluasi ulang. Defibrilasi dini meningkatkan peluang hidup secara signifikan. Evaluasi resusitasi dilakukan setiap dua menit dengan menilai irama jantung, nadi, dan tanda Return of Spontaneous Circulation. Tanda ROSC meliputi nadi teraba, tekanan darah terukur, pernapasan spontan, gerakan pasien, dan irama terorganisir. Jika ROSC tercapai, RJP dihentikan dan dilanjutkan perawatan pasca henti jantung. Jika belum, resusitasi dilanjutkan sesuai algoritma.

Aspek keselamatan dan etika dalam BLS mencakup keselamatan penolong, penggunaan alat pelindung diri, prinsip beneficence dan nonmaleficence, serta penghormatan keputusan pasien seperti DNR. Secara legal, tindakan BLS dapat dilakukan tanpa persetujuan tertulis berdasarkan implied consent. Dokumentasi resusitasi harus lengkap meliputi waktu kejadian, tindakan, penggunaan AED, hasil resusitasi, dan keputusan klinis. Dokumentasi berfungsi untuk komunikasi tim, evaluasi mutu, serta perlindungan hukum tenaga kesehatan.

R. Red Flag dan Eskalasi

PASIEN DENGAN KONDISI GAWAT DARURAT HENTI JANTUNG PADA KOMPONEN RJP DAN AED

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Tidak respons Pasien tidak menjawab panggilan	Penurunan kesadaran / henti jantung	Aktifkan penilaian BLS panggil code Blue
Tidak bernapas normal Apnea / gasping	Henti napas atau henti jantung	Mulai RJP segera Aktifkan tim resusitasi
Tidak ada nadi karotis Nadi tidak teraba ≤ 10 detik	Henti jantung	Mulai kompresi dada Code Blue segera
Gasping Napas megap-megap	Hipoksia berat	Mulai RJP AED Segera
Sianosis, bibir kebiruan	Hipoksia Berat	RJP + oksigen
Penurunan kesadaran mendadak GCS menurun	Perfusi otak menurun	Penilaian BLS Code Blue
Nyeri dada sebelum kolaps Riwayat IMA	Risiko henti jantung	Monitoring ketat
Nadi lemah kemudian hilang, Perfusi buruk	Pre-arrest condition	Siapkan RJP, Panggil Dokter
Bradikardia berat, HR < 40 x/menit	Risiko henti jantung	Monitoring + kesiapan RJP Eskalasi tim
Takikardia ventrikel	Henti jantung imminen	Siapkan AED, devibrilasi
Hipotensi berat TD < 90 mmHg	Syok	Monitoring intensif Eskalasi cepat
Pasien kolaps mendadak Sinkop tiba-tiba	Kemungkinan henti jantung	Penilaian cepat code blue
Tidak ada gerakan dada, apnea	Henti napas	Ventilasi + RJP, Tim Resusitasi
Monitor menunjukkan VF/VT Irama shockable	Henti jantung	Defibrilasi AED/defibrillator
Asistol pada monitor Tidak ada aktivitas listrik	Henti jantung	RJP segera ALS team

Form Checklist “Saya sudah bisa...”

Bab Bantuan Hidup Dasar BLS dan Henti Jantung Dewasa

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya memastikan keamanan lingkungan sebelum tindakan	☐	☐	
2	Saya memeriksa respons pasien	☐	☐	
3	Saya memanggil bantuan atau aktivasi Code Blue	☐	☐	
4	Saya menilai pernapasan pasien	☐	☐	
5	Saya memeriksa nadi karotis maksimal 10 detik	☐	☐	
6	Saya menyatakan pasien henti jantung	☐	☐	
7	Saya memposisikan pasien pada permukaan datar	☐	☐	
8	Saya mulai kompresi dada segera	☐	☐	
9	Saya melakukan kompresi di tengah dada	☐	☐	
10	Saya melakukan kedalaman kompresi 5–6 cm	☐	☐	
11	Saya menjaga frekuensi kompresi 100–120/menit	☐	☐	
12	Saya memastikan recoil dada penuh	☐	☐	
13	Saya menggunakan rasio kompresi ventilasi 30:2	☐	☐	
14	Saya memberikan ventilasi adekuat	☐	☐	
15	Saya meminta AED segera	☐	☐	
16	Saya meminta AED segera	☐	☐	
17	Saya menyalakan AED	☐	☐	
18	Saya membuka pakaian dada pasien	☐	☐	

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
19	Saya memasang pad AED dengan benar	☐	☐	
20	Saya menghentikan kompresi saat analisis AED	☐	☐	
21	Saya memastikan semua menjauh sebelum shock	☐	☐	
22	Saya memberikan defibrilasi sesuai instruksi AED	☐	☐	
23	Saya melanjutkan RJP segera setelah shock	☐	☐	
24	Saya melakukan RJP selama 2 menit	☐	☐	
25	Saya melakukan evaluasi ulang	☐	☐	
26	Saya melakukan pergantian penolong bila perlu	☐	☐	
27	Saya menjaga komunikasi tim selama resusitasi	☐	☐	
28	Saya menjaga keselamatan selama penggunaan AED	☐	☐	
29	Saya mengevaluasi tanda ROSC	☐	☐	
30	Saya menyimpulkan tindakan resusitasi	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

S. Glosarium

Airway: Jalan napas yang harus dipastikan terbuka selama tindakan resusitasi

AED (Automated External Defibrillator): Alat defibrilasi otomatis yang menganalisis irama jantung dan memberikan kejutan listrik bila diperlukan.

Agonal Gasping: Napas tidak normal berupa tarikan napas lambat atau tersengal yang sering muncul pada henti jantung.

Algoritma Resusitasi: Urutan langkah sistematis dalam penanganan henti jantung sesuai pedoman resusitasi

Asistol: Kondisi tidak adanya aktivitas listrik jantung pada monitor EKG.

Bag Valve Mask (BVM): Alat ventilasi manual untuk memberikan bantuan napas pada pasien

Beneficence: Prinsip etik yang menekankan tindakan untuk memberikan manfaat terbaik bagi pasien.

Basic Life Support (BLS): Tindakan dasar penyelamatan hidup pada korban henti napas atau henti jantung.

Breathing: Komponen penilaian pernapasan dalam pendekatan ABC.

Cardiac Arrest: Henti jantung mendadak yang menyebabkan sirkulasi darah berhenti

Chain of Survival: Rangkaian tindakan penyelamatan pasien henti jantung mulai dari deteksi dini hingga perawatan pasca resusitasi

Chest Compression Fraction: Persentase waktu kompresi dada selama resusitasi berlangsung

Closed Loop Communication: Teknik komunikasi tim dengan konfirmasi ulang instruksi untuk mengurangi kesalahan

Code Blue: Sistem panggilan darurat rumah sakit untuk pasien yang mengalami henti jantung atau kegawatan serius.

Compression: Tekanan ritmik pada dada untuk membantu sirkulasi darah saat RJP

CPR (Cardiopulmonary Resuscitation): Resusitasi jantung paru yang terdiri dari kompresi dada dan ventilasi bantuan

Defibrilasi: Pemberian energi listrik untuk menghentikan aritmia jantung yang mematikan

DNR (Do Not Resuscitate): Instruksi medis untuk tidak melakukan resusitasi pada pasien tertentu.

DOPS (Direct Observation of Procedural Skills): Metode penilaian keterampilan klinik melalui observasi langsung di lahan praktik.

Emergency Medical System (EMS): Sistem layanan medis darurat yang memberikan respons cepat pada kondisi kegawatan

EtCO₂ (End Tidal Carbon Dioxide): Kadar karbon dioksida akhir ekspirasi yang digunakan untuk memantau efektivitas resusitasi.

Fibrilasi Ventrikel (VF): Irama jantung tidak teratur yang menyebabkan ventrikel hanya bergetar tanpa memompa darah efektif.

Gasping: Pola napas abnormal yang sering ditemukan pada pasien henti jantung

Head Tilt Chin Lift: Teknik membuka jalan napas dengan mendongakkan kepala dan mengangkat dagu.

Hipoksia: Kondisi kekurangan oksigen pada jaringan tubuh.

Hypovolemia: Penurunan volume cairan intravaskular dalam tubuh

Implied Consent: Persetujuan tindakan medis yang diasumsikan diberikan pada pasien tidak sadar dalam kondisi darurat

Jaw Thrust: Teknik membuka jalan napas tanpa menggerakkan leher pada pasien trauma servikal.

Pulseless Electrical Activity (PEA): Aktivitas listrik jantung tanpa denyut nadi yang teraba

Recovery Position: Posisi miring aman untuk pasien tidak sadar tetapi masih bernapas spontan.

Recoil Dada: Kembalinya dada ke posisi semula setelah kompresi dilepaskan.

Resusitasi: Upaya mengembalikan fungsi napas dan sirkulasi pada pasien henti jantung

Return of Spontaneous Circulation (ROSC): Kembalinya sirkulasi darah spontan setelah tindakan resusitasi.

Ventricular Fibrillation (VF): Irama ventrikel kacau yang menyebabkan henti sirkulasi

Ventricular Tachycardia (VT): Irama jantung cepat yang berasal dari ventrikel.

T. Daftar Pustaka

American Heart Association. (2024). Highlights of the 2024 AHA Guidelines for CPR and ECC. <https://Cpr.Heart.Org/En/Resuscitation-Science/2024-First-Aid-Guidelines>.

American Heart Association. (2025). Guidelines for CPR and ECC. Circulation. <https://Cpr.Heart.Org/En/Resuscitation-Science/High-Quality-Cpr>.

Cpr, P., & Ecc, D. (2020). Fokus utama Pedoman American Heart Association 2020 untuk CPR dan ECC.

Del Rios, M., Bartos, J. A., Panchal, A. R., Atkins, D. L., Cabañas, J. G., Cao, D., Dainty, K. N., Dezfulian, C., Donoghue, A. J., Drennan, I. R., Elmer, J., Hirsch, K. G., Idris, A. H., Joyner, B. L., Kamath-Rayne, B. D., Kleinman, M. E., Kurz, M. C., Lasa, J. J., Lee, H. C., ... Previdi, J. K. (2025). Part 1: Executive Summary: 2025 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation, 152(16_suppl_2). <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001372>

dr. Nurul Falah. (2026). Patofisiologi Henti Jantung Mendadak. <https://www.alomedika.com/penyakit/kegawatdaruratan-medis/henti-jantung-mendadak/patofisiologi>.

John Wink, M. E. L. M. (2025, December 16). Cardiac arrest. <https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/283?>

Kleinman, M. E., Buick, J. E., Huber, N., Idris, A. H., Levy, M., Morgan, S. G., Nassal, M. M. J., Neth, M. R., Norii, T., Nunnally, M. E., Rodriguez, A. J., Walsh, B. K., &

- Drennan, I. R. (2025). Part 7: Adult Basic Life Support: 2025 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. *Circulation*, 152(16_suppl_2). <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001369>
- Olasveengen, T. M., Semeraro, F., Ristagno, G., Castren, M., Handley, A., Kuzovlev, A., Monsieurs, K. G., Raffay, V., Smyth, M., Soar, J., Svavarsdottir, H., & Perkins, G. D. (2021). European Resuscitation Council Guidelines 2021: Basic Life Support. *Resuscitation*, 161, 98–114. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2021.02.009>
- Rante, A., Rasyid, D., Dg Salimung, H., & M, W. (2025). Effect of BTCLS Training on Emergency Department Clinicians' Competencies in Cardiac Arrest Management: A Single-Group Pretest–Posttest Study at Rumah Sakit Umum Pongtiku. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 9(1), 77–87. <https://doi.org/10.56338/mppki.v9i1.8447>
- Sekhon, M. M. (2021). The pathophysiology of hypoxic ischemic brain injury after cardiac arrest. <https://open.library.ubc.ca/collections/24/items/1.0395938>
- Soar, J., Böttiger, B. W., Carli, P., Couper, K., Deakin, C. D., Djärv, T., Lott, C., Olasveengen, T., Paal, P., Pellis, T., Perkins, G. D., Sandroni, C., & Nolan, J. P. (2021). European Resuscitation Council Guidelines 2021: Adult advanced life support. *Resuscitation*, 161, 115–151. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2021.02.010>
- Tsao, C. W., Aday, A. W., Almarzooq, Z. I., Alonso, A., Beaton, A. Z., Bittencourt, M. S., Boehme, A. K., Buxton, A. E., Carson, A. P., Commodore-Mensah, Y., Elkind, M. S. V., Evenson, K. R., Eze-Nliam, C., Ferguson, J. F., Generoso, G., Ho, J. E., Kalani, R., Khan, S. S., Kissela, B. M., ... Martin, S. S. (2022). Heart Disease and Stroke Statistics—2022 Update: A Report From the American Heart Association. *Circulation*, 145(8). <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001052>
- Tsao, C. W., Aday, A. W., Almarzooq, Z. I., Anderson, C. A. M., Arora, P., Avery, C. L., Baker-Smith, C. M., Beaton, A. Z., Boehme, A. K., Buxton, A. E., Commodore-Mensah, Y., Elkind, M. S. V., Evenson, K. R., Eze-Nliam, C., Fugar, S., Generoso, G., Heard, D. G., Hiremath, S., Ho, J. E., ... Martin, S. S. (2023). Heart Disease and Stroke Statistics—2023 Update: A Report From the American Heart Association. *Circulation*, 147(8). <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001123>
- Virani, S. S., Newby, L. K., Arnold, S. V., Bittner, V., Brewer, L. C., Demeter, S. H., Dixon, D. L., Fearon, W. F., Hess, B., Johnson, H. M., Kazi, D. S., Kolte, D., Kumbhani, D. J., LoFaso, J., Mahtta, D., Mark, D. B., Minissian, M., Navar, A. M., Patel, A. R., ... Williams, M. S. (2023). 2023 AHA/ACC/ACCP/ASPC/NLA/PCNA Guideline for the Management of Patients With Chronic Coronary Disease. *Journal of the*

American College of Cardiology, 82(9), 833–955.
<https://doi.org/10.1016/j.jacc.2023.04.003>

Winterburn, H., Perkins, G. D., Ji, C., Booth, S., de Paeztron, A., Fothergill, R., & Brown, T. P. (2026). Epidemiology and outcomes of out-of-hospital cardiac arrests at sport and recreational events in England, 2015–2022. *Resuscitation Plus*, 27, 101168. <https://doi.org/10.1016/j.resplu.2025.101168>

Yow, A. G., Rajasurya, V., Ahmed, I., & Sharma, S. (2026). Sudden Cardiac Death.

Yvette Tam. (2024, April 22). How to Use an AED: Step-By-Step Guide. <https://www.avive.life/blog/how-to-use-aed>.

BAB 6

KEGAWATDARURATAN PERNAPASAN

Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-4	Mampu melaksanakan resusitasi dan tata laksana awal kegawatdaruratan (respirasi, kardiovaskular, syok) secara aman dan terukur.	CPMK-4, CPMK-5

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-4	Melaksanakan manajemen airway dan oksigenasi dasar serta intervensi awal kegawatdaruratan pernapasan secara aman dan terukur.
CPMK-5	Melaksanakan bantuan hidup dasar (dewasa, anak, bayi) dan penanganan awal henti jantung/kegawatdaruratan kardiovaskular sesuai prosedur keselamatan.

Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 4	Sub-CPMK 5	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 6. Kegawatdaruratan Pernapasan	4.1 Memilih dan menerapkan teknik airway dasar sesuai kondisi klinis.	5.1 Melaksanakan rangkaian BLS dewasa sesuai prosedur dan keselamatan resusitasi.	CPMK 4	CPMK-5
	4.2 Menentukan strategi oksigenasi/ventilasi dasar dan monitoring respons.	5.2 Mengoperasikan penggunaan AED/defibrilasi dasar sesuai indikasi dan protokol keselamatan.		

Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-4	Skill station airway/oksigenasi + checklist	Ketepatan pemilihan teknik/alat (persentase item benar) dan efektivitas ventilasi/oksigenasi dasar berdasarkan parameter respons.	15	Checklist keterampilan; catatan respons
CPMK-5	Simulasi resusitasi (megacode) + checklist	Kualitas rangkaian BLS (persentase langkah terpenuhi) dan ketepatan penggunaan AED/defibrilasi dasar sesuai prosedur.	20	Checklist megacode; catatan waktu

Rubrik CPMK (skala 1–4)

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Ketepatan pemilihan & penerapan airway/oksigenasi dasar	Banyak langkah salah; risiko tinggi	Langkah dasar benar; ada kekurangan bermakna	Tepat; kesalahan minor	Sangat tepat; aman tanpa kesalahan bermakna
4.2 Efektivitas ventilasi/oksigenasi & monitoring respons	Tidak efektif; respons tidak dipantau	Cukup efektif; monitoring belum konsisten	Efektif; monitoring konsisten	Sangat efektif; monitoring lengkap dan respons cepat

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Kualitas rangkaian BLS (item checklist)	≤60% langkah terpenuhi; ada kesalahan kritis	61–75% terpenuhi; langkah penting terlewat	76–90% terpenuhi; tanpa kesalahan kritis	>90% terpenuhi; ritme kerja sangat baik
5.2 Ketepatan penggunaan AED/defibrilasi dasar & keselamatan	Indikasi/prosedur keliru; keselamatan diabaikan	Prosedur cukup; keselamatan kurang konsisten	Prosedur tepat; keselamatan terpenuhi	Prosedur sangat tepat; keselamatan sangat konsisten

A. Definisi Kegawatdaruratan Pernapasan

Kegawatdaruratan pernapasan merupakan kondisi klinis ketika sistem respirasi tidak mampu mempertahankan ventilasi dan oksigenasi secara adekuat, sehingga terjadi hipoksemia, hiperkapnia, atau keduanya, yang dapat berkembang cepat menjadi ancaman terhadap kehidupan. Dalam konteks klinis, keadaan ini tidak hanya berkaitan dengan gangguan paru semata, tetapi juga dapat melibatkan jalan napas, mekanika pernapasan, perfusi paru, serta gangguan sistemik yang memengaruhi pertukaran gas. Oleh karena itu, kegawatdaruratan pernapasan harus dipahami sebagai kondisi prioritas tinggi dalam pelayanan gawat darurat karena keterlambatan identifikasi dan tata laksana dapat meningkatkan risiko gagal napas, kebutuhan ventilasi mekanik, dan kematian. Bagi perawat, pemahaman konsep dasar ini penting sebagai landasan untuk melakukan pengkajian cepat, penentuan prioritas, dan intervensi yang berorientasi pada keselamatan pasien (Lagina & Valley, 2025; Summers et al., 2020; Fujishima, 2023).

B. Etiologi dan Faktor Risiko

Secara etiologis kegawatdaruratan pernapasan dapat disebabkan oleh berbagai kondisi yang memengaruhi jalan napas, jaringan paru, pleura, neuromuskular, maupun sistem sirkulasi. Penyebab yang sering dijumpai meliputi obstruksi jalan napas, asma berat, eksaserbasi penyakit paru obstruktif kronik, pneumonia berat, edema paru, emboli paru, pneumotoraks, trauma toraks, serta acute respiratory distress syndrome. Selain itu, penyakit sistemik seperti sepsis, gangguan neurologis, dan penurunan kesadaran juga dapat memperburuk ventilasi dan memicu gagal napas akut. Faktor risiko yang meningkatkan kerentanan pasien antara lain usia lanjut, penyakit paru kronik, kebiasaan merokok, obesitas, penyakit jantung, infeksi berat, dan adanya komorbid multipel. Dalam pembelajaran keperawatan, pemahaman mengenai etiologi dan faktor risiko penting karena membantu mahasiswa menghubungkan penyebab gangguan dengan pola gejala, prioritas pemantauan, serta urgensi intervensi (Scala & Heunks, 2018).

C. Patofisiologi Kegawatdaruratan Pernapasan

Secara patofisiologis kegawatdaruratan pernapasan umumnya terjadi akibat gangguan ventilasi, gangguan perfusi, gangguan difusi, atau kombinasi dari ketiganya. Ketidakseimbangan ventilasi-perfusi menyebabkan oksigen yang masuk

ke alveoli tidak dimanfaatkan secara optimal oleh sirkulasi paru, sehingga kadar oksigen darah menurun. Pada saat yang sama, gangguan eliminasi karbon dioksida dapat menyebabkan hiperkapnia dan asidosis respiratorik. Tubuh mula-mula berupaya mengompensasi keadaan ini melalui peningkatan frekuensi napas, penggunaan otot bantu pernapasan, dan peningkatan kerja kardiovaskular. Namun, apabila gangguan berlanjut, kelelahan otot respirasi dapat terjadi dan mempercepat perburukan menuju gagal napas akut. Dalam kondisi berat, hipoksia jaringan yang menetap dapat memicu disfungsi organ, penurunan kesadaran, dan kegagalan multiorgan. Karena itu, mahasiswa perlu memahami bahwa perubahan klinis pada pasien respirasi selalu berkaitan erat dengan perubahan fisiologis yang mendasarinya, bukan sekadar perubahan angka saturasi oksigen semata (Scala & Heunks, 2018).

Untuk mempermudah mahasiswa memahami hubungan antara penyebab, perubahan fisiologis, dan munculnya manifestasi klinis, patofisiologi kegawatdaruratan pernapasan dapat dipahami sebagai rangkaian proses yang dimulai dari gangguan jalan napas, ventilasi, perfusi, atau difusi oksigen. Gangguan tersebut menyebabkan pertukaran gas menjadi tidak efektif sehingga timbul hipoksemia, hiperkapnia, atau keduanya. Tubuh kemudian berusaha melakukan kompensasi melalui peningkatan frekuensi napas, penggunaan otot bantu pernapasan, dan peningkatan kerja jantung. Namun, apabila penyebab dasar tidak segera diatasi, kompensasi ini akan gagal dan berlanjut menjadi kelelahan otot respirasi, asidosis, hipoksia jaringan, serta disfungsi organ vital. Pada tahap lanjut, kondisi ini dapat berkembang menjadi gagal napas akut, henti napas, hingga kematian (Scala & Heunks, 2018).



Gambar 6.1: Patofisiologi kegawatdaruratan pernapasan menunjukkan bahwa berbagai penyebab seperti obstruksi jalan napas, gangguan parenkim paru, trauma, dan gangguan perfusi paru dapat menimbulkan ketidakseimbangan ventilasi–perfusi dan gangguan difusi oksigen. Keadaan ini menyebabkan hipoksemia dan/atau hiperkapnia yang mula-mula direspons tubuh melalui mekanisme kompensasi, tetapi pada kondisi berat akan berujung pada kelelahan otot respirasi, hipoksia jaringan, gagal napas akut, dan disfungsi multiorgan (Scala & Heunks, 2018).

D. Klasifikasi Kegawatdaruratan Pernapasan

Kegawatdaruratan pernapasan dapat diklasifikasikan berdasarkan mekanisme gangguan yang dominan. Kelompok pertama adalah gangguan obstruktif, seperti asma berat, eksaserbasi COPD, dan sumbatan jalan napas atas. Kelompok kedua adalah gangguan restriktif atau parenkim paru, seperti pneumonia berat, edema paru, dan ARDS, yang terutama mengganggu ekspansi paru dan difusi oksigen. Kelompok ketiga adalah gangguan perfusi paru, misalnya emboli paru, yang menyebabkan aliran darah ke alveoli terganggu. Kelompok keempat mencakup gangguan mekanik dan trauma, seperti pneumotoraks atau hemotoraks, sedangkan kelompok kelima meliputi gangguan neuromuskular yang menurunkan kemampuan ventilasi, misalnya cedera medula spinalis atau

kelemahan otot napas. Pemahaman terhadap klasifikasi ini penting dalam pendidikan keperawatan karena setiap kelompok memiliki pola klinis, risiko, dan prioritas penanganan yang berbeda (Scala & Heunks, 2018).

Untuk mempermudah mahasiswa memahami berbagai penyebab kegawatdaruratan pernapasan, kondisi tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan mekanisme gangguan fisiologis yang mendasarinya. Klasifikasi ini membantu tenaga kesehatan mengidentifikasi sumber utama gangguan respirasi sehingga dapat menentukan prioritas penanganan yang tepat. Secara umum, kegawatdaruratan pernapasan dapat dibagi menjadi beberapa kelompok utama, yaitu gangguan obstruktif, gangguan restriktif atau parenkim paru, gangguan perfusi paru, trauma toraks, gangguan neuromuskular, serta gangguan sistemik yang memengaruhi ventilasi dan oksigenasi. Setiap kelompok memiliki karakteristik klinis yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan pengkajian dan intervensi yang berbeda pula (Rae, 2019).

Pemahaman terhadap klasifikasi ini sangat penting dalam praktik keperawatan gawat darurat karena membantu perawat menghubungkan antara penyebab penyakit, perubahan patofisiologi, serta manifestasi klinis yang muncul pada pasien. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami konsep teoritis mengenai penyakit respirasi akut, tetapi juga mampu menginterpretasikan tanda klinis secara lebih sistematis dan melakukan tindakan yang tepat dalam situasi kegawatdaruratan (Lagina & Valley, 2025; Siela, 2018).

Tabel 6.1: Klasifikasi Kegawatdaruratan pernapasan berdasarkan mekanisme gangguan

Klasifikasi	Mekanisme Gangguan	Contoh Kondisi Klinis	Karakteristik Utama
Obstruktif	Terjadi hambatan aliran udara pada jalan napas sehingga ventilasi alveolar menurun	Asma akut berat, Eksaserbasi COPD, Obstruksi jalan napas atas	Wheezing, sesak napas, peningkatan kerja napas
Restriktif / Parenkim Paru	Penurunan ekspansi paru atau gangguan difusi oksigen di alveoli	Pneumonia berat, ARDS, edema paru	Takipnea, sesak napas, peningkatan kerja napas
Gangguan Perfusi Paru	Aliran darah ke alveoli terganggu sehingga terjadi ketidakseimbangan ventilasi-perfusi	Emboli paru	Hipoksemia mendadak, nyeri dada, takipnea
Trauma Toraks	Gangguan mekanika pernapasan akibat cedera dinding dada atau pleura	Pneumotoraks, hemotoraks, flail chest	Penurunan ekspansi dada, nyeri toraks, sesak napas
Gangguan Neuromuskular	Kelemahan otot respirasi atau gangguan saraf yang mengontrol ventilasi	Guillain-Barré syndrome, cedera medula spinalis, myasthenia gravis	Hipoventilasi, penurunan kekuatan napas
Gangguan Sistemik	Gangguan metabolik atau inflamasi sistemik yang memengaruhi fungsi respirasi	Sepsis, syok, keracunan obat	Takipnea, perubahan status mental, hipoksia

Sumber : (Lagina & Valley, 2025; Siela, 2018).

E. Manifestasi Klinis

Manifestasi klinis kegawatdaruratan pernapasan umumnya mencerminkan adanya gangguan oksigenasi, ventilasi, atau peningkatan kerja napas. Tanda yang sering ditemukan meliputi sesak napas, takipnea, penggunaan otot bantu napas, retraksi dinding dada, bunyi napas tambahan seperti wheezing, crackles, atau stridor, serta penurunan saturasi oksigen. Pada kasus yang lebih berat, pasien dapat tampak sianosis, gelisah, bingung, letargi, hingga mengalami penurunan kesadaran. Dalam praktik keperawatan, penting dipahami bahwa perubahan status mental sering kali merupakan tanda hipoksia atau hiperkapnia yang signifikan. Oleh sebab itu, pengamatan klinis tidak boleh hanya berfokus pada monitor, tetapi juga harus memperhatikan tampilan umum pasien, kemampuan berbicara, posisi bernapas, pola napas, serta respons terhadap intervensi awal (Sweet et al., 2017; Nejat, 2024).

Dalam praktik klinis penting bagi tenaga kesehatan untuk membedakan antara respiratory distress dan respiratory failure karena kedua kondisi ini menunjukkan tingkat keparahan gangguan respirasi yang berbeda. Respiratory distress merupakan tahap awal ketika tubuh masih mampu melakukan kompensasi melalui peningkatan frekuensi napas dan penggunaan otot bantu pernapasan. Sebaliknya, respiratory failure terjadi ketika mekanisme kompensasi tidak lagi mampu mempertahankan ventilasi dan oksigenasi yang adekuat sehingga menyebabkan hipoksemia berat, hiperkapnia, atau keduanya. Pada tahap ini, pasien memerlukan intervensi segera seperti ventilasi bantuan atau ventilasi mekanik untuk mencegah henti napas dan kerusakan organ vital (Enrique et al., 2024 ;Summers et al., 2020).

Bagi mahasiswa keperawatan kemampuan mengenali perbedaan tanda klinis antara kedua kondisi ini sangat penting karena akan memengaruhi kecepatan pengambilan keputusan klinis serta prioritas intervensi dalam situasi kegawatdaruratan.

F. Pemeriksaan Penunjang

**Tabel 6.2: Perbedaan Tanda Klinis
Respiratory Distress dan Respiratory Failure**

Tabel 6.3 Perbedaan Tanda Klinis <i>Respiratory Distress</i> dan <i>Respiratory Failure</i>		
Parameter Klinis	Respiratory Distress	Respiratory Failure
Definisi	Kondisi ketika pasien mengalami peningkatan usaha napas untuk mempertahankan ventilasi dan oksigenasi	Kondisi ketika sistem respirasi tidak mampu mempertahankan ventilasi atau oksigenasi yang adekuat
Frekuensi napas	Takipnea (napas cepat)	Dapat sangat cepat atau menurun akibat kelelahan
Usaha napas	Peningkatan kerja napas, penggunaan otot bantu napas	Usaha napas menurun akibat kelelahan otot respirasi
Bunyi napas	Wheezing, crackles, atau stridor	Bunyi napas dapat menurun atau tidak terdengar
Saturasi oksigen	Menurun tetapi sering masih dapat dikompensasi	Sangat rendah meskipun sudah diberikan oksigen
Status mental	Gelisah, ansietas	Penurunan kesadaran, letargi, kebingungan
Gas darah arteri	Hipoksemia ringan hingga sedang	Hipoksemia berat ± hiperkapnia
Warna kulit	Pucat atau sedikit sianosis	Sianosis berat
Kemampuan berbicara	Masih dapat berbicara meskipun terputus-putus	Sulit atau tidak mampu berbicara
Prognosis klinis	Masih dapat dikompensasi tubuh	Mengancam kehidupan dan memerlukan intervensi segera
Prognosis klinis	Masih dapat dikompensasi tubuh	Mengancam kehidupan dan memerlukan intervensi segera

Sumber: (Lagina & Valley, 2025; Siela, 2018).

Pemeriksaan penunjang pada pasien dengan kegawatdaruratan pernapasan bertujuan memperkuat temuan klinis, menilai derajat keparahan, dan membantu identifikasi penyebab dasar. Pemeriksaan yang lazim digunakan meliputi pulse oximetry untuk memantau saturasi oksigen, analisis gas darah arteri untuk menilai oksigenasi, ventilasi, dan status asam-basa, serta radiologi toraks untuk melihat infiltrat, edema paru, atelektasis, atau pneumotoraks. Pada kondisi tertentu, CT scan toraks, elektrokardiografi, dan ultrasonografi bedside dapat membantu membedakan penyebab respirasi akut yang kompleks. Pemeriksaan laboratorium seperti hemoglobin, leukosit, laktat, dan parameter inflamasi juga sering diperlukan untuk menilai kondisi sistemik yang menyertai. Dalam pembelajaran keperawatan, hal penting yang perlu ditekankan adalah bahwa hasil pemeriksaan penunjang harus selalu diinterpretasikan bersama data klinis, bukan dipisahkan dari konteks kondisi pasien (Bilan et al., 2010).

G. Komplikasi

Apabila tidak dikenali dan ditangani secara cepat kegawatdaruratan pernapasan dapat berkembang menjadi komplikasi yang berat. Komplikasi tersebut meliputi gagal napas akut, asidosis respiratorik, hipoksia jaringan berkepanjangan, kebutuhan ventilasi mekanik invasif, syok, hingga kegagalan multiorgan. Pada pasien tertentu, terutama yang memiliki penyakit dasar berat atau infeksi sistemik, progresivitas gangguan pernapasan dapat berlangsung sangat cepat. Oleh karena itu, kemampuan perawat dalam mendeteksi dini tanda perburukan mempunyai kontribusi besar terhadap pencegahan komplikasi. Dalam konteks pendidikan, mahasiswa perlu memahami bahwa komplikasi bukan sekadar akibat akhir penyakit, tetapi juga indikator keterlambatan identifikasi, kurang adekuatnya pemantauan, atau tidak efektifnya respons terapeutik.

H. Penatalaksanaan Kegawatdaruratan Pernapasan

Penatalaksanaan kegawatdaruratan pernapasan berfokus pada stabilisasi fungsi vital dengan prinsip “*treat first what kills first*,” yang dalam praktik klinis sering diterapkan melalui pendekatan ABCDE. Prioritas utama adalah memastikan jalan napas tetap paten, menilai efektivitas pernapasan, memberikan oksigen sesuai kebutuhan, serta menyiapkan ventilasi bantu apabila pasien menunjukkan tanda kelelahan napas atau gagal napas. Pada kasus tertentu dapat diperlukan suction, nebulisasi bronkodilator, ventilasi noninvasif, intubasi endotrakeal, atau ventilasi mekanik invasif. Selain itu, terapi definitif terhadap penyebab dasar seperti antibiotik pada infeksi, diuretik pada edema paru, atau dekompresi pada pneumotoraks tensi harus dilakukan secara kolaboratif. Dalam pembelajaran keperawatan, mahasiswa perlu dibiasakan memahami bahwa keberhasilan penatalaksanaan sangat bergantung pada kecepatan penilaian awal, ketepatan prioritas, dan koordinasi antarprofesi (Lagina & Valley, 2025).

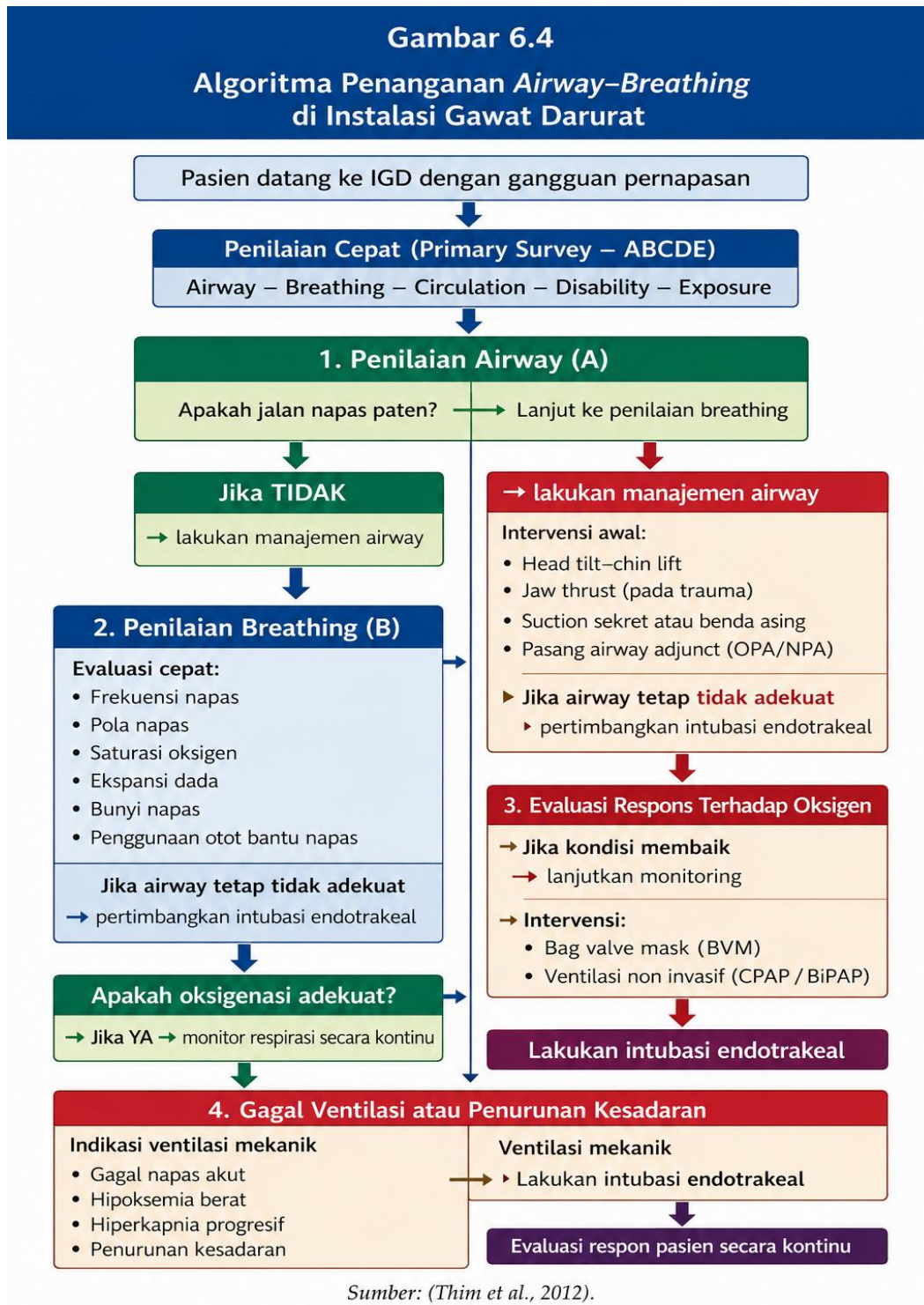
I. Pengkajian Keperawatan

Pengkajian keperawatan pada pasien dengan kegawatdaruratan pernapasan harus dilakukan secara cepat, sistematis, dan berulang. Pada tahap awal, perawat menilai patensi jalan napas, ada tidaknya sekret atau obstruksi, frekuensi dan pola napas, penggunaan otot bantu napas, saturasi oksigen, warna kulit, bunyi napas, serta tingkat kesadaran pasien. Data subjektif dapat berupa keluhan sesak, nyeri dada, sulit menarik napas, rasa tercekik, atau cepat lelah saat bernapas. Data objektif perlu diintegrasikan dengan hasil pemeriksaan penunjang, seperti SpO₂, gas darah, dan foto toraks. Lebih lanjut, pengkajian tidak boleh bersifat satu kali, melainkan harus menilai tren perubahan kondisi pasien dari waktu ke waktu.

Pendekatan ini penting karena perburukan respirasi sering terjadi progresif, dan perubahan kecil dapat menjadi sinyal awal kegagalan napas. Dalam praktik kegawatdaruratan, penanganan pasien dengan gangguan pernapasan harus dilakukan secara sistematis menggunakan pendekatan primary survey ABCDE (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure). Penilaian airway dan breathing menjadi prioritas utama karena kegagalan dalam mempertahankan jalan napas dan ventilasi dapat menyebabkan hipoksia jaringan yang cepat berkembang menjadi kegagalan organ dan kematian. Oleh karena itu, perawat di unit gawat darurat harus mampu melakukan pengkajian cepat terhadap patensi jalan napas, pola pernapasan, serta status oksigenasi pasien (Thim et al., 2012).

Setelah airway dipastikan paten langkah berikutnya adalah mengevaluasi kemampuan ventilasi dan oksigenasi pasien. Bila ditemukan tanda-tanda hipoksemia atau peningkatan kerja napas, terapi oksigen harus segera diberikan dengan perangkat yang sesuai dengan tingkat keparahan kondisi pasien. Apabila terapi oksigen tidak memberikan perbaikan yang adekuat, ventilasi bantuan seperti bag valve mask atau ventilasi noninvasif dapat dipertimbangkan sebelum dilakukan intubasi endotrakeal. Pendekatan bertahap ini membantu memastikan bahwa intervensi yang diberikan sesuai dengan kondisi fisiologis pasien serta meminimalkan komplikasi yang mungkin terjadi (Nejat, 2024; Rochweg et al., 2017).

Gambar 6.3: Algoritma penanganan Airway-Breathing di Instalasi Gawat Darurat



Pemantauan respirasi merupakan komponen penting dalam perawatan pasien kritis karena sistem respirasi berperan utama dalam mempertahankan keseimbangan oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh. Pada pasien dengan kegawatdaruratan pernapasan, perubahan parameter respirasi dapat terjadi secara

cepat dan mencerminkan perkembangan kondisi klinis pasien. Oleh karena itu, perawat harus melakukan pemantauan secara sistematis terhadap berbagai parameter respirasi, baik melalui observasi klinis maupun pemeriksaan penunjang (Cahill, 2016; Nakano et al., 2021).

Parameter seperti frekuensi napas saturasi oksigen, serta analisis gas darah arteri memberikan informasi penting mengenai status ventilasi dan oksigenasi pasien. Selain itu, observasi terhadap ekspansi dada, bunyi napas, penggunaan otot bantu pernapasan, serta perubahan status mental juga memiliki nilai klinis yang tinggi dalam mendeteksi tanda-tanda perburukan respirasi. Melalui pemantauan yang komprehensif dan berkesinambungan, perawat dapat mengenali perubahan kondisi pasien secara dini dan segera melakukan intervensi yang diperlukan untuk mencegah terjadinya gagal napas atau komplikasi yang lebih berat (Yao et al., 2016).

Tabel 6.4: Parameter Monitoring Respirasi pada Pasien Kritis

Parameter	Nilai Normal Dewasa	Makna Klinis	Implikasi Keperawatan
Frekuensi napas (Respiratory Rate)	12–20 kali/menit	Takipnea dapat menunjukkan hipoksia, asidosis metabolik, atau distress respirasi	Monitor frekuensi napas, secara berkala; laporkan perubahan signifikan
Saturasi oksigen (SpO ₂)	≥ 95%	Penurunan SpO ₂ menunjukkan hipoksemia	Berikan terapi oksigen sesuai indikasi; monitor respons terhadap terapi
Tekanan parsial oksigen arteri (PaO ₂)	80–100 mmHg	Nilai rendah menunjukkan gangguan oksigenasi	Evaluasi kebutuhan ventilasi bantuan atau respons ventilasi mekanik
Tekanan parsial karbon dioksida (PaCO ₂)	35–45 mmHg	Nilai tinggi menunjukkan hipoventilasi, laju napas menurun menunjukkan hiperkapnia	Evaluasi gas darah arteri dan respons ventilasi
pH darah arteri	7,35–7,45	Nilai rendah menunjukkan asidosis, nilai tinggi menunjukkan alkalosis	Pantau gas darah arteri secara berkelanjutan
Ekspansi dada	Simetris	Ekspansi dada asimetris dapat menandakan gangguan ventilasi	Monitor pergerakan dada dan auskultasi bunyi napas
Bunyi napas	Vesikuler normal	Bunyi napas melemah dapat menandakan obstruksi jalan napas atau gangguan ventilasi	Monitor pergerakan dada dan auskultasi bunyi napas; laporkan perubahan signifikan!
Penggunaan otot bantu napas	Minimal, jernih	Menunjukkan peningkatan WOB atau distress respirasi	Berikan terapi oksigen dan intervensi untuk mengurangi WOB.
Produksi sputum	Minimal, jernih	Sputum purulen dapat menunjukkan infeksi	Lakukan pengkajian sekresi dan hidrasi adekuat
Status mental	Sadar penuh	Perubahan kesadaran secara kontinu	Monitor tingkat kesadaran secara kontinu

Sumber: (Yao et al., 2016).

J. Diagnosis Keperawatan

Berdasarkan hasil pengkajian, perawat dapat merumuskan beberapa diagnosis keperawatan yang relevan sesuai respons pasien. Diagnosis yang sering muncul pada kegawatdaruratan pernapasan antara lain gangguan pertukaran gas, pola napas tidak efektif, bersihan jalan napas tidak efektif, intoleransi aktivitas, ansietas, dan risiko aspirasi, tergantung pada etiologi dan manifestasi klinis yang dominan. Penetapan diagnosis harus didasarkan pada data yang jelas, misalnya takipnea, penggunaan otot bantu napas, SpO₂ menurun, bunyi napas tambahan, sputum yang tidak efektif dikeluarkan, atau perubahan status mental. Dalam pendidikan keperawatan, penting ditekankan bahwa diagnosis bukan sekadar label, melainkan simpulan klinis yang menghubungkan data, penyebab, dan respons pasien secara logis.

K. Luaran Keperawatan

Setelah diagnosis ditetapkan perawat perlu menyusun luaran keperawatan yang terukur, realistis, dan berorientasi pada stabilisasi respirasi pasien. Luaran yang diharapkan dapat berupa jalan napas tetap paten, frekuensi napas membaik, pola napas lebih efektif, saturasi oksigen berada pada target yang ditentukan, bunyi napas membaik, pasien tampak lebih tenang, dan tanda hipoksia berkurang. Pada pasien yang lebih berat, luaran juga dapat mencakup perbaikan gas darah, penurunan kerja napas, dan tidak adanya tanda progresi menuju gagal napas. Dalam konteks pembelajaran, mahasiswa perlu memahami bahwa luaran harus individual, disesuaikan dengan penyebab dan derajat keparahan pasien, serta dapat dievaluasi secara objektif dalam praktik klinis.

Dalam praktik keperawatan gawat darurat, penetapan diagnosis keperawatan yang tepat menjadi dasar dalam menentukan luaran yang diharapkan serta intervensi yang harus dilakukan. Pada pasien dengan kegawatdaruratan pernapasan, diagnosis keperawatan umumnya berkaitan dengan gangguan ventilasi, gangguan pertukaran gas, serta ketidakmampuan pasien mempertahankan jalan napas yang adekuat. Oleh karena itu, perawat harus mampu melakukan pengkajian respirasi secara cepat dan sistematis agar dapat mengidentifikasi masalah klinis yang paling mendesak (Thim et al., 2012).

Luaran keperawatan pada kondisi ini berfokus pada perbaikan oksigenasi jaringan, stabilitas pola napas, serta pemeliharaan patensi jalan napas. Pencapaian luaran tersebut memerlukan intervensi keperawatan yang tepat, seperti pemberian terapi oksigen, pemantauan respirasi secara kontinu, manajemen jalan napas, serta kolaborasi dengan tim medis dalam penggunaan ventilasi bantuan atau ventilasi mekanik. Melalui pendekatan ini, proses keperawatan tidak hanya menjadi

kerangka kerja teoritis, tetapi juga panduan praktis dalam memberikan asuhan yang cepat, tepat, dan berorientasi pada keselamatan pasien (Emergency & Guideline, 2017).

L. Intervensi Keperawatan

Intervensi keperawatan pada kegawatdaruratan pernapasan berfokus pada pemeliharaan jalan napas, peningkatan oksigenasi, pemantauan ketat, dan pencegahan perburukan. Intervensi tersebut meliputi memposisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi, memantau frekuensi dan pola napas, memantau saturasi oksigen, memberikan terapi oksigen sesuai indikasi, melakukan suction bila diperlukan, membantu pemberian nebulisasi, serta mengobservasi respons pasien terhadap terapi. Perawat juga berperan penting dalam kolaborasi untuk ventilasi noninvasif, intubasi, atau tindakan definitif lain sesuai penyebab gangguan. Intervensi harus selalu berbasis data dan dievaluasi secara kontinu, sebab respons pasien respirasi dapat berubah cepat dalam waktu singkat (Emergency & Guideline, 2017).

Dalam praktik keperawatan gawat darurat, integrasi antara diagnosis keperawatan, luaran yang diharapkan, dan intervensi keperawatan sangat penting untuk memastikan bahwa asuhan yang diberikan bersifat sistematis dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Pendekatan NANDA–NOC–NIC membantu perawat menghubungkan respons pasien terhadap gangguan respirasi dengan tujuan klinis yang ingin dicapai serta tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Melalui pendekatan ini, mahasiswa keperawatan dapat memahami bahwa proses keperawatan bukan hanya serangkaian langkah administratif, tetapi merupakan kerangka berpikir klinis yang mendukung pengambilan keputusan secara rasional dan berbasis bukti.

Pada pasien dengan kegawatdaruratan pernapasan, diagnosis keperawatan yang paling sering muncul berkaitan dengan gangguan ventilasi, gangguan pertukaran gas, serta ketidakmampuan pasien mempertahankan jalan napas yang adekuat. Oleh karena itu, intervensi keperawatan difokuskan pada upaya mempertahankan patensi jalan napas, meningkatkan oksigenasi jaringan, serta memantau respons pasien terhadap terapi yang diberikan. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan penanganan kegawatdaruratan pernapasan sangat bergantung pada kemampuan perawat dalam melakukan observasi yang cermat, interpretasi data klinis yang tepat, serta pelaksanaan intervensi secara cepat dan terkoordinasi dengan tim kesehatan lainnya.

M. Implementasi dan Evaluasi Keperawatan

Implementasi merupakan tahap pelaksanaan seluruh intervensi yang telah direncanakan secara aman, tepat waktu, dan sesuai prioritas klinis pasien. Dalam praktik kegawatdaruratan, implementasi keperawatan harus disertai pemantauan ketat terhadap respons pasien, termasuk perubahan saturasi oksigen, kerja napas, bunyi napas, tingkat kesadaran, dan stabilitas hemodinamik. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah luaran keperawatan telah tercapai atau belum. Jika respons pasien belum adekuat, maka perawat perlu melakukan pengkajian ulang, mengidentifikasi hambatan, dan menyesuaikan rencana asuhan. Hal ini penting untuk ditekankan kepada mahasiswa agar mereka memahami bahwa proses keperawatan bersifat dinamis, sirkular, dan responsif terhadap perubahan kondisi klinis, bukan berjalan secara linier dan kaku.

N. Edukasi Keperawatan

Edukasi merupakan bagian penting dari asuhan keperawatan pada pasien dengan kegawatdaruratan pernapasan, baik kepada pasien maupun keluarga. Edukasi dapat mencakup penjelasan tentang kondisi pasien, alasan pemantauan ketat, tujuan pemberian oksigen atau terapi lain, serta tanda bahaya yang harus segera dilaporkan, seperti sesak yang memberat, penurunan kesadaran, bunyi napas abnormal yang meningkat, atau penurunan saturasi oksigen. Pada konteks pasien kritis, keterlibatan keluarga juga penting karena keluarga sering mengalami stres psikologis dan membutuhkan komunikasi yang jelas, empatik, dan terstruktur. Dengan edukasi yang baik, kerja sama pasien dan keluarga dapat meningkat, kecemasan berkurang, dan kesinambungan perawatan menjadi lebih baik. Dalam pendidikan keperawatan, aspek edukasi ini perlu ditampilkan lebih menonjol agar mahasiswa memahami bahwa komunikasi terapeutik adalah bagian integral dari keselamatan dan mutu pelayanan.

O. Dokumentasi Keperawatan

Dokumentasi keperawatan merupakan komponen esensial dalam asuhan pasien dengan kegawatdaruratan pernapasan. Seluruh hasil pengkajian, diagnosis, luaran, intervensi, implementasi, respons pasien, dan hasil evaluasi harus dicatat secara sistematis, akurat, dan tepat waktu. Pada pasien respirasi akut, dokumentasi sebaiknya menonjolkan data tren, seperti perubahan frekuensi napas, saturasi oksigen, pola napas, bunyi napas, tingkat kesadaran, dan respons terhadap terapi oksigen atau intervensi lainnya. Dokumentasi yang baik tidak hanya mendukung kontinuitas pelayanan dan komunikasi antar tenaga kesehatan, tetapi juga berfungsi sebagai alat klinis untuk menilai perjalanan kondisi pasien serta sebagai

dasar audit mutu dan perlindungan profesional. Bagi mahasiswa keperawatan, kemampuan mendokumentasikan data respirasi secara benar merupakan kompetensi penting yang harus dibangun sejak dini.

P. Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Contoh Kasus

Seorang laki-laki berusia 62 tahun datang ke Instalasi Gawat Darurat dengan keluhan sesak napas yang semakin berat sejak dua jam terakhir. Pasien memiliki riwayat penyakit paru obstruktif kronik (COPD) dan merokok selama lebih dari 30 tahun. Keluarga menyatakan bahwa pasien tampak semakin gelisah dan sulit berbicara karena sesak napas.

Perawat melakukan pengkajian awal menggunakan pendekatan primary survey (Airway–Breathing–Circulation) dan mendapatkan data sebagai berikut.

Hasil Pengkajian

- Frekuensi napas: 32 kali/menit
- Saturasi oksigen (SpO₂): 86% tanpa oksigen
- Tekanan darah: 100/65 mmHg
- Frekuensi nadi: 120 kali/menit
- Suhu tubuh: 37,8°C

Temuan klinis tambahan:

- Pasien tampak gelisah dan sulit berbicara
- Terlihat penggunaan otot bantu napas
- Terdapat retraksi interkosta
- Bunyi napas: wheezing bilateral
- Warna kulit tampak pucat dengan sianosis pada bibir

Pemeriksaan Penunjang

Analisis gas darah arteri (AGD):

- pH: 7,30
- PaO₂: 60 mmHg
- PaCO₂: 55 mmHg
- HCO₃⁻: 26 mEq/L

Dokter mencurigai pasien mengalami gagal napas akibat eksaserbasi akut COPD. Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menginterpretasikan kondisi respirasi pasien berdasarkan data yang tersedia.

Pertanyaan Diskusi

1. Identifikasi tanda dan gejala yang menunjukkan bahwa pasien mengalami respiratory distress.

2. Interpretasikan hasil analisis gas darah arteri (pH, PaO₂, PaCO₂, HCO₃⁻) pada kasus tersebut.
3. Berdasarkan data klinis yang tersedia, apakah pasien lebih mengarah pada respiratory distress atau respiratory failure? Jelaskan alasan Anda.
4. Jelaskan mekanisme patofisiologi yang menyebabkan gangguan pertukaran gas pada pasien dengan eksaserbasi COPD.
5. Identifikasi tindakan keperawatan awal yang harus dilakukan oleh perawat di IGD untuk menstabilkan kondisi respirasi pasien.
6. Intervensi keperawatan apa saja yang perlu diprioritaskan untuk mempertahankan oksigenasi dan ventilasi pasien?

Q. Simulasi / Skill Lab Penanganan Kegawatdaruratan Pernapasan

Mahasiswa melakukan simulasi di laboratorium keterampilan keperawatan gawat darurat untuk mempraktikkan keterampilan pengkajian dan penanganan awal pada pasien dengan gangguan pernapasan akut. Simulasi dirancang untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam melakukan pengkajian airway dan breathing, interpretasi tanda klinis respiratory distress, serta pengambilan keputusan keperawatan awal sesuai dengan prinsip penanganan kegawatdaruratan.

Dalam simulasi ini mahasiswa diminta melakukan beberapa tindakan, antara lain:

1. Melakukan hand hygiene dan menyiapkan alat penanganan respirasi
2. Melakukan pengkajian airway dan breathing menggunakan pendekatan ABCDE
3. Menilai frekuensi napas, pola napas, penggunaan otot bantu napas, dan ekspansi dada
4. Mengukur saturasi oksigen menggunakan pulse oximetry
5. Melakukan auskultasi bunyi napas untuk mengidentifikasi wheezing, crackles, atau stridor
6. Mengidentifikasi tanda respiratory distress atau respiratory failure
7. Memberikan terapi oksigen sesuai indikasi (nasal cannula, simple mask, atau non-rebreathing mask)
8. Memposisikan pasien pada posisi semi-Fowler atau Fowler untuk meningkatkan ventilasi
9. Menyiapkan alat airway management seperti suction dan bag valve mask (BVM)
10. Melaporkan kondisi pasien secara sistematis kepada tim kesehatan menggunakan SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation)

Simulasi menekankan pada urutan tindakan yang sistematis, ketepatan pengkajian respirasi, komunikasi klinis yang efektif, serta penerapan prinsip keselamatan pasien dalam situasi kegawatdaruratan.

Fokus Pembelajaran

- Urutan pengkajian airway dan breathing secara sistematis
- Identifikasi tanda dan gejala respiratory distress
- Interpretasi parameter respirasi dan saturasi oksigen
- Penentuan prioritas intervensi keperawatan pada kegawatdaruratan pernapasan
- Komunikasi klinis dan pelaporan kondisi pasien kepada tim Kesehatan
- Penerapan prinsip keselamatan pasien dalam penanganan kegawatdaruratan

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode Penilaian
Knows / Knows How	Self-check konsep + analisis mini-case interpretasi respiratory distress dan gas darah arteri
Shows How	OSCE Pengkajian Airway–Breathing dan Pemberian Terapi Oksigen pada Respiratory Emergency

OSCE Ringkas + Critical Items

Pada tahap ini mahasiswa diuji melalui Objective Structured Clinical Examination (OSCE) untuk mendemonstrasikan keterampilan dalam pengkajian dan penanganan awal kegawatdaruratan pernapasan. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan pengkajian airway dan breathing secara sistematis, mengidentifikasi tanda respiratory distress atau gagal napas, serta melakukan intervensi keperawatan awal untuk mempertahankan oksigenasi dan ventilasi pasien.

Simulasi OSCE biasanya menggunakan manikin atau standardized patient dengan skenario pasien yang mengalami sesak napas akut di ruang gawat darurat. Mahasiswa diminta melakukan pengkajian cepat menggunakan pendekatan primary survey (Airway–Breathing–Circulation) serta menentukan tindakan keperawatan prioritas berdasarkan kondisi klinis pasien.

Critical Items (WAJIB LULUS)

- Melakukan hand hygiene dan menerapkan prinsip pencegahan infeksi
- Melakukan identifikasi pasien serta menjaga privasi pasien
- Melakukan pengkajian airway dan breathing secara sistematis (frekuensi napas, pola napas, penggunaan otot bantu napas, ekspansi dada)

- Mengukur saturasi oksigen menggunakan pulse oximetry
- Mengidentifikasi tanda respiratory distress atau respiratory failure
- Memberikan terapi oksigen sesuai indikasi klinis
- Memposisikan pasien pada posisi semi-Fowler atau Fowler untuk meningkatkan ventilasi
- Melakukan eskalasi atau pelaporan kepada tim kesehatan apabila ditemukan tanda hipoksia atau gagal napas

Cuplikan Rubrik Penilaian

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan pasien	Aman, konsisten, sesuai prosedur	Ada kesalahan kecil	Risiko kecil muncul	Tidak aman
Asesmen & keputusan klinis	Pengkajian airway–breathing sistematis dan interpretasi tepat	Pengkajian cukup tepat	Masih ragu dalam interpretasi	Interpretasi keliru
Keterampilan klinis	Teknik pemeriksaan respirasi dan pemberian oksigen tepat	Teknik cukup baik	Teknik kurang tepat	Tidak mampu melakukan tindakan
Komunikasi klinis	Jelas, sistematis, empatik	Baik	Kurang jelas	Tidak efektif

Catatan untuk Penulis

- Nilai tinggi pada aspek lain tidak dapat menutupi kegagalan pada aspek keselamatan pasien.
- Mahasiswa dinyatakan tidak lulus apabila tidak memenuhi critical items keselamatan, misalnya tidak melakukan pengkajian airway atau tidak memberikan oksigen pada pasien dengan hipoksia.
- OSCE dirancang untuk memastikan mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan teoritis kegawatdaruratan pernapasan ke dalam praktik klinis secara aman, sistematis, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

R. Template Soal Osce Keperawatan

No	Komponen	Isi
1	Nomor station	 (Dikosongkan)
2	Judul station	Penanganan Awal Kegawatdaruratan Pernapasan dan Interpretasi Status Respirasi
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian respirasi secara sistematis, mengidentifikasi tanda kegawatdaruratan pernapasan, menginterpretasikan data klinis respirasi, menegakkan diagnosis keperawatan, serta merencanakan tindakan keperawatan awal pada pasien dengan gangguan pernapasan akut.
5	Kompetensi	Komunikasi terapeutik dan edukasi pasien Pengkajian airway dan breathing Interpretasi data klinis respirasi Diagnosis dan perencanaan keperawatan Implementasi tindakan keperawatan awal Perilaku profesional
6	Kategori	Sistem respirasi Kegawatdaruratan pernapasan Gangguan pertukaran gas Keselamatan pasien Keperawatan gawat darurat / kritis
7	Instruksi untuk Peserta Ujian	SKENARIO KLINIK Seorang laki-laki berusia 60 tahun datang ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan keluhan sesak napas yang semakin berat sejak beberapa jam terakhir. Pasien tampak gelisah dan kesulitan berbicara karena napas terasa pendek. Hasil pengkajian awal menunjukkan: Frekuensi napas: 32 x/menit Saturasi oksigen (SpO ₂): 86% tanpa oksigen Tekanan darah: 100/65 mmHg

		Frekuensi nadi: 118 x/menit Suhu tubuh: 37,8°C Temuan klinis tambahan: Pasien tampak gelisah Terdapat penggunaan otot bantu napas Terlihat retraksi intercostal Bunyi napas: wheezing bilateral Warna bibir tampak sianosis ringan TUGAS Lakukan pengkajian fokus respirasi berdasarkan skenario tersebut pada klien standar (KS). Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawab berdasarkan data pengkajian yang ditemukan. Tuliskan perencanaan intervensi keperawatan awal untuk mengatasi gangguan respirasi pasien. Jelaskan kepada pasien atau keluarga mengenai kondisi pasien, tujuan pemberian oksigen, serta pentingnya pemantauan respirasi secara kontinu.
8	Instruksi untuk Penguji	SKENARIO KLINIK (sama dengan yang diberikan kepada peserta) INSTRUKSI PENGUJI Penguji menilai kemampuan peserta dalam: Menentukan pengkajian respirasi tambahan, seperti: kedalaman dan pola napas penggunaan otot bantu napas ekspansi dada bunyi napas saturasi oksigen tingkat kesadaran pasien Menentukan diagnosis keperawatan yang tepat, misalnya: Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi–perfusi ditandai dengan takipnea, hipoksemia, penggunaan otot bantu napas, dan sianosis. atau

		Pola napas tidak efektif berhubungan dengan peningkatan kerja napas ditandai dengan takipnea dan penggunaan otot bantu napas. Menentukan intervensi keperawatan yang sesuai, seperti: - memonitor frekuensi dan pola napas - memonitor saturasi oksigen - memberikan terapi oksigen sesuai indikasi - memposisikan pasien semi-Fowler - mempersiapkan alat airway management - kolaborasi terapi bronkodilator atau ventilasi bantuan Menilai komunikasi klinis peserta, termasuk kemampuan menjelaskan kondisi pasien kepada keluarga. Menilai perilaku profesional, termasuk keselamatan pasien dan komunikasi terapeutik. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi atau bertanya kepada peserta selain yang telah ditentukan.
9	Instruksi untuk Klien Standar (KS)	Hal-hal yang perlu dicantumkan: - Identitas pasien - Laki-laki usia 60 tahun - Dirawat di IGD - Keluhan utama "Saya merasa sangat sesak napas." - Riwayat penyakit sekarang - Sesak napas muncul sejak beberapa jam terakhir dan semakin berat. - Riwayat penyakit keluarga - Tidak ada riwayat penyakit paru berat dalam keluarga. - Perilaku pasien - Tampak gelisah - Bernapas cepat dan dangkal - Sulit berbicara panjang - Respon jika ditanya tentang sesak "Saya merasa napas saya sangat pendek." - Respon jika ditanya tentang batuk

		"Saya batuk sejak beberapa hari yang lalu." Posisi pasien KS berbaring di tempat tidur pasien dan tampak sesak napas
10	Setting Station	Ruang IGD / ruang simulasi kegawatdaruratan Peralatan ruang: Tempat tidur pasien Manekin pasien dewasa Monitor tanda vital Kursi klien standar Meja penguji Kursi penguji Pintu masuk Troli alat Wastafel / handrub Tempat sampah Kursi laboran
11	Peralatan yang Dibutuhkan	Peralatan: Handrub / hand sanitizer Sarung tangan bersih Stetoskop Tensimeter Pulse oximeter Masker oksigen (nasal cannula / simple mask) Monitor pasien (simulasi) Lembar hasil monitoring respirasi Lembar jawaban peserta Pulpen
12	Laboran tersedia	Peran laboran: menyiapkan alat sebelum ujian merapikan alat setelah digunakan peserta memastikan station siap untuk peserta berikutnya
13	Penulis	
14	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP

		PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. Jakarta: DPP PPNI.
--	--	---

SOP Pengkajian dan Penanganan Awal Kegawatdaruratan Pernapasan dalam Praktik Keperawatan Gawat Darurat

No	Kegiatan / Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra Interaksi				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan pasien				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan:				
a	Sarung tangan bersih				
b	Handrub / sabun cuci tangan				
c	Stetoskop				
d	Pulse oximeter				
e	Tensimeter / monitor tekanan darah				
f	Alat terapi oksigen (nasal cannula / simple mask / non-rebreathing mask)				
g	Suction set / alat suction				
h	Bag valve mask (BVM)				
i	Lembar monitoring respirasi				
j	Pulpen / alat dokumentasi				
k	Troli alat bila diperlukan				

3	Melakukan kebersihan tangan (hand hygiene)				
B	Tahap Orientasi				
4	Menyampaikan salam terapeutik				
5	Menyampaikan nama dan peran perawat				
6	Melakukan identifikasi pasien minimal dua identitas (nama dan tanggal lahir / nomor rekam medis)				
7	Menjelaskan tujuan pengkajian dan tindakan respirasi				
8	Menyampaikan kontrak waktu tindakan				
9	Memberi kesempatan pasien atau keluarga untuk bertanya				
10	Menjaga privasi dan kenyamanan pasien				
C	Tahap Kerja (Sistematis)				
11	Melakukan hand hygiene sebelum tindakan				
12	Menggunakan sarung tangan bila ada risiko kontak dengan cairan tubuh				
13	Mengkaji patensi jalan napas (airway)				
14	Mengidentifikasi adanya sekret, obstruksi, atau suara				

	napas abnormal (stridor)				
15	Mengkaji frekuensi napas				
16	Mengkaji pola dan kedalaman napas				
17	Mengobservasi penggunaan otot bantu napas				
18	Mengobservasi ekspansi dada				
19	Mengukur saturasi oksigen (SpO ₂) menggunakan pulse oximeter				
20	Melakukan auskultasi bunyi napas				
21	Menilai warna kulit dan adanya sianosis				
22	Mengkaji tingkat kesadaran pasien				
23	Mengidentifikasi tanda respiratory distress				
24	Mengidentifikasi tanda respiratory failure				
25	Memberikan terapi oksigen sesuai indikasi				
26	Memposisikan pasien pada posisi semi-Fowler atau Fowler				
27	Menyiapkan suction bila terdapat sekret berlebih				
28	Menyiapkan ventilasi bantuan (bag valve mask) bila diperlukan				
29	Menghubungkan temuan klinis dengan				

	kemungkinan gangguan respirasi				
30	Melaporkan temuan abnormal kepada tim kesehatan secara sistematis				
31	Merapikan pasien dan alat-alat yang digunakan				
32	Melepaskan sarung tangan bila digunakan				
33	Melakukan kebersihan tangan setelah tindakan				
D	Tahap Terminasi				
34	Menyimpulkan hasil pengkajian respirasi				
35	Mengevaluasi respons pasien terhadap intervensi respirasi				
36	Memberikan penjelasan singkat kepada pasien atau keluarga mengenai kondisi pasien				
37	Membuat kontrak waktu pemantauan respirasi berikutnya				
38	Mengakhiri tindakan dengan baik				
E	Tahap Dokumentasi				
39	Mendokumentasikan hari, tanggal, waktu tindakan, hasil pengkajian respirasi (RR, SpO ₂ , pola napas, bunyi napas), intervensi yang diberikan, serta respons pasien				

F	Penampilan Profesional				
40	Melakukan tindakan dengan aman, teliti, cermat, responsif, serta menjaga keselamatan pasien				

Form Penilaian Osce Keperawatan

STATION: PENGKAJIAN DAN PENANGANAN AWAL KEGAWATDARURATAN PERNAPASAN DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN GAWAT DARURAT

1. Form Penilaian

No	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S × B)
1	Pengkajian Keperawatan	Melakukan pengkajian respirasi meliputi patensi jalan napas, frekuensi napas, pola napas, penggunaan otot bantu napas, ekspansi dada, bunyi napas, dan saturasi oksigen					2	
2	Interpretasi data klinis respirasi	Menginterpretasikan data respirasi seperti frekuensi napas, SpO ₂ , penggunaan otot bantu napas, serta tanda respiratory distress atau respiratory failure					3	
3	Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Menetapkan diagnosis keperawatan yang tepat (misalnya gangguan pertukaran gas atau pola napas tidak efektif)					2	

		serta menyusun rencana intervensi keperawatan						
4	Implementasi keperawatan	Melakukan tindakan keperawatan awal seperti pemberian terapi oksigen, memposisikan pasien semi-Fowler, monitoring respirasi, serta melaporkan kondisi pasien secara sistematis					2	
5	Perilaku profesional	Menunjukkan komunikasi terapeutik, menjaga privasi pasien, melakukan tindakan secara sistematis, aman, teliti, dan responsif					1	
	Jumlah							10

Keterangan Skor

0 = tidak dilakukan

1 = dilakukan tetapi tidak tepat atau tidak lengkap

2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap

3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

Rubrik Penilaian Osce Keperawatan

STATION: PENGKAJIAN DAN PENANGANAN AWAL KEGAWATDARURATAN PERNAPASAN DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN GAWAT DARURAT

1. Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S × B)
Pengkajian Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian respirasi pada pasien dengan gangguan pernapasan akut.					2	

Pengkajian meliputi penilaian patensi jalan napas (airway), frekuensi dan pola napas, penggunaan otot bantu napas, ekspansi dada, bunyi napas, saturasi oksigen (SpO ₂), warna kulit, serta tingkat kesadaran pasien. Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara sistematis dan mengidentifikasi tanda respiratory distress secara tepat.						
Interpretasi Data Klinis Respirasi Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menginterpretasikan parameter respirasi seperti frekuensi napas, SpO ₂ , penggunaan otot bantu napas, serta temuan auskultasi paru. Peserta diharapkan mampu menghubungkan data tersebut dengan kondisi klinis pasien, seperti respiratory distress, gangguan pertukaran gas, atau risiko gagal napas. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					3	
Diagnosis dan Perencanaan Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menegaskan diagnosis keperawatan yang tepat berdasarkan hasil pengkajian respirasi, misalnya gangguan pertukaran gas atau pola napas tidak efektif. Peserta juga diharapkan mampu menyusun rencana intervensi keperawatan yang relevan untuk mempertahankan patensi jalan					2	

napas, meningkatkan oksigenasi jaringan, serta mencegah perburukan kondisi pasien. Diagnosis dan perencanaan harus disusun secara jelas dan sistematis.						
Implementasi Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam melaksanakan tindakan keperawatan awal pada pasien dengan kegawatdaruratan pernapasan. Tindakan meliputi pemberian terapi oksigen, pemantauan frekuensi dan pola napas, observasi penggunaan otot bantu napas, pemantauan saturasi oksigen, memposisikan pasien untuk meningkatkan ventilasi, serta melaporkan kondisi pasien secara sistematis kepada tim kesehatan. Tindakan harus dilakukan secara aman, tepat, dan sistematis sesuai kondisi klinis pasien.					2	
Perilaku Profesional Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan profesionalisme sesuai prinsip etik dan keselamatan pasien, di antaranya memperkenalkan diri, melakukan identifikasi pasien, berkomunikasi terapeutik dengan pasien atau keluarga, menjaga privasi pasien, serta melakukan tindakan secara hati-hati, teliti, dan responsif terhadap kondisi pasien.					1	

2. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian respirasi atau pengkajian yang dilakukan tidak relevan dengan kondisi kegawatdaruratan pernapasan pasien.	Melakukan pengkajian sangat terbatas, hanya menilai sebagian kecil parameter seperti frekuensi napas atau saturasi oksigen, tidak sistematis, serta tidak mampu mengidentifikasi tanda respiratory distress secara tepat.	Melakukan pengkajian respirasi cukup baik dan cukup sistematis, mampu menilai sebagian besar parameter seperti patensi jalan napas, frekuensi napas, pola napas, penggunaan otot bantu napas, ekspansi dada, bunyi napas, dan saturasi oksigen, namun masih ada data penting yang terlewat atau interpretasi belum lengkap.	Melakukan pengkajian respirasi secara lengkap, sistematis, dan relevan meliputi patensi jalan napas, frekuensi dan pola napas, penggunaan otot bantu napas, ekspansi dada, bunyi napas, saturasi oksigen, warna kulit, serta tingkat kesadaran pasien, kemudian mampu menyampaikan hasil pengkajian secara tepat.
2. Interpretasi Data Klinis Respirasi	Tidak mampu menginterpretasikan parameter respirasi atau interpretasi yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi klinis pasien.	Melakukan interpretasi sangat terbatas atau keliru, tidak mampu menghubungkan parameter respirasi seperti frekuensi napas, SpO ₂ , atau penggunaan otot bantu napas dengan kondisi klinis pasien.	Melakukan interpretasi parameter respirasi cukup baik, mampu menghubungkan sebagian data seperti saturasi oksigen atau pola napas dengan kondisi pasien, namun analisis masih kurang lengkap atau belum sistematis.	Melakukan interpretasi parameter respirasi secara tepat, mampu menghubungkan frekuensi napas, SpO ₂ , penggunaan otot bantu napas, bunyi napas, dan tingkat kesadaran dengan kemungkinan kondisi seperti respiratory distress, gangguan pertukaran gas, atau gagal napas.

3. Diagnosis dan Perencanaan Keperawatan	Tidak mampu menegakkan diagnosis keperawatan atau diagnosis tidak sesuai dengan data klinis. Tidak mampu menyusun rencana keperawatan.	Menetapkan diagnosis keperawatan tetapi tidak tepat sebagai prioritas atau tidak sesuai dengan data pengkajian. Rencana keperawatan sangat terbatas dan tidak relevan dengan kondisi respirasi pasien.	Menetapkan diagnosis keperawatan yang cukup tepat sesuai masalah utama, seperti gangguan pertukaran gas atau pola napas tidak efektif, serta menyusun rencana keperawatan yang cukup sesuai namun masih kurang lengkap atau kurang spesifik.	Menetapkan diagnosis keperawatan prioritas secara tepat berdasarkan data pengkajian, serta menyusun rencana keperawatan yang lengkap, sistematis, relevan, dan sesuai untuk mempertahankan patensi jalan napas, meningkatkan oksigenasi jaringan, serta mencegah gagal napas.
4. Implementasi Keperawatan	Tidak melakukan tindakan keperawatan atau tindakan yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan berisiko bagi keselamatan pasien.	Melakukan tindakan keperawatan secara terbatas, banyak langkah penting yang tidak dilakukan, pengkajian respirasi tidak sistematis, dan pelaporan kondisi pasien tidak jelas.	Melakukan tindakan keperawatan dengan cukup baik, sebagian besar langkah penanganan kegawatdaruratan pernapasan telah dilakukan, seperti monitoring respirasi atau pemberian oksigen, namun masih terdapat kekurangan dalam urutan tindakan atau pelaporan kondisi pasien.	Melakukan tindakan keperawatan secara tepat, aman, dan sistematis, meliputi pemantauan respirasi, pemberian terapi oksigen sesuai indikasi, memposisikan pasien untuk meningkatkan ventilasi, serta melaporkan kondisi pasien secara jelas dan sistematis kepada tim kesehatan.

5. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional, tidak memperkenalkan diri, tidak melakukan identifikasi pasien, tidak menjaga privasi, serta tidak memperhatikan keamanan dan kenyamanan pasien.	Menunjukkan sebagian kecil perilaku profesional, tetapi masih kurang dalam komunikasi terapeutik, identifikasi pasien, privasi, atau keselamatan pasien.	Menunjukkan perilaku profesional yang cukup baik, komunikasi terapeutik cukup jelas, memperhatikan privasi, kenyamanan, dan keamanan pasien, namun masih terdapat kekurangan kecil dalam sikap atau sistematika tindakan.	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten, meliputi komunikasi terapeutik yang baik, memperkenalkan diri, melakukan identifikasi pasien dengan benar, menjaga privasi, memperhatikan keamanan dan kenyamanan pasien, serta bersikap teliti, responsif, dan etis selama tindakan.
--------------------------------	--	--	---	--

3. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

4. Global Performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = ----- x 100 =
30

(Kota),.....

Penguji :

S. DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

1. Observasi langsung terhadap mahasiswa saat melakukan pengkajian dan penanganan awal kegawatdaruratan pernapasan pada pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD), ruang perawatan intensif (ICU), atau ruang perawatan dengan pasien berisiko gangguan respirasi.
2. Penilaian dilakukan menggunakan checklist keterampilan pengkajian respirasi yang mencakup penilaian patensi jalan napas, frekuensi napas, pola napas, penggunaan otot bantu napas, ekspansi dada, bunyi napas, saturasi oksigen, warna kulit, serta tingkat kesadaran pasien.
3. Mahasiswa juga dinilai dalam kemampuan menginterpretasikan kondisi respirasi pasien, seperti mengenali tanda respiratory distress, gangguan pertukaran gas, atau risiko gagal napas, serta menentukan tindakan keperawatan awal yang tepat, misalnya pemberian terapi oksigen, pemantauan respirasi, atau eskalasi kepada tim kesehatan.
4. Dosen klinik atau preceptor memberikan umpan balik singkat dan konstruktif setelah tindakan dilakukan untuk memperkuat kemampuan clinical reasoning mahasiswa dalam mengenali perubahan kondisi respirasi pasien dan menentukan prioritas intervensi keperawatan.

Keputusan Hasil Penilaian

1. **Kompeten** → mahasiswa mampu melakukan pengkajian respirasi dan interpretasi kondisi klinis secara tepat, sistematis, serta mampu menentukan intervensi keperawatan awal secara benar.

2. **Perlu supervise** → mahasiswa mampu melakukan sebagian langkah pengkajian respirasi dan tindakan awal tetapi masih memerlukan bimbingan dalam interpretasi data klinis atau penentuan prioritas intervensi.
3. **Remedial** → mahasiswa belum mampu melakukan pengkajian respirasi secara sistematis atau belum mampu menginterpretasikan kondisi respirasi pasien dengan benar.

Catatan untuk Penulis

1. Pembelajaran dirancang secara bertahap dari simulasi di skill lab menuju praktik nyata di lahan klinik, sehingga mahasiswa memiliki kesiapan sebelum melakukan tindakan pada pasien dengan kegawatdaruratan pernapasan.
2. DOPS menjadi bukti performa klinis nyata (real clinical performance) mahasiswa dalam melakukan pengkajian respirasi dan penanganan awal pasien dengan gangguan pernapasan akut.
3. Penilaian ini menekankan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data fisiologis respirasi (frekuensi napas, saturasi oksigen, bunyi napas) dengan tanda klinis pasien (sesak napas, penggunaan otot bantu napas, perubahan kesadaran) untuk mendukung pengambilan keputusan keperawatan yang tepat dalam situasi kegawatdaruratan.

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Pengkajian dan Penanganan Awal Kegawatdaruratan Pernapasan dalam Praktik Keperawatan Gawat Darurat

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Kegawatdaruratan Pernapasan
Metode penilaian	DOPS merupakan metode penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural mahasiswa saat melakukan tindakan klinis nyata di lahan praktik. Penilaian dilakukan oleh pembimbing klinik menggunakan checklist terstruktur dan diikuti dengan umpan balik segera setelah tindakan dilakukan.	Pembimbing klinik mengamati secara langsung mahasiswa saat melakukan pengkajian respirasi dan penanganan awal pasien dengan sesak napas di ruang IGD atau ICU.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Kegawatdaruratan Pernapasan
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan pengkajian respirasi secara sistematis, menginterpretasikan kondisi klinis pasien, melakukan komunikasi terapeutik, serta menunjukkan profesionalisme selama tindakan keperawatan.	Mahasiswa dinilai tidak hanya dari pemahaman teorinya mengenai sistem respirasi, tetapi juga dari kemampuannya menilai frekuensi napas, pola napas, penggunaan otot bantu napas, bunyi napas, saturasi oksigen, serta menjelaskan kondisi pasien kepada keluarga.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan relevan dengan capaian pembelajaran mata kuliah keperawatan gawat darurat.	Seorang pasien laki-laki usia 58 tahun datang ke IGD dengan keluhan sesak napas berat. Pasien tampak gelisah dengan frekuensi napas 34 x/menit, SpO ₂ 85%, penggunaan otot bantu napas, serta bunyi napas wheezing bilateral.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan tindakan klinis secara utuh mulai dari interaksi awal dengan pasien hingga interpretasi data dan penyampaian rencana tindakan keperawatan.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan pengkajian airway dan breathing, menilai frekuensi dan pola napas, mengukur saturasi oksigen, melakukan auskultasi paru, memberikan terapi oksigen sesuai indikasi, serta melaporkan kondisi pasien kepada pembimbing atau tim kesehatan.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi pengkajian klinis, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinis, komunikasi terapeutik, profesionalisme, serta organisasi tindakan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu melakukan pengkajian respirasi secara sistematis, mengidentifikasi tanda respiratory distress, serta menjelaskan kondisi pasien

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Kegawatdaruratan Pernapasan
		dengan bahasa yang jelas dan tepat.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa klinik mahasiswa secara langsung menggunakan format DOPS yang terstruktur.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menghubungkan data klinis seperti frekuensi napas, SpO ₂ , bunyi napas, dan penggunaan otot bantu napas dengan kemungkinan gangguan respirasi seperti respiratory distress atau gagal napas.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat singkat, spesifik, dan berorientasi pada peningkatan performa mahasiswa.	Pembimbing dapat memberikan umpan balik bahwa mahasiswa sudah baik dalam melakukan pengkajian frekuensi napas dan saturasi oksigen, tetapi masih perlu meningkatkan kemampuan interpretasi bunyi napas dan prioritas intervensi respirasi.
Keputusan penilaian	Hasil DOPS digunakan untuk menentukan tingkat kompetensi mahasiswa dalam praktik klinik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan pengkajian respirasi secara runtut, aman, serta mampu menginterpretasikan kondisi klinis pasien dengan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila masih memerlukan bimbingan dalam interpretasi data respirasi. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila belum mampu melakukan pengkajian atau penanganan awal

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Kegawatdaruratan Pernapasan
		kegawatdaruratan pernapasan dengan benar.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does dalam Piramida Miller.	Pada kasus kegawatdaruratan pernapasan, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori tentang gangguan respirasi, tetapi juga mampu melakukan pengkajian dan penanganan awal secara langsung, aman, dan profesional pada pasien di lahan praktik.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel Portofolio pada Pengkajian dan Penanganan Kegawatdaruratan Pernapasan dalam Praktik Keperawatan Gawat Darurat

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Kegawatdaruratan Pernapasan
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam pendekatan Outcome-Based Education (OBE), portofolio	Pada kegawatdaruratan pernapasan, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian respirasi secara sistematis, mengidentifikasi tanda respiratory distress, memberikan terapi oksigen sesuai indikasi,

	digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	menjaga keselamatan pasien, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik dari pembimbing klinik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, serta tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik klinik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah melakukan pengkajian respirasi pada pasien dengan sesak napas, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kemampuannya dalam menginterpretasikan kondisi respirasi dan menentukan intervensi keperawatan berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau Clinical Instructor (CI).
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium serta bukti performa nyata di lahan praktik klinik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan pengkajian airway-breathing dan pemberian terapi oksigen pada pasien dengan respiratory distress, sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung ketika mahasiswa melakukan pengkajian respirasi dan penanganan awal pasien sesak napas di ruang IGD atau ICU.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, meliputi data penting, masalah keperawatan, intervensi utama, serta hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus pasien dengan gangguan pernapasan akut, misalnya pasien dengan pneumonia berat yang menunjukkan takipnea, saturasi oksigen menurun, dan penggunaan otot bantu napas, kemudian mencatat diagnosis keperawatan, intervensi

		pemberian oksigen, serta evaluasi respons pasien.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan merencanakan langkah pencegahan dalam asuhan keperawatan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya memantau saturasi oksigen secara berkala, mengenali tanda respiratory distress secara dini, memberikan terapi oksigen dengan tepat, serta segera melaporkan kondisi pasien bila terjadi penurunan oksigenasi atau tanda gagal napas.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan oleh mahasiswa.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam melakukan pengkajian frekuensi napas dan saturasi oksigen serta komunikasi dengan pasien, namun masih perlu meningkatkan kemampuan interpretasi bunyi napas dan prioritas intervensi pada kegawatdaruratan pernapasan.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, melainkan kumpulan bukti belajar yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu pengalaman menangani pasien sesak napas, tetapi dari beberapa pengalaman klinik yang menunjukkan bahwa ia mampu melakukan pengkajian respirasi dan penanganan awal kegawatdaruratan pernapasan secara konsisten dan aman.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa klinik pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, serta umpan balik pembimbing, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan pengkajian respirasi, mengidentifikasi tanda

		respiratory distress, serta melakukan intervensi keperawatan awal secara tepat.
Makna dalam OBE	Dalam pendekatan OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi tampak dalam performa klinik yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada kegawatdaruratan pernapasan, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami konsep gangguan respirasi, tetapi juga mampu menerapkannya secara langsung dan profesional dalam praktik keperawatan gawat darurat.

Tabel Case Report pada Pengkajian dan Penanganan Kegawatdaruratan Pernapasan dalam Praktik Keperawatan Gawat Darurat

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Kegawatdaruratan Pernapasan
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis mengenai satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam pendekatan Outcome-Based Education (OBE), case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus klinik secara ilmiah dan sistematis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang pasien laki-laki usia 58 tahun yang datang ke IGD dengan sesak napas berat. Pasien menunjukkan takipnea, saturasi oksigen menurun, penggunaan otot bantu napas, dan tampak gelisah sehingga dicurigai mengalami respiratory distress.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian klinis, analisis masalah keperawatan, rencana tindakan, implementasi intervensi, serta evaluasi hasil asuhan secara komprehensif.	Mahasiswa tidak hanya mencatat data respirasi pasien, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas seperti gangguan pertukaran gas atau pola napas tidak efektif, intervensi pemberian oksigen yang dilakukan, serta perkembangan kondisi pasien setelah tindakan keperawatan diberikan.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, serta	Pada kasus kegawatdaruratan pernapasan, mahasiswa menuliskan data frekuensi napas, saturasi oksigen, bunyi napas, penggunaan otot bantu napas, diagnosis keperawatan seperti gangguan pertukaran gas, intervensi terapi oksigen dan pemantauan respirasi,

	refleksi pembelajaran dari kasus.	serta evaluasi perbaikan oksigenasi pasien.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian klinis, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinis, ketepatan intervensi keperawatan, serta kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan data klinis seperti frekuensi napas, SpO ₂ , bunyi napas, dan penggunaan otot bantu napas dengan kondisi respirasi pasien serta menentukan intervensi keperawatan yang tepat.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi klinis, serta kebiasaan merefleksikan praktik keperawatan secara ilmiah dan sistematis.	Dari kasus kegawatdaruratan pernapasan, mahasiswa belajar bahwa pengkajian airway dan breathing, pemantauan saturasi oksigen, serta interpretasi tanda respiratory distress merupakan bagian penting dalam penanganan pasien dengan gangguan respirasi akut.
Makna dalam OBE	Dalam pendekatan OBE, case report menjadi bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori keperawatan dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep fisiologi respirasi dan gangguan pertukaran gas, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan proses pengkajian, interpretasi kondisi respirasi, serta tindakan keperawatan secara utuh dalam praktik klinik kegawatdaruratan.

Tabel Refleksi Patient Safety pada Pengkajian dan Penanganan Kegawatdaruratan Pernapasan dalam Praktik Keperawatan Gawat Darurat

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Kegawatdaruratan Pernapasan
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah klinis, serta merencanakan tindakan pencegahan yang tepat dalam praktik keperawatan.	Pada kasus pasien dengan gangguan pernapasan akut, mahasiswa merefleksikan bahwa hipoksemia yang tidak dikenali secara dini dapat menyebabkan penurunan kesadaran, gangguan perfusi jaringan, hingga kegagalan organ bila tidak ditangani secara cepat dan tepat.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan keperawatan, terutama pada pasien dengan kondisi kritis yang memerlukan pemantauan ketat.	Mahasiswa memahami bahwa keterlambatan mengenali tanda respiratory distress, kesalahan interpretasi saturasi oksigen, atau keterlambatan pemberian terapi oksigen dapat memperburuk kondisi pasien dan meningkatkan risiko gagal napas.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko keselamatan pasien, analisis penyebab masalah, tindakan pencegahan yang dapat dilakukan, serta pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada pasien dengan kegawatdaruratan pernapasan adalah hipoksemia berat, kelelahan otot respirasi, gagal napas akut, serta keterlambatan penanganan apabila perubahan kondisi respirasi tidak terdeteksi secara dini.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain penurunan saturasi

	mengenali situasi yang berpotensi membahayakan keselamatan pasien selama proses asuhan keperawatan.	oksigen yang tidak terdeteksi, peningkatan frekuensi napas yang tidak dimonitor secara berkala, penggunaan otot bantu napas yang diabaikan, serta keterlambatan pelaporan kondisi respirasi kepada tim kesehatan.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien dalam praktik klinik.	Mahasiswa menuliskan pentingnya memantau frekuensi napas dan saturasi oksigen secara berkala, melakukan auskultasi paru secara sistematis, memberikan terapi oksigen sesuai indikasi, serta segera melaporkan tanda penurunan oksigenasi atau tanda gagal napas kepada tim medis.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dari pengalaman klinik dan bagaimana pembelajaran tersebut akan memengaruhi praktik keperawatan berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada pasien dengan kegawatdaruratan pernapasan, pengkajian airway dan breathing yang cepat, interpretasi tanda respirasi secara tepat, serta komunikasi efektif dengan tim kesehatan sangat penting untuk menjaga keselamatan pasien.
Makna dalam OBE	Dalam pendekatan Outcome-Based Education (OBE), refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, serta kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam menjaga keselamatan pasien.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya melakukan pengkajian respirasi dan pemberian terapi oksigen, tetapi juga mampu menganalisis risiko klinis serta meningkatkan kualitas praktik keperawatan gawat darurat secara berkelanjutan.

T. Ringkasan

Kegawatdaruratan pernapasan merupakan kondisi klinis yang mengancam kehidupan dan memerlukan penanganan segera untuk mempertahankan ventilasi dan oksigenasi yang adekuat. Gangguan pada sistem respirasi dapat menyebabkan penurunan pertukaran gas di paru-paru sehingga jaringan tubuh tidak memperoleh oksigen yang cukup. Kondisi ini dapat berkembang secara cepat menjadi gagal napas apabila tidak dikenali dan ditangani secara tepat. Oleh karena itu, pengkajian dan penanganan kegawatdaruratan pernapasan merupakan kompetensi penting bagi perawat, terutama dalam lingkungan pelayanan gawat darurat dan perawatan kritis.

Dalam praktik klinik perawat memiliki peran penting dalam melakukan pengkajian awal sistem respirasi secara cepat dan sistematis. Parameter yang sering digunakan untuk menilai kondisi respirasi pasien antara lain frekuensi napas, pola dan kedalaman napas, saturasi oksigen (SpO₂), ekspansi dada, bunyi napas, serta penggunaan otot bantu napas. Selain itu, evaluasi tanda klinis lain seperti tingkat kesadaran, warna kulit, dan adanya sianosis juga penting untuk mengidentifikasi derajat gangguan oksigenasi. Pengkajian ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini tanda-tanda respiratory distress atau kegagalan ventilasi yang dapat mengarah pada kondisi gagal napas.

Interpretasi kondisi respirasi memerlukan kemampuan *clinical reasoning* yang baik. Perawat harus mampu menghubungkan data pengkajian dengan mekanisme fisiologis gangguan respirasi, seperti obstruksi jalan napas, gangguan ventilasi alveolar, ketidakseimbangan ventilasi-perfusi, atau gangguan difusi oksigen di alveoli. Misalnya, takipnea dan penggunaan otot bantu napas dapat menunjukkan peningkatan kerja napas, sedangkan penurunan saturasi oksigen dan perubahan status mental dapat menandakan hipoksemia yang berat. Oleh karena itu, interpretasi data respirasi tidak dapat dilakukan secara terpisah, tetapi harus dianalisis secara terpadu dengan kondisi klinis pasien.

Dalam konteks kegawatdaruratan pernapasan, perawat juga berperan dalam melakukan intervensi awal untuk mempertahankan patensi jalan napas dan meningkatkan oksigenasi jaringan. Tindakan tersebut meliputi menjaga jalan napas tetap terbuka, memberikan terapi oksigen sesuai indikasi, memposisikan pasien secara optimal, serta memantau respons pasien terhadap terapi yang diberikan. Pada kondisi yang lebih berat, perawat juga berperan dalam mempersiapkan dan mendukung tindakan ventilasi bantuan seperti ventilasi non-invasif atau ventilasi mekanik sesuai dengan kebutuhan klinis pasien.

Secara keseluruhan kemampuan melakukan pengkajian, interpretasi, dan penanganan awal kegawatdaruratan pernapasan merupakan kompetensi

fundamental dalam praktik keperawatan gawat darurat dan keperawatan kritis. Kompetensi ini tidak hanya mencakup keterampilan teknis dalam melakukan pemantauan respirasi, tetapi juga kemampuan analisis klinis, komunikasi dengan tim kesehatan, serta penerapan prinsip keselamatan pasien. Dengan pemahaman yang baik mengenai konsep fisiologi respirasi dan mekanisme gangguan pernapasan, perawat dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga oksigenasi jaringan, mencegah perburukan kondisi pasien, serta meningkatkan kualitas asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan respirasi akut.

U. Red Flags & Eskalasi

Kegawatdaruratan Pernapasan dalam Praktik Keperawatan Gawat Darurat

Red Flags	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
SpO₂ < 90% meskipun sudah diberikan oksigen	Menunjukkan hipoksemia berat dan gangguan pertukaran gas yang signifikan	Segera laporkan kepada dokter atau tim resusitasi, tingkatkan terapi oksigen, siapkan ventilasi bantuan seperti bag valve mask atau ventilasi non-invasif
Frekuensi napas > 30 kali/menit atau < 8 kali/menit	Mengindikasikan distress respirasi berat atau depresi respirasi	Lakukan pemantauan respirasi ketat, evaluasi airway dan breathing, serta segera eskalasi kepada tim medis
Penggunaan otot bantu napas yang jelas	Menunjukkan peningkatan kerja napas dan risiko kelelahan otot respirasi	Pantau kondisi respirasi secara kontinu, berikan terapi oksigen, dan laporkan kepada tim kesehatan
Penurunan kesadaran	Dapat menunjukkan hipoksemia atau hiperkapnia yang memengaruhi perfusi otak	Segera eskalasi kepada dokter, pantau status neurologis, dan siapkan dukungan ventilasi

Sianosis sentral (bibir atau lidah kebiruan)	Menunjukkan hipoksemia berat yang mengancam kehidupan	Berikan oksigen segera, pantau saturasi oksigen secara kontinu, dan aktifkan respon kegawatdaruratan
Silent chest pada auskultasi paru	Menunjukkan obstruksi jalan napas berat atau ventilasi yang sangat minimal	Segera eskalasi kepada tim medis, siapkan ventilasi bantuan atau intubasi endotrakeal
Stridor atau obstruksi jalan napas atas	Menunjukkan penyempitan jalan napas yang berpotensi menyebabkan kegagalan ventilasi	Segera lakukan manajemen airway, siapkan airway adjunct dan intubasi jika diperlukan
Takipnea progresif disertai gelisah	Menunjukkan hipoksia dan distress respirasi yang semakin memburuk	Pantau respirasi dan oksigenasi secara ketat serta laporkan kepada tim kesehatan
Hiperkapnia pada gas darah arteri (PaCO₂ meningkat)	Menunjukkan hipoventilasi dan retensi karbon dioksida	Segera laporkan kepada dokter, evaluasi kebutuhan ventilasi bantuan
Tanda gagal napas: hipoksemia, hiperkapnia, penurunan kesadaran	Menunjukkan kegagalan sistem respirasi dalam mempertahankan ventilasi dan oksigenasi	Aktifkan respon kegawatdaruratan, siapkan ventilasi mekanik, dan lakukan pemantauan intensif

Form Checklist “Saya Sudah Bisa...”

Bab Kegawatdaruratan Pernapasan dalam Praktik Keperawatan Gawat Darurat

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

No	Pernyataan Kompetensi	Ya	Belum
1	Saya dapat menjelaskan konsep dasar kegawatdaruratan pernapasan dalam praktik keperawatan gawat darurat	☐	☐
2	Saya dapat mengidentifikasi tanda dan gejala respiratory distress pada pasien	☐	☐
3	Saya dapat melakukan pengkajian sistem respirasi secara sistematis (frekuensi napas, pola napas, ekspansi dada, bunyi napas, SpO ₂)	☐	☐
4	Saya dapat membedakan kondisi respiratory distress dan respiratory failure	☐	☐
5	Saya dapat mengenali tanda bahaya respirasi seperti hipoksemia, sianosis, penggunaan otot bantu napas, dan penurunan kesadaran	☐	☐
6	Saya dapat melakukan intervensi awal untuk mempertahankan jalan napas dan oksigenasi pasien	☐	☐
7	Saya dapat memilih dan memberikan terapi oksigen yang sesuai dengan kondisi pasien	☐	☐
8	Saya dapat memantau respons pasien terhadap terapi oksigen dan intervensi respirasi	☐	☐
9	Saya dapat mengenali kondisi yang memerlukan eskalasi atau bantuan ventilasi	☐	☐
10	Saya dapat melaporkan kondisi pasien dengan gangguan respirasi secara sistematis kepada tim kesehatan	☐	☐

V. Glosarium

A

Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)

Kondisi gagal napas akut akibat inflamasi berat pada paru yang menyebabkan gangguan pertukaran gas dan hipoksemia berat.

Airway

Jalan napas yang berfungsi sebagai saluran masuk dan keluarnya udara dari dan ke paru-paru.

Airway Adjunct

Alat bantu jalan napas seperti OPA (Oropharyngeal Airway) dan NPA (Nasopharyngeal Airway) untuk mempertahankan patensi jalan napas.

Asidosis Respiratorik

Gangguan keseimbangan asam-basa akibat retensi karbon dioksida (CO₂) karena hipoventilasi.

B

Bag Valve Mask (BVM)

Alat ventilasi manual yang digunakan untuk memberikan bantuan napas pada pasien dengan gangguan ventilasi.

Breathing

Proses ventilasi atau pernapasan yang melibatkan inspirasi dan ekspirasi.

C

Circulation

Komponen penilaian primer yang berkaitan dengan perfusi, sirkulasi darah, dan fungsi kardiovaskular.

Chin Lift

Teknik membuka jalan napas dengan mengangkat dagu.

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)

Metode ventilasi noninvasif dengan tekanan positif kontinu untuk mempertahankan alveoli tetap terbuka.

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)

Penyakit paru obstruktif kronik yang menyebabkan hambatan aliran udara progresif.

D

Disability

Komponen penilaian primer yang berkaitan dengan status neurologis dan tingkat kesadaran pasien.

Dispnea

Sensasi sesak napas atau kesulitan bernapas.

E

Edema Paru

Penumpukan cairan di alveoli paru yang mengganggu oksigenasi.

Ekspansi Dada

Pergerakan dinding dada selama proses inspirasi dan ekspirasi.

Endotrakeal

Berkaitan dengan pemasangan pipa ke dalam trakea untuk mempertahankan jalan napas.

F

Flail Chest

Cedera dada akibat fraktur multipel iga yang menyebabkan gerakan paradoksal dinding dada.

G

Gagal Napas Akut

Ketidakmampuan sistem respirasi mempertahankan oksigenasi atau ventilasi adekuat.

Gas Darah Arteri (AGD)

Pemeriksaan laboratorium untuk menilai oksigenasi, ventilasi, dan keseimbangan asam-basa.

H

Head Tilt–Chin Lift

Teknik membuka jalan napas dengan ekstensi kepala dan pengangkatan dagu.

Hemotoraks

Penumpukan darah di rongga pleura.

Hiperkapnia

Peningkatan kadar karbon dioksida (CO₂) dalam darah.

Hipoksemia

Penurunan kadar oksigen dalam darah arteri.

Hipoksia

Kondisi kekurangan oksigen pada jaringan tubuh.

I

Intubasi Endotrakeal

Tindakan memasukkan pipa endotrakeal ke trakea untuk mempertahankan jalan napas dan ventilasi.

J

Jaw Thrust

Teknik membuka jalan napas tanpa menggerakkan leher, terutama pada pasien trauma.

K

Krekels (Crackles)

Suara napas tambahan akibat cairan di alveoli atau saluran napas kecil.

L

Laju Pernapasan

Jumlah siklus napas per menit.

M

Monitoring Respirasi

Pengkajian dan pemantauan fungsi pernapasan pasien secara kontinu.

N

NPA (Nasopharyngeal Airway)

Alat bantu jalan napas yang dimasukkan melalui hidung.

O

Obstruksi Jalan Napas

Hambatan pada jalan napas yang mengganggu aliran udara.

OPA (Oropharyngeal Airway)

Alat bantu jalan napas yang dimasukkan melalui mulut.

Oksigenasi

Proses pemberian dan distribusi oksigen ke jaringan tubuh.

P

PaCO₂ (Partial Pressure of Carbon Dioxide)

Tekanan parsial karbon dioksida dalam darah arteri.

PaO₂ (Partial Pressure of Oxygen)

Tekanan parsial oksigen dalam darah arteri.

Perfusi

Aliran darah ke jaringan tubuh.

Pneumonia

Infeksi jaringan paru yang menyebabkan inflamasi alveoli.

Pneumotoraks

Masuknya udara ke rongga pleura yang menyebabkan kolaps paru.

Primary Survey

Penilaian cepat awal pasien gawat darurat dengan pendekatan ABCDE.

R

Respiratory Distress

Kondisi peningkatan usaha napas untuk mempertahankan ventilasi dan oksigenasi.

Respiratory Failure

Kondisi ketika sistem respirasi tidak mampu mempertahankan ventilasi atau oksigenasi adekuat.

S**Saturasi Oksigen (SpO₂)**

Persentase hemoglobin yang terikat oksigen dalam darah.

Sepsis

Respons inflamasi sistemik akibat infeksi yang dapat menyebabkan disfungsi organ.

Shunt

Kondisi ketika darah melewati paru tanpa mengalami oksigenasi.

SpO₂

Indikator noninvasif kadar saturasi oksigen perifer.

Stridor

Suara napas abnormal bernada tinggi akibat obstruksi jalan napas atas.

Suction

Tindakan menghisap sekret atau benda asing dari jalan napas.

T**Takikardia**

Peningkatan denyut jantung di atas nilai normal.

Takipnea

Peningkatan frekuensi napas di atas normal.

Trauma Toraks

Cedera pada dada yang dapat memengaruhi fungsi respirasi.

V**Ventilasi**

Proses keluar masuknya udara ke paru-paru.

Ventilasi Mekanik

Bantuan ventilasi menggunakan alat mekanik untuk mempertahankan fungsi respirasi.

Ventilasi Noninvasif

Bantuan ventilasi tanpa pemasangan pipa endotrakeal, seperti CPAP atau BiPAP.

Ventilation–Perfusion Mismatch (V/Q Mismatch)

Ketidakseimbangan antara ventilasi alveolar dan perfusi paru.

W**Wheezing**

Suara napas mengi akibat penyempitan saluran napas.

Work of Breathing (WOB)

Usaha atau energi yang digunakan pasien untuk bernapas.

W. Daftar Pustaka

- Bilan, N., Behbahan, A. G., Abdinia, B., & Mahallei, M. (2010). *Validity of pulse oximetry in detection of hypoxaemia in children: comparison of ear, thumb and toe probe placements*. 16(2), 218–222.
- Cahill, C. M. (2016). *Universalizing anonymity anxiety*. October, 647–654. <https://doi.org/10.1093/jlb/lsw043>
- Emergency, S., & Guideline, O. (2017). *BTS guideline for oxygen use in adults in healthcare and emergency settings*. <https://doi.org/10.1136/thoraxjnl-2016-209729>
- Enrique, M., Flores, V., Ernesto, O., Escudero, S., Larisa, J., Guevara, L., Montañó, D. M., Alexis, G., & Morales, B. (2024). *International journal of medical science and clinical research studies acute respiratory failure: Pathophysiology, diagnosis, and current therapeutic modalities*. 04(06), 1023–1030.
- Fujishima, S. (2023). Guideline - based management of acute respiratory failure and acute respiratory distress syndrome. *Journal of Intensive Care*, 1–9. <https://doi.org/10.1186/s40560-023-00658-3>
- Lagina, M., & Valley, T. S. (2025). *Diagnosis and management of acute respiratory failure*. 40(2), 235–253. <https://doi.org/10.1016/j.ccc.2024.01.002>.Diagnosis
- Nakano, M., Kuromatsu, R., Niizeki, T., Okamura, S., Iwamoto, H., Shimose, S., Shirono, T., Noda, Y., Kamachi, N., & Koga, H. (2021). Immunological in inflammatory biomarkers as prognostic predictors for advanced hepatocellular carcinoma. *ESMO Open*, 6(1), 100020. <https://doi.org/10.1016/j.esmoop.2020.100020>
- Nejat, T. (2024). *Emergency medicine: Open Access*. 14(1000313), 1–2. <https://doi.org/10.35248/2165-7548.24.14.313>
- Rae, J. (2019). *INTENSIVE Tutorial 411 Acute respiratory distress syndrome*. October, 6–11.
- Rochweg, B., Brochard, L., Elliott, M. W., Hess, D., Hill, N. S., Nava, S., Navalesi, P., Antonelli, M., Brozek, J., Conti, G., & Ferrer, M. (2017). *Official ERS/ATS clinical practice guidelines: noninvasive ventilation for acute respiratory failure*. <https://doi.org/10.1183/13993003.02426-2016>
- Scala, R., & Heunks, L. (2018). *Highlights in acute respiratory failure*. 8–11. <https://doi.org/10.1183/16000617.0008-2018>
- Siela, B. D. (2018). *Acute respiratory failure and COPD: Recognition and care*. 13(1), 28–37.

- Sweet, L. R., Keech, C., Klein, N. P., Marshall, H. S., Tagbo, B. N., & Quine, D. (2017). Respiratory distress in the neonate: Case definition & guidelines for data collection, analysis, and presentation of maternal immunization safety data. *Vaccine*, 35(48), 6506–6517. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2017.01.046>
- Thim, T., Vinther, N. H., Grove, E. L., Rohde, C. V., & Løfgren, B. (2012). *Initial assessment and treatment with the airway, breathing, circulation, disability, exposure (ABCDE) approach*. 117–121.
- Yao, S., District, H., United, H., District, L., Rojanasakul, L. W., Chen, Z., Beidai, S., Xu, Y., United, H., District, L., Bai, Y., United, H., District, L., Chen, G., Beidai, S., Zhang, X., United, H., District, L., & Zhang, C. (2016). *HHS public access*. 16(12), 1195–1204. <https://doi.org/10.1007/s10495-011-0647-4.Fas/FasL>

PROFIL PENULIS



Dr. Sri Haryuni, S.Kep., Ns., M.Kep. Lahir di Sukoharjo, 1 Mei 1983. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Brawijaya lulus tahun 2005 dan Program Profesi Ners lulus tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Brawijaya dan lulus 2013. Lanjut pendidikan S3 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga lulus tahun 2023. Riwayat

pekerjaan diawali pada tahun 2006 di Universitas Kediri hingga saat ini. Saat ini penulis mengampu mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat, Keperawatan Bencana di Program Studi Ilmu Keperawatan serta mengajar Ilmu sosial dan perilaku di Program studi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Kediri. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai peneliti, penulis buku, publikasi, seminar, serta kegiatan pengabdian masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sri.haryuni@unik-kediri.ac.id

Motto: "Meniti jalan menuju Husnul Khatimah"



Sulastri, SKp., M.Kep. Lahir di Bangka Selatan. Penulis merupakan lulusan Sarjana Keperawatan (SKp) pada Studi Keperawatan Universitas Indonesia lulus tahun 1994 dan Magister Keperawatan (medikal bedah) di Universitas Indonesia lulus tahun 2013. Riwayat pekerjaan pada tahun 1994-1996 bekerja di RS. Islam Jakarta, kemudian pada tahun 1996-2025 bekerja di Akper Yaspen Jakarta dan sekarang di STIKES Pasar Rebo Jakarta. Mata kuliah yang diampu adalah keperawatan

medikal bedah, keperawatan gawat darurat dan anatomi fisiologi. Penulis telah menulis buku sebanyak 17 judul baik sebagai penulis tunggal maupun tim. Penulis juga telah melakukan beberapa publikasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat pada jurnal terakreditasi SINTA. Penulis juga telah menghasilkan beberapa Haki berupa buku, booklet, poster, dan artikel hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Saat ini penulis merupakan salah satu pengurus Hipmebi DK Jakarta. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sulastrisutiyono2@gmail.com

Motto: Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya

PROFIL PENULIS



Vita Maryah Ardiyani, lahir di Malang, 26 Februari 1987. Jenjang Pendidikan S1 ditempuh di Universitas Brawijaya Malang Program Studi Ilmu Keperawatan, lulus tahun 2010. Pendidikan S2 Magister Keperawatan Universitas Brawijaya Peminatan Keperawatan Gawat Darurat, lulus tahun 2015. Saat ini aktif sebagai dosen tetap di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Tribhuwana Tunggal Malang. Penulis sangat mencintai dunia pendidikan tinggi terutama bidang keperawatan yang sudah di geluti selama lebih dari 10 tahun dan aktif dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkup perguruan tinggi. Penulis aktif terlibat dalam beberapa penelitian termasuk yang didanai kemenristek DIKTI. Beberapa artikel telah diterbitkan penulis pada jurnal bereputasi sinta terutama dalam lingkup keperawatan gawat darurat dan keperawatan medical bedah. Penulis berfokus pada penelitian di area keperawatan gawat darurat khususnya triase. Besar harapan penulis untuk aktif dalam menghasilkan produk artikel, buku dan karya lain yang dapat memberikan manfaat bagi sesama.



Dr. Nurma Afiani, S.Kep., Ns., M.Kep. lahir di Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur. Penulis merupakan lulusan Program Studi Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners Universitas Brawijaya lulus tahun 2009, Magister Keperawatan Peminatan Gawat Darurat di Universitas Brawijaya lulus tahun 2013, dan Program Doktor Kesehatan Masyarakat di Universitas Airlangga lulus tahun 2025. Pada tahun 2009-2010 bekerja sebagai perawat ICU di RS Mitra Keluarga Surabaya, kemudian pada tahun 2010-2022 bekerja sebagai Dosen di STIKES Widyagama Husada dan mulai tahun 2022 hingga saat ini bekerja sebagai Dosen pada Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang (UM). Mata kuliah yang diampu adalah Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Gawat Darurat dan Promosi Kesehatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pengajar, penulis buku, publikasi ilmiah, seminar, peneliti, serta terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada Masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nurma.afiani.fk@um.ac.id

PROFIL PENULIS



Anshar Rante S.Kep., Ns., M.Kes. Lahir tanggal 02 Nopember 1972 di Ujung Bassiang Luwu Sulawesi Selatan . Pendidikan Penulis Dimulai D3 Keperawatan Depkes Ujung Pandang Sekarang Makassar Lulus Tahun 1995,Kemudian Lanjut Ke Program S1 Ners Universitas Hasanudin lulus tahun 2003 dan menyelesaikan S2 Prodi Biomedik Konsentrasi Emergency and Disaster Manajemen lulus Tahun 2013 selain pendidikan formal penulis juga pernah mengikuti program Temasek foundation Singhealth Disaster Preparedness Program Makassar Indoensia bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin tahun 2014-2016 dan tercatat sebagai Master Trainer. Riwayat pekerjaan pada tahun 1996-1999 bekerja di RSU Sawerigading Palopo di Ruang IGD dan Kamar Operasi, kemudian pada tahun 2003-2024 bekerja di Akper Sawerigading Pemda Luwu Kemudian Tahun 2024 sampai sekarang bekerja di STIKes Kamus Arunika Palopo. Mata kuliah yang diampu adalah keperawatan medikal bedah, keperawatan gawat darurat Manajemen Pasien Safety,Patofisiologi dan Psikologi Keperawatan. Penulis telah menulis beberapa buku buku.Selain Sebagai dosen penulis juga sebagai instruktur BTCLS pada LP2TK Indonesia Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: anchamkes@gmail.com

PROFIL PENULIS



Ns. Nunung Nurhayati, S.Kep., M.Kep. merupakan dosen dan akademisi keperawatan yang telah mengabdikan diri di STIKep PPNI Jawa Barat sejak tahun 2007 hingga sekarang. Beliau memiliki kepakaran dalam bidang Keperawatan Gawat Darurat, Keperawatan Kritis, dan Keperawatan Medikal Bedah dengan fokus penelitian pada kualitas tidur pasien kritis, intervensi keperawatan intensif, keselamatan pasien ICU,

terapi komplementer, serta kesiapsiagaan bencana. Pendidikan sarjana keperawatan dan profesi diselesaikan di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (FIK UI) tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan magister Keperawatan Kritis di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Padjadjaran tahun 2012, dan saat ini sedang menempuh pendidikan doktoral di FIK Universitas Indonesia bidang Keperawatan Medikal Bedah. Dalam kegiatan akademik, beliau aktif mengampu mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana, Keperawatan Kritis, serta Gizi dan Diet. Sebagai peneliti dan penulis produktif, beliau telah menghasilkan berbagai publikasi nasional dan internasional bereputasi yang terindeks SINTA dan Scopus, serta aktif menjadi pemakalah dalam seminar ilmiah nasional dan internasional di Indonesia, Malaysia, dan Hongkong. Selain itu, beliau memperoleh berbagai hibah penelitian dan pengabdian masyarakat, termasuk Hibah PUTI Q3 UI, Hibah Publikasi Kemenristek, Hibah PKM Penugasan Dosen UI, dan Hibah AINEC. Beliau juga telah menulis berbagai buku ajar dan buku referensi di bidang keperawatan kritis serta memiliki sejumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa modul, video pembelajaran, poster edukasi, dan buku panduan keperawatan.

Sinopsis

Buku Ajar Keperawatan Gawat Darurat merupakan bahan ajar yang dirancang untuk memberikan pemahaman dasar mengenai konsep, prinsip, dan praktik keperawatan dalam situasi gawat darurat. Buku ini membahas konsep dasar keperawatan gawat darurat, sistem pelayanan gawat darurat, keselamatan pasien (patient safety), Sasaran Keselamatan Pasien (SKP), etika, aspek legal, serta prinsip keselamatan dalam pelayanan gawat darurat. Melalui pembahasan tersebut, pembaca diharapkan mampu memahami peran perawat dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, aman, dan profesional pada kondisi kegawatdaruratan.

Pembahasan buku ini dilanjutkan dengan sistem triage dan manajemen alur pasien di Instalasi Gawat Darurat, meliputi definisi, tujuan, alur pasien, serta konsep prioritas kegawatdaruratan dalam triage. Selain itu, buku ini menguraikan penilaian awal gawat darurat menggunakan pendekatan ABCDE, mulai dari persiapan alat dan pasien, langkah prosedur, keselamatan pasien, komplikasi, evaluasi hasil, hingga dokumentasi. Materi manajemen airway dan oksigenasi dasar juga disajikan untuk membekali pembaca dalam mengenali dan menangani gangguan jalan napas serta kebutuhan oksigenasi pada pasien gawat darurat.

Buku ini juga membahas Bantuan Hidup Dasar (BHD) dan henti jantung pada dewasa, termasuk konsep henti jantung, chain of survival, penilaian awal korban, resusitasi jantung paru, penggunaan AED, algoritma henti jantung, serta aspek keselamatan dan etika dalam tindakan resusitasi. Pada bagian akhir, disajikan materi kegawatdaruratan pernapasan yang mencakup definisi, etiologi, patofisiologi, klasifikasi, manifestasi klinis, pemeriksaan penunjang, komplikasi, penatalaksanaan, serta asuhan keperawatan. Dilengkapi dengan latihan soal, mini-case, simulasi keterampilan, OSCE, DOPS, portofolio, rubrik penilaian, ringkasan, red flags, glosarium, dan daftar pustaka, buku ini dapat menjadi panduan pembelajaran teori dan praktik bagi mahasiswa keperawatan dalam meningkatkan kompetensi di bidang keperawatan gawat darurat.

Buku Ajar Keperawatan Gawat Darurat merupakan bahan ajar yang dirancang untuk memberikan pemahaman dasar mengenai konsep, prinsip, dan praktik keperawatan dalam situasi gawat darurat. Buku ini membahas konsep dasar keperawatan gawat darurat, sistem pelayanan gawat darurat, keselamatan pasien (patient safety), Sasaran Keselamatan Pasien (SKP), etika, aspek legal, serta prinsip keselamatan dalam pelayanan gawat darurat. Melalui pembahasan tersebut, pembaca diharapkan mampu memahami peran perawat dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, aman, dan profesional pada kondisi kegawatdaruratan.

Pembahasan buku ini dilanjutkan dengan sistem triage dan manajemen alur pasien di Instalasi Gawat Darurat, meliputi definisi, tujuan, alur pasien, serta konsep prioritas kegawatdaruratan dalam triage. Selain itu, buku ini menguraikan penilaian awal gawat darurat menggunakan pendekatan ABCDE, mulai dari persiapan alat dan pasien, langkah prosedur, keselamatan pasien, komplikasi, evaluasi hasil, hingga dokumentasi. Materi manajemen airway dan oksigenasi dasar juga disajikan untuk membekali pembaca dalam mengenali dan menangani gangguan jalan napas serta kebutuhan oksigenasi pada pasien gawat darurat.

Buku ini juga membahas Bantuan Hidup Dasar (BHD) dan henti jantung pada dewasa, termasuk konsep henti jantung, chain of survival, penilaian awal korban, resusitasi jantung paru, penggunaan AED, algoritma henti jantung, serta aspek keselamatan dan etika dalam tindakan resusitasi. Pada bagian akhir, disajikan materi kegawatdaruratan pernapasan yang mencakup definisi, etiologi, patofisiologi, klasifikasi, manifestasi klinis, pemeriksaan penunjang, komplikasi, penatalaksanaan, serta asuhan keperawatan. Dilengkapi dengan latihan soal, mini-case, simulasi keterampilan, OSCE, DOPS, portofolio, rubrik penilaian, ringkasan, red flags, glosarium, dan daftar pustaka, buku ini dapat menjadi panduan pembelajaran teori dan praktik bagi mahasiswa keperawatan dalam meningkatkan kompetensi di bidang keperawatan gawat darurat.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7756-69-5 (PDF)



9

786347

756695

